

Buku Ajar

EVIDENCE BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Laily Rachmawati • Juanda Syafitasari • Rita Ariesta
Nurlaili Ramli • Brivian Florentis Yustanta • Nova Avianti Rahayu
Deny Eka Widyastuti • Tetty Rina Aritonang • Yollanda Dwi Santi Violentina
Dwi Retno Wati • Emi Br Barus • Dily Ekasari
Desi Br Sembiring



BUKU AJAR: EVIDENCE BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis:

Laily Rachmawati, S.SiT., M.KM.

Juanda Syafitasari, M.Keb.

Rita Ariesta, M.Kes.

Nurlaili Ramli, S.SiT. MPH.

Bd. Brivian Florentis Yustanta, SST, M.Kes.

Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.

Dr. Bdn. Tetty Rina Aritonang, S.ST., M.Keb.

Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr Keb., M.Tr.Keb.

Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb.

Dily Ekasari, S.ST.Keb., M.K.M.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.



**Optimal
Untuk
Negeri**

Buku Ajar Evidence Based dalam Praktik Kebidanan

Penulis: Laily Rachmawati, S.SiT., M.KM.

Juanda Syafitasari, M.Keb.

Rita Ariesta, M.Kes.

Nurlaili Ramli, S.SiT. MPH.

Bd. Brivian Florentis Yustanta, SST, M.Kes.

Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb.

Dr. Bdn. Tetty Rina Aritonang, S.ST., M.Keb.

Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb.

Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr Keb., M.Tr.Keb.

Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb.

Dily Ekasari, S.ST.Keb., M.K.M.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham, S.pd.

ISBN: 978-634-7294-74-6

Cetakan Pertama: Agustus, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

PRAKATA

Buku ajar ini disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi kebidanan untuk memahami konsep dan aplikasi praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). Dalam dunia kesehatan, khususnya kebidanan, pengambilan keputusan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini sangat penting guna meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan pasien, serta hasil klinis yang optimal. Materi dalam buku ini mencakup berbagai aspek penting seperti metode penelitian, aplikasi penelitian dalam praktik kebidanan, dan tantangan serta strategi implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM).

Setiap bab dalam buku ini dirancang secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami proses penelitian, mulai dari desain, teknik pemilihan sampel, pengumpulan dan analisis data, hingga diseminasi hasil penelitian. Buku ini juga menyoroti pentingnya integrasi penelitian dalam praktik klinis kebidanan, termasuk aspek kepakaran klinis, dilema etik, serta nilai individu pasien yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan kebidanan. Untuk memfasilitasi pemahaman, setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, glosarium, dan daftar pustaka yang komprehensif.

Melalui buku ini, diharapkan mahasiswa dan praktisi kebidanan tidak hanya mampu memahami teori dasar EBP tetapi juga mampu mengaplikasikan hasil penelitian terbaik ke dalam praktik sehari-hari secara efektif. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pelayanan kebidanan berbasis bukti serta membantu praktisi kebidanan dalam menghadapi tantangan klinis secara profesional dan berintegritas tinggi.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 METODE YANG UMUM DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN: DESAIN, SAMPLE, PENGUMPULAN DATA, DAN ANALISIS.....	1
A. Desain Penelitian Dalam Kebidanan.....	3
B. Teknik Pemilihan Sampel	6
C. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kebidanan	9
D. Analisis Data Dalam Penelitian Kebidanan	12
E. Latihan Soal	16
F. Kunci Jawaban	17
G. Rangkuman Materi	17
H. Glosarium.....	18
I. Daftar Pustaka.....	19
BAB 2 EVIDENCE BASED PRACTICE IN MIDWIFERY	21
A. Pengertian Evidence-Based Practice	23
B. Tujuan Evidence-Based Practice.....	23
C. Manfaat Evidence Based Practice	24
D. Model Evidence-Based Practice	26
E. Dampak Evidence-Based Practice.....	27
F. Tantangan dalam menerapkan <i>Evidence-Based Practice</i>	28
G. Strategi dalam rangka peningkatan praktek berbasis bukti.....	28
H. Penelusuran dan <i>review literature</i>	29
I. Tugas Mahasiswa.....	32
J. Latihan Soal	33
K. Rangkuman Materi	35
L. Glosarium.....	36
M. Referensi	37

BAB 3 APLIKASI BERBAGAI METODE PENELITIAN DALAM SETTING PRAKTIK PELAYANAN KEBIDANAN, PUBLIKASI DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN.....	43
A. Pengantar Evidence-Based Midwifery Practice	45
B. Metode Penelitian Kuantitatif dalam Praktik Kebidanan	46
C. Metode Penelitian Kualitatif dalam Praktik Kebidanan	48
D. Mixed Methods dalam Penelitian Kebidanan.....	50
E. Teknik Pelaksanaan Penelitian di Lapangan.....	52
F. Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kebidanan	55
G. Panduan Penulisan Publikasi Ilmiah (Struktur, Etika, Abstrak, Referensi)	57
H. Strategi Efektif Diseminasi Hasil Penelitian.....	59
I. Evaluasi Dampak Penelitian dalam Praktik Pelayanan Kebidanan	61
J. Latihan Soal	64
K. Rangkuman Materi	66
L. Glosarium.....	66
M. Daftar Pustaka.....	68

BAB 4 EVIDENCE-BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN: HASIL PENELITIAN TERBAIK, IMPLIKASI, DAN PENTINGNYA EBP DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	71
A. Hasil Penelitian Terbaik dalam Evidence-Based Midwifery Practice.....	72
B. Implikasi Penerapan Evidence-Based Practice dalam Praktik Kebidanan	76
C. Pentingnya Evidence-Based Practice dalam Praktik Kebidanan	78
D. Latihan Soal	80
E. Rangkuman Materi	82
F. Glosarium.....	83
G. Daftar Pustaka.....	85

BAB 5 EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: PRINSIP APLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN, PRINSIP DAN LANGKAH DALAM EVIDENCE-BASED MIDWIFERY CARE	87
A. Prinsip Aplikasi Hasil Penelitian dalam Praktik Kebidanan.....	89
B. Prinsip dan Langkah dalam Evidence-Based Midwifery Care	91
C. Latihan Soal	93
D. Rangkuman Materi	96
E. Glosarium.....	96

F. Daftar Pustaka.....	99
------------------------	----

BAB 6 PRINSIP APLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

DAN PRINSIP SERTA LANGKAH EVIDENCE-BASED MIDWIFERY CARE.....101

A. Prinsip Aplikasi Hasil Penelitian dalam Praktik Kebidanan.....	103
B. Prinsip dan Langkah dalam Evidence-Based Midwifery Care	105
C. Latihan Soal	110
D. Rangkuman Materi	112
E. Glosarium.....	113
F. Daftar Pustaka.....	114

BAB 7 KEPAKARAN KLINIS (CLINICAL EXPERTISE): PENGAMBILAN

KEPUTUSAN KLINIS DALAM ASUHAN, REFLEKTIF117

A. Konsep Dasar Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan	118
B. Komponen Utama Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan	119
C. Peran Kepakaran Klinis dalam Pengambilan Keputusan dalam Praktik Kebidanan.....	121
D. Praktik Reflektif sebagai Bagian Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan	123
E. Pengembangan Kepakaran Klinis dalam Pendidikan Kebidanan	124
F. Latihan Soal	127
G. Rangkuman Materi	129
H. Glosarium.....	131
I. Daftar Pustaka.....	132

BAB 8 KEPAKARAN KLINIS (CLINICAL EXPERTISE): PERTIMBANGAN

KEILMUAN, PENGALAMAN KLINIK133

A. Pertimbangan Keilmuan	136
B. Pengalaman Klinik.....	140
C. Penutup	145
D. Latihan Soal	146
E. Glosarium.....	148
F. Daftar Pustaka.....	149

BAB 9 KEPAKARAN KLINIS DALAM PRAKTIK KEBIDANAN BERBASIS BUKTI:

NILAI INDIVIDU DAN DILEMA ETIK.....151

A. Kepakaran Klinis dalam Evidence-Based Midwifery Practice.....	153
B. Pentingnya Menghormati Nilai Individu Pasien	154
C. Dilema Etik dalam Praktik Kebidanan	156
D. Strategi Menghadapi Dilema Etik dalam Kebidanan	157
E. Latihan Soal	159
F. Rangkuman Materi	161
G. Glosarium.....	162
H. Daftar Pustaka.....	164

BAB 10 EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: DATA COLLECTION AND ANALYSIS METHODS, QUALITY APPRAISAL OF RESEARCH..... 165

A. Metode Pengumpulan Data dalam Praktik Kebidanan	166
B. Metode Analisis Data dalam Penelitian Kebidanan.....	168
C. Quality Appraisal of Research (Penilaian Kualitas Penelitian)	170
D. Integrasi Data dan Analisis dalam Praktik Klinis Kebidanan	172
E. Daftar Pustaka.....	173
F. Rangkuman Materi	176
G. Glosarium.....	177
H. Daftar Pustaka.....	178

BAB 11 EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: THE APPLICATION OF KNOWLEDGE TO MIDWIFERY PRACTICE, EVIDENCE FOR HOSPITAL-BASED CARE 181

A. Konsep Dasar EBMP dalam Praktik Kebidanan Rumah Sakit	183
B. Identifikasi Sumber-Sumber Bukti Ilmiah.....	185
C. Penilaian Kritis terhadap Bukti Ilmiah	187
D. Implementasi Bukti Ilmiah dalam Asuhan Kebidanan.....	189
E. Komunikasi Efektif Mengenai Bukti Ilmiah.....	191
F. Latihan Soal	193
G. Rangkuman Materi	195
H. Glosarium.....	196
I. Daftar Pustaka.....	198

BAB 12 EVIDENCE BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: KEKUATAN KELEMAHAN DALAM PENERAPAN EVIDENCE-BASED PADA PRAKTIK,

BIOMEDICAL ETHICS AND THERE APPLICATION TO MIDWIFERY PRACTICE

.....	201
A. Konsep Dasar Evidence-Based Midwifery (EBM)	203
B. Kekuatan dalam Penerapan Evidence-Based Midwifery	205
C. Kelemahan dan Tantangan dalam Penerapan Evidence-Based Midwifery ..	206
D. Prinsip-Prinsip Biomedical Ethics dalam Kebidanan	208
E. Implementasi Biomedical Ethics dalam Praktik Evidence-Based Midwifery	210
F. Tantangan dan Strategi Implementasi Praktik Kebidanan Berbasis Bukti ...	212
G. Latihan Soal	214
H. Rangkuman Materi	216
I. Glosarium.....	218
J. Daftar Pustaka.....	219

BAB 13 APLIKASI PENELITIAN PADA PRAKTIK KEBIDANAN221

A. Tantangan dalam Penerapan Evidence-Based	222
B. Pemberian Informasi Sesuai Evidence-Based (Kenyataan)	224
C. Latihan Soal	225
D. Rangkuman Materi	228
E. Glosarium.....	229
F. Daftar Pustaka.....	230

BAB 14 TREND DAN ISSUE233

A. Tren Terbaru dalam Praktik Kebidanan	234
B. Isu Aktual dalam Praktik Kebidanan	235
C. Implementasi Evidence-Based untuk Menghadapi Isu dan Tren	237
D. Latihan Soal	239
E. Rangkuman Materi	241
F. Glosarium.....	242
G. Daftar Pustaka.....	243

PROFIL PENULIS245

BAB 1

METODE YANG UMUM DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN: DESAIN, SAMPLE, PENGUMPULAN DATA, DAN ANALISIS

Pendahuluan

Pelayanan kebidanan merupakan bagian penting dalam sistem kesehatan yang berfokus pada kesehatan perempuan sepanjang siklus kehidupannya, terutama selama masa kehamilan, persalinan, nifas, serta kesehatan reproduksi. Bidan memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks global, peningkatan kualitas pelayanan kebidanan telah menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Untuk menjamin mutu pelayanan, sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendekatan ilmiah. Di sinilah pentingnya penelitian kebidanan sebagai alat untuk mengevaluasi praktik yang ada, mengidentifikasi masalah, serta mengembangkan inovasi dan solusi yang efektif. Penelitian kebidanan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, psikologis, dan budaya yang memengaruhi pengalaman perempuan dalam menerima layanan kesehatan.

Dalam upaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam praktik klinis, diperlukan pemahaman yang kuat mengenai metode penelitian. Metodologi yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, serta konteks dan populasi yang diteliti. Oleh karena itu, pemilihan desain penelitian, teknik sampling, metode pengumpulan data, serta strategi analisis data merupakan aspek krusial yang harus dirancang secara sistematis dan logis.

Saat ini, penelitian dalam kebidanan semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada metode kuantitatif yang mengukur dan menguji hipotesis secara objektif, tetapi juga melibatkan pendekatan kualitatif yang bertujuan memahami makna dan pengalaman individu secara mendalam. Kombinasi kedua pendekatan ini sering kali

diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena yang kompleks dalam praktik kebidanan.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai metode yang umum digunakan dalam penelitian dan pelayanan kebidanan. Pembahasan mencakup berbagai jenis desain penelitian, pendekatan dalam pemilihan sampel, teknik pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif, serta cara menganalisis data secara sistematis. Dengan memahami metode ini, diharapkan mahasiswa kebidanan, peneliti pemula, dan praktisi kesehatan dapat merancang dan melaksanakan penelitian yang bermutu tinggi serta relevan dengan kebutuhan pelayanan.

Lebih dari itu, buku ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kritis terhadap pentingnya evidence-based practice dalam kebidanan. Hanya dengan pendekatan yang berbasis pada data dan bukti ilmiah, pelayanan kebidanan dapat terus ditingkatkan demi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan perempuan sebagai penerima layanan.

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan pengertian dan pentingnya desain penelitian dalam konteks kebidanan.
- Mengidentifikasi berbagai jenis desain penelitian yang umum digunakan dalam penelitian kebidanan.
- Menganalisis kelebihan dan keterbatasan masing-masing desain penelitian.
- Memilih desain penelitian yang sesuai berdasarkan permasalahan kebidanan yang diteliti.

Capaian Pembelajaran:

- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya metode penelitian dalam pelayanan kebidanan.
- Mengidentifikasi dan membedakan berbagai desain penelitian yang umum digunakan dalam kebidanan.
- Menentukan teknik sampling yang tepat berdasarkan tujuan dan jenis penelitian.
- Menjelaskan metode pengumpulan data baik dalam pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
- Menerapkan teknik analisis data yang sesuai dengan desain dan jenis data penelitian.
- Menyusun rancangan penelitian kebidanan secara sistematis dan berbasis bukti.
- Mengintegrasikan hasil penelitian dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Uraian Materi

Metode yang umum digunakan dalam pelayanan kebidanan mencakup desain penelitian, teknik pemilihan sampel, pengumpulan data, dan analisis data yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Desain penelitian yang tepat, seperti deskriptif, analitik, dan eksperimen, akan menentukan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Teknik sampling yang digunakan, baik probabilitas maupun non-probabilitas, membantu memilih sampel yang representatif dari populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, wawancara, atau observasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data kemudian digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta menghasilkan temuan yang dapat diterapkan dalam praktik kebidanan berbasis bukti.

A. Desain Penelitian Dalam Kebidanan

Desain penelitian adalah kerangka yang digunakan untuk merancang penelitian secara sistematis dan terstruktur, guna menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kebidanan, desain penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kebidanan, memberikan wawasan baru, dan memberikan bukti ilmiah yang berguna bagi pengembangan praktik kebidanan. Desain penelitian yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya dengan cara yang dapat memberikan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tiga desain penelitian yang umum digunakan dalam kebidanan adalah desain deskriptif, desain analitik, dan desain eksperimen. Masing-masing desain memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, serta digunakan untuk menjawab berbagai jenis pertanyaan penelitian.

1. Desain Deskriptif

Desain deskriptif adalah desain penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kondisi tertentu tanpa bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat. Dalam kebidanan, desain deskriptif sering digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik populasi atau kejadian yang sedang berlangsung. Penelitian ini hanya menggambarkan fenomena yang ada tanpa mencoba untuk menjelaskan atau menguji hubungan antar variabel.

Contoh penerapan desain deskriptif dalam kebidanan adalah penelitian yang menggambarkan prevalensi anemia pada ibu hamil di suatu daerah, atau penelitian yang menggambarkan persepsi ibu terhadap pelayanan antenatal care (ANC). Penelitian deskriptif berguna untuk memberikan gambaran awal tentang

suatu masalah kesehatan dan dapat memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Kelebihan dari desain deskriptif adalah mudah diterapkan, biaya yang relatif rendah, dan dapat dilakukan dengan sampel yang lebih besar. Namun, desain ini tidak dapat digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel atau untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab suatu masalah.

2. Desain Analitik

Desain analitik digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian atau kondisi. Dalam kebidanan, desain analitik sering digunakan untuk menilai faktor risiko yang terkait dengan komplikasi kehamilan, seperti preeklamsia atau kelahiran prematur.

Ada beberapa jenis desain analitik yang umum digunakan dalam penelitian kebidanan, yaitu studi kohort, studi kasus-kontrol, dan studi potong lintang (cross-sectional study).

a. Studi Kohort

Studi kohort adalah jenis desain analitik yang digunakan untuk mengevaluasi faktor risiko dengan mengikuti kelompok individu yang memiliki karakteristik atau paparan yang sama selama periode waktu tertentu. Peneliti membandingkan kejadian suatu hasil (misalnya, komplikasi kehamilan) antara kelompok yang terpapar dan yang tidak terpapar terhadap faktor risiko tertentu.

Contoh studi kohort dalam kebidanan adalah penelitian yang mengevaluasi hubungan antara status gizi ibu hamil dengan kejadian preeklamsia. Kelompok ibu hamil dengan status gizi baik dibandingkan dengan ibu hamil yang kekurangan gizi untuk melihat apakah ada perbedaan dalam kejadian preeklamsia.

Kelebihan dari studi kohort adalah kemampuannya untuk menilai hubungan sebab-akibat dan untuk mempelajari faktor risiko. Namun, studi kohort memerlukan waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

b. Studi Kasus-Kontrol

Studi kasus-kontrol adalah desain analitik yang digunakan untuk membandingkan individu yang memiliki suatu kondisi atau penyakit (kasus) dengan individu yang tidak memiliki kondisi tersebut (kontrol). Peneliti kemudian mencari faktor-faktor risiko yang membedakan kedua kelompok tersebut.

Contoh penerapan studi kasus-kontrol dalam kebidanan adalah penelitian yang membandingkan ibu hamil yang mengalami kelahiran

prematur (kasus) dengan ibu hamil yang melahirkan bayi cukup bulan (kontrol), untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang terkait dengan kelahiran prematur, seperti riwayat medis atau pola makan.

Studi kasus-kontrol relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan studi kohort, namun tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat secara langsung.

c. Studi Potong Lintang (Cross-Sectional Study)

Studi potong lintang adalah desain analitik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada satu titik waktu untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang berbeda. Peneliti mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu dan menganalisis hubungan antar variabel pada saat yang sama.

Contoh studi potong lintang dalam kebidanan adalah penelitian yang menilai hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai kesehatan reproduksi dengan tingkat kepatuhan ibu terhadap jadwal pemeriksaan antenatal.

Desain potong lintang mudah dilakukan dan relatif murah, tetapi hanya memberikan gambaran hubungan yang bersifat asosiatif, bukan sebab-akibat.

3. Desain Eksperimen

Desain eksperimen adalah desain penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu intervensi atau perlakuan dengan membandingkan hasil sebelum dan setelah intervensi dilakukan. Dalam kebidanan, desain eksperimen sering digunakan untuk menilai efektivitas intervensi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, seperti uji coba penggunaan suplemen gizi pada ibu hamil atau penerapan metode persalinan tertentu.

Salah satu contoh desain eksperimen yang paling sering digunakan dalam kebidanan adalah randomized controlled trial (RCT), yang dianggap sebagai standar emas dalam penelitian klinis. Dalam RCT, peserta dibagi secara acak menjadi dua kelompok: satu kelompok menerima intervensi, sementara kelompok lain menerima perlakuan standar atau plasebo. Hasil dari kedua kelompok kemudian dibandingkan untuk menilai efektivitas intervensi tersebut.

Kelebihan desain eksperimen, khususnya RCT, adalah kemampuannya untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat secara jelas dan memberikan bukti yang kuat mengenai efektivitas suatu intervensi. Namun, RCT memerlukan sumber daya yang besar, serta kontrol yang ketat terhadap variabel yang mempengaruhi hasil.

B. Teknik Pemilihan Sampel

Dalam setiap penelitian, salah satu aspek yang sangat penting adalah pemilihan sampel, yaitu kelompok responden atau objek yang dipilih dari populasi yang lebih besar untuk menjadi representasi dari keseluruhan populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang tepat akan memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas, serta memberikan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks kebidanan, teknik pengambilan sampel yang digunakan harus memperhatikan karakteristik populasi ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi, yang sering kali memiliki kebutuhan dan kondisi kesehatan yang sangat bervariasi.

Secara umum, terdapat dua kategori teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, yaitu teknik sampling probabilitas dan teknik sampling non-probabilitas. Kedua teknik ini memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, dan pilihan teknik yang tepat bergantung pada desain penelitian serta tujuan dari penelitian itu sendiri.

1. Teknik Sampling Probabilitas

Teknik sampling probabilitas adalah teknik di mana setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar representatif dari populasi, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan lebih baik. Teknik sampling probabilitas lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis variabel secara statistik.

Beberapa jenis teknik sampling probabilitas yang sering digunakan dalam kebidanan adalah:

a. Simple Random Sampling (Pengambilan Sampel Acak Sederhana)

Pada teknik ini, setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, biasanya menggunakan undian, tabel angka acak, atau perangkat lunak komputer. Teknik ini sangat cocok digunakan ketika populasi relatif homogen, dan peneliti ingin memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk masuk dalam sampel.

Contoh penerapan dalam kebidanan adalah penelitian untuk mengetahui prevalensi anemia pada ibu hamil di sebuah rumah sakit. Dengan menggunakan simple random sampling, peneliti dapat memilih secara acak sejumlah ibu hamil yang datang ke rumah sakit untuk menjadi responden, tanpa mempertimbangkan faktor lain.

- b. **Stratified Sampling (Pengambilan Sampel Bertingkat)** Stratified sampling digunakan ketika populasi terbagi menjadi subgrup atau strata yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam teknik ini, populasi dibagi menjadi strata berdasarkan suatu karakteristik tertentu (misalnya, usia, status gizi, tingkat pendidikan), dan sampel diambil dari setiap strata secara proporsional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subgrup dalam populasi terwakili dalam sampel, yang dapat meningkatkan akurasi dan reliabilitas hasil penelitian.

Dalam kebidanan, contoh penerapan stratified sampling adalah penelitian yang mengkaji perbedaan tingkat kepatuhan terhadap pemeriksaan antenatal care (ANC) antara ibu hamil dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Peneliti akan membagi populasi ibu hamil menjadi beberapa strata berdasarkan tingkat pendidikan mereka, dan kemudian mengambil sampel secara acak dari setiap strata.

- c. **Cluster Sampling (Pengambilan Sampel Kelompok)** Cluster sampling digunakan ketika populasi sangat besar dan tersebar di wilayah yang luas. Dalam teknik ini, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster, dan kemudian beberapa cluster dipilih secara acak. Setelah cluster dipilih, semua elemen dalam cluster tersebut akan dijadikan sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian yang melibatkan populasi yang tersebar di daerah geografis yang besar, seperti penelitian di tingkat kabupaten atau provinsi. Contoh penerapan dalam kebidanan adalah penelitian yang menilai implementasi program kesehatan ibu di beberapa puskesmas di wilayah tertentu. Peneliti akan memilih beberapa puskesmas secara acak sebagai cluster, dan kemudian semua ibu hamil yang ada di puskesmas yang dipilih akan dijadikan sampel.

2. Teknik Sampling Non-Probabilitas

Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Teknik ini lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana tujuan utama adalah untuk memahami pengalaman atau pandangan individu secara mendalam, bukan untuk menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi.

Beberapa jenis teknik sampling non-probabilitas yang sering digunakan dalam kebidanan adalah:

- a. **Purposive Sampling (Pengambilan Sampel Berdasarkan Tujuan)** Purposive sampling adalah teknik di mana peneliti memilih responden berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang pengalaman atau pandangan individu tertentu. Purposive sampling tidak mengutamakan representasi statistik, tetapi lebih pada seleksi yang cermat terhadap individu yang dapat memberikan informasi yang berguna.

Contoh penerapan dalam kebidanan adalah penelitian yang mengeksplorasi pengalaman ibu hamil remaja dalam mengikuti program kesehatan ibu. Peneliti akan memilih ibu hamil remaja yang memiliki pengalaman mengikuti program kesehatan ibu tertentu untuk diwawancarai.

- b. Convenience Sampling (Pengambilan Sampel Berdasarkan Kemudahan)
- Convenience sampling adalah teknik di mana sampel dipilih berdasarkan kenyamanan atau kemudahan akses bagi peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian eksplorasi atau penelitian dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Meskipun praktis, teknik ini sering kali menghasilkan sampel yang tidak representatif, sehingga dapat mempengaruhi validitas eksternal penelitian.

Contoh penerapan dalam kebidanan adalah penelitian yang mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan di sebuah rumah sakit, di mana peneliti memilih pasien yang mudah diakses atau yang bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian.

- c. Snowball Sampling (Pengambilan Sampel Bola Salju)
- Snowball sampling adalah teknik yang digunakan ketika peneliti kesulitan dalam mengidentifikasi dan merekrut responden dari populasi yang spesifik, misalnya pada kelompok yang sangat terisolasi atau sulit dijangkau. Dalam teknik ini, peneliti meminta responden pertama untuk merekomendasikan individu lain yang memenuhi kriteria, dan proses ini berlanjut seperti bola salju yang berkembang.

Contoh penerapan dalam kebidanan adalah penelitian yang mengkaji pengalaman ibu hamil dengan penyakit langka atau komplikasi tertentu yang jarang terjadi. Peneliti dapat memulai dengan mengidentifikasi satu ibu hamil yang memiliki kondisi tersebut, kemudian meminta mereka untuk merujuk ibu hamil lainnya dengan kondisi yang serupa.

3. Pemilihan Teknik Pengambilan Sampel dalam Kebidanan

Pemilihan teknik pengambilan sampel yang tepat dalam kebidanan sangat bergantung pada tujuan penelitian, desain penelitian, dan karakteristik populasi yang diteliti. Teknik sampling probabilitas lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk generalisasi hasil, sedangkan teknik

sampling non-probabilitas lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada eksplorasi pengalaman dan perspektif individu.

Peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran populasi, ketersediaan sumber daya, dan waktu yang terbatas dalam memilih teknik yang sesuai. Dengan pemilihan teknik pengambilan sampel yang tepat, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, serta bayi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan praktik kebidanan dan kualitas pelayanan kesehatan maternal secara keseluruhan.

C. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kebidanan

Pengumpulan data adalah salah satu tahap yang sangat penting dalam proses penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kualitas data yang dikumpulkan akan sangat memengaruhi kualitas hasil penelitian, karena data yang valid dan akurat menjadi dasar utama dalam proses analisis dan interpretasi. Dalam konteks penelitian kebidanan, pengumpulan data tidak hanya menyangkut aspek medis dan biologis, tetapi juga melibatkan dimensi psikososial, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memilih metode pengumpulan data yang tepat agar dapat memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat untuk praktik kebidanan yang lebih baik.

Dalam penelitian kebidanan, terdapat berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan, baik untuk pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pemilihan metode pengumpulan data sangat bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang ingin dikumpulkan, serta desain penelitian yang dipilih. Secara umum, terdapat dua kategori utama metode pengumpulan data, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif bertujuan untuk mengukur variabel yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Data kuantitatif sering kali berbentuk angka atau kategori yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel atau untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian kebidanan, data kuantitatif sering kali berkaitan dengan aspek kesehatan yang dapat diukur, seperti tingkat prevalensi penyakit, jumlah kunjungan antenatal care, tingkat kelahiran normal, dan sebagainya.

Beberapa metode pengumpulan data kuantitatif yang sering digunakan dalam kebidanan adalah:

a. Kuesioner (Survei)

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Pertanyaan dalam kuesioner biasanya bersifat tertutup (pilihan ganda) atau terbuka (responden menulis jawaban mereka sendiri), tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan.

Di dalam kebidanan, kuesioner sering digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman ibu hamil dalam mengikuti program kesehatan, tingkat pengetahuan tentang kebidanan, kepuasan terhadap pelayanan kebidanan, atau faktor risiko yang memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Kuesioner dapat dibagikan kepada ibu hamil di klinik kebidanan, rumah sakit, atau komunitas.

b. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung antara peneliti dan responden, menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih terperinci dibandingkan dengan kuesioner karena pertanyaan dapat dijelaskan lebih lanjut jika diperlukan. Namun, karena format pertanyaan yang telah ditentukan, wawancara terstruktur lebih terbatas dalam fleksibilitas.

Wawancara terstruktur dalam kebidanan dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait pola perilaku, tingkat pengetahuan, atau pengalaman ibu hamil terhadap pelayanan kebidanan atau proses persalinan. Misalnya, wawancara terstruktur bisa digunakan untuk mengetahui seberapa banyak ibu hamil yang mengetahui tentang pentingnya pemeriksaan antenatal.

c. Pengukuran Fisik dan Klinis Dalam penelitian kebidanan, pengukuran fisik dan klinis seperti pengukuran tekanan darah, berat badan, indeks massa tubuh (IMT), kadar hemoglobin, atau pemeriksaan lain yang relevan sering dilakukan untuk mengumpulkan data objektif mengenai kondisi kesehatan ibu hamil. Alat medis yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter ini harus akurat dan sesuai standar, karena data yang tidak valid atau tidak terukur dengan benar dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Misalnya, dalam penelitian yang mengevaluasi prevalensi anemia pada ibu hamil, pengukuran kadar hemoglobin pada ibu hamil menjadi sangat penting untuk menentukan status gizi mereka.

2. Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu fenomena atau pengalaman subjektif

individu. Data kualitatif sering kali bersifat deskriptif dan tidak dapat dihitung secara statistik, tetapi memberikan wawasan yang lebih luas dan kontekstual mengenai suatu masalah. Dalam kebidanan, penelitian kualitatif sering digunakan untuk menggali pengalaman ibu hamil atau perempuan dalam menerima layanan kebidanan, memahami persepsi mereka terhadap kesehatan reproduksi, serta menggali faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan mereka.

Beberapa metode pengumpulan data kualitatif yang sering digunakan dalam kebidanan adalah:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah salah satu teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif. Dalam wawancara mendalam, peneliti berinteraksi dengan responden secara lebih fleksibel dan terbuka untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan perasaan responden tentang suatu isu. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, persepsi, atau pengalaman ibu hamil dalam menjalani proses kehamilan dan persalinan.

Wawancara mendalam sering digunakan dalam penelitian kebidanan yang bertujuan untuk memahami pengalaman ibu hamil dalam mengikuti proses perawatan atau pelayanan kebidanan. Misalnya, penelitian tentang pengalaman ibu hamil remaja dalam menerima layanan kesehatan ibu atau tentang tantangan yang dihadapi ibu hamil dalam komunitas pedesaan yang sulit akses ke fasilitas kesehatan.

b. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion - FGD)

Diskusi kelompok terfokus adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok kecil individu yang dipandu oleh seorang moderator untuk mendiskusikan topik tertentu. FGD sering digunakan untuk menggali pandangan kelompok terhadap isu-isu tertentu, serta mengidentifikasi pola pikir dan dinamika kelompok yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara individu.

Dalam kebidanan, FGD sering digunakan untuk memperoleh pandangan ibu hamil mengenai pelayanan kesehatan ibu atau untuk menggali persepsi mereka mengenai program edukasi kesehatan. Misalnya, FGD dapat digunakan untuk mengeksplorasi pendapat ibu hamil tentang pentingnya imunisasi atau program pemeriksaan prenatal yang disediakan oleh tenaga medis.

c. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengamati perilaku atau aktivitas responden dalam konteks alami mereka.

Dalam penelitian kebidanan, observasi sering dilakukan di ruang layanan kesehatan untuk mempelajari interaksi antara ibu hamil dan tenaga medis atau untuk menilai pelaksanaan kebijakan pelayanan kebidanan di lapangan.

Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana pelayanan kebidanan diberikan, serta mencatat aspek-aspek yang mungkin tidak dijelaskan dalam wawancara atau kuesioner. Misalnya, dalam penelitian tentang pelayanan di rumah sakit, peneliti dapat mengamati proses pemberian konseling antenatal oleh bidan atau dokter untuk menilai kualitas komunikasi antara tenaga kesehatan dan ibu hamil.

3. Validitas dan Keandalan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kebidanan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengumpulan data mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara keandalan (reliabilitas) berkaitan dengan konsistensi hasil yang diperoleh jika data dikumpulkan kembali dalam kondisi yang serupa.

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, peneliti dapat melakukan uji coba instrumen pengumpulan data sebelum penelitian utama dimulai. Selain itu, peneliti harus selalu mempertimbangkan konteks budaya dan sosial saat merancang instrumen pengumpulan data, karena ini akan mempengaruhi bagaimana responden memahami dan merespons pertanyaan.

D. Analisis Data Dalam Penelitian Kebidanan

Analisis data adalah tahap penting dalam penelitian karena hasil dari analisis ini yang akan memberikan pemahaman tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks kebidanan, analisis data menjadi kunci untuk menginterpretasi informasi yang dikumpulkan mengenai kesehatan ibu hamil, persalinan, dan bayi. Penelitian kebidanan seringkali melibatkan data yang kompleks, baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun dari segi pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi (kualitatif). Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kebidanan haruslah sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penelitian itu sendiri. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai berbagai teknik analisis data yang umum digunakan dalam penelitian kebidanan.

Terdapat dua jenis pendekatan utama dalam analisis data penelitian kebidanan, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki teknik analisis yang spesifik dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Memahami teknik analisis yang tepat sangat penting untuk memperoleh hasil yang valid dan bermanfaat dalam praktik kebidanan.

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk mengolah data yang berbentuk angka atau variabel yang dapat diukur secara numerik. Data kuantitatif sering kali digunakan untuk menguji hipotesis atau untuk mengetahui hubungan antar variabel. Teknik analisis ini sangat bergantung pada statistik untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Dalam penelitian kebidanan, data kuantitatif sering digunakan untuk menilai prevalensi masalah kesehatan, menguji efektivitas intervensi kebidanan, atau menganalisis faktor risiko tertentu yang memengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Beberapa teknik analisis data kuantitatif yang umum digunakan dalam penelitian kebidanan adalah sebagai berikut:

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang telah dikumpulkan. Teknik ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik sampel atau populasi yang diteliti, misalnya frekuensi kejadian, rata-rata, dan distribusi variabel. Dalam kebidanan, statistik deskriptif sering digunakan untuk menggambarkan profil kesehatan ibu hamil, seperti usia, status gizi, tekanan darah, atau status kesehatan lainnya.

Contoh aplikasi statistik deskriptif dalam kebidanan adalah menghitung rata-rata usia ibu hamil, distribusi paritas (jumlah kelahiran sebelumnya), atau proporsi ibu hamil dengan anemia di suatu daerah tertentu. Hasil statistik deskriptif ini membantu peneliti memahami kondisi dasar sebelum melanjutkan dengan analisis yang lebih kompleks.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hubungan antar variabel atau untuk membandingkan dua atau lebih kelompok berdasarkan variabel yang diteliti. Uji hipotesis ini dapat menggunakan berbagai uji statistik, tergantung pada jenis data dan desain penelitian. Beberapa uji yang sering digunakan dalam penelitian kebidanan antara lain:

- 1) Uji t (t-test): Digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang independen, misalnya membandingkan tingkat stres antara ibu hamil primipara (kehamilan pertama) dan multipara (kehamilan lebih dari satu).
- 2) Analisis Varians (ANOVA): Digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok, seperti membandingkan tingkat kepuasan pelayanan kebidanan antara berbagai rumah sakit atau klinik.
- 3) Uji chi-square: Digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori, seperti hubungan antara status imunisasi dengan kejadian infeksi pada bayi baru lahir.

- c. **Analisis Regresi** Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam kebidanan, analisis regresi sering digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan ibu atau bayi. Sebagai contoh, regresi logistik dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian komplikasi kehamilan berdasarkan beberapa faktor risiko, seperti usia, status gizi, atau riwayat penyakit sebelumnya. Dalam penelitian eksperimen atau intervensi, regresi juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas intervensi kebidanan, misalnya menilai pengaruh pemberian suplemen gizi terhadap peningkatan berat badan ibu hamil.

2. Analisis Data Kualitatif

Berbeda dengan analisis kuantitatif yang berfokus pada data numerik, analisis data kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman, pandangan, dan perasaan individu atau kelompok. Penelitian kualitatif dalam kebidanan seringkali digunakan untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, atau sikap ibu hamil, keluarga, atau tenaga kesehatan terhadap pelayanan kebidanan atau topik tertentu. Data kualitatif bersifat deskriptif dan berfokus pada makna di balik fenomena yang diamati, bukan sekadar angka atau frekuensi kejadian.

Beberapa teknik analisis data kualitatif yang sering digunakan dalam kebidanan adalah sebagai berikut:

a. Analisis Tematik

Analisis tematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif. Dalam analisis tematik, peneliti membaca dan meninjau transkrip wawancara atau catatan observasi untuk mencari tema-tema yang muncul dari pengalaman atau persepsi responden. Tema-tema ini kemudian diorganisasi dan dikategorikan untuk mengidentifikasi pola yang lebih besar atau hubungan antar tema.

Contoh aplikasi analisis tematik dalam kebidanan adalah mengidentifikasi tema-tema utama dalam pengalaman ibu hamil terkait akses pelayanan antenatal, seperti tantangan yang dihadapi ibu hamil dalam mengikuti pemeriksaan rutin atau persepsi ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan antenatal untuk kesehatan mereka dan bayi.

b. Analisis Naratif

Analisis naratif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis cerita atau narasi yang diceritakan oleh responden. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggali bagaimana seseorang menyusun atau

memberikan makna terhadap pengalaman mereka. Dalam kebidanan, analisis naratif sering digunakan untuk mengeksplorasi cerita pribadi ibu hamil atau keluarga mengenai perjalanan kehamilan dan persalinan mereka, serta bagaimana cerita tersebut membentuk pandangan mereka terhadap perawatan kesehatan.

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengalaman persalinan, ibu dapat menceritakan kisah mereka tentang perasaan cemas atau bahagia saat menghadapi proses persalinan. Peneliti kemudian dapat mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam narasi tersebut yang mencerminkan makna atau nilai yang diberikan ibu terhadap pengalaman tersebut.

c. Grounded Theory

Grounded theory adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan teori atau konsep yang muncul dari data itu sendiri, tanpa hipotesis atau teori yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian kebidanan, pendekatan ini sering digunakan untuk mengembangkan teori yang lebih baik tentang pengalaman ibu hamil dalam konteks tertentu, misalnya bagaimana budaya dan norma sosial memengaruhi keputusan ibu hamil terkait tempat persalinan atau jenis asuhan yang diterima.

Grounded theory melibatkan pengumpulan data secara berulang (iteratif), dan data dianalisis secara paralel dengan pengumpulan data. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengembangkan pemahaman teoritis yang mendalam dan berbasis bukti dari fenomena yang diteliti.

3. Keandalan dan Validitas dalam Analisis Data

Keandalan (reliabilitas) dan validitas adalah dua hal yang sangat penting dalam analisis data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keandalan merujuk pada konsistensi hasil penelitian jika penelitian diulang dalam kondisi yang sama. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen pengumpulan data dan metode analisis benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Dalam penelitian kuantitatif, keandalan dapat diuji dengan menggunakan teknik seperti uji reliabilitas (misalnya, dengan menggunakan Alpha Cronbach untuk kuesioner), sedangkan validitas dapat diuji melalui uji validitas konstruk, validitas konten, atau validitas kriteria. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan keandalan sering kali dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi (menggunakan berbagai sumber atau metode untuk mengonfirmasi hasil), memberikannya kepada peserta untuk melakukan pengecekan kembali (*member checking*), atau menggunakan catatan lapangan yang sistematis.

E. Latihan Soal

Pilihan ganda

1. Desain penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena tanpa menguji hubungan sebab-akibat disebut:
 - A. Eksperimen
 - B. Analitik
 - C. Deskriptif
 - D. Longitudinal
 - E. Kohort
2. Teknik sampling yang memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih disebut:
 - A. Purposive sampling
 - B. Convenience sampling
 - C. Snowball sampling
 - D. Simple random sampling
 - E. Cluster sampling
3. Metode pengumpulan data yang paling tepat untuk mengeksplorasi pengalaman ibu hamil remaja adalah:
 - A. Survei kuesioner
 - B. Wawancara mendalam
 - C. Observasi pasif
 - D. Diskusi umum
 - E. Uji laboratorium
4. Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen dan dependen secara statistik adalah:
 - A. Analisis naratif
 - B. Statistik deskriptif
 - C. Uji chi-square
 - D. Regresi
 - E. Analisis tematik
5. Berikut ini adalah kelebihan dari desain studi kasus-kontrol, kecuali:
 - A. Cepat dan murah
 - B. Cocok untuk penyakit langka
 - C. Dapat membuktikan sebab-akibat secara langsung
 - D. Memungkinkan analisis beberapa faktor risiko
 - E. Efisien untuk studi retrospektif

Essay

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara desain penelitian deskriptif, analitik, dan eksperimen dalam konteks pelayanan kebidanan!
2. Mengapa pemilihan teknik sampling yang tepat penting dalam penelitian kebidanan? Berikan contoh aplikasinya!
3. Bandingkan antara purposive sampling dan snowball sampling dalam penelitian kualitatif kebidanan!
4. Uraikan jenis-jenis metode pengumpulan data kuantitatif dan sebutkan contoh penggunaannya dalam studi kebidanan!
5. Jelaskan mengapa validitas dan reliabilitas penting dalam proses analisis data, baik pada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif!

F. Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. B
4. D
5. C

G. Rangkuman Materi

Buku ajar *"Metode yang Umum Digunakan dalam Pelayanan Kebidanan: Desain, Sampel, Pengumpulan Data, dan Analisis"* disusun sebagai panduan praktis dan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi kebidanan dalam memahami dasar-dasar metodologi penelitian yang aplikatif. Dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan, pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) menjadi landasan penting dalam menjamin mutu dan keamanan layanan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap metode penelitian sangat diperlukan agar tenaga kebidanan mampu melakukan kajian ilmiah secara sistematis dan bermutu.

Buku ini menguraikan berbagai jenis desain penelitian yang sering digunakan dalam studi kebidanan, mulai dari desain deskriptif yang menggambarkan fenomena, desain analitik yang menilai hubungan antar variabel, hingga desain eksperimen yang menilai efektivitas intervensi. Di dalamnya juga dibahas teknik-teknik pengambilan sampel baik secara probabilitas maupun non-probabilitas, yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan karakteristik populasi yang diteliti.

Selain itu, metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dipaparkan dengan jelas, lengkap dengan contoh aplikasinya dalam konteks kebidanan. Tidak kalah penting, pembaca juga diajak memahami berbagai pendekatan analisis data,

baik secara statistik maupun naratif, sebagai dasar untuk menarik kesimpulan ilmiah yang valid dan reliabel.

H. Glosarium

1. Analisis Tematik: Teknik analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola atau tema dalam data naratif.
2. Cluster Sampling: Teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau klaster yang dipilih secara acak.
3. Convenience Sampling: Teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan responden.
4. Cross-Sectional Study (Studi Potong Lintang): Desain penelitian untuk melihat hubungan antar variabel pada satu titik waktu.
5. Desain Analitik: Jenis desain penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel atau faktor risiko.
6. Desain Deskriptif: Desain penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena tanpa menguji hubungan sebab-akibat.
7. Desain Eksperimen: Desain penelitian untuk mengevaluasi intervensi melalui perbandingan kelompok (misal: RCT).
8. Evidence-Based Practice: Pendekatan praktik pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah yang terpercaya.
9. Focus Group Discussion (FGD): Teknik pengumpulan data kualitatif melalui diskusi kelompok yang dipandu moderator.
10. Grounded Theory: Pendekatan analisis kualitatif untuk mengembangkan teori yang berasal dari data lapangan.
11. Kuesioner: Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data dari responden.
12. Purposive Sampling: Teknik pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai tujuan penelitian.
13. Randomized Controlled Trial (RCT): Desain eksperimen dengan pembagian kelompok secara acak untuk menilai efektivitas intervensi.
14. Sampling Probabilitas: Teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih.
15. Sampling Non-Probabilitas: Teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang sama kepada seluruh elemen populasi.
16. Simple Random Sampling: Teknik pengambilan sampel secara acak sederhana tanpa mempertimbangkan subkelompok.
17. Snowball Sampling: Teknik pengambilan sampel di mana responden pertama merekomendasikan responden lain.

18. Statistik Deskriptif: Teknik statistik untuk menyajikan dan meringkas data dalam bentuk angka, grafik, atau tabel.
19. Stratified Sampling: Teknik pengambilan sampel berdasarkan strata atau kelompok tertentu dalam populasi.
20. Uji Hipotesis: Prosedur statistik untuk menguji dugaan awal (hipotesis) tentang populasi.

I. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Nieswiadomy, R. M., & Bailey, C. (2018). *Foundations of nursing research* (7th ed.). Pearson.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Setia, M. S. (2016). Methodology series module 3: Cross-sectional studies. *Indian Journal of Dermatology*, 61(3), 261–264. <https://doi.org/10.4103/0019-5154.182410>

BAB 2

EVIDENCE BASED PRACTICE IN MIDWIFERY

Pendahuluan

Praktik kebidanan pada era pelayanan kesehatan modern saat ini telah mengalami berbagai transformasi secara signifikan, mulai dari pelayanan yang berbasis budaya/tradisi menuju pelayanan kesehatan yang berbasis bukti ilmiah. Praktik kebidanan berbasis bukti merupakan fondasi utama layanan kebidanan yang diberikan secara optimal kepada ibu dan anak.

Evidence based practice in midwifery perlu dipahami dengan baik oleh mahasiswa agar dapat memberikan layanan yang optimal berbasis bukti, karenanya mahasiswa perlu memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam memberikan asuhan kebidanan yang berbasis bukti, mampu mengimplementasi hasil *evidence based practice in midwifery* pada klien dengan baik, mampu memberikan keputusan klinis berdasarkan *evidence based* dan memberikan tindakan asuhan berdasarkan bukti ilmiah dengan mempertimbangkan prinsip etik dalam layanan kesehatan.

Bab ini mahasiswa akan mempelajari tentang konsep *evidence-based practice* (EBP) meliputi pengertian, manfaat, model, dampak, tantangan dan strategi dalam rangka peningkatan praktek berbasis bukti dan penelusuran serta *review literature*. Adapun tujuan dari penulisan bab ini adalah agar mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep EBP dalam pelayanan kebidanan. Sedangkan sasaran *audiens* yang membaca buku ini adalah mahasiswa sarjana terapan kebidanan atau mahasiswa sarjana kebidanan.

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep *Evidence Based Practice* dalam pelayanan kebidanan

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk :

- Menjelaskan pengertian Evidence Based Practice dalam kebidanan
- Mengidentifikasi tujuan dan manfaat Evidence Based Practice
- Menganalisis model-model Evidence Based Practice dalam kebidanan

- Mengidentifikasi dampak dan tantangan penerapan Evidence Based Practice
- Menerapkan strategi peningkatan praktik berbasis bukti
- Melakukan penelusuran dan review literatur

Capaian Pembelajaran

Kognitif:

- Mahasiswa mampu memahami konsep dasar EBP dalam kebidanan
- Mahasiswa mampu menganalisis berbagai model EBP
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan dalam penerapan EBP

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu melakukan penelusuran literatur ilmiah
- Mahasiswa mampu menerapkan EBP dalam praktik klinis kebidanan
- Mahasiswa mampu menggunakan berbagai sumber database untuk mencari *evidence*

Afektif:

- Mahasiswa memiliki kesadaran pentingnya praktik berbasis bukti
- Mahasiswa memiliki sikap kritis dalam menilai bukti ilmiah
- Mahasiswa memiliki komitmen untuk menerapkan EBP dalam praktik

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini meliputi pengertian, manfaat, model, dampak, tantangan dan strategi dalam rangka peningkatan praktek berbasis bukti dan penelusuran serta *review literature*.

A. Pengertian Evidence-Based Practice

Evidence Based Practice atau EBP merupakan pendekatan yang sistematis dalam melakukan praktek klinis yang mengintegrasikan bukti dari hasil penelitian untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. *Evidence based* berasal dari bahasa inggris yang berarti sebagai bukti, fakta (*evidence*) dan dasar (*base*), *evidence base* berarti praktik berdasarkan bukti. Sedangkan *Evidence Base Midwifery* merupakan asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sistematis (Nugrawati & Amriani, 2021)

Faktor kunci yang perlu diketahui dalam EBP adalah memastikan bahwa bidan dapat memiliki akses terhadap bukti terbaik yang tersedia saat ini, memiliki ketrampilan yang tepat untuk menilai bukti secara kritis dan dapat berhasil menerapkannya dalam praktek. Bidan perlu melaksanakan kebidanan berbasis bukti dalam melaksanakan praktek, Bidan perlu mengajukan pertanyaan yang dapat dijawab, mencari literatur secara efektif, menggunakan teori yang mendukung penelitian kita dan menilai bukti secara kritis. Hal ini memungkinkan bukti dapat diterapkan melalui kolaborasi dengan teman sejawat, kolega medis dan terpenting adalah pada ibu, bayi dan keluarga (Macdonald & Jhonson, 2024).

B. Tujuan Evidence-Based Practice

Tujuan utama *Evidence Based Practice* /EBP adalah untuk meningkatkan kesehatan klien dengan menerapkan rencana intervensi, implementasi dan metodologi yang telah diotentifikasi secara ilmiah. Pendekatan EBP telah mendapatkan pengakuan secara luas pada berbagai bidang, termasuk pada bidang kedokteran, kebidanan, keperawatan, dan psikologi serta bidang kesehatan masyarakat, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas perawatan.

EBP juga mempunyai tujuan yang beragam dalam pemberian asuhan kebidanan, berfokus pada hasil klinis yang meningkat, promosi keselamatan klien dan menumbuhkan budaya membaca serta adaptasi berlanjut pada penyedia layanan kebidanan. EBP yang diadopsi pada proses pembelajaran berkelanjutan dan dapat diadaptasikan dengan temuan baru sehingga dapat diintegrasikan dalam pemberian asuhan yang berbasis bukti pada ibu dan anak.

Tujuan dari pendekatan evidence-based practice adalah untuk memberikan perawatan yang tepat dengan cara yang efisien kepada pasien (WHO, 2017). Pemberian asuhan melalui pendekatan EBP akan membantu dalam pembuatan keputusan berdasarkan bukti klinis, dapat mengarah pada perawatan yang aman dan terbaik terutama pada bidang ginekologi dan kebidanan (Stimac, 2017). Intervensi yang berbasis bukti, seperti pemberian ASI selama imunisasi, telah terbukti dapat mengurangi rasa sakit pada bayi baru lahir, yang menunjukkan manfaat praktis EBP dalam perawatan klinis (Putri et al., 2022).

C. Manfaat Evidence Based Practice

Manfaat *Evidence Based Practice* dalam kebidanan adalah dapat menghasilkan kondisi ibu dan bayi yang lebih sehat, serta dapat meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dalam kebidanan (Fikre et al., 2023; Hassan, 2020). Selain itu, manfaat penerapan EBP pada layanan kebidanan menurut Dartiwen and Yati (2019) antara lain adalah:

1. Keamanan bagi tenaga Kesehatan karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah
2. Meningkatkan kompetensi (kognitif)
3. Memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai professional dalam memberikan asuhan yang bermutu
4. Memenuhi kepuasan pelanggan, klien mengharapkan asuhan yang tepat. Asuhan diberikan asuhan yang sesuai dengan bukti dan teori serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Praktik berbasis bukti yang berkaitan dengan persalinan seperti penggunaan oksitosin profilaksis dan peregangan tali pusat terkendali pada persalinan kala III terbukti mempunyai manfaat dalam mengurangi perdarahan setelah bersalin dan meningkatkan kesehatan ibu (Masuda et al., 2020). Penggunaan pemberian antibiotik profilaksis dan tehnik bedag yang spesifik pada operasi sesaria telah terbukti dapat mengurangi morbiditas ibu dan dapat meningkatkan waktu pemulihan (Dahlike et al., 2016; Morrish & Hoskins, 2018).

EBP juga memastikan tentang perawatan yang diberikan pada klien sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari sebuah pemberian asuhan (Hassan, 2020). Pedoman yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) tentang daftar pemeriksaan persalinan aman, terbukti telah meningkatkan kualitas asuhan yang mengakibatkan rendahnya kematian pada perinatal yang disebabkan oleh tingginya kepatuhan terhadap praktik terbaik (Semrau et al., 2020).

Manfaat dari EBP juga dapat membantu untuk identifikasi dan pengurangan penggunaan praktik asuhan yang berbahaya, seperti penggunaan rutin episiotomy dan tekanan pada fundus. Praktik rutin tersebut dapat menyebabkan terjadinya peningkatan cedera pada spinter anal obstetrik dan beberapa komplikasi lain (Masuda et al., 2020). Selain itu, penerapan praktik berbasis bukti dapat mengurangi intervensi yang tidak dibutuhkan, seperti amniotomy dan posisi lithotomi selama bersalin. Hal ini menyebabkan ibu mengalami persalinan yang tidak menyenangkan dan berdampak negative pada persalinan ibu (Côrtes et al., 2018). Kehadiran pendamping persalinan dan memilih posisi melahirkan dan memilih posisi melahirkan yang nyaman bagi ibu dan didorong dengan pelaksanaan EBP telah terbukti telah meningkatkan pengalaman yang menyenangkan dalam hal posisi Wanita saat bersalin. (Côrtes et al., 2018)

Pelaksanaan keselarasan antara praktik klinik dan bukti terbaik yang telah dilakukan dapat meningkatkan pemberdayaan pasien dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan memastikan pilihan serta nilai mereka perlu dipertimbangkan. Pendekatan yang terpusat pada pasien dapat menyebabkan kepuasan yang lebih tinggi dan pengalaman yang baik saat terjadi persalinan (Ford, 2019).

WHO (2017) menyebutkan bahwa terdapat 4 aspek dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti, yaitu:

1. Integrasi *evidence-based* yang tersedia dihasilkan oleh penelitian yang berkualitas;
2. Terdapat bukti klinis dan keahlian;
3. Nilai dan preferensi dari pasien; dan
4. Pengetahuan kontekstual yang relevan, mencakup sumber daya yang tersedia dan mengakui adanya potensi

Selain itu WHO (2017) menyebutkan bahwa manfaat EBP adalah termasuk manfaat bagi masyarakat umum, perawat dan bidan, sistem pelayanan kesehatan, serta penelitian dan pendidikan. Manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Manfaat EBP menurut WHO (2017)

No	Penerima Manfaat	Manfaatnya
1	Masyarakat Umum	a. Dapat meningkatkan perawatan yang berpusat pada pasien b. Meningkatkan preferensi pasien termasuk dalam pengambilan keputusan c. Meningkatkan kesetaraan yang lebih baik dalam layanan kesehatan yang konsisten d. Mengurangi variasi geografis e. Pengurangan lama rawat inap pasien

		f. Meningkatkan hasil yang lebih baik bagi pasien g. Meningkatkan Layanan perawatan kesehatan yang berkualitas h. Meningkatkan keselamatan pasien/<i>patient safety</i>
2	Perawat dan Bidan	a. Meningkatkan kepuasan kerja b. Meningkatkan pemberdayaan c. Meningkatkan keterampilan dalam mengintegrasikan preferensi pasien pada pelaksanaan praktik d. Terdapatnya dukungan untuk pertumbuhan profesional e. Pengembangan karier yang berkelanjutan melalui peran sebagai tenaga ahli
3	Sistem pelayanan kesehatan	a. Peningkatan kualitas perawatan b. Hasil yang lebih baik bagi pasien c. Peningkatan keselamatan pasien d. Pengurangan biaya e. Dasar yang lebih kuat untuk keputusan investasi layanan kesehatan f. Pengembangan kapasitas melalui kolaborasi
4	Penelitian dan Pendidikan	a. Meningkatnya kebutuhan akan luaran penelitian dan meyaraskan bukti yang kuat b. Pengembangan kompetensi c. Integrasi peran ahli keperawatan dan kebidanan dalam sistem kesehatan

D. Model Evidence-Based Practice

Pengembangan model pengambilan keputusan berbasis bukti dalam perawatan kebidanan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Model yang berbasis bukti dapat diperoleh melalui penelitian klinis, penelitian terkait topik kebidanan, dan preferensi pasien, hal ini untuk memastikan perawatan yang dipersonalisasi dan efektif. Model *Evidence Based Practice* mempunyai tujuan untuk menjembatani adanya kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis dalam kebidanan, mempromosikan pengambilan keputusan bersama dan otonomi pasien.

Terdapat beberapa model dalam menerapkan *evidence-based practice*, diantaranya adalah model kolaboratif *hibryd*, integrasi hasil penelusuran *evidence*, penggunaan tools untuk pembuatan keputusan dan Unit Perawatan yang Dipimpin oleh bidan/ *Midwifery-Led Care Units* (MLUs). Model kolaboratif *hybrid* dalam melakukan perawatan Kesehatan dilakukan melalui integrasi oleh pemangku

kepentingan, termasuk penyedia layanan kesehatan dan klien dalam rangka meningkatkan efektifitas layanan kesehatan. Model kolaboratif *hybrid* menekankan pentingnya perawatan yang berpusat pada pasien, dengan melibatkan pasien dalam mengambil keputusan dan pertimbangan yang diberikan oleh pasien. Pendekatan ini akan meningkatkan rasa aman dan kepuasan pasien (Ekpenyong et al., 2020).

Model yang menekankan pendekatan menggunakan model sokrates dapat mendorong pengambilan keputusan bersama antara bidan dan pasien, sehingga kedua belah pihak saling berkontribusi saat mengambil keputusan. Model ini memastikan bahwa otonomi yang ada pada diri pasien dapat dihormati bersamaan dengan pemanfaatan keahlian bidan (Gunby & Lockhart, 2022). Model yang mengintegrasikan semua sumber dari penelitian klinis, berdasarkan keahlian bidan dan pilihan pasien merupakan model yang memastikan bahwa sebuah keputusan diambil berdasarkan keputusan yang menyeluruh dan mempunyai relevansi yang sesuai (Ménage, 2016).

Model COM-B dan *theoretical domain framework/* TDF merupakan salah satu alat dan kerangka kerja pengambilan keputusan yang digunakan oleh bidan. Alat tersebut digunakan untuk membantu bidan dalam melakukan penilaian kemampuan, motivasi dan peluang dalam penerapan praktik yang berbasis bukti (Leo et al., 2021).

Midwifery- Led Care Units (MLCUs) merupakan sebuah model yang berfungsi sebagai aplikasi praktis yang membahas tentang bidan yang memimpin perawatan pada ibu bersalin, terutama pada ibu dengan kehamilan yang mempunyai risiko rendah. Model ini terbukti dalam meningkatkan Kesehatan ibu dan anak dengan perawatan yang mempunyai biaya yang rendah dan memuaskan (Edmonds et al., 2020; Podder et al., 2023).

E. Dampak Evidence-Based Practice

Evidence Based Practice dalam layanan kebidanan kehamilan dikaitkan dengan hasil kehamilan yang lebih baik/positif. Kelahiran prematur, perdarahan *postpartum*, dan operasi seksio sesarea yang dilakukan secara darurat menjadi berkurang kejadiannya dengan diberikannya asuhan kebidanan berbasis bukti pada ibu. Perawatan yang diberikan berdasarkan bukti ilmiah yang dilakukan secara komprehensif selama kehamilan hingga masa nifas. Hal ini juga meningkatkan persalinan normal dan perawatan BBL di unit intensif menjadi lebih sedikit (Fikre et al., 2023).

Perawatan kebidanan yang menerapkan EBP dalam pemberian asuhan kebidanan dapat meningkatkan kepuasan dan keselamatan bagi klien. EBP dapat

memastikan bahwa asuhan persalinan yang menerapkan perawatan berbasis bukti dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi (Blomgren et al., 2024; Taye et al., 2024).

F. Tantangan dalam menerapkan *Evidence-Based Practice*

Penerapan *Evidence Based Practice* oleh bidan mengalami berbagai tantangan dalam pemberian asuhan kebidanan. Penerapan EBP dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman bidan dalam pemberian asuhan kebidanan. Bidan dengan tingkat pendidikan tinggi dan baru lulus dari pendidikan mempunyai pengetahuan yang lebih baik terkait *Evidence Based Practice* (Lanssens et al., 2022). Tantangan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi EBP antara lain adalah rendahnya dukungan kelembagaan dan kurangnya waktu untuk mengakses informasi. Hambatan tersebut menyebabkan bidan tidak dapat mengintegrasikan asuhan berbasis bukti dalam pemberian asuhan sehari-hari (Dagne et al., 2021).

Menurut Gebresilassie et al. (2022) bahwa keterlibatan bidan dalam melaksanakan penelitian sangat terbatas, hal ini akan mempengaruhi bidan dalam menerapkan berbagai intervensi dalam asuhan kebidanan berbasis bukti. Hambatan tersebut juga sering menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pedoman yang berbasis bukti dan praktek klinis terkini (Amalia et al., 2020; Dagne et al., 2021).

Bidan banyak yang belum terlatih dalam melakukan metodologi penelitian, hal ini akan menghambat bidan dalam menerapkan praktik berbasis bukti dapat dilakukan secara efektif (Dagne et al., 2021; Gebresilassie et al., 2022). Kesulitan tenaga kesehatan tersebut dalam mengakses artikel penelitian yang mempunyai teks lengkap, dan kebutuhan untuk pelatihan metodologi penelitian yang dapat menghambat penerapannya (Tlili et al., 2022). Sangat penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi agar keberhasilan integrasi EBP dapat diintegrasikan dalam praktis klinis dan pendidikan.

Tantangan lain yang dapat terjadi dalam EBP adalah terjadinya resistensi dari perubahan, sumberdaya yang kurang dan persepsi terhadap *evidence based*. Terdapat pula kesenjangan antara bukti dan pelaksanaan praktik dilapangan, pengetahuan empirik lebih diutamakan dibandingkan dengan bukti ilmiah yang ada (Ford, 2019; Masuda et al., 2020). Pentingnya untuk memastikan bahwa praktik kebidanan yang diberikan dapat berjalan aman dan efektif yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi yang baru dilahirkan.

G. Strategi dalam rangka peningkatan praktek berbasis bukti

Praktek yang berbasis bukti dalam penerapannya pasti menghadapi berbagai tantangan. Dibutuhkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan tersebut, diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan dan keberlanjutan pendidikan.

Kegiatan pelatihan yang diberikan pada bidan terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik bidan mengenai EBP, khususnya pada manajemen persalinan (Fahajan et al., 2023).

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengetahuan terkait EBP adalah dengan melakukan peningkatan pengembangan profesional berkelanjutan dan berpartisipasi dalam seminar dan konferensi yang berkaitan dengan implementasi EBP yang lebih baik.(Taye et al., 2024). Penerapan EBP juga dapat menghemat biaya, seperti halnya yang ditunjukkan oleh kerangka kerja bidan di Kenya, praktik berbasis bukti seperti bebas memilih posisi melahirkan dan kontak kulit ke kulit pada bayi baru lahir dapat dicapai dengan penggunaan biaya yang wajar (Kiragu et al., 2023).

Evidence Based Practice dalam kebidanan membutuhkan integrasi dari hasil penelitian sehingga dapat memberikan perawatan yang berkualitas tinggi pada ibu dan anak. EBP dalam layanan kebidanan sangat penting diterapkan agar ibu dan anak mendapatkan perawatan yang optimal pada masa hamil, bersalin dan periode nifas. Bidan harus terampil dalam menerapkan dan menafsirkan bukti penelitian saat melakukan pemberian asuhan pada ibu dan anak serta memastikan bahwa intervensi yang diberikan efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien (Hassan, 2020; Setswe & Zungu, 2022). Bidan perlu diinformasikan tentang tata cara untuk mengakses informasi dan menggunakan berbagai sumber daya serta mendorong bidan agar dapat berpartisipasi secara aktif untuk melakukan inisiatif dalam proses pengambilan keputusan untuk menerapkan EBP(Ladopoulou et al., 2020).

Selain hal itu, menumbuhkan budaya untuk menghargai penelitian dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti sangat penting dalam mengatasi tantangan yang terjadi. Dapat juga dipastikan bahwa perawatan yang diberikan merupakan inovasi *terupdate* dalam perawatan kebidanan (Avery & Hunter, 2022; Ladopoulou et al., 2020).

H. Penelusuran dan *review literature*

Terdapat 2 jenis kategori sumber literatur yang dapat dikaji dalam melakukan penelusuran dan review literatur, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah teori/temuan yang ditulis oleh seseorang/beberapa orang yang terlibat pada suatu penelitian, sedangkan sumber sekunder merupakan teori atau penelitian yang dirujuk oleh seorang penulis. Sumber sekunder memiliki kelemahan yaitu terkadang akses terhadap sumber aslinya tidak dapat diakses karena penulis menyaring hasil bacaan dari sumber referensi tersebut sehingga dapat menimbulkan sikap dan bias tersendiri oleh penulis. Contoh sumber sekunder adalah buku teks, artikel majalah, ensiklopedia, dan situs internet yang bertujuan untuk menyebarkan informasi kesehatan masyarakat (Richardson-Tench et al., 2018).

Penelusuran sumber literatur merupakan sebuah langkah yang penting dalam melakukan penelitian yang lengkap dan efektif. Proses tersebut dapat melibatkan penggunaan berbagai alat dan strategi dalam menemukan makalah akademik yang relevan, buku, dan materi ilmiah lainnya. Penelusuran literatur dapat menggunakan berbagai kombinasi, seperti metode tradisional dan modern dalam memastikan literatur tersebut sudah sesuai pada bidang tertentu secara komprehensif atau tidak. Adapun sumber literatur pada umumnya menurut Richardson-Tench et al. (2018), antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jurnal

Jurnal merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi para peneliti. Jurnal-jurnal tersebut memiliki cakupan yang bervariasi untuk berbagai pembaca. Jurnal dapat bersifat elektronik atau non elektronik dan bersifat internasional dan nasional.

Google Scholar merupakan sebuah alat *search engine* yang ampuh untuk menemukan sejumlah besar kutipan, bahkan dalam bidang tertentu (Lehnen & Insua, 2022). Selain itu terdapat beberapa platform lainnya yang dapat digunakan sebagai alat penelusuran literatur, seperti *Pubmed*, *Elsevier*, *Ebsco CINAHL*, *Cochrane Library* dan lain sebagainya. Pencarian jurnal secara internasional dapat menggunakan *search engine* yang diatas, namun untuk jurnal nasional dapat dicari *sinta* dan *arjuna* yang disiapkan oleh Kemenristekdikti.

Beberapa aplikasi *artificial Intelegant* (AI) juga dapat digunakan untuk mencari sumber literatur berupa jurnal, yaitu *Spicspace*, *Scite AI*, *Semantic Scholar*, dan lain lain. Disarankan menggunakan berbagai alat *search engine* untuk menangkap berbagai sumber kutipan dalam sebuah karya ilmiah.

2. Buku

Buku merupakan sumber informasi tradisional dan dapat diandalkan,, buku menjadi sangat berharga pada bidang sejarah dan hukum, terdapat narasi dan analisis yang terperinci yang tidak selalu tersedia dalam artikel jurnal (Siqueira, 2018). Selain itu, buku juga berfungsi sebagai sumber sekunder yang mensintesa hasil temuan penelitian primer, membuatnya dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. (Евдокименкова & Соболева, 2021).

3. Prosiding konferensi

Prosiding konferensi berfungsi sebagai sumber literatur yang signifikan dalam berbagai disiplin ilmu akademis, menawarkan platform untuk penyebaran temuan penelitian awal dan mendorong komunikasi ilmiah. Basis data kutipan utama seperti *Web of Science*, *Scopus*, dan *Dimensions* semakin mengindeks prosiding konferensi, membuatnya lebih mudah diakses dan diakui dalam evaluasi akademis. Prosiding konferensi merupakan cara cepat peneliti dalam

menyebarkan penelitian mereka, hal ini yang akan menguntungkan peneliti karena karyanya selain cepat tersebar juga sebaran informasi akan meluas jangkauannya (Purnell, 2021).

4. Laporan

Laporan dari pemerintah dan lembaga lain merupakan sumber informasi yang berguna sebagai dasar mencari literatur. Seperti laporan kematian Ibu dan Anak yang dapat diperoleh melalui laporan profil Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Kementerian Kesehatan RI. Demikian juga Badan Pusat Statistik juga menggambarkan berbagai informasi terkait kependudukan yang dibutuhkan informasinya demi sebuah kegiatan penelitian.

5. Tesis

Pencarian literatur mencakup pencarian tesis yang relevan dapat digunakan sebagai bahan referensi *evidence-based*, meskipun penulisan tesis tidak diharuskan menyertakan jenis literatur ini sebagai referensi. Perpustakaan setiap universitas selalu menyimpan salinan cetak tesis mahasiswa yang belajar di sana. Pencarian Google dapat menunjukkan tempat tesis di bagian repository perpustakaan.

6. Literatur abu-abu

Google dan *google scholar* menghasilkan penemuan penelusuran sumber literatur abu-abu. Selain itu laporan pemerintah dan publikasi non-akademik lainnya sangat penting untuk memberikan sebuah pandangan yang komprehensif tentang sebuah bukti yang didapatkan. Strategi baru untuk mencari sumber literatur yang tidak diterbitkan dapat secara signifikan meningkatkan hasil dari sumber yang relevan (Enticott et al., 2018). Literatur yang tidak diterbitkan juga penting dicari untuk mengurangi bias publikasi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan hasil tinjauan secara sistematis (Atkinson & Cipriani, 2018).

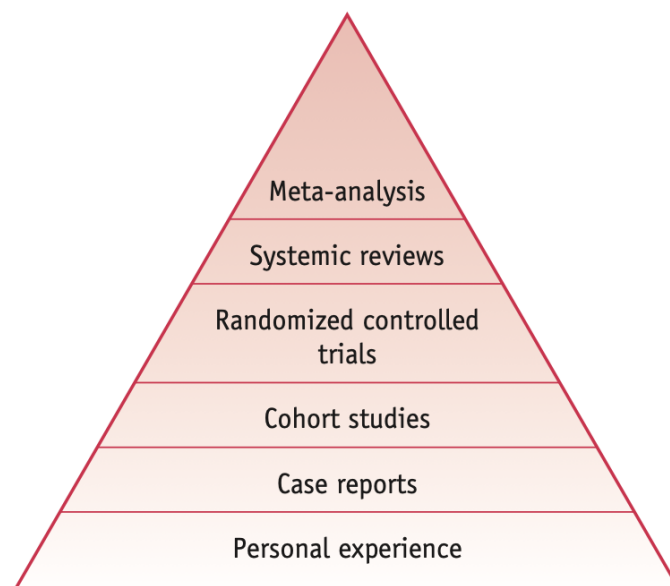
Tingkatan *evidence* mengacu pada klasifikasi hierarkis bukti yang digunakan dalam praktik berbasis bukti (EBP). Hirarki tersebut dirancang untuk menilai kualitas dan keandalan dari *evidence*, serta dapat memberikan petunjuk bagi para praktisi dalam membuat keputusan berdasarkan informasi. Tingkatan *evidence* biasanya dimulai dari kualitas tinggi ke kualitas yang rendah, dengan tinjauan sistematis dan meta-analisis pada bagian atas dan pendapat ahli di bagian bawah. Sistem klasifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan klinis didasarkan pada bukti terbaik yang tersedia, meminimalkan bias dan meningkatkan *outcome* pasien.

Hirarki *evidence* merupakan sebuah sistem terstruktur yang memberi peringkat berdasarkan metodologi dan adanya potensi bias. Literatur review

dan meta analisis menggunakan uji *Randomized Control Trial* merupakan *evidence* dengan level tinggi, sedangkan pendapat ahli dan laporan kasus pada level yang terendah (Middleton & Price, 2017; Rutka, 2017). Praktisi didorong untuk membuat keputusan berdasarkan *evidence-based practice*. Tingkat *evidence-based practice* yang perlu diikuti adalah dimulai dari level I berdasarkan literatur dan expert opinion dan mengukur hasil penelitian berdasarkan bukti pada level 2 (Hamilton, 2020)

Namun masih terdapat tantangan dalam melakukan penerapan *evidence-based* ini. Rendahnya tingkat *evidence-based* level 1 yang tertuang pada pedoman klinis mencerminkan rekomendasi yang terlalu inklusif atau kurangnya RCT untuk kondisi tertentu (Scott, 2020). Klasifikasi *evidence* tersebut tidak dianggap mutlak dan kualitas *evidence* dapat bervariasi dalam setiap level (Rosen & Tsesis, 2016).

Adapun tingkatan *evidence based* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1: Tingkatan *evidence based* (Macdonald & Jhonson, 2024)

I. Tugas Mahasiswa

1. Individu: Identifikasi *evidence based practice* dalam 3 artikel, dan buatlah rangkumannya dengan baik
2. Kelompok:
 - a. Menyusun strategi implementasi EBP di tatanan klinik
 - b. Menganalisis tantangan dan solusi penerapan EBP di Indonesia

J. Latihan Soal

Pilihan Berganda

1. Seorang bidan di Puskesmas sedang menangani kasus persalinan kala III. Ia menemukan beberapa artikel penelitian tentang manajemen aktif kala III dengan hasil yang berbeda-beda.
Langkah pertama apakah yang harus dilakukan bidan dalam rangka menerapkan *evidence based practice* dalam kebidanan?
A. Konsultasi dengan dokter spesialis kandungan
B. Mengikuti saja protokol yang sudah ada di Puskesmas
C. Mendiskusikan dengan pasien metode mana yang ingin dipilih
D. Langsung menerapkan metode terbaru yang ditemukan dalam artikel
E. Menilai kualitas dan *level evidence* dari setiap artikel yang ditemukan
2. Di sebuah rumah sakit, terdapat program implementasi EBP untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Beberapa bidan menolak perubahan dengan alasan sudah nyaman dengan cara lama.
Berdasarkan konsep EBP, strategi apakah yang terbaik dilakukan oleh Rumah Sakit untuk mengatasi resistensi tersebut?
A. Menunggu sampai semua bidan setuju untuk menerapkan EBP
B. Membuat kebijakan wajib menerapkan EBP tanpa pengecualian
C. Memberikan sanksi bagi bidan yang tidak mau menerapkan EBP
D. Membiarkan bidan memilih apakah mau menerapkan EBP atau tidak
E. Mengadakan pelatihan dan workshop disertai pendampingan berkelanjutan
3. Seorang mahasiswa kebidanan menemukan artikel *systematic review* tentang penanganan preeklampsia. Dalam artikel tersebut terdapat rekomendasi yang berbeda dengan yang diajarkan di kampus.
Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan oleh mahasiswa tersebut ?
A. Menerapkan rekomendasi dari *systematic review* saat praktik klinik
B. Mencari artikel *systematic review* lain yang sesuai dengan yang diajarkan
C. Mengabaikan artikel tersebut karena berbeda dengan yang diajarkan dosen
D. Mempercayai *systematic review* karena merupakan level tertinggi dalam hierarki *evidence*
E. Menganalisis metodologi dan kualitas *systematic review* serta mendiskusikannya dengan dosen
4. Bidan Ani bekerja di praktik mandiri bidan dan ingin melakukan penelusuran literatur untuk mencari *evidence* terbaru tentang penanganan perdarahan *postpartum*.

Sumber apakah yang paling tepat dibawah ini untuk penelusuran literatur tersebut?

- A. Artikel populer di website kesehatan
 - B. Pengalaman senior di tempat praktik
 - C. Media sosial dan grup WhatsApp bidan
 - D. Buku teks kebidanan terbitan 5 tahun terakhir
 - E. Database jurnal ilmiah seperti PubMed, CINAHL, dan Cochrane Library
5. Dalam sebuah rapat evaluasi layanan kebidanan, ditemukan berbagai variasi dalam praktik perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Beberapa bidan menggunakan alkohol 70%, ada yang menggunakan *povidone iodine*, dan ada yang membiarkan kering alami.
- Langkah terbaik apakah yang bisa dilakukan oleh bidan untuk menyelesaikan variasi praktik tersebut?
- A. Menggunakan metode yang paling banyak dipakai oleh bidan
 - B. Mewajibkan semua bidan menggunakan metode yang paling murah
 - C. Membiarkan masing-masing bidan menggunakan metode yang dikuasai
 - D. Mengikuti saran dari kepala ruangan tanpa mempertimbangkan *evidence*
 - E. Melakukan *review literature* sistematis dan membuat protokol berbasis bukti

Latihan Essay

1. Apakah yang dimaksud dengan *Evidence-based practice* dalam kebidanan?
2. Apasajakah tantangan yang terjadi dalam mengadopsi *Evidence-based practice* dalam kebidanan
3. Sebutkan manfaat dari *Evidence-based practice* dalam kebidanan?
4. Bagaimana cara mencari sumber literatur yang *ter-update*?
5. Jelaskan tentang hirarki tingkatan *evidence-based practice* !

Kunci Jawaban:

1. E

Penjelasannya: Dalam menerapkan EBP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai kualitas dan level *evidence* dari setiap artikel yang ditemukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang akan diterapkan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Pilihan A Belum diperlukan pada tahap ini, B mengabaikan *evidence* baru, C belum tepat karena belum ada bukti assessment dan D belum diperlukan pada tahap ini. terlalu terburu-buru,

2. E

Penjelasan: Pelatihan dan workshop disertai pendampingan berkelanjutan merupakan strategi terbaik untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan. Pendekatan ini memberikan pemahaman, keterampilan, dan dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan EBP. Pilihan B dan C terlalu memaksa, A dan D terlalu pasif dan tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

3. E

Penjelasan: Tindakan yang paling tepat adalah menganalisis metodologi dan kualitas systematic review serta mendiskusikannya dengan dosen. Hal ini sesuai dengan prinsip EBP yang menekankan pada penilaian kritis terhadap bukti dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Pilihan A mengabaikan konteks lokal, dan B terlalu terburu-buru tanpa analisis mendalam, sementara pilihan C dan D menunjukkan adanya bias konfirmasi

4. E

Penjelasan: Database jurnal ilmiah seperti PubMed, CINAHL, dan Cochrane Library merupakan sumber yang paling tepat untuk penelusuran literature dalam EBP karena menyediakan artikel *peer-reviewed* dan *up-to-date*. Pilihan lain kurang *reliable* sebagai sumber utama *evidence*, meskipun bisa digunakan sebagai informasi tambahan.

5. E

Penjelasan: Melakukan *review literature* yang sistematis dan membuat protokol berbasis bukti merupakan langkah terbaik untuk menyelesaikan beragam praktik. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Pilihan lain tidak mencerminkan prinsip EBP dan dapat mengkompromikan kualitas pelayanan.

K. Rangkuman Materi

Evidence Based Practice (EBP) merupakan komponen penting dalam pelayanan kebidanan modern yang mengintegrasikan bukti penelitian terbaik sesuai dengan keahlian klinis dan preferensi pasien. Penerapan EBP dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan outcomes kesehatan ibu dan bayi. Meski menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, strategi seperti pendidikan berkelanjutan dan dukungan institusi dapat membantu meningkatkan penerapan EBP. Bidan perlu mengembangkan keterampilan dalam mencari, menilai, dan menerapkan bukti ilmiah serta berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan pelayanan terbaik yang berbasis bukti.

Evidence-Based Practice (EBP) dalam kebidanan merupakan sebuah pendekatan sistematis yang mengintegrasikan bukti ilmiah, keahlian klinis, dan preferensi pasien dalam rangka peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada ibu

dan anak. Penerapan EBP ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien, mengoptimalkan keputusan klinis, dan memastikan bahwa asuhan kebidanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Mahasiswa kebidanan perlu memahami konsep, manfaat, model, tantangan, dan strategi penerapan EBP agar dapat mengimplementasikan praktik berbasis bukti dengan baik.

Manfaat utama EBP dalam kebidanan mencakup adanya peningkatan *outcome* terhadap kesehatan ibu dan bayi, peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan, serta adanya efisiensi dalam pemberian asuhan kebidanan. Selain itu, EBP membantu mengurangi penggunaan praktik yang tidak efektif atau berbahaya serta memastikan perawatan yang lebih aman dan berkualitas. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses terhadap sumber bukti, kurangnya pelatihan, serta resistensi terhadap perubahan praktik tradisional.

Strategi untuk meningkatkan implementasi EBP dalam kebidanan meliputi pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, peningkatan akses terhadap jurnal dan database ilmiah, serta dukungan institusional bagi tenaga kesehatan dalam menerapkan praktik berbasis bukti. Bidan perlu memiliki keterampilan dalam mencari, menilai, dan menerapkan bukti ilmiah dalam praktik sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu dan bayi.

L. Glosarium

EBP	: <i>Evidence-based practice</i> /praktik berbasis bukti
CINAHL	: adalah sebuah basis data berisikan literatur dan penelitian dibidang keperawatan dan kesehatan. CINAHL adalah singkatan dari <i>Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature</i> .
Google	: merupakan salah satu perusahaan mesin pencarian secara online yang menggunakan teknologi terbesar di dunia, didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998.
Google Scholar	: merupakan mesin untuk mencari publikasi ilmiah yang telah dikembangkan oleh Google. Google Scholar membantu para pengguna dalam menemukan, mengakses, dan mengelola literatur ilmiah.
Model COM-B	: adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk memahami dan mengubah perilaku. Model ini melakukan identifikasi terhadap tiga

faktor utama yang dapat memengaruhi perilaku, yaitu kemampuan, peluang, dan motivasi.

Pubmed : basis data gratis yang berisi kutipan dan abstrak literatur biomedis dan ilmu hayati. *PubMed* dikembangkan dan dikelola oleh *National Center for Biotechnology Information* (NCBI).

M. Referensi

- Amalia, R., Hakimi, M., & Fitriani, H. (2020). Evidence-based implementation of normal childbirth: what are the obstacles?(qualitative study). *Journal of Health Technology Assessment in Midwifery*, 3(3), 115-126.
- Atkinson, L. Z., & Cipriani, A. (2018). How to carry out a literature search for a systematic review: a practical guide. *BJPsych Advances*, 24(2), 74-82. <https://doi.org/doi:10.1192/bja.2017.3>
- Avery, M. D., & Hunter, L. A. (2022). Innovation in Midwifery Practice and care. *Journal of Midwifery & Women's Health*. <https://doi.org/doi:10.1111/jmwh.13450>
- Blomgren, J., Lindgren, H., Amongin, D., Erlandsson, K., Lundberg, C., Kanyunyuzi, A. E., Muwanguzi, S., Babyrie, V. M., Ogwang, K., Aineomugasho, D., Catherine, N., & Wells, M. B. (2024). Midwife-Led Quality Improvement: Increasing the Use of Evidence-Based Birth Practices in Uganda. *Midwifery*, 139, 104188-104188.
- Córtés, C. T., de Oliveira, S. M. J. V., dos Santos, R. C. S., Francisco, A. A., Riesco, M. L. G., & Shimoda, G. T. (2018). Implementation of evidence-based practices in normal delivery care. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 26(e2988), 1-11. <https://doi.org/DOI: 10.1590/1518-8345.2177.2988>
- Dagne, A. H., Beshah, M. H., Kassa, B. G., & Dagnaw, E. H. (2021). Implementation of evidence-based practice and associated factors among nurses and midwives working in Amhara Region government hospitals: a cross-sectional study. *BMC Reprod health*, 18(36), 1-10.
- Dahlike, J. D., Mendez-Figueroa, H., Sperling, J. D., Maggio, L., Connealy, B. D., & Chauhan, S. P. C. (2016). Evidence-Based Cesarean Delivery for the Nonobstetrician. *The Surgery Journal*, 2(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1570316>.
- Dartiwen, & Yati, N. (2019). *Asuhan Kebidanan pada Kehamilan*. Penerbit Andi.

- Edmonds, J. K., Ivanof, J., & Kafulafula, U. (2020). Midwife Led Units: Transforming Maternity Care Globally. *Annals of Global Health*, 86(1). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5334/aogh.2794>
- Ekpenyong, M. E., Udoh, S., Edoho, M. E., Udo, I. J., Udo, E., Fakiyesi, T., & Oyong, S. B. (2020). Hybrid Collaborative Model for Evidence-Based Healthcare Practice. Proceedings of the 4th International Conference on Medical and Health Informatics.,
- Enticott, J., Buck, K., & Shawyer, F. (2018). Finding “hard to find” literature on hard to find groups: A novel technique to search grey literature on refugees and asylum seekers. *International Journal of Methods in Psychiatric Research (MPR)*, 27(e1580.), 1-7. <https://doi.org/DOI:10.1002/mpr.1580>
- Fahajan, Y., Abu Shnena, Y., Al-Kasseh, A., & Abu Haddaf, T. (2023). Effect of Training Program on Midwife’s Knowledge and Practice Regarding Evidence Based Practice for Active Management of Third Stage of Labor in Al Tahreer Maternity Hospital in Gaza strip, Palestine. *The Scholar Journal for Sciences & Technology*, 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.53348/nea3>
- Fikre, R., Gubbels, J., Teklesilasie, W., & Gerards, S. (2023). Effectiveness of midwifery-led care on pregnancy outcomes in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy Pregnancy and Childbirth*, 23(386), 1-10.
- Ford, A. (2019). Advocating for evidence in birth
- Proving cause, effecting outcomes, and making the case for ‘curers’. *Medicine Anthropology Theory*, 6(2), 25-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.17157/mat.6.2.674>
- Gebresilassie, K. Y., Baraki, A. G., Kassie, B. A., & Wami, S. D. (2022). Midwifery-led researches for evidence-based practice: Clinical midwives engagement in research in Ethiopia, 2021. *PLOS ONE*, 3, 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268697>
- Gunby, J., & Lockhart, J. A. (2022). Clinical reasoning as midwifery: A Socratic model for shared decision making in person-centred care. . *Nursing Philosophy*, e12390. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nup.12390>
- Hamilton, D. K. (2020). Evidence-Based Practice: Four Levels Revisited. *Health Environments Research & Design Journal*, 13(3), 26-29.
- Hassan, H. E. (2020). Evidence-Based Practice in Midwifery and Maternity Nursing for Excellent Quality of Care Outcomes. *American Journal of Nursing Research*, 8(6), 606-607. <https://doi.org/DOI:10.12691/ajnr-8-6-3>
- Kiragu, J. M., Friberg, I. O., Erlandsson, K., Wells, M. B., Wagoro, M. C. A., Blomgren, J., & Lindgren, H. (2023). Costs and intermediate outcomes for the implementation of evidence-based practices of midwifery under a MIDWIZE

framework in an urban health facility in Nairobi, Kenya. *Sexual & Reproductive Healthcare* 37, 100893-100893.

- Ladopoulos, A., Charos, D., Maniati, E., Plassara, I., Giaksi, P., & Vivilaki, V. G. (2020). A survey for the readiness of Greek midwives for the adoption of evidence-based practice (EBP). *European journal of midwifery*, 4(43), 1-9.
- Lanssens, D., Goemaes, R., Vrielinck, C., & Tency, I. (2022). Knowledge, attitudes and use of evidence-based practice among midwives in Belgium: A cross-sectional survey. *European journal of midwifery* 6(Juni), 1-9.
- Lehnen, C., & Insua, G. (2022). Search tools and scholarly citation practices in literary studies. *Reference Services Review*, 50(3/4), 406-418. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/rsr-07-2022-0025>
- Leo, A. D., Bayes, S., Bloxsome, D., & Butt, J. (2021). Exploring the usability of the COM-B model and Theoretical Domains Framework (TDF) to define the helpers of and hindrances to evidence-based practice in midwifery. *Implementation Science Communications* 2(7), 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s43058-020-00100-x>
- Macdonald, S., & Jhonson, G. (Eds.). (2024). *Mayes' Midwifery* (6 th ed.). Elsevier.
- Masuda, C., Ferolin, S. K., Masuda, K., Smith, C., & Matsui, M. (2020). Evidence-based intrapartum practice and its associated factors at a tertiary teaching hospital in the Philippines, a descriptive mixed-methods study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(78), 1-10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-020-2778-5>
- Ménage, D. (2016). Part 1: A model for evidence-based decision-making in midwifery care. *The British Journal of Midwifery*, 24(2), 137-143. <https://doi.org/https://doi.org/10.12968/BJOM.2016.24.2.137>
- Middleton, R., & Price, A. (2017). Levels of evidence in orthopaedics. *BMJ*, 2(6), 295-296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1136/JISAKOS-2017-000188>
- Morrish, D., & Hoskins, I. A. (2018). Improving Obstetrical Outcomes in Cesarean Sections, by Utilizing Evidence-Based Strategies. In (pp. 123-133). Intech Open. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.78667>
- Nugrawati, N., & Amriani. (2021). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*. Penerbit Adab.
- Podder, L., Bhardwaj, G., Siddiqui, A., Agrawal, R., Halder, A., & Rani, M. A. (2023). Utilizing Midwifery-Led Care Units (MLCU) for Enhanced Maternal and Newborn Health in India: An Evidence-Based Review. *Cureus*, 15(8), e43214. <https://doi.org/https://doi.org/10.7759/cureus.43214>

- Purnell, P. J. (2021). Conference proceedings publications in bibliographic databases: a case study of countries in Southeast Asia. *Scientometrics*, 126, 355–387. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11192-020-03773-2>
- Putri, V. A., Ulfah, K., & Purwaningsih, D. (2022). Evidence Based Case Report (EBCR): Pengaruh Menyusui selama Imunisasi terhadap Nyeri pada Neonatus Cukup Bulan. *Jurnal Kesehatan Siliwangi*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34011/jks.v3i1.1200>
- Richardson-Tench, M., Nicholson, P., Beverley, T., Stephen, K., & Roberts, K. (2018). *Research in Nursing, Midwifery and Allied Health: Evidence for Best practice* (6th Edition ed.). Cengage Learning Australias.
- Rosen, E., & Tsesis, I. (2016). Classifying scientific evidence as the basis for evidence-based decision making: is strength of evidence absolute? *Evidence-based Endodontics*, 1(1), 1-4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/S41121-016-0005-7>
- Rutka, J. T. (2017). Clases of evidence in neurosurgery. *Journal of Neurosurgery*, 126, 1747-1748.
- Scott, I. A. (2020). Filling the glass of evidence-based medicine. *Internal Medicine Journal*, 50, 15-16. <https://doi.org/doi:10.1111/imj.14697>
- Semrau, K. E., Miller, K. A., Lipsitz, S., Fisher-Bowman, J., Karlage, A., Neville, Bridget A , Krasne, M., Gass, J., Jurczak, A., Singh, V. P., Singh, S., Delaney, M. M., Hirschhorn, L. R., Kodkany, B., Kumar, V., & Gawande, A. A. (2020). Does adherence to evidence-based practices during childbirth prevent perinatal mortality? A post-hoc analysis of 3,274 births in Uttar Pradesh, India. *BMJ Global Health*, 5 (e002268). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2019-002268>
- Setswe, G., & Zungu, L. (2022). Embracing Implementation Science in Nursing and Midwifery to Translate Evidence-based Interventions into Policies and Clinical Practice. *Africa Journal of Nursing and Midwifery*, 24(2), 1-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.25159/2520-5293/12431>
- Siqueira, G. S. (2018). Observações sobre como o Direito ensina errado a História do Direito. *Passagens. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica*, 10(1), 93-103. <https://doi.org/DOI: 10.15175/1984-2503-201810105>
- Stimac, T. (2017). Evidence based medicine: gynecologist and obstetricians view. *medicina fluminensis*, 53(4), 489-494. https://doi.org/doi: 10.21860/medflum2017_187377
- Taye, E. B., Muche, H. A., Haile, T. T., Addis, B., Awoke, M. K., Bekele, M. M., Abadi, M. B., & Taye, Z. W. (2024). Implementation of evidence-based practice in clinical decision-making among midwives working in Central and South Gondar Zone public Hospitals, Ethiopia. *Clinical Epidemiology and Global Health*.

- Tlili, M. A., Aouicha, W., Tarchoune, S., Sahli, J., Dhiab, M. B., Chelbi, S., Mtiraoui, A., Ajm, T., Rejeb, M. B., & Mallouli, M. (2022). Predictors of evidence-based practice competency among Tunisian nursing students. *BMC Medical Education*, 22(421), 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12909-022-03487-4>
- WHO. (2017). *Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region*. WHO European Region.
- Евдокименкова, Ю. Б., & Соболева, Н. О. (2021). The evolution of secondary information sources in chemistry. *Научные и технические библиотеки*, 4, 125-140. <https://doi.org/DOI: 10.33186/1027-3689-2021-4-125-140>

BAB 3

APLIKASI BERBAGAI METODE PENELITIAN DALAM SETTING PRAKTIK PELAYANAN KEBIDANAN, PUBLIKASI DAN DISEMINASI HASIL PENELITIAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode penelitian secara efektif dalam praktik pelayanan kebidanan serta mampu mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil penelitian secara profesional.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi dan mengaplikasikan berbagai metode penelitian dalam konteks praktik kebidanan.
- Merancang penelitian yang relevan dan aplikatif dalam praktik kebidanan.
- Melakukan publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah, seminar, atau forum ilmiah lainnya.
- Mengelola diseminasi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas praktik pelayanan kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya penelitian berbasis bukti dalam kebidanan.
- Mengidentifikasi jenis dan desain penelitian yang cocok untuk konteks praktik kebidanan (kuantitatif, kualitatif, mixed methods).
- Menerapkan langkah-langkah praktis pelaksanaan penelitian di lapangan.
- Melakukan analisis dan interpretasi data hasil penelitian kebidanan secara ilmiah.
- Menyusun naskah publikasi hasil penelitian sesuai kaidah penulisan ilmiah (struktur artikel, etika publikasi, teknik penyusunan abstrak dan referensi).
- Merancang strategi diseminasi hasil penelitian kepada komunitas ilmiah maupun praktisi kebidanan, termasuk media cetak, digital, dan forum ilmiah.

- Melakukan evaluasi efektivitas diseminasi hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Pendahuluan

Praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice) merupakan pendekatan dalam pelayanan kebidanan yang menggunakan bukti penelitian terbaik yang tersedia sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Berbagai metode penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun kombinasi (mixed methods), memainkan peran penting dalam menghasilkan bukti yang berkualitas. Selain menghasilkan bukti, publikasi dan diseminasi hasil penelitian juga menjadi tahap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan kebidanan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis ilmiah dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Uraian Materi

A. Pengantar Evidence-Based Midwifery Practice

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) adalah pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang memadukan tiga elemen penting: hasil penelitian ilmiah terbaik dan terkini, keahlian klinis praktisi kebidanan, serta nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien. Konsep ini mengedepankan prinsip bahwa setiap tindakan kebidanan yang diambil harus didukung oleh bukti ilmiah yang sahih agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada pasien, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan hasil asuhan yang efektif dan aman bagi ibu dan bayi.

Penerapan EBMP dilatarbelakangi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebidanan yang berlangsung pesat. Kebidanan sebagai profesi kesehatan yang fokus pada asuhan kepada ibu, bayi baru lahir, dan keluarga, menghadapi tantangan berupa variasi praktik yang luas serta adanya kesenjangan antara teori yang dipelajari dalam pendidikan formal dengan praktik nyata di lapangan. Keadaan ini memicu munculnya kebutuhan akan pendekatan berbasis bukti yang mampu memastikan setiap tindakan yang dilakukan bidan tidak hanya berdasarkan tradisi atau kebiasaan turun-temurun, tetapi berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang valid dan terpercaya.

Dalam EBMP, bidan harus memiliki kemampuan kritis dalam mengevaluasi, menginterpretasi, serta mengintegrasikan bukti penelitian ke dalam praktik sehari-hari. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan klinis secara jelas dan terstruktur, mencari bukti terbaik yang tersedia melalui literatur ilmiah, mengevaluasi kualitas dan relevansi bukti, mengintegrasikan temuan penelitian dengan pengalaman klinis, serta menyesuaikan rekomendasi praktik berdasarkan nilai-nilai pasien dan konteks lokal pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, EBMP mendorong bidan untuk tidak lagi mengandalkan intuisi atau kebiasaan semata, tetapi secara aktif dan sistematis menggunakan hasil penelitian sebagai dasar dalam membuat keputusan klinis yang efektif dan aman.

Pentingnya EBMP dalam kebidanan sangat besar karena secara langsung berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Bukti penelitian menunjukkan bahwa penerapan praktik berbasis bukti mampu mengurangi angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima, serta mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel dalam praktik kebidanan. Selain itu, EBMP juga berperan

dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi bidan, karena proses penerapannya menuntut bidan untuk terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui studi ilmiah dan pelatihan berkelanjutan.

Lebih lanjut, penerapan EBMP juga mendukung advokasi terhadap kebijakan kesehatan yang lebih efektif, di mana bukti-bukti ilmiah dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan standar pelayanan, pedoman klinis, serta kebijakan kesehatan masyarakat yang berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Dengan demikian, EBMP tidak hanya berdampak pada tingkat individu, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan sistem pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, konsep dasar praktik kebidanan berbasis bukti sangat penting diterapkan karena mampu memberikan jaminan bahwa setiap tindakan kebidanan yang dilakukan benar-benar berdasarkan informasi ilmiah yang valid. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, memperkuat profesionalisme bidan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi yang dilayani.

B. Metode Penelitian Kuantitatif dalam Praktik Kebidanan

Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang secara sistematis mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data numerik untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel serta menguji hipotesis tertentu dalam konteks praktik kebidanan. Pendekatan ini berorientasi pada objektivitas, pengukuran yang akurat, dan analisis statistik, sehingga dapat memberikan bukti yang kuat dan dapat digeneralisasikan dalam pengambilan keputusan klinis dan kebijakan kesehatan.

Dalam konteks praktik kebidanan, penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi klinis, mengidentifikasi faktor risiko, menganalisis prevalensi suatu kondisi kesehatan, serta menilai kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan. Misalnya, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara pemberian intervensi tertentu, seperti pendidikan antenatal, terhadap hasil kesehatan seperti tingkat kepatuhan ibu terhadap program imunisasi atau pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini memungkinkan bidan untuk memahami sejauh mana intervensi tersebut berdampak terhadap pasien dalam bentuk angka statistik yang konkret dan jelas.

Dalam pelaksanaan penelitian kuantitatif, langkah awal yang penting adalah perumusan masalah penelitian yang jelas dan terstruktur dalam bentuk pertanyaan

atau hipotesis spesifik. Selanjutnya, peneliti harus menentukan desain penelitian yang sesuai untuk menjawab pertanyaan tersebut. Desain yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif di bidang kebidanan meliputi studi deskriptif, korelasional, cross-sectional, case-control, kohort, dan eksperimen. Pemilihan desain ini tergantung pada tujuan penelitian, waktu, sumber daya yang tersedia, serta jenis pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

Studi eksperimen atau intervensi, seperti uji klinis acak terkontrol (Randomized Controlled Trial/RCT), dianggap sebagai desain terbaik dalam penelitian kuantitatif karena mampu secara efektif mengontrol faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dalam RCT, subjek penelitian dibagi secara acak menjadi kelompok kontrol dan kelompok perlakuan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil antara dua kelompok tersebut disebabkan oleh intervensi yang diteliti. Dalam kebidanan, RCT sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi seperti teknik relaksasi untuk mengurangi nyeri persalinan atau dampak suplementasi nutrisi terhadap kesehatan ibu hamil.

Setelah desain penelitian dipilih, langkah selanjutnya adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan individu atau subjek yang ingin diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut yang dipilih dengan metode tertentu agar hasilnya dapat merepresentasikan seluruh populasi. Pemilihan sampel secara acak (random sampling) sering dianggap paling ideal dalam penelitian kuantitatif karena mampu mengurangi bias serta meningkatkan validitas eksternal penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan melalui instrumen penelitian yang telah divalidasi, seperti kuesioner, lembar observasi, atau alat ukur standar seperti tensimeter, termometer, timbangan bayi, atau alat laboratorium yang menghasilkan angka atau ukuran tertentu. Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel sangat penting karena menentukan kualitas data yang dikumpulkan, yang selanjutnya akan mempengaruhi akurasi hasil penelitian.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan metode statistik. Analisis statistik ini dapat dilakukan dengan statistik deskriptif, seperti rata-rata, median, modus, dan persentase, untuk mendeskripsikan karakteristik data yang diperoleh. Sementara itu, statistik inferensial, seperti uji chi-square, uji t, regresi logistik, dan analisis varian (ANOVA), digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah ada hubungan atau perbedaan yang signifikan antar variabel yang diteliti.

Misalnya, seorang peneliti dalam kebidanan mungkin menggunakan uji chi-square untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan kepatuhan mengikuti kelas antenatal. Hasil dari analisis statistik akan memberikan bukti ilmiah tentang sejauh mana pendidikan mempengaruhi keputusan ibu dalam mengikuti program antenatal, yang selanjutnya bisa dijadikan dasar untuk intervensi lanjutan atau perbaikan layanan kebidanan.

Penerapan metode kuantitatif dalam praktik kebidanan memberikan manfaat besar karena mampu menghadirkan data objektif yang dapat dijadikan acuan kuat dalam menyusun kebijakan, standar pelayanan, serta protokol klinis yang berbasis bukti. Dengan demikian, penggunaan penelitian kuantitatif secara rutin dan berkualitas tinggi akan membantu profesi kebidanan berkembang lebih efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan optimal dan terukur terhadap pasien yang dilayani.

C. Metode Penelitian Kualitatif dalam Praktik Kebidanan

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian ilmiah yang berfokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam mengenai berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam praktik kebidanan, melalui interpretasi makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok dalam konteks sosial tertentu. Berbeda dari penelitian kuantitatif yang mengedepankan data numerik, penelitian kualitatif lebih menekankan data deskriptif berupa kata-kata, narasi, cerita, atau pengalaman pribadi, yang dihasilkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, atau kajian dokumen.

Dalam konteks praktik kebidanan, metode penelitian kualitatif berperan sangat penting dalam memahami berbagai aspek subjektif yang tidak dapat diukur atau dijelaskan sepenuhnya oleh angka. Misalnya, metode ini digunakan untuk menggali persepsi ibu hamil terhadap layanan antenatal, pengalaman psikologis ibu dalam menghadapi persalinan pertama, dinamika hubungan antara bidan dan pasien, hingga faktor budaya yang mempengaruhi keputusan ibu dalam pemilihan tempat persalinan atau perawatan bayi baru lahir. Informasi-informasi tersebut tidak hanya melibatkan aspek objektif tetapi juga aspek emosional, kultural, dan sosial yang kompleks, sehingga sangat cocok diungkap melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif dalam kebidanan dimulai dengan identifikasi masalah penelitian secara jelas dan mendalam, serta perumusan pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka (open-ended). Pertanyaan tersebut umumnya dirancang untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, pendapat, atau makna yang diberikan oleh

individu atau kelompok mengenai fenomena tertentu. Selanjutnya, pemilihan informan atau subjek penelitian dilakukan secara purposif, yaitu peneliti secara sengaja memilih subjek yang dianggap memiliki pengalaman atau pengetahuan mendalam terkait dengan fenomena yang diteliti.

Salah satu metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif kebidanan adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendetail dan mendalam dari subjek penelitian mengenai pengalaman pribadi, emosi, pandangan, atau opini mereka terhadap suatu fenomena tertentu. Misalnya, wawancara mendalam dapat digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman ibu pasca-persalinan dalam menghadapi tantangan menyusui atau perasaan bidan dalam menghadapi situasi kritis selama proses persalinan. Selama wawancara ini, peneliti harus mampu menciptakan suasana nyaman, aman, dan terbuka agar informan merasa bebas dan jujur mengungkapkan pikiran serta perasaan mereka.

Selain wawancara, metode observasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif. Observasi langsung dalam konteks praktik kebidanan memungkinkan peneliti untuk menyaksikan dan mencatat interaksi sosial, prosedur klinis, pola komunikasi antara bidan dengan pasien, serta respons emosional dan perilaku individu dalam situasi nyata. Misalnya, peneliti dapat melakukan observasi partisipatif dalam kegiatan kelas antenatal, praktik persalinan alami, atau kunjungan rumah bidan untuk memahami secara mendalam dinamika hubungan interpersonal serta konteks sosial yang mempengaruhi intervensi kebidanan. Data hasil observasi ini dapat memperkuat hasil wawancara dan memberikan gambaran utuh tentang konteks penelitian.

Selain wawancara mendalam dan observasi, penelitian kualitatif dalam kebidanan sering juga menggunakan pendekatan naratif atau studi cerita kehidupan (life history approach). Pendekatan ini berfokus pada kisah-kisah pribadi informan mengenai pengalaman hidup mereka yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, pendekatan naratif digunakan untuk menggali pengalaman perempuan tentang kehilangan janin, tantangan dalam kehamilan risiko tinggi, atau proses pemulihan emosional setelah persalinan traumatis. Informasi ini membantu peneliti memahami konteks historis, emosional, dan sosial yang kompleks di balik fenomena-fenomena tertentu dalam kebidanan.

Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif seperti analisis tematik, fenomenologis, grounded theory, atau etnografi. Misalnya, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema tertentu

yang muncul secara konsisten dalam data wawancara atau observasi, sementara analisis fenomenologis digunakan untuk mendalami esensi pengalaman informan secara mendetail, sehingga makna mendalam dari fenomena tertentu dapat ditemukan.

Keunggulan utama dari metode penelitian kualitatif dalam praktik kebidanan adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas hubungan manusia, interaksi sosial, nilai budaya, serta dinamika emosi yang tidak mungkin terukur sepenuhnya dengan metode kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif dapat menjadi dasar yang sangat kuat dalam mengembangkan pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan, serta memperkaya pengetahuan bidan mengenai bagaimana cara terbaik melayani pasien sesuai dengan kebutuhan sosial, emosional, dan budaya mereka secara efektif dan sensitif.

Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif merupakan instrumen yang esensial dalam praktik kebidanan karena mampu mengungkap makna, persepsi, pengalaman, serta faktor-faktor kontekstual yang mendalam, yang menjadi dasar penting dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan dan menyesuaikan praktik dengan realitas kehidupan sosial budaya masyarakat.

D. Mixed Methods dalam Penelitian Kebidanan

Metode penelitian mixed methods atau metode campuran dalam penelitian kebidanan merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan keunggulan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara sistematis dalam sebuah studi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, serta memperkaya validitas dan relevansi hasil penelitian. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa integrasi antara data numerik yang objektif dengan data naratif atau deskriptif yang subjektif mampu menghasilkan wawasan yang lebih lengkap, serta memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena secara lebih utuh dibandingkan jika hanya menggunakan satu pendekatan penelitian saja.

Dalam konteks praktik kebidanan, metode campuran sangat relevan dan sering digunakan karena fenomena dalam bidang kebidanan melibatkan aspek klinis yang dapat diukur secara objektif, serta aspek emosional, sosial, dan budaya yang lebih baik dipahami melalui pendekatan subjektif. Sebagai contoh, penelitian tentang tingkat kepuasan pasien terhadap layanan antenatal dapat menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei yang menggunakan instrumen skala numerik untuk mengukur tingkat kepuasan, sekaligus menggunakan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengeksplorasi alasan, perasaan, dan pengalaman pasien

secara lebih mendalam. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana pasien mengalami layanan, serta alasan mengapa pasien merasa puas atau tidak puas terhadap layanan tersebut.

Penerapan metode campuran biasanya dimulai dengan perumusan pertanyaan penelitian yang kompleks dan tidak cukup dijawab hanya dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif saja. Pertanyaan ini sering kali berkaitan dengan aspek yang bersifat multidimensional, seperti evaluasi efektivitas program kebidanan berbasis komunitas, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan ibu terhadap jenis persalinan, atau pemahaman tentang pengalaman emosional ibu menghadapi komplikasi kehamilan yang dikaitkan dengan data klinis. Dengan menggabungkan data yang bersifat numerik dan naratif, penelitian ini mampu memberikan jawaban yang jauh lebih kaya dibandingkan jika dilakukan secara terpisah.

Metode campuran dalam penelitian kebidanan memiliki beberapa model umum penerapan, di antaranya adalah model sekuensial (sequential), model konkuren (concurrent), serta model embeded (embedded). Pada model sekuensial, pendekatan kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bertahap. Misalnya, penelitian dapat dimulai dengan survei kuantitatif untuk mendapatkan gambaran umum tentang preferensi pasien terhadap intervensi persalinan, yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengeksplorasi alasan dibalik pilihan tersebut secara lebih detail. Dengan demikian, hasil survei kuantitatif digunakan untuk menginformasikan atau mengarahkan pengumpulan data kualitatif berikutnya.

Sementara itu, model konkuren adalah model yang menerapkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dalam satu periode penelitian. Dalam praktik kebidanan, misalnya, peneliti secara bersamaan melakukan survei kepuasan pasien serta wawancara mendalam tentang persepsi mereka terkait kualitas layanan persalinan yang diterima. Data kuantitatif dan kualitatif ini kemudian dianalisis secara terpisah namun kemudian diintegrasikan dalam interpretasi hasil akhir penelitian.

Model embeded adalah model yang salah satu pendekatan, baik kuantitatif maupun kualitatif, menjadi pendekatan utama, sedangkan pendekatan yang lainnya digunakan sebagai pelengkap atau pendukung untuk mengklarifikasi atau memperdalam hasil dari pendekatan utama. Sebagai contoh, penelitian tentang dampak pendidikan prenatal terhadap hasil persalinan dapat menggunakan

eksperimen kuantitatif sebagai metode utama, sementara wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa peserta secara terbatas untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pengalaman dan persepsi mereka terhadap program pendidikan prenatal tersebut.

Keunggulan utama dari metode campuran dalam penelitian kebidanan adalah kemampuannya menghasilkan data yang saling melengkapi serta memperkaya interpretasi hasil penelitian. Data kuantitatif memberikan gambaran umum dan angka yang jelas mengenai skala atau prevalensi fenomena tertentu, sementara data kualitatif memberikan pemahaman mendalam mengenai alasan, makna, dan konteks sosial budaya dibalik angka-angka tersebut. Kombinasi keduanya juga membantu mengatasi keterbatasan yang ada pada masing-masing pendekatan secara individu, seperti keterbatasan kuantitatif dalam memahami aspek emosional atau keterbatasan kualitatif dalam menghasilkan generalisasi statistik.

Selain itu, metode campuran juga meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Validitas penelitian meningkat karena triangulasi data, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk memverifikasi atau mengonfirmasi hasil penelitian. Misalnya, data kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan kebidanan akan lebih kuat jika diperkuat dengan data kualitatif yang menunjukkan secara jelas alasan dan pengalaman pasien yang mendukung angka-angka tersebut.

Secara keseluruhan, metode penelitian campuran dalam praktik kebidanan merupakan pendekatan yang sangat penting karena mampu menghadirkan gambaran multidimensional tentang fenomena kebidanan yang kompleks, sehingga menghasilkan bukti penelitian yang lebih kuat, relevan, dan aplikatif. Hasil penelitian ini kemudian dapat digunakan secara lebih efektif dalam menginformasikan keputusan klinis, menyusun kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, serta mengembangkan standar pelayanan kebidanan yang tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga responsif secara sosial dan budaya terhadap kebutuhan pasien dan masyarakat.

E. Teknik Pelaksanaan Penelitian di Lapangan

Pelaksanaan penelitian di lapangan dalam konteks praktik kebidanan merupakan kegiatan sistematis yang mencakup serangkaian langkah praktis mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil, dengan tujuan untuk menghasilkan data penelitian yang akurat, relevan, dan aplikatif. Kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kecermatan dan konsistensi peneliti dalam menjalankan setiap

tahapan pelaksanaan penelitian, mulai dari tahap persiapan awal hingga penyelesaian akhir berupa laporan atau publikasi ilmiah.

Pada tahap perencanaan awal, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi masalah penelitian secara jelas dan relevan dengan praktik kebidanan. Tahap ini melibatkan analisis literatur atau telaah pustaka secara mendalam untuk memahami konteks permasalahan serta merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian yang tepat. Dalam praktik kebidanan, pemilihan masalah penelitian biasanya terkait langsung dengan kebutuhan praktis di lapangan, seperti evaluasi intervensi klinis, kajian terhadap fenomena sosial-budaya yang mempengaruhi pelayanan, atau eksplorasi kebutuhan pasien dalam konteks pelayanan kebidanan.

Selanjutnya, peneliti harus merancang desain penelitian secara detail. Pemilihan desain penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran) harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, ketersediaan sumber daya, dan waktu penelitian. Setelah desain penelitian ditetapkan, peneliti merumuskan secara terperinci instrumen pengumpulan data, seperti kuesioner, panduan wawancara, lembar observasi, atau perangkat pengukuran klinis. Instrumen yang digunakan harus melewati proses validasi dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh nanti akurat dan representatif.

Setelah persiapan desain penelitian dan instrumen selesai, tahap berikutnya adalah pengajuan izin penelitian kepada pihak terkait. Di setting kebidanan, izin biasanya diajukan ke lembindungan etik penelitian (ethical clearance), institusi pelayanan kesehatan (seperti klinik, puskesmas, rumah sakit), serta persetujuan tertulis dari responden atau subjek penelitian melalui informed consent. Dalam informed consent, peneliti harus menjelaskan tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh, risiko yang mungkin muncul, serta menjamin kerahasiaan data subjek. Proses ini penting untuk menjaga integritas etika penelitian dan memastikan penelitian dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip etika profesional.

Setelah memperoleh izin penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan dimulai dengan langkah persiapan teknis seperti pelatihan tim peneliti atau enumerator mengenai tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, serta standar operasional prosedur (SOP). Pelattraining ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami perannya masing-masing dan memiliki konsistensi dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dalam konteks praktik kebidanan, tim peneliti sering kali harus melibatkan tenaga kesehatan lokal atau petugas yang telah terbiasa berinteraksi

dengan ibu dan bayi agar dapat mengumpulkan data secara efektif dan sensitif terhadap kondisi sosial budaya setempat.

Selanjutnya, tahap pengumpulan data di lapangan dilaksanakan secara sistematis sesuai jadwal yang telah direncanakan. Untuk penelitian kuantitatif, peneliti harus memastikan pengambilan sampel dilakukan secara representatif dan konsisten, sedangkan untuk penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk wawancara mendalam atau observasi partisipatif. Dalam praktik kebidanan, peneliti perlu memahami dan menghormati privasi dan kenyamanan ibu, bayi, dan keluarga, serta memastikan bahwa prosedur penelitian tidak mengganggu pelayanan klinis yang sedang berjalan.

Selama proses pengumpulan data, manajemen penelitian sangat penting diperhatikan, khususnya pengelolaan data, waktu, sumber daya, serta pemantauan terhadap kualitas data yang diperoleh. Peneliti harus secara rutin melakukan evaluasi dan supervisi di lapangan untuk memastikan bahwa prosedur pengumpulan data berjalan sesuai rencana, data yang dikumpulkan lengkap, konsisten, dan akurat, serta permasalahan yang timbul dapat segera diatasi. Dalam penelitian kebidanan, peneliti juga perlu membangun komunikasi yang baik dengan staf kesehatan setempat dan responden, untuk menjamin kelancaran proses pengumpulan data dan meminimalisasi hambatan.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data secara teliti dan sistematis. Untuk penelitian kuantitatif, analisis statistik dilakukan dengan menggunakan software statistik yang relevan untuk mengolah data numerik yang diperoleh, sedangkan untuk penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik atau analisis isi secara mendalam. Pada tahap ini, hasil analisis perlu dikaitkan kembali dengan pertanyaan penelitian awal untuk memastikan bahwa tujuan penelitian tercapai.

Langkah terakhir dalam pelaksanaan penelitian adalah pelaporan hasil dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau publikasi ilmiah. Dalam pelaporan ini, peneliti wajib menjelaskan metode penelitian secara jelas dan transparan, menyajikan hasil analisis secara sistematis, dan mendiskusikan implikasi hasil penelitian untuk praktik kebidanan. Laporan harus disusun dengan bahasa yang jelas dan terstruktur agar dapat dipahami serta diaplikasikan oleh praktisi kebidanan maupun pembuat kebijakan kesehatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penelitian lapangan dalam praktik kebidanan merupakan serangkaian proses kompleks yang memerlukan perencanaan matang, manajemen yang ketat, keterampilan teknis, serta sensitivitas sosial budaya yang

tinggi. Ketelitian dan konsistensi dalam setiap tahapan penelitian sangat menentukan kualitas hasil yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid, akurat, dan relevan bagi pengembangan praktik kebidanan berbasis bukti.

F. Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kebidanan

Analisis dan interpretasi data merupakan tahapan kritis dalam proses penelitian kebidanan yang menentukan kualitas informasi dan kesimpulan yang akan digunakan dalam mendukung keputusan klinis. Tahapan ini bertujuan untuk mengolah dan memahami data penelitian secara sistematis agar dapat memberikan wawasan yang jelas mengenai fenomena atau masalah kebidanan yang diteliti. Proses analisis tidak sekadar menampilkan data dalam bentuk angka atau kutipan wawancara, tetapi juga mencakup interpretasi mendalam untuk menghasilkan makna yang dapat diaplikasikan dalam praktik klinis dan pembuatan kebijakan kesehatan berbasis bukti.

Dalam penelitian kebidanan, metode analisis data yang digunakan sangat bergantung pada jenis data yang dikumpulkan, yaitu apakah data tersebut bersifat kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya (mixed methods). Untuk data kuantitatif, analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik, baik statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dalam bentuk angka, seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, atau persentase. Statistik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran umum tentang fenomena yang diteliti, seperti prevalensi komplikasi persalinan atau tingkat kepuasan pasien terhadap layanan antenatal.

Lebih lanjut, statistik inferensial seperti uji t, uji chi-square, analisis regresi, dan uji korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara variabel atau membandingkan perbedaan antar kelompok dalam studi kebidanan. Misalnya, peneliti dapat menggunakan uji chi-square untuk menguji hubungan antara status sosial ekonomi dengan kejadian pre-eklampsia pada ibu hamil, atau menggunakan analisis regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum. Hasil analisis statistik ini memberikan dasar objektif untuk memahami hubungan sebab-akibat atau asosiasi antar variabel yang diteliti.

Dalam menginterpretasi hasil analisis kuantitatif, peneliti harus hati-hati dalam melihat signifikansi statistik serta relevansi klinis. Signifikansi statistik menunjukkan apakah hubungan antar variabel yang ditemukan dalam penelitian merupakan

temuan yang konsisten secara statistik ataukah hanya kebetulan semata. Namun, selain signifikansi statistik, interpretasi harus juga mempertimbangkan signifikansi klinis atau sejauh mana hasil tersebut memiliki dampak nyata dan bermakna dalam praktik kebidanan. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu intervensi pendidikan antenatal menghasilkan peningkatan kecil namun bermakna secara klinis dalam perilaku ibu dalam memberikan ASI eksklusif, sehingga keputusan klinis yang tepat dapat diambil berdasarkan hasil ini.

Sebaliknya, analisis data kualitatif dalam penelitian kebidanan berfokus pada eksplorasi mendalam mengenai makna, persepsi, pengalaman, atau konteks sosial budaya yang terungkap dari data wawancara mendalam, observasi, atau catatan lapangan. Metode analisis kualitatif yang umum digunakan antara lain analisis tematik, analisis isi (content analysis), analisis fenomenologis, analisis grounded theory, serta analisis naratif. Sebagai contoh, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola atau tema utama dari wawancara mengenai pengalaman ibu saat menjalani persalinan di fasilitas kesehatan tertentu, yang kemudian dapat membantu praktisi kebidanan memahami aspek emosional, psikologis, atau budaya yang mempengaruhi keputusan pasien.

Interpretasi data kualitatif melibatkan kemampuan peneliti untuk menghubungkan tema atau pola yang ditemukan dengan konteks teori, pengalaman klinis, serta kondisi nyata dalam praktik kebidanan. Interpretasi ini harus dilakukan secara reflektif dan kritis, dengan terus mempertimbangkan perspektif subjek penelitian untuk memahami makna yang lebih dalam dari temuan-temuan yang diperoleh. Misalnya, penelitian tentang persepsi ibu terhadap pelayanan kebidanan di daerah terpencil harus mampu menginterpretasikan bagaimana faktor budaya, geografis, atau sosial-ekonomi secara nyata mempengaruhi sikap dan tindakan ibu dalam mengakses layanan kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, dalam metode mixed methods, interpretasi data mengintegrasikan secara bersamaan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif memberikan gambaran umum tentang fenomena dalam angka statistik, sedangkan data kualitatif memperdalam pemahaman tentang alasan, makna, dan konteks di balik angka-angka tersebut. Interpretasi ini dilakukan melalui triangulasi, yakni menghubungkan temuan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran utuh dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Sebagai contoh, temuan kuantitatif tentang rendahnya kepatuhan ibu mengikuti kelas antenatal bisa diinterpretasi lebih dalam dengan hasil wawancara

yang mengungkapkan hambatan sosial atau emosional yang dihadapi ibu, sehingga hasil penelitian lebih bermakna dan aplikatif.

Akhirnya, hasil analisis dan interpretasi penelitian kebidanan harus disajikan secara jelas dan sistematis dalam laporan penelitian atau publikasi ilmiah, sehingga dapat dipahami oleh praktisi kebidanan, pengambil keputusan, maupun masyarakat umum. Dalam laporan tersebut, hasil analisis harus didiskusikan secara eksplisit mengenai implikasi klinis atau kebijakan, serta rekomendasi yang jelas untuk praktik kebidanan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian kebidanan tidak hanya berkontribusi secara ilmiah, tetapi juga mampu secara langsung mendukung peningkatan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu, bayi, keluarga, dan komunitas secara luas.

G. Panduan Penulisan Publikasi Ilmiah (Struktur, Etika, Abstrak, Referensi)

Penulisan publikasi ilmiah merupakan proses penting dalam diseminasi hasil penelitian di bidang kebidanan, yang bertujuan menyampaikan temuan penelitian secara jelas, akurat, etis, dan sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Kualitas sebuah publikasi ilmiah tidak hanya ditentukan oleh substansi penelitian, tetapi juga oleh kesesuaian struktur penulisan, pemenuhan etika penelitian, penulisan abstrak yang ringkas dan informatif, serta penggunaan referensi yang tepat sesuai dengan kaidah akademik.

1. Struktur Publikasi Ilmiah

Struktur penulisan artikel ilmiah dalam bidang kebidanan harus mengikuti standar internasional yang umum diterapkan, yaitu struktur IMRAD (Introduction, Methods, Results, and Discussion). Struktur ini memastikan bahwa informasi tersampaikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

Pendahuluan (Introduction) menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian, mengidentifikasi masalah penelitian secara jelas, serta merinci tujuan dan signifikansi penelitian. Bagian ini harus mampu menjelaskan mengapa topik tersebut relevan dengan bidang kebidanan serta implikasi praktis atau teoritis yang mendasari penelitian tersebut.

Metode Penelitian (Methods) harus disusun secara terperinci, transparan, dan jelas. Bagian ini mencakup penjelasan mengenai desain penelitian yang digunakan (kuantitatif, kualitatif, atau mixed methods), populasi dan teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, proses pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan. Detail metodologi ini penting agar

penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain serta memudahkan pembaca menilai validitas hasil penelitian.

Hasil Penelitian (Results) menyajikan data atau temuan penelitian secara jelas dan ringkas, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun uraian naratif. Dalam penelitian kuantitatif, hasil umumnya mencakup data statistik yang relevan, sedangkan dalam penelitian kualitatif, hasil mencakup tema atau kutipan yang mewakili hasil analisis secara mendalam.

Pembahasan (Discussion) merupakan bagian yang menginterpretasikan hasil penelitian, menjelaskan relevansi hasil dalam konteks teori atau praktik kebidanan, serta membandingkan hasil penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya. Bagian ini juga memuat implikasi klinis atau kebijakan, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

Terakhir, kesimpulan memberikan ringkasan singkat dari temuan utama, implikasi klinis, serta rekomendasi praktis untuk penerapan hasil penelitian dalam praktik kebidanan.

2. Etika Publikasi Ilmiah

Etika publikasi ilmiah merupakan prinsip mendasar yang wajib diikuti oleh setiap penulis dalam menyajikan hasil penelitian. Prinsip etika ini mencakup keaslian karya, akurasi data, transparansi proses penelitian, serta pengakuan kontribusi ilmiah orang lain melalui kutipan dan referensi yang tepat.

Penulis harus menjamin bahwa penelitian dilakukan secara etis, yang mencakup mendapatkan persetujuan etik dari komite etik penelitian, persetujuan informan melalui informed consent, menjaga privasi dan kerahasiaan data subjek, serta memastikan tidak ada konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. Plagiarisme dalam bentuk apa pun harus dihindari sepenuhnya, baik plagiarisme teks, gagasan, data, maupun hasil penelitian.

Setiap kontribusi orang lain, baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung, harus secara jelas disebutkan melalui kutipan yang akurat sesuai standar kutipan akademik seperti APA (American Psychological Association). Penulis juga wajib menyatakan secara transparan apabila penelitian menerima pendanaan atau terdapat afiliasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

3. Penulisan Abstrak

Abstrak adalah ringkasan singkat namun komprehensif dari isi artikel ilmiah. Dalam publikasi ilmiah kebidanan, abstrak harus disusun secara jelas dan informatif dengan panjang ideal antara 150–250 kata. Abstrak biasanya

mencakup tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan utama hasil penelitian, serta kesimpulan dan implikasi yang dihasilkan.

Abstrak harus mampu berdiri sendiri, artinya pembaca dapat memahami inti artikel tanpa perlu membaca seluruh isi artikel. Penyusunan abstrak sebaiknya dilakukan terakhir setelah artikel selesai ditulis, sehingga penulis dapat memastikan bahwa abstrak benar-benar mencerminkan substansi artikel secara tepat.

Kata kunci (keywords) harus disertakan di bawah abstrak, biasanya sekitar 3–5 kata atau frasa penting yang menggambarkan topik penelitian secara spesifik untuk memudahkan pencarian artikel di basis data ilmiah.

4. Penulisan Referensi

Referensi adalah bagian yang sangat penting dalam publikasi ilmiah, karena menunjukkan kredibilitas artikel melalui dukungan dari literatur akademik yang relevan. Referensi harus menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, relevan, dan mutakhir, khususnya dalam publikasi kebidanan yang idealnya menggunakan sumber dari lima tahun terakhir.

Sistem referensi yang umum digunakan dalam kebidanan adalah APA (American Psychological Association), yang mencakup aturan rinci mengenai penulisan nama penulis, tahun publikasi, judul artikel, judul jurnal atau buku, nomor volume atau edisi, serta halaman artikel yang dikutip.

H. Strategi Efektif Diseminasi Hasil Penelitian

Diseminasi hasil penelitian merupakan tahapan akhir yang krusial dalam proses penelitian kebidanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian secara efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari komunitas ilmiah, praktisi kebidanan, hingga masyarakat umum. Diseminasi hasil penelitian yang efektif dapat meningkatkan dampak positif hasil penelitian terhadap peningkatan kualitas praktik kebidanan, pengambilan kebijakan berbasis bukti, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kesehatan ibu dan anak.

Diseminasi hasil penelitian ke komunitas ilmiah umumnya dilakukan melalui publikasi ilmiah dalam jurnal nasional atau internasional bereputasi, serta presentasi pada konferensi ilmiah. Pemilihan jurnal yang tepat adalah kunci utama efektivitas diseminasi, yaitu jurnal yang memiliki cakupan sesuai dengan topik penelitian, terindeks secara luas seperti Scopus atau Web of Science, atau jurnal yang memiliki pembaca aktif dari kalangan profesional kebidanan. Publikasi ilmiah harus ditulis secara jelas, sistematis, dan akurat dengan mengikuti standar struktur ilmiah serta

ketentuan gaya referensi seperti APA (American Psychological Association). Dengan demikian, publikasi dapat dijangkau oleh peneliti lain dan digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian berikutnya.

Presentasi pada konferensi ilmiah adalah cara efektif lain untuk diseminasi hasil penelitian di lingkungan akademik dan profesional. Presentasi ini dapat berbentuk presentasi lisan (oral presentation) maupun presentasi poster, bergantung pada skala dan jenis acara. Peneliti perlu mempersiapkan presentasi yang jelas, informatif, dan menarik, dilengkapi dengan visualisasi data yang mudah dipahami. Interaksi langsung pada konferensi memberikan kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari rekan sejawat serta membuka peluang kolaborasi penelitian lanjutan.

Selain diseminasi kepada komunitas akademik, hasil penelitian kebidanan juga harus disebarluaskan secara efektif kepada para praktisi kebidanan seperti bidan, dokter kandungan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja langsung dengan pasien. Cara efektif untuk melakukan ini antara lain melalui seminar, pelatihan berbasis bukti, lokakarya (workshop), serta pembuatan pedoman atau protokol klinis. Misalnya, hasil penelitian tentang teknik relaksasi efektif dalam mengurangi nyeri persalinan dapat disampaikan melalui pelatihan khusus yang diselenggarakan untuk bidan atau praktisi kesehatan di tingkat fasilitas pelayanan primer atau rumah sakit.

Kegiatan pelatihan atau lokakarya memungkinkan praktisi kebidanan tidak hanya memahami hasil penelitian secara teoritis tetapi juga belajar cara menerapkan temuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Diseminasi hasil penelitian melalui media seperti booklet atau panduan singkat berbasis bukti juga membantu praktisi dalam mengakses informasi secara praktis, mudah dipahami, dan dapat langsung diterapkan.

Untuk menjangkau masyarakat umum, terutama ibu hamil, keluarga, atau komunitas setempat, diseminasi hasil penelitian perlu dilakukan melalui media komunikasi yang lebih umum dan mudah dipahami. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, atau YouTube adalah saluran yang efektif untuk menjangkau audiens luas. Materi penelitian bisa dikemas dalam bentuk video singkat edukatif, infografis sederhana, podcast, atau tulisan-tulisan informatif yang populer tetapi tetap berbasis bukti.

Selain media digital, media massa seperti surat kabar lokal, radio, dan televisi juga bisa digunakan untuk meningkatkan cakupan dan dampak penyebaran hasil penelitian kebidanan. Misalnya, penelitian tentang pentingnya pemeriksaan

antenatal bisa disampaikan dalam bentuk wawancara langsung di stasiun radio atau TV lokal, sehingga pesan kesehatan dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan influencer atau tokoh masyarakat setempat yang dipercaya oleh publik juga bisa menjadi strategi efektif untuk memperkuat penyampaian informasi kesehatan berbasis bukti kepada masyarakat.

Strategi diseminasi lain yang efektif adalah melibatkan komunitas langsung melalui pertemuan atau dialog komunitas, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Peneliti dan praktisi kebidanan dapat menyampaikan hasil penelitian dalam pertemuan kelompok ibu hamil, posyandu, atau pertemuan warga. Dalam konteks ini, materi penelitian disajikan dalam bahasa sederhana, komunikatif, serta memperhatikan konteks budaya dan sosial lokal, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerima pesan yang disampaikan.

Dalam pelaksanaan diseminasi hasil penelitian kebidanan, strategi integrasi hasil penelitian ke dalam kebijakan dan program kesehatan pemerintah merupakan langkah penting. Ini dapat dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan pembuat kebijakan, seperti Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, serta menyediakan ringkasan kebijakan (policy brief) yang jelas dan ringkas untuk memudahkan pengambil keputusan dalam mengadopsi hasil penelitian ke dalam kebijakan kesehatan yang aktual.

Secara keseluruhan, diseminasi hasil penelitian kebidanan yang efektif harus menggunakan pendekatan multisaluran yang disesuaikan dengan karakteristik audiens. Kombinasi pendekatan akademik, praktis, komunitas, dan kebijakan ini memastikan bahwa hasil penelitian kebidanan tidak hanya menjadi temuan ilmiah yang terbatas pada jurnal akademik, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi, serta memberikan manfaat praktis yang luas bagi masyarakat.

I. Evaluasi Dampak Penelitian dalam Praktik Pelayanan Kebidanan

Evaluasi dampak penelitian dalam praktik pelayanan kebidanan merupakan suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana hasil penelitian berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas intervensi klinis, serta kepuasan pasien. Evaluasi ini bertujuan tidak hanya untuk memastikan bahwa hasil penelitian diaplikasikan dalam praktik, tetapi juga untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam implementasi, serta untuk memberikan masukan dalam perbaikan penelitian di masa depan.

Dalam praktik kebidanan, evaluasi dampak penelitian melibatkan penggunaan metode evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menilai efektivitas hasil penelitian. Evaluasi ini diawali dengan menetapkan indikator-indikator spesifik yang akan digunakan untuk menilai dampak hasil penelitian terhadap kualitas praktik kebidanan. Indikator ini dapat mencakup aspek klinis, seperti penurunan angka komplikasi persalinan, angka morbiditas dan mortalitas ibu-bayi, atau peningkatan cakupan pelayanan antenatal. Indikator lain juga bisa bersifat non-klinis, seperti peningkatan kepuasan pasien, peningkatan kompetensi bidan, atau perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.

Evaluasi kuantitatif dilakukan dengan menggunakan desain studi tertentu, seperti studi pre-post atau studi eksperimental terkontrol, di mana indikator yang dipilih diukur sebelum dan sesudah hasil penelitian diimplementasikan. Sebagai contoh, bila hasil penelitian adalah intervensi pendidikan antenatal untuk meningkatkan kepatuhan ibu terhadap pemeriksaan kehamilan, maka evaluasi dilakukan dengan membandingkan angka kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Data kuantitatif yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menentukan signifikansi perubahan yang terjadi, sehingga efektivitas penelitian dapat diketahui secara objektif.

Metode evaluasi kualitatif juga memainkan peran penting dalam menilai dampak penelitian kebidanan, terutama dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan implementasi hasil penelitian. Teknik yang umum digunakan dalam evaluasi kualitatif antara lain wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta observasi langsung terhadap praktik klinis. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana bidan merasakan manfaat implementasi hasil penelitian dalam praktik sehari-hari serta hambatan apa saja yang mereka hadapi. Misalnya, peneliti bisa menggali bagaimana pandangan bidan mengenai implementasi metode baru untuk manajemen nyeri persalinan dan apa saja tantangan yang mereka alami dalam menerapkannya.

Diskusi kelompok terfokus (FGD) juga merupakan cara efektif untuk mengevaluasi dampak penelitian secara kolektif, dengan melibatkan beberapa praktisi kebidanan sekaligus. Dalam FGD, interaksi antar peserta membantu memperjelas berbagai persepsi yang mungkin berbeda tentang dampak penelitian, memunculkan gagasan solusi terhadap tantangan implementasi, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya penerapan hasil penelitian dalam meningkatkan praktik kebidanan berbasis bukti.

Observasi langsung dalam praktik klinis juga menjadi teknik penting dalam evaluasi dampak penelitian kebidanan. Peneliti bisa secara langsung melihat perubahan perilaku atau praktik klinis setelah penerapan hasil penelitian, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian tersebut diterapkan dalam keseharian pelayanan pasien. Misalnya, observasi langsung dapat dilakukan di klinik kebidanan atau puskesmas untuk menilai kepatuhan bidan terhadap protokol persalinan aman yang baru diperkenalkan melalui hasil penelitian.

Selain evaluasi langsung terhadap praktik klinis, evaluasi dampak penelitian juga mencakup penilaian tingkat kepuasan dan persepsi pasien terhadap perubahan layanan yang terjadi. Penilaian ini biasanya dilakukan melalui survei atau wawancara dengan pasien, yang memungkinkan peneliti mendapatkan masukan langsung mengenai efektivitas implementasi hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari sudut pandang pengguna layanan kebidanan.

Evaluasi dampak penelitian juga melibatkan aspek jangka panjang, yaitu menilai apakah perubahan yang dihasilkan oleh penelitian berkelanjutan ataukah hanya sementara. Evaluasi berkelanjutan ini penting untuk menentukan apakah hasil penelitian memberikan dampak yang stabil dan konsisten terhadap kualitas pelayanan kebidanan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan evaluasi longitudinal, di mana indikator dampak dinilai secara rutin dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap enam bulan atau setiap tahun setelah implementasi hasil penelitian.

Hasil evaluasi dampak penelitian yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan lanjutan dalam praktik pelayanan kebidanan. Apabila evaluasi menunjukkan hasil positif, penelitian tersebut dapat direkomendasikan untuk diimplementasikan secara lebih luas. Namun jika evaluasi menunjukkan hasil kurang memuaskan, maka evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan hasil penelitian di masa mendatang.

Secara keseluruhan, evaluasi dampak penelitian dalam praktik pelayanan kebidanan sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas layanan. Melalui evaluasi yang sistematis dan komprehensif, hasil penelitian tidak hanya berhenti sebagai publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam praktik klinis, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta peningkatan kualitas hidup ibu dan bayi secara keseluruhan.

J. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan di puskesmas ingin menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti (EBMP) dalam menangani keluhan nyeri persalinan pada pasien primigravida. Langkah awal yang sebaiknya dilakukan bidan dalam menerapkan EBMP adalah:

- A. Melakukan wawancara dengan bidan senior
- B. Menyiapkan laporan tindakan yang pernah berhasil sebelumnya
- C. Merumuskan pertanyaan klinis secara terstruktur (PICO)
- D. Memulai pemberian analgesik standar puskesmas
- E. Mengikuti tradisi penanganan nyeri persalinan yang berlaku

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Langkah awal dalam EBMP adalah merumuskan pertanyaan klinis dengan metode PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), yang menjadi dasar pencarian bukti ilmiah terbaru.

Soal 2

Seorang bidan menemukan adanya perbedaan praktik dalam penanganan bayi baru lahir di tempat praktiknya. Untuk memastikan praktik tersebut didasarkan pada bukti ilmiah yang sahih, tindakan terbaik yang dilakukan bidan adalah:

- A. Mengikuti praktik yang umum dilakukan kolega
- B. Melakukan pencarian literatur ilmiah terbaru
- C. Mengamati secara langsung tindakan senior
- D. Menerapkan tindakan yang pernah dipelajari selama pendidikan
- E. Meminta rekomendasi dari dokter yang sering merujuk pasien

Kunci Jawaban: B

Rasional:

EBMP menekankan pencarian bukti terbaru dari literatur ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan klinis yang akurat dan efektif.

Soal 3

Seorang bidan di TPMB ingin mengevaluasi efektivitas pendidikan antenatal terhadap peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya ASI eksklusif. Metode penelitian yang paling tepat digunakan bidan adalah:

- A. Studi deskriptif
- B. Penelitian fenomenologi
- C. Randomized Controlled Trial (RCT)

- D. Observasi partisipatif
- E. Studi kasus kualitatif

Kunci Jawaban: C

Rasional:

RCT merupakan desain penelitian kuantitatif yang paling kuat untuk mengevaluasi efektivitas intervensi tertentu, seperti pendidikan antenatal terhadap pengetahuan ibu hamil.

Soal 4

Seorang bidan melakukan penelitian tentang pengalaman emosional ibu yang mengalami persalinan prematur di sebuah rumah sakit. Metode penelitian yang paling tepat untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena ini adalah:

- A. Uji statistik deskriptif
- B. Studi kohort retrospektif
- C. Penelitian kualitatif fenomenologis
- D. Eksperimen acak terkontrol
- E. Studi korelasional

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Penelitian kualitatif fenomenologis sangat tepat digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman emosional dan persepsi subjek terhadap fenomena tertentu.

Soal 5

Seorang bidan menerapkan hasil penelitian terbaru tentang teknik manajemen nyeri persalinan. Untuk mengevaluasi dampak implementasi hasil penelitian tersebut di puskesmas, indikator paling tepat yang dapat digunakan adalah:

- A. Jumlah total kunjungan ibu hamil
- B. Penurunan keluhan nyeri persalinan berdasarkan skala nyeri
- C. Jumlah rujukan ke rumah sakit rujukan
- D. Jumlah persalinan normal yang dilakukan
- E. Tingkat pendidikan ibu hamil yang datang

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Evaluasi dampak penelitian harus menggunakan indikator yang relevan langsung dengan tujuan penelitian. Dalam kasus ini, indikator yang tepat adalah penurunan keluhan nyeri persalinan berdasarkan skala nyeri setelah implementasi teknik baru.

K. Rangkuman Materi

Praktik kebidanan berbasis bukti (EBMP) merupakan pendekatan sistematis yang sangat penting diterapkan dalam bidang kebidanan karena mampu memastikan setiap tindakan klinis didasarkan pada bukti ilmiah terbaru yang valid, pengalaman klinis, serta mempertimbangkan preferensi pasien. Penerapan EBMP meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, mengurangi risiko komplikasi, dan memperkuat kompetensi profesional bidan.

Untuk mendukung EBMP secara optimal, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan sebagai instrumen pelengkap yang saling melengkapi. Metode kuantitatif memberikan data objektif melalui analisis statistik untuk mengukur efektivitas intervensi dan menentukan hubungan antar variabel secara jelas, sementara metode kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap aspek emosional, sosial, dan budaya pasien. Pendekatan campuran (mixed methods) mengintegrasikan kedua metode ini, menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan.

Pelaksanaan penelitian kebidanan di lapangan memerlukan perencanaan matang, desain yang tepat, pengumpulan data yang akurat, serta analisis dan interpretasi yang sistematis agar menghasilkan temuan valid dan aplikatif dalam praktik klinis. Setelah penelitian selesai, penulisan publikasi ilmiah harus mengikuti standar internasional seperti IMRAD dan memenuhi prinsip etika ilmiah yang tinggi.

Strategi diseminasi hasil penelitian yang efektif sangat penting untuk memastikan hasil penelitian diketahui secara luas dan diterapkan oleh praktisi kebidanan maupun masyarakat, melalui berbagai saluran seperti publikasi jurnal, konferensi ilmiah, pelatihan, media sosial, dan media massa. Evaluasi dampak penelitian secara berkelanjutan juga perlu dilakukan guna memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan dan kesejahteraan ibu serta bayi secara keseluruhan.

L. Glosarium

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Pendekatan sistematis dalam praktik kebidanan yang menggabungkan hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis bidan, serta preferensi dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis untuk mencapai hasil asuhan optimal.

PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)

Kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan klinis dalam penelitian berbasis bukti, mencakup identifikasi populasi pasien, intervensi yang diuji, pembandingan intervensi, serta hasil atau luaran yang diharapkan.

Morbiditas

Angka atau tingkat kejadian penyakit atau komplikasi pada suatu populasi tertentu.

Mortalitas

Angka kematian dalam suatu populasi, yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas intervensi kesehatan.

Penelitian Kuantitatif

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan objektif melalui pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi hubungan antar variabel, serta menilai efektivitas intervensi secara terukur.

Randomized Controlled Trial (RCT)

Studi eksperimental yang melibatkan pembagian subjek secara acak menjadi kelompok intervensi dan kontrol, dianggap sebagai metode penelitian paling efektif untuk menentukan hubungan sebab-akibat secara ilmiah.

Random Sampling

Teknik pemilihan sampel secara acak dari populasi tertentu agar hasil penelitian dapat mewakili populasi secara akurat dan mengurangi bias.

Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, seperti kuesioner, lembar observasi, atau perangkat pengukuran klinis, yang harus valid dan reliabel agar data yang diperoleh akurat.

Statistik Deskriptif

Metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, seperti rata-rata, median, modus, standar deviasi, atau persentase.

Statistik Inferensial

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan menentukan hubungan antar variabel atau perbedaan antar kelompok secara signifikan, contohnya uji chi-square, uji t, regresi logistik, dan ANOVA.

Penelitian Kualitatif

Metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena berdasarkan interpretasi makna yang diberikan individu atau kelompok, menggunakan data deskriptif berupa wawancara mendalam, narasi, observasi langsung, dan analisis dokumen.

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan percakapan terstruktur atau semi-terstruktur untuk menggali informasi mendalam tentang persepsi, pengalaman, atau pandangan subjek penelitian.

Observasi Partisipatif

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan kehadiran langsung peneliti dalam situasi nyata untuk mencatat perilaku, interaksi, dan konteks sosial secara detail.

Analisis Tematik

Metode analisis data kualitatif yang mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang konsisten dalam data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi.

Mixed Methods Research

Pendekatan penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, memperkuat validitas temuan, dan melengkapi keterbatasan masing-masing metode.

M. Daftar Pustaka

- Carter, M. C., Corry, M., Delaney, H., & Madden, S. (2020). Evidence-based practice in midwifery: A systematic approach to clinical decision making. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 65(5), 631–640. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13128>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2022). *An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ferguson, L., Davis, D., & Browne, J. (2021). Does midwifery-led care improve maternal and newborn outcomes? A systematic review. *Midwifery*, 94, 102911. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102911>
- Holloway, I., & Galvin, K. (2017). *Qualitative research in nursing and healthcare* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.

- Sandelowski, M. (2022). Rigor in qualitative research revisited. *Research in Nursing & Health*, 45(4), 317–322. <https://doi.org/10.1002/nur.22263>
- Santos, M., Serruya, S. J., Cecatti, J. G., & Vogel, J. P. (2019). Evidence-based practices for improving maternal and newborn care: A global review. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 147(1), 3–8. <https://doi.org/10.1002/ijgo.12957>
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2020). *Handbook of mixed methods in social & behavioral research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- World Health Organization. (2019). *WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO Press.
- Yanti, Y., & Claramita, M. (2020). Implementasi praktik kebidanan berbasis bukti dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan di Indonesia. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 16(2), 108–115. <https://doi.org/10.31101/jkk.1239>

BAB 4

EVIDENCE-BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN: HASIL PENELITIAN TERBAIK, IMPLIKASI, DAN PENTINGNYA EBP DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip Evidence-Based Midwifery Practice dalam pengambilan keputusan klinis untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami konsep Evidence-Based Midwifery Practice, menerapkan hasil penelitian terbaik, serta mengevaluasi implikasi penerapan EBP dalam praktik kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan konsep dasar Evidence-Based Midwifery Practice.
- Mengidentifikasi dan menilai hasil penelitian terbaik untuk digunakan dalam praktik kebidanan.
- Memahami implikasi penerapan Evidence-Based Practice dalam praktik kebidanan.
- Menjelaskan pentingnya EBP dalam meningkatkan hasil asuhan kebidanan.

Pendahuluan

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) merupakan pendekatan praktik kebidanan yang didasarkan pada integrasi hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, dan nilai serta preferensi pasien. Penerapan EBMP memungkinkan bidan untuk memberikan asuhan yang berkualitas tinggi, efektif, dan aman serta membantu dalam mengatasi tantangan praktik kebidanan yang terus berkembang.

A. Hasil Penelitian Terbaik dalam Evidence-Based Midwifery Practice

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP), kualitas keputusan klinis sangat bergantung pada penggunaan hasil penelitian terbaik yang tersedia. Menentukan hasil penelitian terbaik adalah kunci penting untuk memastikan bahwa tindakan dan intervensi kebidanan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pengalaman klinis saja, tetapi benar-benar didukung oleh bukti ilmiah yang kuat, akurat, dan dapat dipercaya. Hal ini penting karena intervensi yang dilakukan tanpa didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat bisa menyebabkan praktik yang tidak efektif, tidak aman, bahkan berisiko menimbulkan komplikasi.

Berikut ini adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh penelitian agar dianggap sebagai hasil penelitian terbaik dalam praktik kebidanan berbasis bukti:

1. Penelitian dengan desain yang kuat

Penelitian yang memiliki desain kuat merupakan salah satu syarat utama untuk dapat digunakan dalam EBMP. Desain penelitian yang kuat ini mencakup beberapa metode yang terbukti dapat memberikan hasil yang paling sahih dan akurat. Di antaranya adalah:

a. Randomized Controlled Trials (RCT)

RCT sering dianggap sebagai standar emas (gold standard) dalam penelitian klinis. Desain penelitian ini secara sistematis mengalokasikan subjek penelitian secara acak ke dalam dua kelompok atau lebih, biasanya kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Tujuan dari alokasi acak ini adalah mengurangi bias seleksi, memastikan bahwa perbedaan hasil yang diamati benar-benar karena intervensi, bukan karena faktor lain. RCT sangat penting karena memberikan bukti langsung mengenai hubungan sebab-akibat antara intervensi dengan hasil yang diamati.

Meta-analisis

Meta-analisis merupakan metode statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian yang sejenis untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat dan kuat. Meta-analisis membantu mengatasi keterbatasan dari studi tunggal, seperti sampel kecil atau hasil yang kurang konsisten, dengan mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai studi. Hasil meta-analisis memiliki nilai tinggi dalam EBMP karena memberikan bukti kuat dan komprehensif mengenai efektivitas intervensi tertentu secara keseluruhan.

b. Systematic Review

Systematic review adalah tinjauan literatur sistematis yang menggunakan metode eksplisit dan terstruktur dalam proses pencarian, evaluasi, dan sintesis hasil penelitian yang relevan. Berbeda dengan tinjauan literatur biasa, systematic review mengurangi bias seleksi dengan cara eksplisit menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta metode analisis yang transparan. Karena sifatnya yang komprehensif dan sistematis, systematic review menjadi dasar penting dalam EBMP karena menyediakan ringkasan bukti terkini tentang topik tertentu yang bisa langsung diaplikasikan dalam praktik klinis.

c. Cohort Studies

Cohort studies atau studi kohort adalah penelitian observasional prospektif yang memantau kelompok tertentu yang memiliki atau tidak memiliki faktor risiko tertentu dan kemudian mengamati hasil klinisnya dalam jangka waktu tertentu. Studi kohort dianggap kuat ketika penelitian eksperimen (RCT) sulit dilakukan karena alasan etika atau praktis. Studi kohort dapat memberikan informasi penting mengenai risiko relatif dan hubungan temporal antara paparan atau intervensi dengan hasil klinis.

2. Penelitian yang memiliki validitas dan reliabilitas tinggi.

Kriteria lain yang menentukan apakah hasil penelitian dapat digunakan dalam EBMP adalah tingkat validitas dan reliabilitasnya. Validitas adalah kemampuan suatu penelitian untuk benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Penelitian yang valid memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik kesimpulan yang benar dan relevan terhadap intervensi yang sedang diuji. Ada dua bentuk validitas utama yang harus dipastikan, yaitu:

a. Validitas Internal

Validitas internal menunjukkan bahwa hasil penelitian secara akurat mencerminkan hubungan sebab-akibat antara intervensi dan hasil yang diamati tanpa gangguan dari faktor-faktor eksternal atau bias. Penelitian dengan validitas internal tinggi menunjukkan bahwa perubahan hasil klinis benar-benar karena intervensi yang diuji, bukan karena faktor lain.

b. Validitas Eksternal

Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat digeneralisasikan atau diterapkan secara luas dalam praktik klinis kebidanan di berbagai situasi dan populasi. Penelitian dengan validitas eksternal tinggi berarti hasilnya dapat dipercaya dan diaplikasikan secara efektif dalam konteks praktik nyata di lapangan.

Reliabilitas, di sisi lain, mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh ketika metode atau pengukuran yang sama diulang dalam kondisi yang sama. Penelitian

dengan reliabilitas tinggi memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya jika pengukuran dilakukan berkali-kali dalam situasi yang berbeda oleh peneliti yang berbeda pula. Hal ini penting agar keputusan klinis yang diambil oleh bidan tidak bervariasi secara tidak konsisten.

3. Penelitian yang relevan dengan masalah klinis yang dihadapi dalam praktik kebidanan.

Selain desain yang kuat serta validitas dan reliabilitas yang tinggi, hasil penelitian terbaik dalam EBMP juga harus relevan secara klinis. Relevansi penelitian mengacu pada sejauh mana hasil dari penelitian tersebut dapat menjawab pertanyaan klinis spesifik yang dihadapi dalam praktik kebidanan sehari-hari. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang langsung menyangkut masalah-masalah klinis yang dihadapi oleh bidan, seperti manajemen nyeri persalinan, teknik menyusui, metode pencegahan perdarahan postpartum, atau penggunaan kontrasepsi.

Relevansi ini sangat penting karena tidak semua hasil penelitian kuat secara desain bisa langsung diterapkan dalam konteks praktik kebidanan. Misalnya, sebuah penelitian RCT yang sangat kuat secara desain tetapi berfokus pada populasi yang berbeda atau intervensi yang tidak lazim dalam praktik kebidanan di Indonesia mungkin kurang relevan untuk diaplikasikan secara langsung. Oleh karena itu, bidan harus mampu menilai relevansi dari setiap hasil penelitian sebelum menerapkannya ke dalam praktik klinisnya.

Dengan memperhatikan secara detail kriteria tersebut—yaitu desain penelitian yang kuat seperti RCT, meta-analisis, systematic review, atau cohort studies, validitas dan reliabilitas penelitian yang tinggi, serta relevansi penelitian terhadap isu klinis spesifik dalam praktik kebidanan—maka bidan dapat yakin bahwa praktik yang dijalankan benar-benar didukung oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Hal ini akan memberikan manfaat maksimal bagi pasien, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, serta membantu mengurangi risiko komplikasi dan efek samping yang tidak diinginkan.

Beberapa sumber penelitian terbaik untuk praktik kebidanan adalah:

1. Cochrane Library

Cochrane Library merupakan sumber penelitian ilmiah yang dianggap sebagai salah satu rujukan utama dalam bidang kesehatan, khususnya kebidanan. Basis data ini dikelola oleh Cochrane Collaboration, sebuah jaringan internasional yang menghasilkan systematic review yang berkualitas tinggi dengan metode ketat. Sistematis review dari Cochrane memiliki standar yang sangat ketat dalam pemilihan studi, penilaian kualitas metodologi, dan sintesis hasil penelitian.

Cochrane Library menyediakan ringkasan dan tinjauan sistematis terhadap berbagai intervensi klinis, prosedur kebidanan, dan kebijakan kesehatan yang relevan untuk praktik kebidanan. Oleh karena itu, hasil penelitian dari Cochrane Library sangat dihargai dalam praktik kebidanan karena memberikan bukti yang dapat dipercaya, valid, relevan, serta praktis untuk langsung diaplikasikan oleh bidan dalam pengambilan keputusan klinis.

2. PubMed

PubMed merupakan basis data bibliografi yang dikembangkan oleh National Library of Medicine, Amerika Serikat. PubMed menyediakan akses gratis ke lebih dari 35 juta artikel penelitian ilmiah dari berbagai jurnal internasional yang terindeks dalam MEDLINE. Artikel yang tersedia mencakup berbagai topik kesehatan termasuk kebidanan, kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan bayi, serta berbagai intervensi klinis terkait. Keunggulan PubMed adalah kemudahan akses, cakupan penelitian yang luas, serta fitur pencarian canggih yang memungkinkan bidan menemukan artikel-artikel terbaru sesuai topik klinis yang relevan. Banyak artikel penelitian yang tersedia di PubMed berasal dari berbagai desain penelitian, mulai dari RCT hingga studi observasional, sehingga memungkinkan bidan memilih penelitian terbaik dan paling relevan dengan kebutuhan praktik klinis sehari-hari.

3. Jurnal kebidanan terkemuka seperti Journal of Midwifery & Women's Health dan Midwifery.

Jurnal kebidanan yang terkemuka seperti Journal of Midwifery & Women's Health dan Midwifery adalah publikasi ilmiah yang khusus membahas penelitian terkini di bidang kebidanan, kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, dan praktik klinis kebidanan.

Journal of Midwifery & Women's Health, misalnya, diterbitkan oleh American College of Nurse-Midwives (ACNM), menyajikan hasil penelitian asli, review literatur, laporan kasus klinis, serta panduan praktik berbasis bukti yang relevan untuk praktik kebidanan. Artikel dalam jurnal ini melalui proses peer-review yang ketat sehingga memastikan validitas, kualitas metodologi, dan relevansi klinisnya.

Midwifery adalah jurnal ilmiah internasional yang berfokus pada perkembangan ilmu pengetahuan kebidanan, intervensi klinis terbaru, kebijakan kesehatan, serta isu-isu terkini dalam praktik kebidanan di berbagai negara. Jurnal ini memiliki reputasi tinggi karena mempublikasikan penelitian inovatif dengan desain kuat seperti randomized controlled trials, systematic review, dan meta-analisis yang sangat berguna dalam EBMP.

Secara keseluruhan, sumber-sumber ini (Cochrane Library, PubMed, dan jurnal kebidanan terkemuka) menyediakan akses penting terhadap hasil penelitian terbaik yang valid, reliabel, relevan, dan terkini untuk praktik kebidanan berbasis bukti. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, bidan akan mampu mengambil keputusan klinis yang efektif, aman, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara nyata bagi pasien dan masyarakat.

B. Implikasi Penerapan Evidence-Based Practice dalam Praktik Kebidanan

Penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam praktik kebidanan memberikan dampak signifikan yang positif baik bagi kualitas asuhan, keselamatan pasien, efisiensi biaya, maupun perkembangan profesionalisme para bidan. Berikut penjelasan mengenai implikasi positif tersebut:

1. Peningkatan kualitas asuhan

Salah satu implikasi terpenting dari penerapan EBP dalam praktik kebidanan adalah peningkatan kualitas asuhan kebidanan. Dengan mempraktikkan asuhan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru, keputusan klinis yang diambil oleh bidan tidak hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman pribadi, melainkan bersandar pada data penelitian yang sah dan teruji secara ketat. Hal ini mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam praktik kebidanan, menjadikan tindakan lebih efektif dalam mencapai tujuan klinis. Misalnya, dalam manajemen nyeri persalinan, penerapan teknik-teknik yang didukung oleh penelitian terkini akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan ibu, sehingga berdampak pada hasil asuhan yang lebih baik secara keseluruhan.

Selain itu, dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti, tindakan yang diambil akan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan spesifik pasien, karena intervensi yang diterapkan telah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat optimal. Dengan demikian, EBP membantu bidan untuk menyediakan asuhan berkualitas tinggi yang mampu meningkatkan kepuasan pasien serta hasil klinis yang positif.

2. Peningkatan keselamatan pasien

Implikasi positif lainnya adalah peningkatan keselamatan pasien. Praktik kebidanan berbasis bukti secara signifikan mengurangi risiko terjadinya komplikasi dan kesalahan klinis yang dapat membahayakan pasien. Hal ini dimungkinkan karena setiap tindakan atau intervensi yang diterapkan didasarkan pada hasil penelitian yang telah terbukti aman dan efektif. Sebagai contoh, dalam upaya pencegahan perdarahan postpartum, intervensi berbasis bukti seperti

penggunaan oksitosin segera setelah kelahiran plasenta telah terbukti mampu menurunkan risiko perdarahan hebat yang bisa membahayakan jiwa ibu.

Di samping itu, penggunaan panduan klinis berbasis bukti memastikan bahwa bidan secara konsisten menggunakan intervensi yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar terkini, menghindari praktik-praktik yang tidak didukung bukti ilmiah atau bahkan berpotensi merugikan. Dengan demikian, pasien mendapatkan pelayanan yang lebih aman dan terpercaya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan.

3. Optimalisasi biaya

Penerapan Evidence-Based Practice dalam kebidanan juga memberikan implikasi positif dalam aspek ekonomi kesehatan, yakni optimalisasi biaya pelayanan kesehatan. Praktik yang didasarkan pada bukti ilmiah dapat mengidentifikasi dan mengeliminasi tindakan atau intervensi yang tidak perlu, tidak efektif, atau bahkan kontra produktif. Akibatnya, biaya pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien karena sumber daya tidak terbuang percuma pada tindakan yang tidak memberikan manfaat klinis yang jelas.

Misalnya, jika sebuah penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan tertentu tidak memiliki nilai diagnostik atau manfaat klinis yang signifikan dalam manajemen kehamilan normal, maka tindakan tersebut dapat dihindari, mengurangi biaya tambahan bagi pasien maupun sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan menerapkan EBP, pengalokasian sumber daya kesehatan menjadi lebih efektif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi biaya pelayanan kebidanan.

4. Pengembangan profesionalisme bidan

Implikasi terakhir dari penerapan EBP dalam praktik kebidanan adalah perkembangan profesionalisme para bidan. EBP mendorong bidan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan teknologi terbaru. Dengan demikian, bidan dituntut terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai bukti ilmiah terkini yang relevan dengan praktiknya.

Kondisi ini mendorong terciptanya budaya belajar berkelanjutan atau continuous professional development di kalangan bidan. Sebagai hasilnya, bidan menjadi lebih kompeten, percaya diri, dan mampu memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan standar profesionalisme terkini. Selain itu, melalui penerapan EBP, bidan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknisnya, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis kritis dan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, sehingga meningkatkan posisi profesional bidan di tengah komunitas kesehatan secara luas.

Secara keseluruhan, penerapan Evidence-Based Practice dalam kebidanan secara nyata memberikan manfaat besar dengan meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan, optimalisasi sumber daya, serta memperkuat profesionalisme bidan dalam memberikan asuhan terbaik kepada pasien.

C. Pentingnya Evidence-Based Practice dalam Praktik Kebidanan

Penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam praktik kebidanan memiliki peran yang sangat penting dan mendasar karena berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada ibu dan bayi. Hal ini tidak hanya berpengaruh secara klinis, namun juga secara profesional, etis, dan dalam konteks kebijakan kesehatan secara lebih luas. EBP sangat penting dalam praktik kebidanan karena:

1. Membantu bidan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan efektif.

Dalam praktik kebidanan, setiap keputusan klinis yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan ibu serta bayinya. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus dibuat dengan cara yang paling tepat, efektif, dan efisien. Melalui penerapan EBP, bidan memiliki dasar yang kuat berupa bukti ilmiah yang membantu mereka menentukan pilihan intervensi terbaik. Hal ini penting karena keputusan yang didasarkan pada bukti ilmiah dapat mengurangi ketidakpastian dalam praktik klinis, meningkatkan akurasi diagnosis, serta memastikan bahwa setiap tindakan memiliki manfaat yang maksimal dan risiko minimal.

Misalnya, dalam manajemen persalinan normal, penggunaan posisi melahirkan tertentu yang didukung bukti ilmiah dapat membantu mengurangi komplikasi persalinan. Tanpa pendekatan EBP, bidan mungkin mengandalkan intuisi, tradisi, atau kebiasaan yang tidak selalu efektif atau bahkan bisa berisiko menimbulkan komplikasi.

2. Memastikan Asuhan Kebidanan Didasarkan pada Bukti Ilmiah, Bukan Tradisi atau Kebiasaan Klinis Semata

Penerapan EBP sangat penting untuk memastikan bahwa asuhan kebidanan tidak sekadar mengikuti kebiasaan turun-temurun atau praktik klinis lama yang belum terbukti secara ilmiah. Tradisi dan kebiasaan klinis, meskipun mungkin telah berlangsung lama, tidak selalu mencerminkan praktik terbaik atau paling aman. Tanpa pendekatan berbasis bukti, kebidanan berisiko terjebak dalam praktik yang tidak efisien, tidak efektif, atau bahkan berbahaya.

Sebaliknya, praktik berbasis bukti secara eksplisit mendorong penggunaan bukti ilmiah terbaru untuk mendukung atau menolak intervensi tertentu. Sebagai

contoh, dahulu kala episiotomi rutin pada setiap persalinan dianggap sebagai praktik standar. Namun, penelitian berbasis bukti telah menunjukkan bahwa episiotomi rutin tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko komplikasi jangka panjang. Dengan EBP, bidan kini dapat menolak kebiasaan lama yang tidak didukung oleh penelitian ilmiah dan mengadopsi praktik yang benar-benar terbukti bermanfaat.

3. Menyediakan Dasar untuk Advokasi Kebijakan Kesehatan yang Lebih Baik

EBP juga memiliki peran penting dalam mendukung advokasi kebijakan kesehatan yang berkualitas tinggi dan berbasis bukti. Dalam konteks kebijakan kesehatan, para pembuat kebijakan memerlukan data dan bukti yang kuat untuk menetapkan kebijakan publik yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Dengan menerapkan EBP, bidan mampu memberikan bukti ilmiah yang jelas mengenai praktik-praktik yang terbukti efektif, sehingga mereka dapat menjadi advokat yang kuat dalam mendorong perubahan kebijakan kesehatan yang proaktif dan berpihak kepada kesejahteraan pasien.

Misalnya, bukti ilmiah yang kuat tentang pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif telah digunakan oleh para bidan untuk mempengaruhi kebijakan publik di berbagai negara termasuk Indonesia. Dengan bukti yang kokoh dari penelitian ilmiah, advokasi terhadap kebijakan tersebut menjadi lebih meyakinkan dan berhasil meningkatkan keselamatan serta kesehatan ibu dan anak secara nasional.

4. Meningkatkan Kredibilitas Profesi Kebidanan Melalui Praktik yang Transparan, Akuntabel, dan Berstandar Tinggi

Salah satu implikasi strategis dari penerapan EBP dalam praktik kebidanan adalah meningkatnya kredibilitas dan legitimasi profesi bidan di mata masyarakat, komunitas kesehatan, serta pemangku kepentingan terkait. Praktik berbasis bukti menciptakan lingkungan klinis yang transparan, karena keputusan klinis yang diambil dapat dibenarkan melalui data ilmiah yang jelas dan terukur. Hal ini membuat praktik kebidanan menjadi lebih akuntabel, karena setiap tindakan klinis yang dilakukan dapat dijelaskan secara ilmiah, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien maupun masyarakat secara luas.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti, profesi kebidanan dapat menunjukkan bahwa pelayanan yang mereka berikan benar-benar didasarkan pada standar praktik tertinggi yang terbukti secara ilmiah. Dampak positifnya adalah meningkatnya kepercayaan publik, pengakuan dari profesi kesehatan lain, serta memperkuat posisi kebidanan sebagai profesi kesehatan yang kredibel, profesional, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Evidence-Based Practice dalam praktik kebidanan sangat krusial karena mampu memberikan manfaat luas yang meliputi peningkatan akurasi keputusan klinis, memastikan tindakan yang dilakukan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah, mendukung advokasi kebijakan kesehatan yang lebih efektif, serta secara signifikan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme para bidan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan keluarga secara keseluruhan.

D. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perawat di ruang nifas ingin menerapkan tindakan terbaik dalam mencegah perdarahan postpartum. Perawat menemukan beberapa sumber penelitian mengenai intervensi tersebut. Di antara pilihan berikut, sumber manakah yang paling kuat tingkat pembuktiannya menurut prinsip Evidence-Based Practice?

- A. Studi kasus
- B. Randomized Controlled Trials (RCT)
- C. Studi cross-sectional
- D. Studi kualitatif
- E. Opini ahli

Kunci Jawaban: B. Randomized Controlled Trials (RCT)

Rasional:

RCT merupakan desain penelitian yang dianggap paling kuat dalam menentukan hubungan sebab-akibat intervensi klinis, karena mengurangi bias melalui pengacakan (randomisasi). Ini menjadikan RCT sebagai sumber bukti terbaik dalam penerapan intervensi klinis termasuk mencegah perdarahan postpartum.

Soal 2

Seorang perawat ingin menerapkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri pasien setelah operasi sesar. Ia menemukan beberapa penelitian, tetapi perawat harus memastikan validitas eksternal dari penelitian tersebut. Apa arti penting dari validitas eksternal dalam konteks ini?

- A. Seberapa besar penelitian tersebut mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat
- B. Seberapa konsisten hasil penelitian jika diulang beberapa kali
- C. Seberapa baik hasil penelitian dapat diterapkan pada berbagai situasi dan populasi berbeda
- D. Seberapa besar tingkat kepercayaan peneliti terhadap hasil penelitiannya
- E. Seberapa akurat instrumen pengukuran dalam penelitian tersebut

Kunci Jawaban: C. Seberapa baik hasil penelitian dapat diterapkan pada berbagai situasi dan populasi berbeda

Rasional:

Validitas eksternal merujuk pada generalisasi hasil penelitian, yaitu kemampuan untuk menerapkan hasil penelitian secara luas di berbagai situasi, kondisi, atau populasi yang berbeda. Hal ini sangat penting agar intervensi yang dilakukan relevan dan efektif pada kondisi pasien nyata.

Soal 3

Dalam sebuah seminar, perawat kebidanan mendengar tentang penggunaan skin-to-skin contact segera setelah kelahiran untuk meningkatkan keberhasilan menyusui. Ia diminta untuk mencari bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Platform mana yang paling tepat digunakan oleh perawat untuk mendapatkan tinjauan sistematis berkualitas tinggi?

- A. Wikipedia
- B. Google Scholar
- C. Cochrane Library
- D. Medscape
- E. Nursing blogs

Kunci Jawaban: C. Cochrane Library

Rasional:

Cochrane Library adalah sumber utama tinjauan sistematis (systematic review) yang diakui secara internasional dengan metodologi yang ketat, transparan, dan terpercaya dalam menghasilkan bukti klinis terbaik untuk praktik keperawatan dan kebidanan.

Soal 4

Seorang perawat ingin mengadopsi intervensi baru untuk manajemen nyeri persalinan, namun menemukan bahwa hasil penelitian dari negara lain mungkin berbeda jika diterapkan di Indonesia. Faktor utama apakah yang perlu dipertimbangkan perawat untuk menilai relevansi penelitian ini?

- A. Validitas internal dari studi
- B. Ukuran sampel penelitian
- C. Metode statistik penelitian
- D. Relevansi klinis penelitian terhadap populasi pasien
- E. Usia penelitian

Kunci Jawaban: D. Relevansi klinis penelitian terhadap populasi pasien

Rasional:

Relevansi klinis merujuk pada sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan secara efektif terhadap masalah atau populasi spesifik dalam konteks klinis tertentu. Meskipun hasil penelitian kuat secara desain, relevansinya harus sesuai dengan karakteristik pasien di tempat praktik.

Soal 5

Seorang perawat ingin menerapkan hasil sebuah meta-analisis yang menunjukkan bahwa edukasi prenatal efektif meningkatkan kesiapan ibu menghadapi persalinan. Apa alasan utama meta-analisis dianggap sebagai bukti kuat dalam praktik keperawatan?

- A. Meta-analisis memiliki banyak opini ahli
- B. Meta-analisis dilakukan dengan desain kualitatif
- C. Meta-analisis menggabungkan hasil dari beberapa penelitian sejenis
- D. Meta-analisis hanya mengandalkan studi kasus tunggal
- E. Meta-analisis menggunakan pendekatan deskriptif

Kunci Jawaban: C. Meta-analisis menggabungkan hasil dari beberapa penelitian sejenis

Rasional:

Meta-analisis merupakan studi yang secara statistik menggabungkan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat, kuat, dan terpercaya dibandingkan studi tunggal. Dengan menggabungkan hasil berbagai penelitian, meta-analisis dapat memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung keputusan klinis.

E. Rangkuman Materi

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) adalah pendekatan penting dalam praktik kebidanan yang mengutamakan penggunaan hasil penelitian ilmiah terbaik sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Untuk menjamin kualitas praktik kebidanan, penelitian yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu seperti desain penelitian kuat (Randomized Controlled Trials, meta-analisis, systematic review, atau cohort studies), memiliki validitas internal dan eksternal yang tinggi, reliabilitas hasil yang konsisten, serta relevansi klinis terhadap permasalahan dalam praktik kebidanan. Penggunaan sumber penelitian terpercaya seperti Cochrane Library, PubMed, dan jurnal kebidanan terkemuka (Journal of Midwifery & Women's Health, Midwifery) semakin memperkuat penerapan EBMP.

Implikasi positif dari penerapan EBMP mencakup peningkatan kualitas asuhan, keselamatan pasien yang lebih baik, efisiensi biaya pelayanan kesehatan, dan pengembangan profesionalisme bidan. Melalui EBMP, bidan dapat mengambil keputusan klinis dengan akurat, efektif, aman, transparan, dan akuntabel, sekaligus berperan aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi. Dengan demikian, EBMP merupakan landasan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah terbaik.

F. Glosarium

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Pendekatan sistematis dalam praktik kebidanan yang menggunakan bukti ilmiah terbaik untuk pengambilan keputusan klinis guna memastikan intervensi aman, efektif, dan efisien.

Randomized Controlled Trials (RCT)

Jenis penelitian eksperimen yang menggunakan alokasi subjek secara acak ke dalam kelompok intervensi atau kontrol untuk menilai efektivitas suatu intervensi klinis, mengurangi risiko bias, dan menunjukkan hubungan sebab-akibat secara jelas.

Meta-analisis

Metode penelitian statistik yang menggabungkan hasil beberapa studi sejenis untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat, akurat, dan dapat dipercaya dibandingkan studi tunggal.

Systematic Review

Tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah dengan metode eksplisit dalam pencarian, evaluasi, serta sintesis data untuk memberikan ringkasan bukti terkini secara komprehensif dan transparan.

Cohort Studies (Studi Kohort)

Penelitian observasional prospektif yang mengikuti kelompok subjek yang memiliki atau tidak memiliki faktor risiko tertentu, dengan tujuan mengamati hasil klinis tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Validitas

Kemampuan suatu penelitian untuk benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan relevan terhadap intervensi yang diuji.

Validitas Internal

Kemampuan penelitian dalam menunjukkan hubungan sebab-akibat secara akurat tanpa gangguan dari faktor eksternal atau bias.

Validitas Eksternal

Kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasikan atau diterapkan secara luas pada situasi, kondisi, atau populasi yang berbeda di luar konteks penelitian awal.

Reliabilitas

Konsistensi atau kestabilan hasil penelitian ketika pengukuran yang sama diulang dalam kondisi yang sama oleh peneliti yang berbeda.

Relevansi Klinis

Sejauh mana hasil penelitian dapat secara efektif menjawab atau diterapkan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang dihadapi dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Cochrane Library

Basis data internasional yang menyediakan tinjauan sistematis berkualitas tinggi dan terpercaya di bidang kesehatan, khususnya kebidanan, dikelola oleh Cochrane Collaboration.

PubMed

Basis data bibliografi daring yang dikembangkan oleh National Library of Medicine, Amerika Serikat, menyediakan akses gratis terhadap jutaan artikel ilmiah dalam bidang kesehatan termasuk kebidanan.

Journal of Midwifery & Women's Health

Jurnal kebidanan internasional yang diterbitkan oleh American College of Nurse-Midwives (ACNM), menyajikan hasil penelitian, tinjauan literatur, laporan kasus, serta panduan praktik berbasis bukti.

Midwifery

Jurnal ilmiah internasional yang menerbitkan artikel penelitian tentang ilmu kebidanan, intervensi klinis terkini, dan kebijakan kesehatan dalam praktik kebidanan.

Profesionalisme Kebidanan

Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang dimiliki oleh bidan dalam memberikan asuhan yang berkualitas tinggi berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan mengikuti standar etika profesi.

Optimalisasi Biaya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya kesehatan dengan menghindari tindakan yang tidak perlu atau tidak efektif melalui penerapan praktik berbasis bukti.

Advokasi Kebijakan Kesehatan

Upaya yang dilakukan oleh para profesional, termasuk bidan, untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehatan berdasarkan data ilmiah agar kebijakan tersebut mendukung keselamatan dan kesejahteraan pasien, khususnya ibu dan bayi.

Kredibilitas Profesi

Kepercayaan publik terhadap profesi kebidanan yang diperoleh melalui praktik klinis yang transparan, akuntabel, dan didukung oleh bukti ilmiah terbaik.

G. Daftar Pustaka

- American College of Nurse-Midwives (ACNM). (n.d.). Journal of Midwifery & Women's Health. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15422011>
- Burns, N., & Grove, S. K. (2018). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Cochrane Collaboration. (n.d.). Cochrane Library. Retrieved from <https://www.cochranelibrary.com/>
- Greenhalgh, T. (2019). How to read a paper: The basics of evidence-based medicine and healthcare (6th ed.). Wiley-Blackwell.
- National Library of Medicine. (n.d.). PubMed. Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Wick, L. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2021). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Smith, V., Begley, C., Clarke, M., & Devane, D. (2012). Professionals' views of fetal monitoring during labour: A systematic review and thematic analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 12(1), 166. <https://doi.org/10.1186/1471-2393-12-166>
- Walsh, D., & Downe, S. (Eds.). (2018). Essential midwifery practice: Expertise, evidence and experience (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>

BAB 5

EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: PRINSIP APLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN, PRINSIP DAN LANGKAH DALAM EVIDENCE-BASED MIDWIFERY CARE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Evidence-Based Midwifery Practice dalam memberikan asuhan kebidanan berdasarkan hasil penelitian terbaik dan terkini secara sistematis dan terintegrasi, serta mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil penelitian ilmiah.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan prinsip dasar aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan.

Mengidentifikasi langkah-langkah dalam praktik kebidanan berbasis bukti (EBMP).

Menerapkan langkah-langkah EBMP dalam kasus klinis kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar evidence-based midwifery practice.
- Menguraikan prinsip-prinsip aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan.
- Menjelaskan langkah-langkah sistematis dalam praktik kebidanan berbasis bukti.
- Mempraktikkan langkah-langkah EBMP dalam pengambilan keputusan klinis kebidanan.

Pendahuluan

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) merupakan pendekatan integral yang menempatkan hasil penelitian ilmiah terbaik sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dalam praktik kebidanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip EBMP, seorang bidan mampu memberikan asuhan yang efektif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Penerapan EBMP penting untuk memastikan bahwa intervensi kebidanan berdasarkan bukti ilmiah yang terkini dan teruji keakuratannya sehingga meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal dan neonatal.

A. Prinsip Aplikasi Hasil Penelitian dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP), aplikasi hasil penelitian memerlukan pendekatan sistematis yang mematuhi prinsip-prinsip tertentu agar praktik klinis benar-benar efektif, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi pasien. Berikut adalah prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan:

1. Validitas dan Reliabilitas

Penelitian yang diterapkan dalam praktik kebidanan harus memiliki kualitas ilmiah yang tinggi, yang melibatkan dua aspek utama yaitu validitas dan reliabilitas.

a. Validitas:

- 1) Merupakan kemampuan sebuah penelitian untuk benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.
- 2) Penelitian valid mencerminkan akurasi metode, prosedur penelitian yang tepat, penggunaan alat ukur yang valid, serta mampu mengurangi bias.
- 3) Contoh desain penelitian yang memenuhi validitas tinggi meliputi Randomized Controlled Trials (RCT), Cohort Studies, Systematic Reviews, dan Meta-analisis.

b. Reliabilitas:

- 1) Mengacu pada konsistensi hasil penelitian bila pengukuran diulang dalam kondisi yang sama.
- 2) Penelitian dengan reliabilitas tinggi menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan konsisten jika diuji ulang oleh peneliti yang berbeda atau dalam waktu berbeda.
- 3) Contoh: Hasil pengukuran tekanan darah, kadar Hb, atau skor nyeri pasien yang konsisten ketika dilakukan pengukuran ulang dalam situasi yang serupa.

Penelitian dengan desain kuat seperti RCT, cohort studies, systematic review, dan meta-analisis diutamakan karena desain tersebut mampu memberikan bukti kuat yang mendasari keputusan klinis.

2. Relevansi Klinis

Penelitian yang diaplikasikan harus relevan terhadap isu klinis nyata yang dihadapi oleh bidan di lapangan. Aspek relevansi klinis mencakup:

a. Keselarasan dengan Masalah Nyata:

- 1) Penelitian yang dipilih harus menjawab masalah atau pertanyaan klinis yang spesifik dalam praktik kebidanan.

- 2) Contoh: Penelitian tentang metode manajemen nyeri persalinan, teknik menyusui yang efektif, atau pencegahan infeksi postpartum.
- b. Fokus pada Kebutuhan Pasien:
 - 1) Penelitian harus mempertimbangkan aspek pasien-sentris seperti kenyamanan pasien, keamanan pasien, serta manfaat klinis langsung.
 - 2) Misalnya, penelitian tentang intervensi yang mengurangi angka kejadian perdarahan postpartum, karena perdarahan adalah masalah yang signifikan dalam kebidanan.
- c. Konteks Klinik:
 - 1) Relevansi klinis juga mencakup kesesuaian hasil penelitian dengan lingkungan praktik, sumber daya, dan situasi budaya serta sosial masyarakat setempat.
 - 2) Contohnya: penerapan penelitian tentang metode KB yang tepat di daerah dengan tingkat penerimaan KB rendah.

3. Kemudahan Implementasi:

Penelitian harus praktis, mudah dimengerti, serta bisa diterapkan secara efektif dan efisien dalam praktik kebidanan sehari-hari. Kriteria penting dalam kemudahan implementasi meliputi:

- a. Praktis dan Operasional:
 - 1) Metode atau intervensi yang dihasilkan oleh penelitian harus jelas, sederhana, mudah dipahami dan dapat segera diaplikasikan oleh tenaga kebidanan tanpa memerlukan pelatihan rumit.
 - 2) Contoh: penggunaan check-list sederhana untuk monitoring postpartum yang bisa langsung digunakan oleh bidan.
- b. Fleksibilitas Penggunaan:
 - 1) Penelitian harus dapat diterapkan dalam berbagai setting kebidanan, baik klinik, rumah sakit, maupun di tempat praktik mandiri bidan (TPMB).
 - 2) Intervensi berbasis bukti harus dapat disesuaikan dengan sumber daya yang ada, baik dari sisi peralatan, biaya, maupun tenaga yang tersedia.
- c. Efektivitas Implementasi:
 - 1) Penelitian harus memberikan hasil yang jelas dan signifikan dalam peningkatan kualitas asuhan kebidanan, terbukti secara statistik maupun klinis.
 - 2) Contoh: penelitian tentang posisi melahirkan yang optimal yang terbukti meningkatkan kenyamanan dan memperpendek durasi persalinan.

4. Keselarasan dengan Nilai Pasien

Implementasi hasil penelitian juga harus selaras dengan nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien secara individu maupun dalam konteks budaya. Hal ini penting karena kebidanan adalah pelayanan yang bersifat personal dan humanistik.

- a. Menghormati Preferensi Pasien:

- 1) Keputusan klinis harus menghormati keinginan dan preferensi pasien sepanjang tidak membahayakan pasien secara klinis.
- 2) Contoh: pemilihan metode persalinan yang nyaman bagi pasien setelah menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap metode berdasarkan hasil penelitian.
- b. Sensitivitas Budaya:
 - 1) Penelitian yang digunakan harus dapat diterima secara budaya oleh pasien, keluarganya, serta masyarakat setempat.
 - 2) Contoh: penelitian mengenai pemberian ASI eksklusif yang memperhatikan budaya menyusui di komunitas tertentu.
- c. Kebutuhan Personal Pasien:
 - 1) Setiap pasien memiliki kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual yang berbeda. Penelitian yang digunakan harus dapat mengakomodasi kebutuhan ini.
 - 2) Contoh: intervensi yang memperhatikan kondisi psikologis ibu setelah persalinan, seperti penelitian tentang efektivitas konseling postpartum dalam mengatasi depresi pasca melahirkan.

B. Prinsip dan Langkah dalam Evidence-Based Midwifery Care

Evidence-Based Midwifery Care (EBMC) atau asuhan kebidanan berbasis bukti adalah pendekatan klinis yang secara sistematis mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu:

- Hasil penelitian ilmiah terbaik
- Keahlian klinis bidan
- Nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien

Prinsip dasar ini memastikan bahwa praktik kebidanan tidak hanya berbasis pengalaman, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, sehingga mampu memberikan hasil asuhan terbaik bagi pasien.

Langkah-Langkah dalam Evidence-Based Midwifery Care

Dalam menerapkan EBMC, bidan perlu melakukan langkah-langkah berikut secara sistematis:

1. Formulasi Pertanyaan Klinis (PICO)

Formulasi pertanyaan klinis merupakan langkah penting pertama dalam EBMC. Metode PICO membantu merumuskan pertanyaan klinis yang terstruktur secara jelas dan spesifik.

Aspek-aspek dalam PICO adalah:

- a. Patient/Problem (Masalah/Pasien):
 - 1) Mendefinisikan populasi atau kondisi yang ingin diteliti.

- 2) Contoh: Ibu hamil dengan preeklamsia ringan.
- b. Intervention (Intervensi):
 - 1) Menentukan tindakan atau terapi yang akan dikaji efektivitasnya.
 - 2) Contoh: Pemberian suplemen kalsium.
- c. Comparison (Pembanding):
 - 1) Menentukan tindakan atau terapi alternatif untuk dibandingkan dengan intervensi utama.
 - 2) Contoh: Dibandingkan dengan kelompok ibu hamil yang tidak diberikan suplemen kalsium (placebo).
- d. Outcome (Hasil):
 - 1) Menentukan hasil yang diinginkan atau akan diukur.
 - 2) Contoh: Menurunkan risiko berkembangnya preeklamsia berat.

2. Pencarian Bukti Ilmiah

Setelah pertanyaan klinis dirumuskan, langkah berikutnya adalah mencari bukti ilmiah terbaik dari sumber yang kredibel.

Strategi pencarian meliputi:

- a. Identifikasi Sumber Database Ilmiah:
 - 1) PubMed, Cochrane Library, Google Scholar, ScienceDirect, CINAHL, dan Scopus.
 - 2) Sumber ini menyediakan penelitian-penelitian ilmiah terbaru, berkualitas tinggi, dan relevan.
- b. Menentukan Kata Kunci yang Tepat:
 - 1) Kata kunci berdasarkan elemen PICO, contohnya "calcium supplementation," "preeclampsia," dan "pregnancy outcomes."
- c. Filter dan Seleksi Artikel:
 - 1) Gunakan kriteria seperti rentang waktu penelitian terbaru (misalnya dalam 5 tahun terakhir), tipe penelitian (RCT, systematic review, meta-analisis), dan relevansi klinis.

3. Penilaian Kritis terhadap Bukti Ilmiah

Penilaian kritis atau critical appraisal adalah proses mengevaluasi kualitas bukti ilmiah yang ditemukan. Proses ini meliputi:

- a. Menilai Validitas
 - Memastikan metode penelitian akurat, minim bias, dan desain penelitian tepat.
- b. Menilai Reliabilitas
 - Memastikan hasil penelitian konsisten jika diulang dalam situasi yang serupa.
- c. Menilai Relevansi

Memastikan hasil penelitian benar-benar relevan dengan pertanyaan klinis dan situasi kebidanan yang dihadapi.

4. Aplikasi Bukti ke Praktik Klinis

Langkah ini adalah integrasi atau penerapan bukti ilmiah yang telah dinilai ke dalam praktik nyata.

Langkah-langkahnya:

- a. Integrasi dengan Keahlian Klinis
Pertimbangkan pengalaman dan pengetahuan klinis bidan dalam menerapkan hasil penelitian secara efektif.
- b. Integrasi dengan Preferensi dan Nilai Pasien:
 - 1) Diskusikan hasil temuan penelitian dengan pasien, libatkan mereka dalam keputusan.
 - 2) Contoh: Konseling kepada ibu hamil tentang manfaat dan risiko suplementasi kalsium.
- c. Penyesuaian terhadap Konteks Praktik:
Pertimbangkan faktor lokal seperti ketersediaan sumber daya, fasilitas kesehatan, serta budaya setempat.

5. Evaluasi Efektivitas

Langkah terakhir ini melibatkan evaluasi hasil setelah menerapkan bukti ilmiah tersebut dalam praktik klinis untuk melihat apakah intervensi yang diberikan benar-benar efektif. Cara evaluasi mencakup:

- a. Penilaian Hasil Klinis Pasien
Mengevaluasi hasil klinis setelah intervensi, seperti perubahan tekanan darah, angka kejadian preeklamsia berat, atau hasil akhir kehamilan.
- b. Umpan Balik dari Pasien
Meminta masukan atau umpan balik dari pasien tentang pengalaman mereka terhadap intervensi tersebut.
- c. Penyesuaian Praktik secara Berkelanjutan
Melakukan perbaikan atau modifikasi praktik berdasarkan evaluasi dan umpan balik, sehingga kualitas asuhan kebidanan terus meningkat.

C. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang bidan sedang memilih penelitian untuk digunakan sebagai referensi dalam penerapan teknik manajemen nyeri persalinan di TPMB. Bidan menemukan beberapa jenis penelitian. Berdasarkan prinsip validitas dalam EBMP, jenis penelitian mana yang paling disarankan untuk digunakan?

Opsi jawaban:

- A. Studi kasus
- B. Randomized Controlled Trials (RCT)
- C. Studi deskriptif
- D. Studi cross-sectional
- E. Studi kualitatif

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Penelitian jenis RCT memiliki validitas tertinggi karena melibatkan kontrol ketat dan pengacakan subjek, sehingga mampu mengurangi bias secara signifikan dan memberikan bukti kuat dalam pengambilan keputusan klinis.

Kasus 2

Seorang bidan akan menerapkan hasil penelitian tentang posisi melahirkan yang efektif dan nyaman bagi pasien di kliniknya. Prinsip penting mana dalam EBMP yang paling relevan untuk dipertimbangkan oleh bidan sebelum menerapkan hasil penelitian ini?

Opsi jawaban:

- A. Reliabilitas
- B. Validitas
- C. Kemudahan implementasi
- D. Relevansi klinis
- E. Fleksibilitas statistik

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Prinsip kemudahan implementasi penting karena intervensi harus praktis, mudah dimengerti, serta dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai setting kebidanan. Dalam kasus ini, intervensi berupa posisi melahirkan harus sederhana untuk diterapkan langsung oleh bidan tanpa pelatihan kompleks.

Kasus 3

Seorang ibu berusia 27 tahun hamil anak pertama datang ke klinik kebidanan. Ibu tersebut memiliki preferensi kuat untuk melahirkan secara alami tanpa intervensi medis yang berlebihan. Prinsip EBMP yang paling tepat digunakan oleh bidan dalam situasi ini adalah?

Opsi jawaban:

- A. Reliabilitas penelitian
- B. Validitas penelitian

- C. Keselarasan dengan nilai pasien
- D. Kemudahan implementasi
- E. Fleksibilitas penggunaan hasil penelitian

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Keselarasn dengan nilai pasien merupakan prinsip utama dalam EBMP yang memastikan keputusan klinis sejalan dengan preferensi dan nilai individu pasien, dalam kasus ini keinginan ibu untuk melahirkan secara alami.

Kasus 4

Seorang bidan ingin mencari penelitian tentang efektivitas pemberian ASI eksklusif di komunitas dengan tingkat pemberian susu formula yang tinggi. Dalam prinsip EBMP, faktor apa yang menjadi pertimbangan penting dalam memilih hasil penelitian tersebut?

Opsi jawaban:

- A. Efektivitas implementasi saja
- B. Kecanggihan statistik dalam penelitian
- C. Reliabilitas tanpa mempertimbangkan budaya
- D. Sensitivitas budaya dalam penelitian
- E. Hasil penelitian harus berasal dari studi cross-sectional

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Sensitivitas budaya dalam penelitian merupakan aspek penting dari prinsip keselarasan nilai pasien di EBMP, karena praktik menyusui dipengaruhi oleh budaya komunitas setempat. Hasil penelitian harus relevan secara budaya agar dapat diterapkan secara efektif dalam komunitas tersebut.

Kasus 5

Seorang bidan telah menerapkan teknik manajemen persalinan berbasis penelitian terbaru selama 6 bulan di kliniknya. Sekarang, bidan ingin mengevaluasi apakah teknik tersebut benar-benar efektif. Langkah apa dalam EBMC yang perlu dilakukan oleh bidan?

Opsi jawaban:

- A. Menyusun pertanyaan PICO baru
- B. Melakukan pencarian database ilmiah ulang
- C. Melakukan penilaian kritis terhadap literatur lagi
- D. Evaluasi efektivitas intervensi klinis
- E. Menentukan intervensi lain untuk perbandingan

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Evaluasi efektivitas merupakan langkah terakhir dalam EBMC yang digunakan untuk mengukur dampak dan efektivitas intervensi yang diterapkan secara langsung terhadap hasil klinis yang didapatkan pasien, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.

D. Rangkuman Materi

Praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice/EBMP) mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam menerapkan hasil penelitian, prinsip-prinsip penting yang perlu diperhatikan adalah validitas dan reliabilitas penelitian, relevansi terhadap isu klinis aktual, kemudahan implementasi, serta keselarasan dengan nilai budaya dan preferensi pasien.

Proses EBMP melibatkan langkah-langkah sistematis yaitu merumuskan pertanyaan klinis dengan metode PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), mencari bukti ilmiah terbaik dari sumber terpercaya, melakukan penilaian kritis terhadap validitas, reliabilitas, dan relevansi penelitian, mengaplikasikan hasil penelitian secara efektif ke dalam praktik dengan mempertimbangkan konteks lokal dan preferensi pasien, serta mengevaluasi efektivitas intervensi secara berkelanjutan.

Pendekatan EBMP ini memastikan bahwa asuhan kebidanan tidak hanya didasarkan pada pengalaman semata, tetapi juga didukung bukti ilmiah terbaik, sehingga kualitas layanan meningkat, keselamatan pasien terjamin, dan praktik kebidanan menjadi lebih optimal dan efektif.

E. Glosarium

A

Aplikasi Bukti Ilmiah:

Proses penerapan hasil penelitian yang telah dinilai kualitasnya ke dalam praktik klinis sehari-hari untuk mencapai hasil klinis yang optimal.

C

Cohort Study:

Penelitian observasional yang mengikuti sekelompok individu dengan karakteristik tertentu selama periode waktu tertentu untuk mengamati hasil klinis yang dialami.

Comparison (Pembanding dalam PICO):

Tindakan atau terapi alternatif yang digunakan sebagai perbandingan terhadap intervensi utama dalam formulasi pertanyaan klinis.

Critical Appraisal (Penilaian Kritis):

Proses sistematis mengevaluasi kualitas bukti ilmiah dengan menilai validitas, reliabilitas, dan relevansi penelitian untuk menentukan kelayakan penggunaannya dalam praktik.

E**Effectiveness (Efektivitas Implementasi):**

Ukuran sejauh mana intervensi klinis berdasarkan hasil penelitian berhasil mencapai hasil yang diinginkan dalam praktik kebidanan, baik secara statistik maupun klinis.

Evidence-Based Midwifery Care (EBMC):

Pendekatan asuhan kebidanan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien secara sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

F**Fleksibilitas Penggunaan:**

Kemampuan suatu intervensi hasil penelitian untuk diaplikasikan secara efektif di berbagai setting kebidanan dengan mempertimbangkan sumber daya, fasilitas, dan situasi lokal.

I**Intervention (Intervensi dalam PICO):**

Tindakan atau terapi spesifik yang akan dikaji efektivitasnya dalam sebuah penelitian atau pertanyaan klinis.

K**Kemudahan Implementasi:**

Karakteristik dari hasil penelitian yang membuatnya praktis, mudah dimengerti, dan langsung dapat diaplikasikan oleh tenaga kebidanan tanpa pelatihan kompleks.

Konteks Klinik:

Lingkungan atau setting pelayanan kebidanan, meliputi kondisi sumber daya, fasilitas, budaya, dan kondisi sosial masyarakat tempat intervensi klinis akan diterapkan.

M**Meta-Analysis:**

Metode penelitian yang menggabungkan data kuantitatif dari beberapa studi ilmiah yang relevan untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat dan valid secara statistik.

O**Outcome (Hasil dalam PICO):**

Parameter atau hasil klinis yang diinginkan atau akan diukur dalam sebuah penelitian atau pertanyaan klinis.

P

Pasien-Sentris:

Pendekatan pelayanan yang menempatkan kebutuhan, preferensi, kenyamanan, serta keselamatan pasien sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan klinis.

Patient/Problem (Masalah/Pasien dalam PICO):

Populasi atau kondisi kesehatan spesifik yang menjadi fokus penelitian atau intervensi klinis.

PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome):

Kerangka kerja sistematis untuk merumuskan pertanyaan klinis dalam praktik berbasis bukti.

Preferensi Pasien:

Keinginan atau pilihan pasien mengenai intervensi klinis, berdasarkan pengalaman pribadi, keyakinan budaya, atau kondisi psikologis dan sosialnya.

Prinsip EBMP:

Pedoman dasar dalam Evidence-Based Midwifery Practice yang mencakup validitas, reliabilitas, relevansi klinis, kemudahan implementasi, serta keselarasan dengan nilai pasien.

R

Randomized Controlled Trial (RCT):

Penelitian eksperimental yang melibatkan pembagian subjek secara acak ke dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol, untuk mengurangi bias dan menghasilkan bukti yang valid dan kuat.

Reliabilitas:

Tingkat konsistensi atau keterandalan hasil penelitian jika dilakukan pengukuran atau penelitian berulang dalam kondisi yang sama.

Relevansi Klinis:

Kesesuaian atau keterkaitan hasil penelitian dengan isu-isu nyata dalam praktik kebidanan, termasuk kebutuhan pasien dan konteks pelayanan yang spesifik.

S

Sensitivitas Budaya:

Kemampuan intervensi klinis atau hasil penelitian untuk menghormati dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan tradisi budaya pasien serta masyarakat tempat intervensi dilakukan.

Systematic Review:

Penelitian yang secara sistematis menelaah, menilai, dan menggabungkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai topik tertentu untuk memberikan kesimpulan yang kuat dan komprehensif tentang topik tersebut.

V

Validitas:

Kemampuan sebuah penelitian dalam mengukur dengan tepat apa yang ingin diukur, mencerminkan akurasi metode, penggunaan alat ukur yang tepat, dan minim bias dalam hasil penelitian.

F. Daftar Pustaka

- Bick, D., & Graham, I. D. (Eds.). (2021). Implementing evidence-based practice in healthcare: A facilitation guide (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Dang, D., & Dearholt, S. L. (2022). Johns Hopkins evidence-based practice for nurses and healthcare professionals: Model and guidelines (4th ed.). Sigma Theta Tau International.
- Ellis, P. (2019). Evidence-based practice in nursing (4th ed.). Learning Matters.
- Greenhalgh, T. (2019). How to read a paper: The basics of evidence-based medicine and healthcare (6th ed.). Wiley-Blackwell.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Declercq, E. (2019). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129-1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2000). Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM (2nd ed.). Churchill Livingstone.
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2019). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2021). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO Press.

BAB 6

PRINSIP APLIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN DAN PRINSIP SERTA LANGKAH EVIDENCE-BASED MIDWIFERY CARE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada topik ini, lulusan mampu menerapkan prinsip-prinsip kebidanan berbasis bukti dalam praktik profesional, menggunakan hasil penelitian terbaru untuk meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan kepada ibu, bayi, dan keluarga.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi prinsip aplikasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan.
- Menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah dalam evidence-based midwifery care.
- Mengintegrasikan hasil penelitian terbaru ke dalam praktik kebidanan yang sesuai dengan standar profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep validitas dan reliabilitas dalam hasil penelitian.
- Menentukan kriteria hasil penelitian yang layak diaplikasikan dalam praktik kebidanan.
- Mengikuti langkah-langkah dalam evidence-based midwifery care secara sistematis.

Pendahuluan

Dalam era pelayanan kesehatan modern, kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) menjadi pendekatan penting dalam pengambilan keputusan klinis. Praktik kebidanan berbasis bukti mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, serta nilai, preferensi, dan kebutuhan klien. Implementasi hasil penelitian dalam praktik kebidanan perlu mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk menjamin tindakan yang diberikan efektif, aman, dan bermutu tinggi. Dengan memahami prinsip-prinsip serta langkah-langkah dalam evidence-based midwifery care, bidan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang diberikan.

A. Prinsip Aplikasi Hasil Penelitian dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP), aplikasi hasil penelitian ilmiah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan intervensi yang efektif, aman, dan berbasis pada data empiris yang kuat. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip yang sangat penting diperhatikan oleh para praktisi kebidanan dalam memilih dan menerapkan hasil penelitian tersebut. Prinsip-prinsip ini mencakup validitas dan reliabilitas, relevansi klinis, kemutakhiran informasi, dan kelayakan praktis.

1. Validitas dan Reliabilitas

Dalam konteks penelitian yang akan digunakan dalam praktik kebidanan, prinsip validitas dan reliabilitas memegang peranan yang sangat krusial.

Validitas berarti bahwa penelitian tersebut secara akurat mampu mengukur apa yang memang ingin diukur. Dengan kata lain, validitas penelitian menjamin bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas atau kondisi yang hendak diteliti, sehingga hasilnya tidak bias atau menyimpang dari kenyataan. Validitas tinggi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi klinis yang didasarkan pada hasil penelitian benar-benar efektif dalam kondisi nyata. Desain penelitian yang paling tinggi validitasnya antara lain adalah Randomized Controlled Trials (RCT), systematic reviews, dan meta-analisis.

- a. RCT atau uji coba klinis acak adalah desain penelitian yang paling tinggi tingkat validitasnya karena menggunakan kelompok kontrol dan perlakuan yang dipilih secara acak sehingga meminimalkan bias dalam penelitian.
- b. Systematic reviews merupakan kajian sistematis terhadap berbagai penelitian dengan tujuan mengevaluasi secara kritis semua bukti ilmiah yang relevan sehingga menghasilkan simpulan yang kuat.
- c. Meta-analisis merupakan teknik statistik untuk mengintegrasikan hasil dari beberapa studi yang serupa sehingga dapat memberikan bukti ilmiah yang lebih kuat dan konklusif.

Sementara itu, prinsip reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keandalan hasil penelitian. Penelitian dengan reliabilitas tinggi berarti bahwa ketika penelitian dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama atau serupa, hasilnya akan tetap konsisten. Ini menjamin bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diandalkan secara klinis. Tanpa reliabilitas yang tinggi, penelitian mungkin

memberikan hasil yang bervariasi, sehingga menyulitkan praktisi kebidanan untuk menggunakannya sebagai pedoman tindakan klinis yang pasti.

2. Relevansi Klinis

Prinsip relevansi klinis mengacu pada pentingnya pemilihan penelitian yang benar-benar sesuai dengan permasalahan klinis atau kebutuhan spesifik yang dihadapi dalam praktik kebidanan sehari-hari. Tidak semua penelitian ilmiah yang baik secara metodologi cocok untuk langsung diterapkan dalam praktik klinis. Oleh karena itu, bidan harus selektif dalam memilih penelitian berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks kebidanan di lapangan.

Misalnya, jika seorang bidan menghadapi tingginya kasus anemia pada ibu hamil di suatu wilayah, maka penelitian yang relevan adalah yang secara langsung mengkaji intervensi efektif dalam pencegahan dan penanganan anemia pada kehamilan. Penelitian yang dipilih harus dapat langsung diterapkan secara nyata untuk mengatasi masalah yang spesifik tersebut. Tanpa relevansi klinis, hasil penelitian yang baik sekalipun bisa kehilangan manfaatnya karena tidak secara efektif mengatasi permasalahan yang ada.

3. Kemutakhiran Informasi

Prinsip kemutakhiran informasi menekankan pentingnya memilih hasil penelitian terbaru yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Bidang kebidanan terus mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan penelitian dan inovasi teknologi. Informasi yang mutakhir akan memastikan bahwa praktik kebidanan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman serta tetap dapat memberikan manfaat terbaik bagi pasien dan masyarakat.

Penelitian terbaru sering kali mengungkapkan intervensi atau teknik baru yang lebih efektif, lebih aman, atau lebih efisien dibandingkan dengan metode sebelumnya. Oleh karena itu, bidan harus secara aktif memperbaharui pengetahuannya melalui jurnal ilmiah terbaru, seminar, atau konferensi ilmiah agar tindakan kebidanan yang diberikan selalu berbasis pada informasi terbaru dan memiliki dasar bukti yang kuat serta aktual.

4. Kelayakan Praktis

Prinsip kelayakan praktis merupakan aspek penting yang seringkali diabaikan dalam proses aplikasi hasil penelitian. Sebuah penelitian mungkin saja memiliki validitas, reliabilitas, relevansi, serta kemutakhiran yang sangat tinggi, namun jika tidak memungkinkan untuk diimplementasikan di lingkungan kerja nyata karena keterbatasan sumber daya, peralatan, maupun keterampilan tenaga kesehatan, maka penelitian tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal.

Misalnya, penelitian mengenai manfaat USG 3D/4D dalam skrining kelainan janin mungkin terbukti sangat efektif, tetapi penggunaannya tidak praktis jika diterapkan di wilayah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap alat USG tersebut. Oleh karena itu, bidan harus mempertimbangkan secara realistis apakah hasil penelitian dapat diterapkan secara efektif dengan kondisi yang tersedia, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, peralatan medis, serta kondisi sosial ekonomi pasien yang dilayani.

Dengan menerapkan keempat prinsip di atas—validitas dan reliabilitas, relevansi klinis, kemutakhiran informasi, serta kelayakan praktis—praktik kebidanan berbasis bukti dapat benar-benar memberikan dampak positif, nyata, dan efektif. Hal ini juga menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada ibu, bayi, dan keluarga berbasis pada data empiris yang kuat, relevan dengan permasalahan nyata, didasarkan pada informasi terbaru, serta mampu diimplementasikan secara efektif di berbagai lingkungan kerja kebidanan. Dengan demikian, praktik kebidanan berbasis bukti akan secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan, menjamin keamanan pasien, serta menghasilkan hasil klinis yang optimal.

B. Prinsip dan Langkah dalam Evidence-Based Midwifery Care

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Care (EBMC) adalah pendekatan yang secara strategis menggabungkan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, keahlian dan pengalaman klinis bidan, serta nilai-nilai, preferensi, dan kebutuhan klien. Dalam EBMC, ketiga komponen ini saling melengkapi untuk menghasilkan praktik yang efektif, aman, serta memiliki dampak positif terhadap hasil kesehatan ibu, bayi, dan keluarga.

1. Prinsip-Prinsip dalam Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

a. Berorientasi pada pasien dan keluarga.

Prinsip ini menekankan bahwa dalam memberikan asuhan kebidanan, kebutuhan, kondisi, dan situasi pasien beserta keluarganya harus menjadi titik sentral dari seluruh intervensi klinis. Praktik kebidanan yang berbasis bukti tidak hanya memandang pasien sebagai subjek klinis semata, tetapi juga sebagai individu yang memiliki latar belakang sosial-budaya, emosional, dan psikologis yang berbeda-beda. Oleh karena itu, asuhan kebidanan haruslah bersifat holistik, memperhatikan seluruh aspek kehidupan pasien. Keluarga pasien juga turut dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi asuhan kebidanan agar praktik yang dilakukan lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan konteks kehidupan pasien.

b. Mengutamakan penggunaan bukti ilmiah terbaik.

Prinsip penggunaan bukti ilmiah terbaik menegaskan bahwa setiap keputusan klinis harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terkini dengan kualitas tinggi. Bukti ilmiah terbaik biasanya diperoleh dari desain penelitian yang kuat seperti Randomized Controlled Trials (RCT), systematic reviews, dan meta-analisis. Dengan mengacu pada bukti ilmiah terbaik, bidan mampu memberikan asuhan klinis yang paling efektif, aman, dan terbukti secara empiris dapat memperbaiki kondisi kesehatan pasien secara optimal. Menggunakan bukti ilmiah terbaik juga memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan tradisi atau pengalaman pribadi semata, tetapi benar-benar didukung oleh data yang teruji secara ilmiah.

c. Mengintegrasikan pengalaman klinis.

Meskipun bukti ilmiah adalah kunci utama dalam EBMP, pengalaman klinis bidan tetap memiliki peranan penting. Keahlian klinis seorang bidan, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, serta pengalaman di lapangan, merupakan modal penting untuk menilai kondisi pasien secara menyeluruh, menentukan intervensi yang paling sesuai, serta menerapkan hasil penelitian secara tepat di lapangan. Integrasi pengalaman klinis ini penting karena setiap kasus klinis memiliki keunikannya sendiri, dan tidak selalu hasil penelitian dapat secara langsung diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik di tempat praktik.

d. Menyesuaikan dengan nilai dan preferensi pasien.

Salah satu prinsip utama EBMP adalah bahwa tindakan klinis harus selalu menghargai nilai, preferensi, serta kebutuhan pasien. Setiap pasien memiliki nilai pribadi, keyakinan budaya, serta preferensi dalam perawatan kesehatannya sendiri. Bidan harus secara aktif berdiskusi dengan pasien mengenai berbagai pilihan yang tersedia berdasarkan bukti ilmiah, sekaligus menghargai pilihan pasien sebagai bagian integral dari keputusan akhir dalam asuhan kebidanan. Dengan demikian, pasien tidak hanya menerima pelayanan kesehatan secara pasif, tetapi menjadi mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

e. Melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap hasil yang diperoleh.

Prinsip evaluasi berkelanjutan menegaskan bahwa EBMP tidak hanya berhenti pada tahap penerapan hasil penelitian, melainkan juga mencakup pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus terhadap hasil tindakan klinis yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi kebidanan yang diterapkan benar-benar efektif, aman, serta memberikan

manfaat maksimal bagi pasien dan keluarga. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan kurang optimal, maka perlu dilakukan penyesuaian atau modifikasi sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi pasien dan temuan penelitian yang terbaru.

Dengan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip ini, maka praktik kebidanan berbasis bukti dapat diwujudkan secara optimal. Hasilnya, pasien akan menerima pelayanan kebidanan yang tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga bersifat personal, menghargai nilai-nilai individual pasien, serta dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui evaluasi yang sistematis dan teratur. Hal ini menciptakan suatu budaya praktik klinis yang dinamis, responsif terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasien, serta mampu secara nyata meningkatkan kualitas layanan kebidanan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

2. Langkah-Langkah dalam EBMP:

Penerapan praktik kebidanan berbasis bukti (EBMP) dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui serangkaian langkah yang jelas dan konsisten. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa praktik kebidanan yang diberikan benar-benar berbasis pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, relevan secara klinis, dan efektif untuk pasien serta keluarga. Secara umum, terdapat enam langkah utama yang harus dilakukan dalam EBMP.

a. Formulasi Pertanyaan Klinis:

Langkah pertama dalam EBMP adalah merumuskan pertanyaan klinis yang jelas dan spesifik. Pertanyaan klinis harus dirancang menggunakan format PICO yang terdiri dari:

- **P (Patient/Population):** Menggambarkan karakteristik pasien atau populasi yang menjadi subjek penelitian. Misalnya, ibu hamil primigravida usia 20-35 tahun yang mengalami anemia.
- **I (Intervention):** Intervensi atau tindakan spesifik yang akan dinilai efektivitasnya. Misalnya, suplementasi zat besi dosis tinggi.
- **C (Comparison):** Tindakan pembanding atau kontrol, misalnya suplementasi zat besi dosis standar.
- **(Outcome):** Hasil atau dampak yang ingin diamati, misalnya peningkatan kadar hemoglobin atau penurunan angka anemia.

Dengan menggunakan format PICO ini, bidan akan mampu merumuskan pertanyaan klinis yang jelas, terarah, dan spesifik sehingga memudahkan proses pencarian bukti ilmiah yang relevan.

b. Pencarian Bukti Ilmiah:

Setelah pertanyaan klinis terbentuk dengan jelas, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian bukti ilmiah yang relevan. Proses pencarian ini dilakukan secara sistematis di berbagai database ilmiah terpercaya seperti PubMed, Cochrane Library, ScienceDirect, serta jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional khusus kebidanan.

Proses pencarian harus menggunakan kata kunci yang relevan dengan komponen-komponen dalam pertanyaan klinis (PICO). Selain itu, dalam pencarian bukti ilmiah ini, bidan perlu memperhatikan kualitas dan tipe penelitian yang diambil, seperti Randomized Controlled Trials (RCT), systematic review, dan meta-analisis, yang merupakan sumber bukti ilmiah dengan kualitas tertinggi.

c. Evaluasi Kritis terhadap Bukti Ilmiah:

Setelah bukti ilmiah yang relevan ditemukan, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi kritis terhadap hasil penelitian tersebut. Evaluasi kritis ini bertujuan untuk menilai secara cermat validitas, reliabilitas, relevansi klinis, serta kualitas penelitian yang ditemukan.

Evaluasi kritis meliputi pemeriksaan metodologi penelitian, apakah desain penelitian cukup kuat untuk mendukung hasil yang diperoleh, apakah penelitian tersebut mampu meminimalkan bias, apakah hasil penelitian tersebut konsisten (reliabilitas tinggi), serta sejauh mana hasil penelitian relevan dan dapat diaplikasikan ke dalam situasi klinis yang nyata.

Proses ini memastikan bahwa hanya penelitian berkualitas tinggi dan relevan yang akan digunakan sebagai dasar dalam praktik kebidanan.

d. Integrasi Bukti Ilmiah dengan Keahlian Klinis:

Langkah ini merupakan proses menggabungkan hasil penelitian yang telah dievaluasi secara kritis dengan pengalaman klinis dan keahlian yang dimiliki oleh bidan serta preferensi dari pasien. Proses integrasi ini sangat penting, karena setiap situasi klinis memiliki karakteristik khusus yang mungkin memerlukan adaptasi tertentu dari hasil penelitian yang ada.

Keahlian klinis seorang bidan akan membantu dalam menerapkan bukti ilmiah secara tepat, sesuai konteks lokal dan spesifik pasien yang dilayani. Selain itu, preferensi pasien seperti nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan kebutuhan pribadi pasien juga menjadi pertimbangan utama untuk memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan harapan dan nilai-nilai pasien serta keluarganya.

e. Implementasi dalam Praktik Klinis:

Setelah hasil penelitian dan keahlian klinis diintegrasikan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikan intervensi berbasis bukti tersebut secara nyata dalam praktik klinis. Implementasi ini merupakan aplikasi langsung dari intervensi yang didasarkan pada bukti ilmiah di tempat praktik bidan seperti klinik, puskesmas, rumah sakit, atau tempat praktik mandiri.

Pada tahap ini, bidan bertanggung jawab memastikan bahwa intervensi dilaksanakan dengan tepat, jelas, dan sistematis. Selain itu, implementasi juga memerlukan komunikasi efektif kepada pasien serta keluarga agar mereka memahami dengan jelas mengenai manfaat, tujuan, serta hasil yang diharapkan dari intervensi berbasis bukti tersebut.

f. Evaluasi dan Refleksi:

Langkah terakhir dalam EBMP adalah evaluasi dan refleksi yang bersifat berkelanjutan. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak nyata dari intervensi yang telah dilakukan terhadap hasil klinis, kesejahteraan pasien, serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi melibatkan pengumpulan data secara sistematis untuk menilai apakah intervensi berhasil mencapai hasil yang diharapkan, seperti peningkatan status kesehatan pasien, penurunan angka komplikasi, atau peningkatan kepuasan pasien.

Setelah evaluasi, bidan harus melakukan refleksi mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan dalam penerapan intervensi berbasis bukti. Proses refleksi ini penting untuk mengembangkan strategi perbaikan secara berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan kebidanan akan semakin meningkat. Jika evaluasi menunjukkan adanya kekurangan atau hambatan, maka perlu dilakukan penyesuaian, modifikasi, atau mencari alternatif lain yang lebih efektif berdasarkan bukti ilmiah yang terbaru.

Dengan mengikuti keenam langkah tersebut secara konsisten, terstruktur, dan sistematis, praktik kebidanan berbasis bukti akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu layanan kebidanan, keselamatan pasien, serta hasil kesehatan ibu, bayi, dan keluarga secara optimal. Hal ini sekaligus menjamin bahwa praktik kebidanan yang diberikan benar-benar berdasarkan bukti ilmiah terbaik, relevan secara klinis, serta mampu diimplementasikan secara nyata di berbagai kondisi dan situasi pelayanan kebidanan.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan di sebuah Puskesmas daerah terpencil ingin menggunakan hasil penelitian tentang pemberian suplemen zat besi dosis tinggi untuk menurunkan angka anemia pada ibu hamil di wilayahnya. Langkah pertama yang harus dilakukan bidan sesuai dengan prinsip EBMP adalah...

- A. Mengintegrasikan hasil penelitian dengan pengalaman klinis
- B. Melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas penelitian
- C. Merumuskan pertanyaan klinis spesifik menggunakan format PICO
- D. Langsung mengimplementasikan hasil penelitian dalam praktik klinis
- E. Mengevaluasi hasil penelitian setelah diterapkan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Langkah pertama EBMP adalah merumuskan pertanyaan klinis spesifik dengan format PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) agar pencarian bukti ilmiah dapat dilakukan dengan jelas dan terarah.

Soal 2

Seorang bidan akan menerapkan hasil penelitian terbaru terkait penggunaan teknik pijat perineum untuk mengurangi risiko robekan saat persalinan pada primigravida. Sebelum melakukan implementasi, aspek yang paling penting dipertimbangkan terkait penelitian tersebut adalah...

- A. Usia penelitian yang lebih dari 15 tahun
- B. Popularitas teknik tersebut di kalangan bidan
- C. Validitas, reliabilitas, relevansi, dan kelayakan praktis penelitian
- D. Penelitian dilakukan di luar negeri sehingga lebih baik
- E. Teknik penelitian menggunakan metode observasional sederhana

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Sebelum implementasi klinis, evaluasi kritis terhadap validitas, reliabilitas, relevansi klinis, dan kelayakan praktis penelitian sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian efektif, aman, dan realistis untuk diterapkan dalam situasi kebidanan sehari-hari.

Soal 3

Seorang bidan menemukan penelitian tentang manfaat USG 3D/4D dalam deteksi dini kelainan janin. Namun, wilayah tempatnya bekerja tidak memiliki fasilitas USG tersebut. Prinsip EBMP yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam situasi ini adalah...

- A. Validitas hasil penelitian
- B. Kemutakhiran hasil penelitian
- C. Kelayakan praktis implementasi
- D. Reliabilitas penelitian
- E. Relevansi klinis secara umum

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Prinsip kelayakan praktis sangat penting, karena intervensi yang berbasis bukti sekalipun tidak akan efektif jika tidak didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai seperti peralatan dan fasilitas medis.

Soal 4

Seorang bidan menghadapi kasus meningkatnya angka preeklamsia di daerah praktiknya. Ia menemukan beberapa penelitian tentang intervensi profilaksis preeklamsia. Dari pilihan berikut, desain penelitian mana yang memberikan validitas tertinggi?

- A. Studi kasus tunggal
- B. Studi cross-sectional
- C. Randomized Controlled Trials (RCT)
- D. Laporan kasus dari pakar kebidanan senior
- E. Editorial jurnal ilmiah kebidanan

Kunci Jawaban: C

Rasional:

RCT memiliki tingkat validitas tertinggi karena subjek penelitian dipilih secara acak, meminimalkan risiko bias, serta memberikan bukti ilmiah yang paling kuat untuk dasar tindakan klinis.

Soal 5

Seorang bidan menerapkan hasil penelitian terbaru tentang manfaat pendampingan keluarga dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Setelah 3 bulan penerapan, ia menemukan hasil tidak optimal. Langkah yang paling tepat dilakukan bidan berdasarkan EBMP adalah...

- A. Tetap menerapkan intervensi tanpa modifikasi
- B. Mengabaikan hasil evaluasi dan melanjutkan intervensi
- C. Melakukan evaluasi dan refleksi untuk mencari hambatan serta melakukan modifikasi sesuai temuan evaluasi
- D. Menghentikan program karena hasilnya tidak sesuai harapan
- E. Langsung mencari penelitian baru tanpa melakukan refleksi evaluasi

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Dalam EBMP, evaluasi secara berkala diikuti oleh refleksi kritis bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan serta melakukan perbaikan atau modifikasi intervensi guna mencapai hasil optimal dalam pelayanan kebidanan.

D. Rangkuman Materi

Penerapan Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) dalam praktik kebidanan merupakan pendekatan sistematis dan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui penggunaan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Empat prinsip utama dalam aplikasi hasil penelitian adalah validitas dan reliabilitas penelitian untuk menjamin hasil yang akurat dan konsisten, relevansi klinis untuk memastikan penelitian sesuai dengan masalah klinis yang nyata, kemutakhiran informasi agar intervensi tetap efektif dan relevan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, serta kelayakan praktis untuk memastikan intervensi dapat diterapkan dengan sumber daya yang tersedia di lapangan.

Secara operasional, EBMP dilaksanakan melalui enam langkah yang jelas dan terstruktur, yaitu formulasi pertanyaan klinis spesifik menggunakan format PICO, pencarian bukti ilmiah melalui database terpercaya, evaluasi kritis terhadap kualitas bukti ilmiah, integrasi bukti ilmiah dengan pengalaman klinis bidan dan preferensi pasien, implementasi intervensi berbasis bukti dalam praktik klinis, serta evaluasi berkelanjutan diikuti refleksi untuk peningkatan kualitas layanan.

Dengan menerapkan prinsip dan langkah-langkah tersebut secara konsisten, bidan mampu memberikan pelayanan kebidanan yang efektif, aman, relevan secara klinis, dan dapat terus ditingkatkan melalui proses evaluasi yang sistematis. Praktik ini akan menghasilkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan keluarga yang optimal, meningkatkan kepuasan pasien, serta memastikan keamanan dan mutu layanan kebidanan secara berkelanjutan.

E. Glosarium

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Pendekatan praktik kebidanan yang menggunakan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis praktisi, serta nilai-nilai dan preferensi pasien untuk memberikan asuhan kebidanan yang efektif, aman, dan berkualitas tinggi.

Validitas

Kemampuan suatu penelitian untuk secara akurat mengukur apa yang memang ingin diukur, sehingga hasilnya mencerminkan realitas sebenarnya dan tidak bias atau menyimpang.

Reliabilitas

Konsistensi atau keandalan hasil penelitian, yaitu kemampuan penelitian untuk memberikan hasil yang sama atau serupa ketika dilakukan berulang kali dalam kondisi yang sama.

Randomized Controlled Trials (RCT)

Desain penelitian eksperimental yang mengalokasikan subjek penelitian secara acak ke dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk mengurangi risiko bias dan meningkatkan validitas penelitian.

Systematic Reviews

Kajian ilmiah sistematis terhadap berbagai penelitian yang relevan, bertujuan mengevaluasi secara kritis semua bukti ilmiah terkait suatu topik untuk menghasilkan simpulan kuat.

Meta-analisis

Teknik statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa studi serupa untuk mendapatkan bukti ilmiah yang lebih kuat dan lebih konklusif daripada hasil studi tunggal.

Relevansi Klinis

Tingkat kesesuaian hasil penelitian dengan kondisi atau masalah klinis spesifik yang dihadapi dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Kemutakhiran Informasi

Prinsip yang menekankan pentingnya penggunaan hasil penelitian terbaru yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menjamin praktik kebidanan tetap efektif dan aman.

Kelayakan Praktis

Kemampuan suatu hasil penelitian untuk secara realistis diterapkan di lingkungan praktik klinis, memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, peralatan medis, dan kondisi sosial ekonomi.

Formulasi Pertanyaan Klinis (PICO)

Langkah awal EBMP dalam menyusun pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik, menggunakan format PICO:

P (Patient/Population): Pasien atau populasi yang diteliti.

I (Intervention): Intervensi atau tindakan yang dievaluasi.

C (Comparison): Tindakan atau intervensi pembandingan.

O (Outcome): Hasil atau dampak yang diinginkan dari intervensi.

F. Daftar Pustaka

- American College of Nurse-Midwives. (2019). Evidence-based practice: A primer for midwives. American College of Nurse-Midwives. <https://www.midwife.org/acnm/files/cclibraryfiles/filename/000000006791/Evidence-Based-Practice-Primer.pdf>
- Bick, D., & Graham, I. D. (2019). The importance of implementing evidence-based practice in midwifery. *Midwifery*, 69, 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.12.006>
- Burns, N., & Grove, S. K. (2019). *Understanding nursing research: Building an evidence-based practice* (7th ed.). Elsevier.
- Higgins, J. P., Thomas, J., Chandler, J., Cumpston, M., Li, T., Page, M. J., & Welch, V. A. (Eds.). (2019). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions* (2nd ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119536604>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Renfrew, M. J., Homer, C. S., Downe, S., McFadden, A., Muir, N., Prentice, T., & ten Hoope-Bender, P. (2019). Midwifery: An evidence-based profession. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence-based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf>

World Health Organization. (2020). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience: Summary. WHO Press. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>

BAB 7

KEPAKARAN KLINIS (CLINICAL EXPERTISE): PENGAMBILAN KEPUTUSAN KLINIS DALAM ASUHAN, REFLEKTIF

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kepakaran klinis dalam pengambilan keputusan dan melakukan praktik reflektif secara kritis dalam asuhan kebidanan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu mengintegrasikan kepakaran klinis dalam pengambilan keputusan klinis dan menerapkan proses reflektif dalam meningkatkan kualitas praktik kebidanan yang didasarkan pada bukti ilmiah.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan konsep dan komponen kepakaran klinis dalam kebidanan.
2. Menerapkan prinsip pengambilan keputusan klinis berdasarkan pendekatan evidence-based.
3. Mengidentifikasi pentingnya refleksi dalam peningkatan kualitas praktik klinis.
4. Menjalankan praktik reflektif secara rutin sebagai sarana pengembangan profesional.

Pendahuluan

Kepakaran klinis merupakan elemen sentral dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Kepakaran ini tidak hanya mencakup pengetahuan teoretis tetapi juga kemampuan dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan pengalaman, intuisi, dan penalaran yang matang. Dalam konteks praktik kebidanan, pengambilan keputusan klinis yang tepat dan refleksi yang berkesinambungan menjadi kunci dalam memberikan asuhan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

A. Konsep Dasar Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan

Kepakaran klinis (clinical expertise) dalam bidang kebidanan merupakan suatu kombinasi unik antara pengetahuan teoritis yang luas, keterampilan klinis tingkat tinggi, intuisi profesional yang tajam, dan kemampuan mengambil keputusan klinis yang cermat serta efektif berdasarkan pengalaman praktik yang ekstensif. Menurut Benner (2021), kepakaran klinis merupakan kondisi akhir dari perjalanan profesional seorang praktisi kesehatan yang berkembang melalui tahapan dari pemula (novice) hingga menjadi pakar (expert). Dalam konteks kebidanan, seorang bidan yang memiliki kepakaran klinis mampu mengenali pola-pola klinis yang kompleks secara cepat dan akurat, bahkan dalam situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, berkat pengalaman klinisnya yang ekstensif.

Karakteristik utama dari kepakaran klinis mencakup kemampuan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia dengan intuisi klinis yang dikembangkan melalui pengalaman praktis berulang (Edwards & Johnson, 2021). Kepakaran klinis juga dicirikan oleh kemampuan dalam mengelola kompleksitas situasi klinis yang dinamis serta membuat keputusan secara fleksibel, tepat waktu, dan efektif dalam berbagai konteks klinis yang berbeda (Thompson & Stapley, 2022). Selain itu, seorang bidan yang memiliki kepakaran klinis biasanya mampu memberikan asuhan yang tidak hanya berbasis pada pedoman klinis formal tetapi juga mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kebutuhan unik pasien secara individual.

Dalam praktik kebidanan, kepakaran klinis menjadi esensial karena berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan hasil klinis yang optimal bagi ibu dan bayi. Ferguson et al. (2020) menegaskan bahwa bidan dengan kepakaran klinis mampu mengurangi risiko komplikasi dan meningkatkan tingkat keberhasilan dalam intervensi kebidanan, terutama dalam situasi klinis yang kritis dan kompleks. Kemampuan seorang bidan untuk menerapkan intuisi klinisnya dalam situasi yang ambigu dan penuh ketidakpastian menjadi aset penting dalam memastikan keselamatan pasien sekaligus mengoptimalkan proses pengambilan keputusan klinis yang efisien.

Lebih jauh, kepakaran klinis dalam kebidanan juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara bidan dengan pasien. Wilson dan Hutchinson (2021) menemukan bahwa kemampuan interpersonal yang berkembang bersamaan dengan kepakaran klinis secara signifikan meningkatkan komunikasi terapeutik, kepercayaan pasien, dan kepuasan dalam pelayanan kebidanan. Bidan dengan

tingkat kepakaran klinis tinggi memiliki kemampuan yang unggul dalam berkomunikasi secara efektif, empati, dan membangun hubungan profesional yang kuat dengan pasien serta keluarganya, yang merupakan aspek krusial dalam memberikan pelayanan kebidanan yang berpusat pada pasien.

Pentingnya kepakaran klinis dalam praktik kebidanan juga terlihat dari segi pendidikan dan pengembangan profesional. Gibson dan Hunter (2022) menyatakan bahwa pengembangan kepakaran klinis merupakan tujuan utama dalam pendidikan kebidanan, baik dalam pendidikan formal maupun informal melalui pelatihan berbasis simulasi, praktik klinis langsung, serta mentorship. Proses pendidikan yang efektif dalam mengembangkan kepakaran klinis tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik semata, tetapi juga pada keterampilan klinis, kemampuan reflektif, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai profesi kebidanan.

Sebagai penutup, kepakaran klinis tidak hanya berfungsi sebagai fondasi untuk praktik kebidanan berbasis bukti tetapi juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan klinis yang efektif, meningkatkan mutu pelayanan pasien, memperkuat komunikasi dan hubungan terapeutik, serta memajukan pendidikan dan pengembangan profesional dalam kebidanan. Dengan demikian, pengembangan kepakaran klinis harus terus menjadi prioritas dalam pendidikan dan praktik kebidanan untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang optimal dan berkualitas tinggi (Lee et al., 2023).

B. Komponen Utama Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan

Kepakaran klinis dalam praktik kebidanan tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui kombinasi yang terintegrasi antara pengetahuan teoritis yang mendalam, keterampilan teknis dan interpersonal yang tinggi, serta pengalaman praktik langsung yang berkelanjutan. Ketiga komponen ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain untuk menciptakan praktisi kebidanan yang efektif dan kompeten secara profesional (Thompson & Stapley, 2022).

Pengetahuan teoritis yang mendalam merupakan fondasi utama dari kepakaran klinis dalam kebidanan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, hingga aspek psikososial dan etika yang relevan dalam praktik kebidanan. Menurut Thompson dan Stapley (2022), penguasaan teori yang mendalam memungkinkan bidan tidak hanya memahami fenomena klinis secara ilmiah tetapi juga mengintegrasikan berbagai informasi dengan cepat saat menghadapi situasi klinis yang kompleks. Pengetahuan teoritis yang kokoh memungkinkan bidan untuk membuat keputusan klinis yang berbasis bukti, menilai risiko secara akurat, dan memahami implikasi

berbagai pilihan tindakan yang tersedia secara komprehensif (Melnyk & Fineout-Overholt, 2022).

Selain pengetahuan teoritis, keterampilan teknis yang canggih menjadi salah satu komponen krusial dalam kepakaran klinis kebidanan. Keterampilan teknis ini meliputi kemampuan praktis dalam melaksanakan berbagai prosedur klinis seperti pemeriksaan antenatal, pemantauan fetal, persalinan, penanganan komplikasi obstetri, hingga perawatan neonatal yang tepat dan aman (Wilson & Hutchinson, 2021). Selain keterampilan teknis, keterampilan interpersonal yang kuat juga menjadi aspek penting dalam kepakaran klinis. Keterampilan ini mencakup kemampuan komunikasi terapeutik, empati, mendengarkan aktif, serta kemampuan membangun hubungan kepercayaan dengan pasien dan keluarga. Menurut penelitian yang dilakukan Wilson dan Hutchinson (2021), keterampilan interpersonal bidan berpengaruh besar terhadap tingkat kepuasan pasien serta hasil klinis yang positif. Bidan yang mampu membangun hubungan interpersonal secara efektif lebih berhasil dalam memahami kebutuhan pasien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi klinis.

Pengalaman praktik langsung yang berkelanjutan adalah komponen ketiga yang menjadi dasar kuat dalam pengembangan kepakaran klinis. Melalui praktik langsung yang intensif dan berkelanjutan, seorang bidan mengembangkan intuisi klinis, kemampuan untuk mengenali pola-pola klinis yang kompleks, serta kemampuan membuat keputusan secara cepat dan efektif dalam situasi klinis yang tidak pasti atau ambigu (Smith et al., 2020). Dalam pandangan Benner (2021), pengalaman praktik langsung yang luas memungkinkan praktisi kebidanan bertransformasi dari tahap pemula (novice) menjadi tahap ahli (expert), dimana seorang bidan mampu mengantisipasi masalah secara proaktif berdasarkan pengalamannya dalam berbagai situasi klinis yang pernah dialami sebelumnya.

Proses pembelajaran dalam praktik langsung tidak hanya berlangsung secara spontan, tetapi memerlukan refleksi yang terus-menerus dan sistematis. Refleksi ini memungkinkan bidan untuk terus belajar dari pengalaman klinis sebelumnya, memperbaiki kesalahan, dan meningkatkan kompetensinya secara konsisten. Menurut Mann et al. (2021), praktik reflektif yang terstruktur secara rutin terbukti efektif dalam mempercepat pengembangan kepakaran klinis, karena memungkinkan praktisi kesehatan, termasuk bidan, untuk secara kritis mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka serta membuat perubahan strategis demi meningkatkan kualitas asuhan di masa depan.

Dalam konteks kebidanan modern, penting untuk memastikan ketiga komponen ini—pengetahuan teoritis, keterampilan teknis dan interpersonal, serta

pengalaman praktik langsung—dapat dikembangkan secara harmonis dan berkelanjutan melalui pendekatan pendidikan berbasis kompetensi, mentorship klinis yang efektif, serta pelatihan berbasis simulasi yang inovatif (Cant & Cooper, 2021). Pendekatan yang terintegrasi ini memastikan bahwa praktisi kebidanan memiliki kepakaran klinis yang tidak hanya luas dalam teori, tetapi juga terampil secara praktis dan interpersonal serta berpengalaman secara klinis, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan bayi.

C. Peran Kepakaran Klinis dalam Pengambilan Keputusan dalam Praktik Kebidanan

Pengambilan keputusan klinis merupakan inti dari praktik kebidanan berbasis bukti, di mana kepakaran klinis memainkan peran sentral dalam menjamin keputusan yang diambil tepat, efektif, dan optimal untuk kesehatan ibu dan bayi. Kepakaran klinis dalam konteks kebidanan tidak hanya mencakup penguasaan pengetahuan teori tetapi juga integrasi mendalam antara pengalaman klinis, hasil penelitian terbaru, dan proses berpikir kritis yang matang (Melnyk & Fineout-Overholt, 2022).

Salah satu elemen penting dalam pengambilan keputusan klinis adalah integrasi pengalaman klinis dengan bukti penelitian. Seorang bidan dengan kepakaran klinis tinggi mampu menyelaraskan pengalaman praktisnya dengan bukti ilmiah terkini sehingga menghasilkan keputusan klinis yang tidak hanya sesuai dengan standar praktik terbaik tetapi juga relevan dengan kondisi pasien secara individual (Edwards & Johnson, 2021). Melalui integrasi ini, seorang bidan dapat secara kritis mengevaluasi relevansi hasil penelitian ilmiah terhadap situasi klinis yang dihadapinya, serta mengidentifikasi kapan suatu hasil penelitian dapat diterapkan secara langsung, kapan perlu modifikasi, atau kapan diperlukan kebijaksanaan khusus berdasarkan konteks unik pasien (Lee et al., 2023).

Lebih lanjut, proses pengambilan keputusan klinis dalam kebidanan melibatkan serangkaian proses kognitif kompleks, seperti persepsi, interpretasi data klinis, penilaian situasi, dan pengambilan tindakan yang cepat namun terukur. Menurut Thompson dan Stapley (2022), proses kognitif yang baik dalam pengambilan keputusan klinis mencakup kemampuan dalam mengenali pola klinis yang muncul, penalaran analitis, dan refleksi intuitif berdasarkan pengalaman yang luas. Proses ini sering kali melibatkan perpaduan antara penalaran deduktif—di mana seorang bidan secara logis menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia—dan penalaran induktif, yang berbasis pada pengamatan empiris dari berbagai kasus klinis sebelumnya. Kepakaran klinis yang matang memungkinkan seorang bidan dengan cepat dan tepat menginterpretasi informasi klinis yang kompleks serta

mengambil keputusan yang bijaksana bahkan dalam situasi yang ambigu atau berisiko tinggi (Edwards & Johnson, 2021).

Proses pengambilan keputusan klinis yang berkualitas tinggi tidak terpisahkan dari kemampuan refleksi, yang memungkinkan bidan mengevaluasi secara mendalam keputusan-keputusan sebelumnya, belajar dari kesalahan, serta terus meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan klinis di masa mendatang. Praktik refleksi ini terbukti mampu meningkatkan kualitas keputusan klinis melalui identifikasi aspek-aspek yang perlu disesuaikan atau diperbaiki berdasarkan pengalaman sebelumnya (Mann et al., 2021). Oleh karena itu, integrasi proses refleksi secara rutin menjadi penting dalam mengasah proses kognitif yang mendasari pengambilan keputusan klinis.

Implikasi dari keputusan klinis dalam praktik kebidanan sangat signifikan terhadap hasil asuhan. Kepakaran klinis yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan hasil klinis, seperti penurunan komplikasi obstetri, peningkatan kepuasan pasien, serta peningkatan keselamatan ibu dan bayi (Lee et al., 2023). Keputusan klinis yang tepat waktu, akurat, dan berbasis bukti dapat secara signifikan mengurangi risiko intervensi medis yang tidak perlu dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Sebaliknya, keputusan klinis yang kurang tepat berisiko menyebabkan komplikasi, kegagalan terapi, atau bahkan hasil asuhan yang tidak optimal bagi pasien dan keluarga (Ferguson et al., 2020).

Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa bidan dengan kepakaran klinis yang tinggi cenderung mampu merancang intervensi klinis yang bersifat individual dan holistik. Mereka secara efektif mengombinasikan aspek teknis dan interpersonal dalam asuhan yang diberikan sehingga pasien merasa didengar, dihargai, dan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka sendiri (Wilson & Hutchinson, 2021). Dengan demikian, kepakaran klinis tidak hanya berdampak pada aspek teknis kesehatan tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas hubungan terapeutik antara bidan dan pasien, yang merupakan komponen penting dalam perawatan kebidanan yang efektif.

Secara keseluruhan, kepakaran klinis memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan klinis dalam kebidanan dilakukan dengan pendekatan yang holistik, kritis, dan berbasis bukti. Dengan mengintegrasikan pengalaman klinis, bukti penelitian, serta proses berpikir reflektif yang mendalam, seorang bidan dapat memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil akan menghasilkan hasil asuhan yang optimal serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

D. Praktik Reflektif sebagai Bagian Kepakaran Klinis dalam Praktik Kebidanan

Praktik reflektif merupakan elemen penting dalam pengembangan kepakaran klinis dalam praktik kebidanan. Menurut Schon (2022), praktik reflektif adalah proses introspektif di mana seorang profesional secara sadar mengevaluasi pengalaman praktik klinisnya untuk memahami keputusan yang telah diambil serta konsekuensi yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Praktik reflektif tidak hanya sebatas mengingat kembali tindakan yang telah dilakukan, tetapi lebih pada proses analitis kritis terhadap peristiwa klinis untuk mendapatkan wawasan mendalam yang bisa diaplikasikan pada situasi klinis berikutnya (Mann, Gordon, & MacLeod, 2021).

Praktik reflektif dalam kebidanan memiliki beberapa tahapan penting. Tahap pertama adalah tahap deskriptif, di mana seorang bidan mendeskripsikan secara objektif situasi klinis yang dialami tanpa bias atau interpretasi awal. Pada tahap ini, tujuan utama adalah mendapatkan gambaran jelas tentang situasi yang dihadapi (Schon, 2022). Tahap berikutnya adalah tahap analisis, yaitu proses penilaian secara kritis terhadap situasi klinis dengan mempertanyakan tindakan yang diambil, hasil yang dicapai, dan alternatif yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tahap ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan serta dampak klinis dan interpersonal yang dihasilkan (Mann et al., 2021). Tahap terakhir adalah tahap sintesis, di mana bidan menarik pelajaran dari analisis tersebut dan merumuskan tindakan baru yang akan diimplementasikan dalam praktik klinis mendatang.

Manfaat utama dari praktik reflektif dalam kebidanan adalah peningkatan kualitas asuhan klinis secara berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi mendalam membantu bidan memperbaiki keputusan klinis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan keterampilan interpersonal yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap hasil klinis pasien (Wilson & Hutchinson, 2021). Melalui proses refleksi, bidan dapat lebih jelas mengidentifikasi kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan praktik nyata di lapangan. Kesadaran ini memungkinkan mereka untuk terus menyesuaikan pendekatan klinis mereka berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan pengalaman pribadi yang terakumulasi seiring waktu (Mann et al., 2021).

Selain meningkatkan kompetensi teknis, refleksi juga memperkuat kemampuan interpersonal dan empati bidan. Wilson dan Hutchinson (2021) mengungkapkan bahwa praktik reflektif membantu bidan memahami secara lebih mendalam perspektif pasien, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih personal dan efektif. Kemampuan ini sangat penting dalam kebidanan, di mana hubungan interpersonal yang kuat antara bidan dan pasien merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kepuasan pasien dan keberhasilan intervensi kebidanan.

Untuk menjalankan praktik reflektif secara efektif, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam praktik kebidanan. Pertama adalah penggunaan jurnal reflektif sebagai alat bantu rutin. Menurut Taylor dan Jones (2023), jurnal reflektif memungkinkan bidan mencatat secara sistematis pengalaman klinis harian, melakukan analisis kritis terhadap situasi yang kompleks, dan mendokumentasikan pelajaran penting untuk referensi masa depan. Strategi lainnya adalah penggunaan diskusi reflektif berbasis kelompok, di mana bidan secara teratur bertemu dengan kolega atau mentor untuk berdiskusi tentang kasus-kasus klinis tertentu. Diskusi ini menciptakan lingkungan pembelajaran kolaboratif, di mana pengalaman dan perspektif dari berbagai praktisi bisa memperkaya pemahaman terhadap situasi klinis yang kompleks (Gibson & Hunter, 2022).

Pelatihan dan mentoring reflektif juga menjadi bagian integral dalam strategi efektif pengembangan praktik reflektif. Menurut Gibson dan Hunter (2022), mentorship yang efektif dalam kebidanan tidak hanya melibatkan supervisi klinis tetapi juga mendorong bidan untuk aktif merefleksikan pengalamannya secara mendalam. Mentor berperan sebagai fasilitator yang membantu bidan mengidentifikasi pola pikir atau asumsi yang mungkin perlu diubah, serta membimbing mereka dalam menyusun rencana tindakan konkret berdasarkan refleksi klinis yang dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan bidan untuk secara sistematis meningkatkan kualitas praktiknya dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, praktik reflektif merupakan unsur kunci dalam kepakaran klinis dalam praktik kebidanan yang membantu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, meningkatkan mutu pelayanan, dan memperkuat hubungan interpersonal dengan pasien. Melalui proses reflektif yang terstruktur dan kontinu, bidan dapat terus memperbaiki diri, beradaptasi dengan tantangan klinis yang terus berubah, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan senantiasa sesuai dengan standar tertinggi dalam praktik berbasis bukti.

E. Pengembangan Kepakaran Klinis dalam Pendidikan Kebidanan

Kepakaran klinis dalam kebidanan merupakan hasil dari proses pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, kontinu, dan intensif. Pendidikan kebidanan saat ini berfokus pada pengembangan kemampuan klinis yang komprehensif agar lulusan mampu menghadapi tantangan kompleks dalam praktik profesional. Untuk itu, pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada simulasi klinis, mentorship, serta identifikasi tantangan dan solusi dalam pengembangan kompetensi klinis menjadi sangat penting.

Salah satu pendekatan utama dalam pengembangan kepakaran klinis adalah model pembelajaran berbasis simulasi klinis. Model ini merupakan metode

pembelajaran inovatif yang menggunakan skenario klinis tiruan untuk meniru kondisi nyata yang akan dihadapi mahasiswa di lapangan. Simulasi memungkinkan mahasiswa kebidanan untuk melatih keterampilan teknis, komunikasi, serta pengambilan keputusan klinis dalam lingkungan yang aman dan terkendali (Cant & Cooper, 2021). Menurut penelitian Cant dan Cooper (2021), simulasi klinis mampu mempercepat transisi mahasiswa dari tahap teori ke praktik, dengan memungkinkan mereka mendapatkan pengalaman langsung tanpa risiko bagi pasien. Dengan demikian, simulasi klinis membantu meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi teknis, dan kesiapan menghadapi tantangan klinis yang sesungguhnya.

Simulasi klinis mencakup berbagai skenario seperti persalinan normal, penanganan komplikasi obstetri, manajemen emergensi neonatal, hingga komunikasi dengan pasien dalam situasi krisis. Selain melatih keterampilan teknis, simulasi juga menekankan pengembangan keterampilan interpersonal seperti komunikasi efektif, empati, dan kolaborasi tim, yang esensial dalam praktik kebidanan modern (Taylor & Jones, 2023). Melalui simulasi, mahasiswa tidak hanya belajar dari pengalaman langsung tetapi juga dari refleksi yang dilakukan setelah simulasi selesai, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap tindakan klinis yang tepat dan relevan dalam konteks praktik yang nyata (Mann et al., 2021).

Selain model simulasi, peran mentorship juga sangat penting dalam mengembangkan kompetensi klinis mahasiswa kebidanan. Mentorship merupakan hubungan profesional yang sistematis antara mentor berpengalaman dan mahasiswa atau bidan pemula, bertujuan memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik konstruktif secara terus-menerus (Gibson & Hunter, 2022). Menurut Gibson dan Hunter (2022), mentorship klinis memungkinkan mahasiswa kebidanan untuk memperoleh wawasan mendalam dari pengalaman nyata mentor mereka, sekaligus mendapatkan panduan langsung tentang cara menghadapi berbagai situasi klinis yang kompleks. Dalam hubungan mentorship ini, mentor berperan sebagai role model yang menunjukkan praktik klinis terbaik, membantu mahasiswa dalam merefleksikan pengalaman mereka, serta membangun kepercayaan diri dalam praktik profesional.

Mentorship juga memiliki dampak signifikan dalam pengembangan keterampilan interpersonal dan emosional mahasiswa. Wilson dan Hutchinson (2021) menyatakan bahwa mentor yang efektif tidak hanya membantu mahasiswa dalam aspek teknis, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan interpersonal seperti komunikasi empatik, manajemen konflik, serta kemampuan bekerja dalam tim multidisiplin. Melalui proses ini, mahasiswa belajar secara langsung dari mentor tentang bagaimana menciptakan hubungan yang positif dan efektif dengan pasien,

keluarga, dan rekan sejawat, yang merupakan komponen krusial dalam memberikan pelayanan kebidanan yang holistik dan efektif.

Namun, proses pengembangan kepakaran klinis dalam pendidikan kebidanan juga menghadapi beberapa tantangan signifikan. Tantangan utama termasuk terbatasnya akses mahasiswa terhadap pengalaman klinis langsung karena persaingan tinggi dalam penggunaan fasilitas praktik, keterbatasan jumlah mentor berpengalaman, serta variasi kualitas pengalaman klinis di lapangan (Young & Edwards, 2023). Tantangan lain adalah kesenjangan antara teori yang diajarkan di kelas dan praktik nyata di fasilitas kesehatan, yang sering kali membuat mahasiswa mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menerapkan pengetahuan teoritis mereka secara efektif di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa solusi praktis dapat diterapkan. Salah satunya adalah integrasi simulasi klinis secara lebih intensif dan sistematis dalam kurikulum kebidanan, sehingga mahasiswa mendapatkan lebih banyak kesempatan latihan sebelum memasuki situasi klinis nyata (Cant & Cooper, 2021). Selain itu, memperluas dan meningkatkan kualitas program mentorship melalui pelatihan khusus bagi mentor dapat membantu memastikan bahwa mentor mampu memberikan bimbingan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan mahasiswa (Gibson & Hunter, 2022). Kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman klinis yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Lebih jauh, strategi untuk meningkatkan praktik reflektif mahasiswa melalui pelatihan refleksi kritis dan jurnal reflektif dapat membantu mahasiswa memahami dan mengevaluasi pengalaman klinis mereka secara mendalam (Taylor & Jones, 2023). Proses ini membantu mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan praktik klinis, sekaligus memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah klinis secara efektif.

Secara keseluruhan, pengembangan kepakaran klinis dalam pendidikan kebidanan membutuhkan pendekatan pendidikan yang komprehensif, inovatif, dan terintegrasi. Model pembelajaran berbasis simulasi klinis, mentorship yang efektif, serta strategi yang mengatasi berbagai tantangan praktik merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa lulusan kebidanan memiliki kompetensi klinis tinggi dan siap menghadapi tantangan klinis yang semakin kompleks di masa depan.

F. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang bidan senior menghadapi pasien yang mengalami perdarahan postpartum yang tidak merespon terhadap tindakan awal yang biasa dilakukan. Meski belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya, bidan dengan cepat mengambil keputusan untuk melakukan manuver khusus yang ia pelajari dari seminar terbaru.

Pertanyaan:

Apa karakteristik kepakaran klinis yang ditunjukkan oleh bidan tersebut dalam kasus ini?

- A. Pengetahuan teoritis
- B. Keterampilan interpersonal
- C. Intuisi klinis berdasarkan pengalaman
- D. Kemampuan adaptasi cepat terhadap situasi klinis baru
- E. Komunikasi terapeutik yang efektif

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Karakteristik utama kepakaran klinis termasuk kemampuan mengadaptasi pengetahuan teoritis dan pengalaman untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif dalam situasi klinis baru atau ambigu (Thompson & Stapley, 2022). Bidan mampu mengenali situasi yang tidak biasa dan menerapkan tindakan alternatif yang relevan.

Kasus 2

Bidan Rani sering berdiskusi dan merefleksikan pengalamannya setelah menghadapi setiap kasus persalinan yang kompleks. Ia mencatat secara detail apa yang terjadi, menganalisis keputusan yang diambil, dan merancang tindakan alternatif yang lebih baik di masa depan.

Pertanyaan:

Tahap manakah dari praktik reflektif yang paling jelas dilakukan oleh bidan Rani pada kasus ini?

- A. Tahap deskriptif
- B. Tahap analisis kritis
- C. Tahap evaluasi
- D. Tahap sintesis
- E. Tahap implementasi perubahan

Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Bidan Rani sedang melakukan analisis kritis, yaitu tahap kedua dari praktik reflektif. Pada tahap ini, bidan mengevaluasi secara kritis tindakan yang diambil, hasil yang dicapai, serta mempertimbangkan alternatif tindakan yang lebih baik di masa depan.

Kasus 3

Bidan Sarah adalah mentor bagi mahasiswa kebidanan. Ia sering membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan situasi klinis yang nyata melalui diskusi kasus dan refleksi kelompok. Ia juga memberikan contoh bagaimana menerapkan komunikasi terapeutik yang efektif kepada pasien.

Pertanyaan:

Peran utama apakah yang sedang dilakukan bidan Sarah dalam pengembangan keparan klinis mahasiswa kebidanan?

- A. Pengajaran teori
- B. Penilaian klinis
- C. Supervisi klinis
- D. Role modeling dan mentorship
- E. Evaluasi formal akademik

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Dalam kasus ini, bidan Sarah berperan sebagai role model dan mentor. Mentorship yang efektif membantu mahasiswa mengintegrasikan teori dan praktik serta mengembangkan kompetensi interpersonal melalui contoh.

Kasus 4

Dalam menghadapi kasus persalinan dengan komplikasi berat, seorang bidan menggunakan pengalaman dan intuisi klinisnya untuk menentukan tindakan selanjutnya secara cepat, meskipun tidak ada protokol jelas yang bisa diikuti dalam situasi tersebut.

Pertanyaan:

Apa proses kognitif utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan bidan dalam kasus ini?

- A. Penalaran deduktif
- B. Interpretasi data klinis
- C. Penalaran induktif
- D. Persepsi pola klinis berdasarkan pengalaman
- E. Analisis bukti penelitian terbaru

Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Dalam situasi kompleks tanpa protokol jelas, kepakaran klinis bidan muncul dari persepsi pola klinis berdasarkan pengalaman, yang memungkinkan pengambilan keputusan cepat dan akurat.

Kasus 5

Bidan Lina baru saja mengikuti pelatihan simulasi klinis intensif tentang penanganan distosia bahu. Ia kemudian menghadapi situasi tersebut dalam praktik nyata dan berhasil mengatasinya dengan percaya diri serta efisien.

Pertanyaan:

Apa manfaat utama dari pelatihan simulasi klinis yang ditunjukkan oleh bidan Lina dalam situasi tersebut?

- A. Meningkatkan pengetahuan teoritis tentang distosia bahu
- B. Mengembangkan keterampilan interpersonal dalam berkomunikasi
- C. Memberikan pengalaman langsung tanpa risiko bagi pasien
- D. Memperluas kemampuan evaluasi kritis
- E. Mengurangi kebutuhan mentorship

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Simulasi klinis memberikan pengalaman langsung tanpa risiko pada pasien, memungkinkan mahasiswa atau bidan mempraktikkan keterampilan teknis serta mengambil keputusan klinis secara efisien dalam situasi nyata.

G. Rangkuman Materi

Kepakaran klinis dalam kebidanan merupakan integrasi mendalam dari pengetahuan teoritis, keterampilan teknis dan interpersonal, serta pengalaman praktik langsung yang berkelanjutan. Kepakaran ini memungkinkan seorang bidan untuk mengambil keputusan klinis secara efektif, akurat, dan fleksibel, bahkan dalam situasi kompleks dan ambigu. Karakteristik utama dari kepakaran klinis mencakup kemampuan mengintegrasikan bukti ilmiah dengan pengalaman intuitif untuk menghadirkan asuhan yang tidak hanya berbasis pedoman klinis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai unik pasien.

Komponen utama kepakaran klinis—pengetahuan teoritis mendalam, keterampilan teknis dan interpersonal yang canggih, serta pengalaman praktik klinis—merupakan dasar kuat bagi pengambilan keputusan yang efektif dalam praktik kebidanan. Pengetahuan teoritis mendalam memberikan fondasi ilmiah yang kuat, keterampilan teknis memastikan ketepatan tindakan klinis, dan keterampilan interpersonal memperkuat hubungan terapeutik yang krusial untuk keberhasilan asuhan kebidanan. Pengalaman praktik langsung yang intensif memungkinkan

bidan mengembangkan intuisi klinis, yang penting dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam situasi klinis yang tidak pasti.

Peran kepakaran klinis sangat sentral dalam pengambilan keputusan klinis di kebidanan, di mana integrasi pengalaman klinis dengan bukti penelitian ilmiah terbaru memastikan keputusan klinis yang optimal. Proses ini didukung oleh proses kognitif yang kompleks, melibatkan analisis kritis, penalaran deduktif dan induktif, serta refleksi mendalam terhadap pengalaman klinis sebelumnya. Keputusan klinis yang didasarkan pada kepakaran klinis ini terbukti meningkatkan hasil klinis seperti pengurangan komplikasi, peningkatan keselamatan pasien, dan peningkatan kepuasan pasien serta keluarga.

Praktik reflektif merupakan bagian integral dari pengembangan kepakaran klinis, karena memungkinkan bidan secara sistematis mengevaluasi pengalaman klinis mereka. Refleksi membantu bidan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang praktik klinis mereka, dan memperkuat keterampilan interpersonal melalui pemahaman yang lebih baik tentang perspektif pasien. Strategi refleksi seperti jurnal reflektif, diskusi reflektif kelompok, serta mentorship reflektif sangat efektif dalam meningkatkan kualitas praktik klinis secara kontinu.

Pendidikan kebidanan modern sangat menekankan pengembangan kepakaran klinis melalui model pembelajaran berbasis simulasi klinis, yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis yang aman, terkontrol, dan mendalam sebelum memasuki praktik klinis nyata. Mentorship klinis memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan kompetensi teknis dan interpersonal, serta membantu mahasiswa merefleksikan praktik mereka secara mendalam dan konsisten. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan pendidikan kebidanan, seperti keterbatasan akses pengalaman langsung dan kualitas mentor, solusi berupa integrasi simulasi klinis intensif, pelatihan mentor, dan penguatan kerjasama institusi pendidikan dengan fasilitas kesehatan menjadi kunci penting untuk mengatasi tantangan ini.

Secara keseluruhan, kepakaran klinis merupakan fondasi esensial dalam praktik kebidanan berbasis bukti, yang menjamin asuhan berkualitas tinggi bagi ibu dan bayi. Pengembangan kepakaran klinis melalui pendekatan pendidikan yang inovatif, praktik reflektif yang konsisten, dan integrasi bukti ilmiah dengan pengalaman klinis menjadi prioritas utama dalam mempersiapkan bidan menghadapi tantangan praktik klinis yang semakin kompleks di masa depan.

H. Glosarium

Kepakaran Klinis (Clinical Expertise)

Kemampuan praktisi kebidanan yang mengintegrasikan pengetahuan teoritis, keterampilan teknis dan interpersonal, intuisi klinis, serta pengalaman praktik yang luas untuk mengambil keputusan klinis secara cepat, tepat, dan efektif.

Intuisi Klinis

Kemampuan profesional dalam mengenali dan merespon pola klinis yang kompleks berdasarkan pengalaman praktik yang luas dan berulang.

Praktik Reflektif

Proses analitis yang dilakukan seorang profesional untuk mengevaluasi tindakan klinis sebelumnya secara kritis, guna meningkatkan kualitas praktik klinis di masa depan.

Simulasi Klinis

Metode pembelajaran yang menggunakan skenario klinis tiruan untuk melatih keterampilan teknis, interpersonal, dan pengambilan keputusan klinis dalam lingkungan yang aman dan terkontrol.

Mentorship Klinis

Hubungan profesional yang melibatkan bimbingan, dukungan, dan pemberian umpan balik konstruktif dari praktisi berpengalaman kepada mahasiswa atau bidan pemula, bertujuan meningkatkan kompetensi klinis dan pengembangan profesional.

Pengambilan Keputusan Klinis Berbasis Bukti

Proses mengambil keputusan klinis dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi, serta nilai dan preferensi individu pasien.

Penalaran Deduktif dan Induktif

Proses berpikir kritis dalam pengambilan keputusan klinis, di mana penalaran deduktif menarik kesimpulan dari teori atau prinsip umum ke kasus khusus, sementara penalaran induktif menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan empiris dari kasus-kasus sebelumnya.

Komunikasi Terapeutik

Komunikasi interpersonal yang efektif dan empatik antara bidan dengan pasien, bertujuan membangun hubungan yang positif dan memperkuat kualitas asuhan kebidanan.

I. Daftar Pustaka

- Benner, P. (2021). *From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice* (Commemorative ed.). Pearson Education.
- Cant, R. P., & Cooper, S. J. (2021). Clinical simulation in nursing and midwifery education: Emerging trends and innovations. *Nurse Education Today*, 99, 104776. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104776>
- Edwards, M., & Johnson, L. (2021). Integrating clinical expertise and evidence-based practice: A qualitative exploration. *Journal of Advanced Nursing*, 77(2), 478–488. <https://doi.org/10.1111/jan.14600>
- Ferguson, L., Day, R. A., & Fast, O. (2020). The role of clinical expertise in reducing obstetric complications: A systematic review. *Midwifery*, 82, 102605. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102605>
- Gibson, J., & Hunter, B. (2022). Mentorship in midwifery education: A qualitative exploration of experiences and outcomes. *Midwifery*, 106, 103282. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103282>
- Lee, K., Hunter, A., & Riley, C. (2023). Advancing clinical expertise in midwifery: Implications for patient safety and quality care. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 68(1), 43–50. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13450>
- Mann, K., Gordon, J., & MacLeod, A. (2021). Reflection and reflective practice in health professions education: A systematic review. *Advances in Health Sciences Education*, 26(2), 363–387. <https://doi.org/10.1007/s10459-020-09920-8>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2022). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Schon, D. A. (2022). *The reflective practitioner: How professionals think in action* (Revised ed.). Routledge.
- Smith, A., Burke, L., & Long, C. (2020). Developing clinical intuition through reflective practice: An integrative review. *Nurse Education Today*, 90, 104464. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104464>
- Taylor, J., & Jones, S. (2023). Promoting reflective practice among midwifery students through structured reflection. *Midwifery*, 111, 103505. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103505>
- Thompson, R., & Stapley, E. (2022). Decision-making and clinical reasoning in midwifery: An integrative review. *International Journal of Nursing Studies*, 130, 104290. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104290>
- Wilson, H., & Hutchinson, M. (2021). The interpersonal skills of expert midwives: A qualitative analysis. *Midwifery*, 96, 102948. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102948>
- Young, C., & Edwards, A. (2023). Developing clinical expertise: Challenges and recommendations for midwifery educators. *Nurse Education in Practice*, 68, 103730. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103730>

BAB 8

KEPAKARAN KLINIS (CLINICAL EXPERTISE): PERTIMBANGAN KEILMUAN, PENGALAMAN KLINIK

Pendahuluan

Dalam konteks Evidence-Based Practice (EBP), clinical expertise tidak hanya mencakup keterampilan teknis atau pengalaman praktik, tetapi juga kemampuan untuk mempertimbangkan aspek keilmuan secara sistematis saat menghadapi berbagai situasi klinis. Di era pelayanan kesehatan modern, pendekatan Evidence-Based Practice (EBP) menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan klinis. EBP merupakan perpaduan yang harmonis antara bukti ilmiah terkini, kepakaran klinis, dan preferensi serta nilai-nilai pasien. Dalam konteks kebidanan, penerapan praktik berbasis bukti tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etis.

Salah satu pilar penting dari EBP adalah kepakaran klinis (clinical expertise), yaitu kemampuan profesional seorang bidan dalam mengenali kondisi klinis, menilai kebutuhan individual pasien, serta mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik nyata. Kepakaran klinis tidak hanya diperoleh dari pendidikan formal, tetapi juga dari pengalaman praktik yang berkelanjutan, refleksi kritis, dan pembelajaran sepanjang hayat. Melalui kepakaran ini, bidan dapat menavigasi kompleksitas situasi klinis, menyesuaikan intervensi berdasarkan konteks, serta membuat keputusan yang responsif terhadap kebutuhan unik tiap pasien.

Sayangnya, dalam praktik sehari-hari, kepakaran klinis sering kali diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu yang sulit diukur. Buku ajar ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyajikan konsep, peran, dan aplikasi kepakaran klinis dalam praktik kebidanan yang berbasis bukti. Diharapkan buku ini dapat menjadi sumber rujukan penting bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, dan praktisi dalam memahami serta mengembangkan kompetensi klinis yang unggul dan beretika.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang kepakaran klinis dalam EBP, para bidan diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan

profesional yang mampu memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan bermakna bagi perempuan, bayi, dan keluarganya.

Tujuan Instruksional Umum (TIU):

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa kebidanan diharapkan mampu menerapkan prinsip dan pendekatan evidence-based practice dalam praktik kebidanan secara profesional, dengan mempertimbangkan bukti ilmiah terkini, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

Setelah menyelesaikan setiap bab dalam buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan penilaian kritis (critical appraisal) terhadap kualitas dan validitas hasil penelitian yang ditemukan.
2. Mengintegrasikan hasil penelitian dengan keahlian klinis dan konteks pasien, termasuk nilai, budaya, dan preferensi pasien.
3. Mengembangkan rencana asuhan kebidanan berbasis bukti yang realistis dan dapat diimplementasikan di lapangan.
4. Mengevaluasi hasil intervensi kebidanan berbasis bukti dan melakukan refleksi praktik secara berkesinambungan.
5. Menunjukkan sikap profesionalisme dan etika dalam pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Sikap (CP-S):

Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menunjukkan sikap profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam penerapan praktik kebidanan berbasis bukti.
- b. Menghargai nilai, preferensi, dan budaya pasien dalam pengambilan keputusan klinis.
- c. Berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan praktik berbasis bukti.

2. Capaian Pembelajaran Pengetahuan (CP-P):

Mahasiswa mampu:

- a. Menjelaskan prinsip dasar dan tahapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam praktik kebidanan.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber bukti ilmiah yang valid, relevan, dan terkini.
- c. Menjelaskan konsep clinical expertise, best available evidence, dan patient values dalam konteks pengambilan keputusan klinis.

- d. Menilai kualitas dan relevansi bukti ilmiah melalui proses critical appraisal.
3. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum (CP-KU):
Mahasiswa mampu:
- a. Mengintegrasikan bukti ilmiah, keahlian klinis, dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan kebidanan.
 - b. Menyusun rencana dan tindakan asuhan kebidanan berdasarkan temuan evidence-based yang dapat diimplementasikan dalam praktik.
 - c. Berkomunikasi secara efektif dan kolaboratif dengan pasien dan tim kesehatan dalam menjelaskan hasil kajian bukti dan pilihan intervensi.
4. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus (CP-KK):
Mahasiswa mampu:
- a. Merumuskan pertanyaan klinis yang fokus dan spesifik menggunakan pendekatan PICO.
 - b. Melakukan pencarian literatur yang sistematis di berbagai database ilmiah.
 - c. Melakukan penilaian kritis terhadap hasil penelitian kuantitatif maupun kualitatif yang relevan untuk praktik kebidanan.
 - d. Menerapkan temuan evidence-based dalam studi kasus atau praktik nyata kebidanan tingkat lanjut secara tepat dan profesional.

A. Pertimbangan Keilmuan

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Practice), pertimbangan keilmuan menjadi komponen utama yang membentuk kepakaran klinis seorang bidan. Kepakaran ini bukan semata-mata hasil dari pengalaman praktik, tetapi juga merupakan hasil dari proses belajar yang terus-menerus dan integrasi antara pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, dan pemahaman kontekstual terhadap pasien dan lingkungan

1. Dasar Ilmiah dalam Pengambilan Keputusan

Bidan diharapkan mampu menelaah dan menafsirkan hasil penelitian terbaru untuk dijadikan dasar praktik. Hal ini mencakup pemahaman terhadap desain penelitian, validitas data, serta relevansi bukti terhadap kondisi pasien. Kemampuan ini membutuhkan keterampilan literasi informasi dan berpikir kritis yang tinggi, sehingga bidan tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga penilai kualitas bukti. Dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan adalah penggunaan bukti yang valid, relevan, dan dapat dipercaya dalam menetapkan tindakan klinis, diagnosis, atau intervensi kebidanan (Rosy, 2016). Ini mencakup proses:

- Menelaah hasil penelitian terbaru
 - Menilai kualitas bukti
 - Menggabungkan bukti dengan keahlian klinis
 - Mempertimbangkan nilai, preferensi, dan kondisi pasien
- Komponen Dasar Ilmiah dalam Praktik Kebidanan (Rosy, 2016)

Tabel 8.1: Komponen dasar Ilmiah

Komponen	Penjelasan
Evidence (Bukti)	Merujuk pada hasil penelitian yang telah ditinjau dan dipublikasikan
Clinical Expertise	Keahlian praktisi dalam menilai dan menerapkan bukti sesuai kasus
Patient Values & Context	Preferensi, budaya, dan kondisi unik setiap individu

2. Makna Pertimbangan Keilmuan dalam Praktik Kebidanan

Pertimbangan keilmuan adalah proses penalaran ilmiah dan reflektif yang dilakukan bidan saat memilih atau menyesuaikan intervensi berdasarkan:

- a. Bukti ilmiah terbaru
- b. Konteks klinis pasien
- c. Prinsip etika dan budaya lokal
- d. Ketersediaan sumber daya

3. Manfaat Menggunakan Dasar Ilmiah dalam Keputusan

- a. Bagi masyarakat umum:
 - 1) Peningkatan kondisi perawatan yang berpusat pada pasien
 - 2) Preferensi pasien termasuk dalam pengambilan keputusan
 - 3) Layanan kesehatan yang konsisten menghasilkan pemerataan yang lebih baik
 - 4) Pengurangan variasi geografis
 - 5) Pengurangan lama tinggal pasien
- b. Bagi Bidan
 - 1) Meningkatkan kepuasan kerja
 - 2) Pemberdayaan
 - 3) Peningkatan keterampilan untuk mengintegrasikan preferensi pasien ke dalam praktik
 - 4) Dukungan untuk pertumbuhan profesional
 - 5) Pengembangan karir berkelanjutan melalui peran ahli
- c. Bagi Penelitian dan pendidikan
 - 1) Meningkatnya kebutuhan untuk produksi dan sintesis bukti yang kuat
 - 2) Pengembangan kompetensi
 - 3) Integrasi peran ahli keperawatan dan kebidanan dalam kesehatan (Jylhä et al., 2017)

4. Komponen Utama Pertimbangan Keilmuan

- a. Validitas Ilmiah Bukti
 - Apakah bukti berasal dari studi berkualitas tinggi (RCT, meta-analisis)?
 - Apakah studi tersebut relevan dengan kondisi lokal?
- b. Kekuatan dan Relevansi Bukti
 - Apakah bukti tersebut kuat (GRADE Level A)?
 - Apakah konteks penelitian sebanding dengan kondisi klinis yang dihadapi?
- c. Kelayakan Penerapan
 - Apakah intervensi realistis di fasilitas kesehatan tempat bidan bekerja?
 - Apakah alat, tenaga, dan protokol mendukung?
- d. Kesesuaian Budaya dan Etika
 - Apakah intervensi sejalan dengan nilai dan norma budaya pasien?
 - Apakah pasien diberi informasi dan hak menentukan pilihan?

5. Strategi Meningkatkan Pertimbangan Ilmiah Bidan

- a. Mengikuti pelatihan Critical Appraisal Skills
- b. Membiasakan membaca journal articles dan clinical guideline

- c. Diskusi reflektif melalui journal club
- d. Kolaborasi antarprofesional untuk berbagi pengalaman dan ilmu
- e. Mencatat dan mengevaluasi hasil intervensi klinis secara sistematis

6. Langkah Pengambilan Keputusan Berdasarkan Dasar Ilmiah

- a. Identifikasi masalah klinis
Misalnya: Ibu bersalin mengalami nyeri hebat pada kala I.
- b. Susun pertanyaan terfokus (menggunakan PICO)
Contoh: Apakah teknik relaksasi efektif dibandingkan tanpa intervensi dalam menurunkan nyeri persalinan?
- c. Telusuri bukti terbaik
Cari di database: PubMed, Cochrane, DOAJ
- d. Appraisal bukti (kritis dan sistematis)
Nilai metodologi, validitas, dan hasil
- e. Terapkan ke dalam praktik klinis
Dengan menyesuaikan bukti terhadap kondisi pasien dan fasilitas

7. Contoh Praktik Pertimbangan Keilmuan

- a. Studi Kasus
Seorang ibu hamil usia 17 tahun meminta proses persalinan alami dirumah. Bidan harus mempertimbangkan:
 - 1) Bukti risiko persalinan di luar fasilitas medis
 - 2) Keinginan dan keyakinan pasien
 - 3) Protokol Kemenkes atau PONEK setempat
 - 4) Kemungkinan komplikasi usia muda dan primigravida
 Dalam kasus ini, clinical expertise dan pertimbangan ilmiah digunakan untuk merumuskan keputusan klinis yang aman, menghargai pasien, dan berbasis bukti.
- b. Kasus:
Ibu dengan usia kehamilan 41 minggu, tidak ada tanda persalinan. Pertimbangan ilmiah:
 - 1) Studi menunjukkan peningkatan risiko komplikasi setelah 41 minggu
 - 2) WHO merekomendasikan induksi setelah 41 minggu
 - 3) Namun, pasien ingin menunggu proses alami
 Keputusan:
Bidan menjelaskan risiko berbasis bukti, memberikan edukasi, mendokumentasikan, dan menghormati keputusan pasien dengan monitoring ketat.

8. Pertimbangan Keilmuan dalam Clinical Expertise

- Kepakaran klinis tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berdasar pada:
- a. Prinsip keilmuan dan logika klinis

- b. Literatur dan pedoman berbasis bukti
- c. Analisis kritis terhadap bukti ilmiah

Contoh pertimbangan keilmuan:

- a. Apakah intervensi ini telah diuji secara RCT atau meta-analisis?
- b. Apakah bukti tersebut relevan dengan populasi lokal?
- c. Apakah data tersebut bebas dari konflik kepentingan?

Tabel 8.2: Hubungan antara Pertimbangan Ilmiah dan Clinical Expertise

Elemen	Peran
Bukti ilmiah	Fondasi keputusan klinis
Keahlian klinis	Penyesuaian terhadap kondisi nyata
Pertimbangan keilmuan	Penyaring bukti agar sesuai dan relevan
Preferensi pasien	Penguatan keputusan yang personal dan bermakna

9. Sumber Dasar Ilmiah

a. Sumber

- 1) Jurnal ilmiah: Women and Birth, Midwifery, Cochrane Library, BMC Pregnancy & Childbirth
- 2) Pedoman praktik klinis: WHO, ICM, Kemenkes RI
- 3) Systematic Review dan Meta-analisis
- 4) Evaluasi praktik klinis sebelumnya

b. Lima strategi pencarian digunakan untuk mengidentifikasi publikasi yang relevan:

- 1) Pencarian sistematis dari sembilan basis data elektronik (ASSIA, CINAHL, Criminal Justice Abstracts, ERIC, Family and Society Studies Worldwide, Medline, PsycInfo, Scopus, dan SocIndex).
- 2) Pencarian situs web organisasi.
- 3) Ajakan untuk publikasi dari para ahli terpilih.
- 4) Ajakan terbuka untuk publikasi melalui media sosial (misalnya Twitter, LinkedIn)
- 5) Pengecekan referensi untuk semua studi yang disertakan.
(Bührmann et al., 2022)

c. Tantangan mendapatkan sumber dasar ilmiah

Tabel 8.3: Tantangan dan Solusi Praktis

Tantangan	Solusi Praktis
Sulit akses jurnal	Gunakan database open access (PubMed Central, DOAJ)

Waktu terbatas	Baca ringkasan atau guideline terpilih
Kurangnya pelatihan EBP	Ikut pelatihan, journal club, mentoring

B. Pengalaman Klinik

1. Pengertian Pengalaman Klinik

Pengalaman klinik merujuk pada keterlibatan langsung mahasiswa atau praktisi kebidanan dalam situasi nyata pelayanan kesehatan, seperti asuhan kehamilan, persalinan, nifas, KB, dan kegawatdaruratan. Pengalaman ini membentuk dasar penting dalam mengembangkan clinical expertise dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Peran Pengalaman Klinik dalam Pengambilan Keputusan

Pengalaman praktik memberi kontribusi besar terhadap: (Leo & Bayes, Sara, Janice Butt, Dianne Bloxsome, 2021)

- Pembentukan intuisi klinis
- Pemahaman terhadap konteks nyata pasien
- Kemampuan membandingkan situasi antar kasus
- Pengembangan kepercayaan diri dan profesionalisme

3. Komponen Pengalaman Klinik yang Efektif

- Interaksi langsung dengan pasien
- Supervisi dari pembimbing klinik (preceptor)
- Dokumentasi dan logbook keterampilan
- Umpan balik reflektif

4. Jenis dan Bentuk Pengalaman Klinik

- Jenis-Jenis Pengalaman Klinik

Tabel 8.4: Jenis Pengalaman Klinik

Jenis Pengalaman	Contoh Aktivitas
Pengalaman langsung (direct care)	Menangani persalinan, pemeriksaan kehamilan
Pengalaman pengamatan (observasi)	Mengamati bidan senior menangani kegawatdaruratan
Refleksi praktik	Menulis jurnal praktik, menganalisis kasus
Kolaborasi antarprofesi	Diskusi kasus dengan dokter, perawat, atau konselor

- Bentuk Pengalaman Klinik

- Pengalaman langsung (direct care)
- Observasi praktik klinik

3) Simulasi praktik

4) Kunjungan lapangan (komunitas, puskesmas, rumah sakit)

5. Pengalaman Klinik dan Clinical Expertise

Clinical expertise tidak hanya dibentuk oleh waktu praktik, tetapi juga oleh kualitas pengalaman yang melibatkan:

- Pengambilan keputusan kompleks
- Situasi yang membutuhkan penilaian kritis
- Evaluasi hasil intervensi
- Kemampuan merefleksikan kesalahan dan keberhasilan

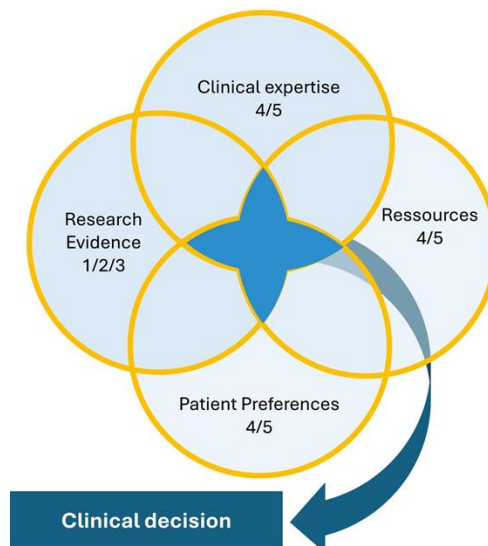
6. Langkah-langkah Pengambilan Keputusan Klinik

EBP merupakan proses yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan metodologi untuk memperbarui praktik. Pendekatan terhadap proses EBP :

Langkah 0: Tumbuhkan semangat ingin tahu dalam budaya dan lingkungan EBP.

- Langkah 1: Rumuskan pertanyaan klinis PICOT yang penting.
- Langkah 2: Cari bukti terbaik.
- Langkah 3: Penilaian kritis terhadap bukti.
- Langkah 4: Integrasikan bukti dengan keahlian klinis dan preferensi pasien/keluarga untuk membuat keputusan klinis terbaik.
- Langkah 5: Mengevaluasi hasil perubahan praktik berdasarkan bukti.
- Langkah 6: Menyebarluaskan hasil perubahan EBP.'

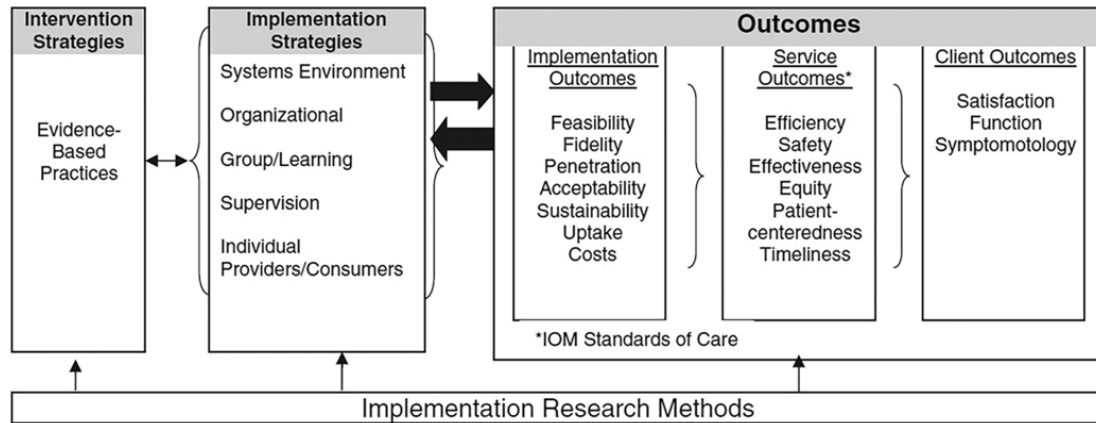
Langkah 0 hingga 3 berada di lingkaran pertama (bukti penelitian), Langkah 4 dan 5 berada di 3 lingkaran lainnya.



Gambar 8.1: Proses EBP untuk Pengambilan Keputusan Klinik (Chays-Amania et al., 2024)

7. Strategi Implementasi

Langkah-langkah penting untuk mendeskripsikan strategi: menamai strategi, mendefinisikannya, dan menentukan (a) aktor, (b) tindakan, (c) target tindakan, (d) temporalitas, (e) dosis, (f) hasil implementasi yang terpengaruh, (g) justifikasi



Gambar 8.2: Model konseptual penelitian implementasi (Chays-Amania et al., 2024)

8. Contoh Kasus Pengalaman Klinik yang Bermakna

Kasus: Seorang ibu mengalami partus lama. Mahasiswa kebidanan mengikuti penanganan kasus ini bersama preseptor, menyusun rencana intervensi berdasarkan partograf, dan mengevaluasi hasilnya.

Hasil refleksi: Mahasiswa menyadari pentingnya early warning signs, komunikasi tim, dan kesesuaian intervensi dengan guideline WHO.

9. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengalaman Klinik

- Pembimbing klinik (preseptor) yang aktif dan mendukung
- Lingkungan belajar yang aman dan terbuka
- Kemampuan refleksi diri mahasiswa
- Variasi kasus dan kompleksitasnya
- Ketersediaan dokumentasi dan alat evaluasi praktik

(Lendahls & Oscarsson, 2017)

10. Aplikasi pada praktek Klinik

Implementasi EBP menggunakan model, strategi, dan mengevaluasi hasil implementasinya mencapai hasil implementasi yang sukses.

Tabel 8.5: Contoh implementasi EBP dalam Praktek Klinik

(Hammond et al., 2020)(Angela Byrnes, Adrienne Young, Alison Mudge, Merrilyn Banks, David Clark, 2018)(Hanrahan et al., 2015)

EBP: Name of the practice, program, intervention, policy being implemented	Model	Strategy	Implementation outcomes	Outcomes
Preoperative nasal decolonization of surgical patients with nasal povidone-iodine (PI)	i-PARiHS	Use evaluative and iterative strategies Develop stakeholder interrelationships Train and ed	Acceptability Feasibility Fidelity	High
Early diet upgrades, postoperative nutrition care processes from ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)	i-PARiHS	Provide interactive assistance Adapt and tailor to the context Develop stakeholder interrelationships stakeholders Support clinicians	Acceptability Adoption Appropriateness Feasibility Fidelity	High
Implementation of EBP practice and remove of Sacred Cows	IOWA Model	Use evaluative and iterative strategies Provide interactive assistance Adapt and tailor to the context Develop stakeholder interrelationships Train and educate stakeholders Support clinicians Engagement of consume	Adoption Sustainability	High

11. Strategi Memaksimalkan Pengalaman Klinik

- Menetapkan tujuan belajar setiap hari praktik
- Mencatat jurnal harian kasus klinik

- c. Berdiskusi dengan pembimbing tentang what went right and what can be improved
 - d. Mencari referensi ilmiah yang relevan dengan kasus klinik
 - e. Mengikuti diskusi kasus dan jurnal club
- (Lendahls & Oscarsson, 2017)

12. Integrasi Pengalaman Klinik dan Evidence-Based Practice

Tabel 8.6: Aspek Evidence-Based Practice dan Peran pada Pengalaman Klinik

Aspek	Peran
Pengalaman praktik	Membangun keterampilan dan pemahaman langsung
Evidence-based	Memberikan dasar ilmiah untuk tindakan
Refleksi klinis	Mengintegrasikan pengalaman dan teori ke dalam pembelajaran

13. Peran Preceptor dan Lingkungan Belajar Klinik

- a. Kriteria preceptor yang efektif
 - b. Komunikasi bidan–mahasiswa–pasien
 - c. Budaya keselamatan dan pembelajaran di lahan praktik
- (Shikuku et al., 2024)

Dalam pendidikan berbasis kompetensi, partisipasi aktif dan akuntabilitas peserta didik harus didukung

14. Penilaian Pengalaman Klinik

- a. Logbook keterampilan klinik
- b. Jurnal refleksi kasus
- c. Umpan balik dari pembimbing
- d. Mini-CEX atau OSCE berbasis kasus nyata

15. Tantangan dalam Pengalaman Klinik

- a. Keterbatasan variasi kasus
 - b. Ketimpangan pembimbingan
 - c. Solusi praktis untuk tetap belajar dalam keterbatasan
- ("State World's Midwifery," 2021)

Wahana Praktek yang terlalu padat dan infrastruktur pengajaran yang tidak memadai telah terbukti berdampak negatif langsung pada kualitas pendidikan dan lulusan kebidanan yang dihasilkan untuk pemberian layanan (WHO, 2019). Program pelatihan diharapkan untuk mengintegrasikan pelatihan keterampilan simulasi dalam kurikulum sebelum penempatan klinis untuk pengalaman praktik klinis. Bukti menunjukkan bahwa simulasi dan pelatihan

keterampilan membuat siswa merasa siap dan percaya diri sebelum praktik klinis (Lendahls & Oscarsson, 2017)

16. Studi Kasus Reflektif dari Pengalaman Klinik

- a. Contoh naratif pengalaman mahasiswa menghadapi kasus preeklampsia
- b. Refleksi kegagalan komunikasi dalam praktik
- c. Evaluasi tindakan dan pelajaran dari pengalaman

C. Penutup

Penerapan evidence-based practice (EBP) dalam kebidanan bukanlah sekadar mengikuti pedoman atau membaca jurnal, tetapi merupakan sebuah proses dinamis yang menggabungkan pengetahuan ilmiah terkini, keahlian klinis (clinical expertise), dan nilai-nilai pasien dalam setiap pengambilan keputusan.

Melalui bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa:

- a. Kepakaran klinis dibangun dari pengalaman yang reflektif, keterampilan teknis, dan kemampuan menyesuaikan bukti ke dalam praktik nyata.
- b. Pertimbangan keilmuan menjadi dasar dalam menyaring bukti yang relevan, menilai validitasnya, dan mengadaptasikannya ke dalam konteks lokal dan budaya.

Praktik kebidanan berbasis bukti akan berhasil bila disertai dengan:

- a. Komitmen profesional untuk terus belajar,
- b. Kemampuan reflektif terhadap praktik sehari-hari, dan
- c. Kepekaan terhadap kebutuhan dan nilai-nilai pasien.

Pengalaman klinik merupakan fondasi penting dalam membentuk kepakaran klinis dan kemampuan bidan dalam menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti. Melalui keterlibatan langsung dengan pasien, bimbingan dari preceptor, dan refleksi dari kasus nyata, mahasiswa kebidanan belajar tidak hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan secara ilmiah dan etis. Pengalaman klinik yang berkualitas mendorong mahasiswa untuk:

- a. Mengembangkan kepercayaan diri dalam membuat keputusan klinis
- b. Mengintegrasikan teori dan penelitian ke dalam praktik nyata
- c. Memahami konteks sosial dan budaya pasien
- d. Berpikir kritis dan melakukan refleksi untuk perbaikan berkelanjutan

Dengan dukungan lingkungan praktik yang kondusif, pembimbing klinik yang kompeten, serta dorongan untuk terus belajar, pengalaman klinik menjadi jembatan antara pengetahuan akademik dan tanggung jawab profesional. Maka, pengalaman klinik bukan hanya bagian dari kurikulum, melainkan media pembentukan karakter dan profesionalisme bidan masa depan.

Semangat kolaboratif dan integritas ilmiah para bidan diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana tindakan, tetapi juga menjadi pengambil keputusan klinis yang bijaksana, adaptif, dan bertanggung jawab secara etis dan ilmiah.

D. Latihan Soal

Soal

Soal 1 (Kasus Klinis – Analisis Situasi)

Seorang bidan menangani ibu bersalin yang ingin melahirkan di posisi jongkok. Namun, protokol rumah sakit hanya menyediakan tempat tidur bersalin standar. Apa yang harus dilakukan bidan dengan mempertimbangkan evidence-based dan clinical expertise?

Soal 2 (Pengetahuan EBP)

Salah satu tahapan awal dalam menerapkan EBP adalah menyusun pertanyaan klinis yang terfokus. Apa nama metode yang digunakan?

Soal 3 (Kasus Reflektif)

Seorang pasien menolak induksi meskipun usia kehamilannya sudah 42 minggu. Apa yang harus dilakukan bidan berdasarkan pendekatan EBP?

Soal 4 (Evaluasi Bukti Ilmiah)

Manakah dari jenis penelitian berikut yang memberikan bukti tertinggi dalam hierarki EBP?

- a. Studi kohort
- b. Randomized Controlled Trial (RCT)
- c. Studi kualitatif
- d. Studi kasus

Soal 5 (Kasus Penilaian Praktik)

Bidan menemukan bahwa praktik episiotomi rutin masih dilakukan di tempat kerjanya. Ia membaca dari Cochrane Review bahwa episiotomi sebaiknya hanya dilakukan secara selektif. Apa langkah terbaik?

Soal 6 (Etika dan Evidence-Based)

Bidan menemukan bahwa terapi akupresur efektif untuk mengurangi nyeri persalinan menurut jurnal. Namun, pasien menolak karena alasan kepercayaan. Apa pendekatan yang paling sesuai?

Soal 7 (Refleksi Profesional)

Mengapa clinical expertise tetap penting meskipun sudah tersedia banyak pedoman praktik?

Soal 8: (Persalinan – Praktik Reflektif)

Seorang ibu bersalin dengan kala I fase aktif mengalami nyeri hebat. Mahasiswa menawarkan teknik relaksasi pernapasan yang dipelajari dari kuliah. Ibu merasa tidak nyaman dan menolaknya. Pertanyaan: Apa yang sebaiknya dilakukan mahasiswa?

Soal 9: (Asuhan Nifas – Clinical Decision Making)

Ibu nifas hari ke-5 melaporkan payudaranya bengkak dan nyeri. Mahasiswa mengidentifikasi tanda mastitis awal. Pertanyaan: Apa langkah berbasis bukti yang harus dilakukan?

Soal 10: (Kehamilan – Evidence Appraisal)

Dalam diskusi klinik, mahasiswa membaca artikel bahwa senam hamil dapat mengurangi angka induksi. Pertanyaan: Apa tindakan terbaik mahasiswa saat menemui ibu hamil yang belum tahu manfaat senam hamil?

Jawaban

Soal 1

Bidan harus mengedepankan komunikasi, menjelaskan manfaat posisi jongkok berdasarkan bukti (misalnya mempercepat kala II), dan mencari alternatif yang aman dalam fasilitas tersebut. Clinical expertise digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan pasien dengan realitas fasilitas yang ada.

Soal 2

PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome)

Soal 3

Memberikan edukasi berdasarkan bukti (risiko kehamilan postterm), mempertimbangkan keinginan pasien, dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Clinical expertise digunakan untuk memfasilitasi keputusan yang aman dan menghargai otonomi pasien.

Soal 4

b. Randomized Controlled Trial (RCT)

Soal 5

Melakukan diskusi dengan tim, menyampaikan bukti ilmiah dari Cochrane Review, dan mengusulkan perubahan SOP berdasarkan praktik berbasis bukti. Clinical expertise digunakan untuk menyesuaikan penerapannya secara bertahap.

Soal 6

Menghargai preferensi pasien dan menawarkan alternatif berbasis bukti lainnya. Clinical expertise dan pertimbangan etik digunakan dalam membuat keputusan yang menghormati nilai pasien.

Soal 7

Karena tidak semua situasi klinis sesuai dengan buku atau pedoman. Clinical expertise dibutuhkan untuk menyesuaikan pedoman dengan kondisi pasien yang unik, mempertimbangkan faktor sosial, emosional, dan budaya dalam pengambilan keputusan.

Soal 8

Menghormati keputusan pasien, menawarkan alternatif lain (seperti kompres hangat), dan mendiskusikan pendekatan yang sesuai preferensi pasien. Ini mencerminkan penggabungan antara pengetahuan ilmiah dan pengalaman klinis yang reflektif.

Soal 9

Edukasi ibu untuk tetap menyusui, melakukan pijat ringan, kompres hangat/dingin, dan merujuk jika tidak membaik dalam 24–48 jam. Mahasiswa harus mendiskusikannya dengan pembimbing sebelum tindakan.

Soal 10

Memberikan edukasi singkat berbasis bukti dan mendorong ibu untuk mengikuti program senam hamil. Mahasiswa juga dapat mencatat pengalaman klinik tersebut sebagai bagian dari jurnal refleksi.

E. Glosarium

ASSIA	: adalah Association for the Study of Sex in Indonesia
ASSIA	: adalah Association for the Study of Sex in Indonesia
CINAHL	: adalah Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature
DOAJ	: adalah Directory of Open Access Journals
EBP	: adalah Evidence-Based Practice
ERIC	: adalah Education Resources Information Center
ICM	: adalah International Confederation of Midwives
IOWA	: adalah kerangka kerja atau metode yang digunakan untuk mempromosikan praktik berbasis bukti (EBP) dalam perawatan kesehatan, terutama dalam keperawatan
i-PARiHS	: adalah Promoting Action on Research Implementation in Health Services
KB	: adalah Keluarga berencana
Mini-CEX	: adalah = Mini Clinical Evaluation Exercise
OSCE	: adalah Objective Structured Clinical Examination
PICO	: adalah Population (Populasi), Intervention (Intervensi),

	Comparison (Perbandingan), dan Outcome (Hasil)
PICOT	: adalah Pasien/Masalah, Intervensi, Comparison (Perbandingan), Outcomes (Hasil), dan Time (Jangka waktu)
PONEK	: adalah Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
RCT	: adalah Randomized Controlled Trial
WHO	: adalah World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)

F. Daftar Pustaka

- Angela Byrnes, Adrienne Young, Alison Mudge, Merrilyn Banks, David Clark, J. B. (2018). Prospective application of an implementation framework to improve postoperative nutrition care processes: Evaluation of a mixed methods implementation study. *Nutrition & Dietetics*, 74(4), 353–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1747-0080.12464>
- Bührmann, L., Driessen, P., Metz, A., Burke, K., Bartley, L., Varsi, C., & Albers, B. (2022). Knowledge and attitudes of Implementation Support Practitioners—Findings from a systematic integrative review. *PLoS ONE*, 17(5 May), 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267533>
- Chays-Amania, A., Schwingrouber, J., & Colson, S. (2024). Using Implementation Science to Implement Evidence-Based Practice: A Discursive Paper. *Journal of Advanced Nursing*, 1–12. <https://doi.org/10.1111/jan.16571>
- Hammond, E. N., Brys, N., Kates, A., Musuuza, J. S., Haleem, A., Bentz, M. L., & Safdar, N. (2020). Nasal povidone-iodine implementation for preventing surgical site infections: Perspectives of surgical nurses. *PLoS ONE*, 15(11 November), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242217>
- Hanrahan, K., Wagner, M., Matthews, G., Stewart, S., Dawson, C., Greiner, J., Pottinger, J., Vernon-Levett, P., Herold, D., Hottel, R., Cullen, L., Tucker, S., & Williamson, A. (2015). Sacred cow gone to pasture: A systematic evaluation and integration of evidence-based practice. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 12(1), 3–11. <https://doi.org/10.1111/wvn.12072>
- Jylhä, V., Oikarainen, A., Perälä, M.-L., & Holopainen, A. (2017). Facilitating evidence-based practice in nursing and midwifery in the WHO European Region. *World Health Organization*, September, 1–34.
- Lendahls, L., & Oscarsson, M. G. (2017). Midwifery students' experiences of simulation- and skills training. *Sciencedirect*, 50, 12–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.12.005>
- Leo, A. De, & Bayes, Sara, Janice Butt, Dianne Bloxsome, S. G. (2021). Midwifery leaders' views on the factors considered crucial to implementing evidence-based practice in clinical areas. *Women and Birth*, 34(1), 22–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.08.013>
- Rosy, M. M. (2016). Evidence based Practice in Midwifery. *International Journal of*

Nursing Education and Research, 4(3), 376. <https://doi.org/10.5958/2454-2660.2016.00067.3>

Shikuku, D. N., Bar-Zeev, S., Ladur, A. N., Allott, H., Mwaura, C., Nandikove, P., Uyara, A., Tallam, E., Ndirangu, E., Waweru, L., Nyaga, L., Bashir, I., Bedwell, C., & Ameh, C. (2024). Experiences, barriers and perspectives of midwifery educators, mentors and students implementing the updated emergency obstetric and newborn care-enhanced pre-service midwifery curriculum in Kenya: a nested qualitative study. *BMC Medical Education*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05872-7>

The State of the World's Midwifery 2021. (2021). *The State of the World's Midwifery 2021*. <https://doi.org/10.18356/9789214030935>

WHO. (2019). Framework For Action Strengthening Quality Of Midwifery Education for Universal Health Coverage 2030. In *Midwife.Org.Tw*. <http://www.midwife.org.tw/upfiles/newsfiles/9789241515849-eng.pdf>

BAB 9

KEPAKARAN KLINIS DALAM PRAKTIK KEBIDANAN BERBASIS BUKTI: NILAI INDIVIDU DAN DILEMA ETIK

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengintegrasikan kepakaran klinis, nilai individu pasien, serta mempertimbangkan aspek etik dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan prinsip-prinsip Evidence-Based Midwifery Practice.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

- Mengidentifikasi peran kepakaran klinis dalam EBMP.
- Menjelaskan pentingnya menghormati nilai individu pasien dalam pelayanan kebidanan.
- Menguraikan dan menganalisis dilema etik yang mungkin timbul dalam praktik klinis kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep kepakaran klinis dan aplikasinya dalam praktik kebidanan berbasis bukti.
- Mengidentifikasi dan menghormati nilai serta preferensi individu pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis.
- Mengenali situasi klinis yang dapat menyebabkan dilema etik.
- Mengembangkan strategi penyelesaian dilema etik dalam konteks EBMP.

Pendahuluan

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice atau EBMP), kepakaran klinis merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberhasilan pelayanan. Kepakaran klinis tidak hanya mencakup keterampilan teknis atau pengetahuan teoretis tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai individu, preferensi pasien, dan kemampuan dalam menghadapi dilema etik yang muncul di lingkungan klinis. Dilema etik sering kali muncul akibat adanya benturan antara prinsip-prinsip etik dasar seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai individu sangat penting agar keputusan klinis tetap menghormati hak pasien sekaligus menjaga integritas profesional seorang bidan.

A. Kepakaran Klinis dalam Evidence-Based Midwifery Practice

Kepakaran klinis dalam praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) adalah sebuah integrasi komprehensif yang mencakup pemahaman mendalam terhadap ilmu pengetahuan terbaru, keterampilan klinis yang terasah, serta pengalaman profesional yang luas dan terstruktur. Integrasi ini membentuk fondasi yang kokoh bagi seorang bidan untuk mengambil keputusan klinis yang akurat dan tepat guna memberikan asuhan optimal kepada pasien. Dalam konteks kebidanan, kepakaran klinis tidak sekadar berarti penguasaan teknik atau prosedur semata, melainkan juga kemampuan menggabungkan berbagai sumber informasi yang relevan dan terbaru serta menyesuaikan praktiknya dengan kondisi khusus yang dihadapi oleh setiap pasien secara individual.

Lebih jauh lagi, kepakaran klinis menuntut seorang bidan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini melibatkan proses analitis yang mendalam, di mana seorang bidan harus mampu mengevaluasi informasi atau data klinis yang tersedia secara teliti, memahami implikasi dari berbagai alternatif tindakan, serta mempertimbangkan hasil penelitian terbaru yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Dalam berpikir kritis ini, seorang bidan tidak hanya sekadar menerima informasi secara pasif, tetapi aktif dalam mempertanyakan validitas dan reliabilitas bukti ilmiah serta mempertimbangkan sejauh mana bukti tersebut dapat diaplikasikan pada situasi klinis spesifik yang dihadapinya.

Selain berpikir kritis, kepakaran klinis juga mencakup kemampuan reflektif yang tinggi. Kemampuan reflektif adalah kapasitas bidan untuk secara rutin mengevaluasi tindakan klinis yang telah dilakukannya, baik yang berjalan sukses maupun yang mengalami kendala atau hambatan tertentu. Proses refleksi ini membantu bidan dalam mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik dan apa yang memerlukan peningkatan. Dengan cara ini, bidan mampu terus menerus mengembangkan kompetensinya serta melakukan penyesuaian terhadap praktik klinisnya berdasarkan pembelajaran yang ia peroleh dari pengalaman sebelumnya.

Selanjutnya, aspek yang tak kalah penting dalam kepakaran klinis adalah kepekaan terhadap kondisi pasien secara holistik. Dalam praktik kebidanan, seorang bidan dituntut tidak hanya untuk melihat gejala atau kondisi fisik pasien semata, tetapi juga harus mampu memahami dimensi emosional, sosial, budaya, dan psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraan pasien secara

keseluruhan. Kepekaan ini memungkinkan bidan untuk menjalin hubungan terapeutik yang efektif, membangun kepercayaan pasien, serta menyesuaikan intervensi klinis yang diberikan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi pasien yang unik.

Dengan demikian, kepakaran klinis dalam praktik kebidanan berbasis bukti tidak hanya merupakan sebuah kompetensi teknis, tetapi juga mencerminkan penguasaan yang seimbang antara ilmu pengetahuan ilmiah yang terbaru, keterampilan teknis dan prosedural yang mumpuni, serta sikap profesional dan etis yang kuat. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil oleh seorang bidan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif, yang pada akhirnya memberikan manfaat optimal bagi pasien dan meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara keseluruhan.

B. Pentingnya Menghormati Nilai Individu Pasien

Dalam Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP), penghormatan terhadap nilai individu pasien merupakan prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Menghormati nilai individu pasien berarti bidan menyadari bahwa setiap pasien adalah pribadi unik dengan berbagai latar belakang budaya, agama, keyakinan pribadi, dan preferensi yang berbeda. Prinsip ini memastikan bahwa pelayanan kebidanan tidak hanya aman dan efektif secara medis, tetapi juga sensitif secara emosional, sosial, budaya, dan spiritual. Dengan menghormati nilai individu, bidan mampu memberikan asuhan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien secara menyeluruh dan holistik.

1. Mengenal secara mendalam preferensi pribadi, budaya, agama, dan keyakinan pasien.

Setiap pasien memiliki perspektif unik terhadap kesehatan dan asuhan medis berdasarkan latar belakangnya masing-masing. Misalnya, preferensi pribadi pasien terkait metode persalinan, posisi persalinan, atau metode penanganan nyeri mungkin berbeda antara satu pasien dengan pasien lainnya. Pasien dari latar belakang budaya tertentu mungkin memiliki kebiasaan khusus selama kehamilan dan persalinan, seperti ritual kelahiran, pantangan tertentu, atau dukungan keluarga yang luas selama proses persalinan berlangsung. Demikian pula dengan agama dan keyakinan spiritual pasien, yang bisa mempengaruhi penerimaan pasien terhadap tindakan medis tertentu, seperti transfusi darah, penggunaan obat tertentu, atau bahkan penerimaan vaksinasi. Oleh karena itu, bidan perlu secara aktif mendengarkan dan memahami preferensi, nilai-nilai, serta kepercayaan pasien secara rinci agar dapat

memberikan asuhan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental pasien. Hal ini menciptakan lingkungan pelayanan yang inklusif, nyaman, dan menghargai setiap pasien sebagai individu.

2. Memastikan bahwa keputusan klinis yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan pasien.

Dalam konteks EBMP, keputusan klinis yang diambil tidak boleh semata-mata didasarkan pada rekomendasi medis atau hasil penelitian ilmiah saja. Sebaliknya, keputusan tersebut harus mencerminkan aspirasi, harapan, dan kebutuhan unik dari setiap pasien. Contohnya, jika seorang pasien memiliki preferensi kuat untuk persalinan secara alami tanpa intervensi medis yang signifikan, maka bidan perlu secara hati-hati mempertimbangkan preferensi ini dalam perencanaan asuhan, selama hal tersebut tidak membahayakan kesehatan ibu maupun bayi. Dengan menempatkan aspirasi pasien sebagai pusat pengambilan keputusan, pasien merasa dihargai, lebih puas terhadap pelayanan yang diterima, dan memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan perawatan sesuai rekomendasi yang telah disepakati bersama. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara keseluruhan, memperkuat hubungan antara pasien dan bidan, serta menciptakan pengalaman klinis yang positif bagi pasien.

3. Memberikan ruang kepada pasien untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Proses pengambilan keputusan klinis dalam praktik kebidanan yang berbasis bukti tidak hanya melibatkan pihak tenaga kesehatan saja. Pasien juga harus dipandang sebagai mitra aktif dalam proses ini. Dengan memberikan ruang kepada pasien untuk menyuarakan pendapat, pertanyaan, keraguan, atau kekhawatiran yang mereka miliki, bidan menciptakan suasana kolaboratif di mana pasien merasa dihormati dan didengarkan. Melalui komunikasi terbuka dan dialog dua arah ini, pasien mampu memahami alasan di balik setiap keputusan klinis yang dibuat, serta memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif tindakan sesuai preferensinya sendiri. Pasien yang terlibat aktif dalam proses ini cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap rencana asuhan, merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan, dan mendapatkan hasil klinis yang lebih baik dibandingkan pasien yang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, menghormati nilai individu pasien dalam praktik kebidanan berbasis bukti bukan hanya tentang etika profesional, tetapi juga merupakan fondasi kuat dalam menciptakan hubungan terapeutik yang efektif antara pasien dan bidan. Penghormatan terhadap nilai individu memungkinkan

terciptanya pelayanan kebidanan yang manusiawi, empatik, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pasien, sehingga mendukung hasil asuhan yang optimal secara holistik.

C. Dilema Etik dalam Praktik Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, dilema etik muncul ketika seorang bidan menghadapi situasi yang kompleks secara moral, di mana terdapat konflik antara dua atau lebih prinsip-prinsip etika yang seharusnya dipegang teguh secara bersamaan. Situasi ini menuntut kebijaksanaan, pemikiran kritis, serta sensitivitas yang tinggi dari bidan agar mampu mengambil keputusan yang paling tepat secara moral dan profesional. Dilema etik dalam kebidanan bukanlah fenomena yang jarang terjadi, melainkan sesuatu yang sering kali harus dihadapi oleh praktisi kebidanan dalam kesehariannya, khususnya karena kebidanan melibatkan pelayanan terhadap dua nyawa sekaligus, yaitu ibu dan bayi, serta berbagai aspek emosional, sosial, budaya, dan spiritual.

1. Otonomi vs Beneficence

Dilema ini terjadi ketika prinsip otonomi pasien yang mengedepankan hak pasien untuk mengambil keputusan secara bebas bertabrakan dengan prinsip beneficence, yaitu kewajiban moral seorang bidan untuk melakukan tindakan yang terbaik bagi kesejahteraan pasien. Contohnya, seorang pasien yang menolak intervensi medis tertentu seperti operasi caesar atau transfusi darah karena alasan keyakinan pribadi atau agama, sementara intervensi tersebut secara klinis sangat diperlukan demi keselamatan nyawa ibu atau bayi. Dalam situasi ini, bidan menghadapi dilema etik yang kompleks: di satu sisi, bidan wajib menghormati keputusan pasien (otonomi) walaupun itu berisiko; di sisi lain, bidan memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil akan memberikan manfaat terbesar (beneficence). Menyelesaikan dilema ini memerlukan pendekatan empatik dan komunikasi efektif, serta negosiasi yang teliti dan terbuka dengan pasien untuk menemukan solusi terbaik yang tetap menghormati hak pasien sekaligus meminimalkan risiko kesehatan.

2. Non-maleficence vs Beneficence

Dalam kebidanan, prinsip non-maleficence (tidak merugikan pasien) sering kali harus ditimbang terhadap prinsip beneficence (melakukan yang terbaik untuk pasien). Situasi ini terjadi ketika tindakan medis yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kondisi pasien memiliki risiko signifikan yang bisa merugikan pasien. Misalnya, seorang ibu yang membutuhkan tindakan episiotomi atau tindakan invasif lainnya, yang di satu sisi akan

menyebabkan rasa nyeri atau trauma fisik sementara (merugikan), tetapi di sisi lain sangat diperlukan untuk menghindari komplikasi yang lebih parah bagi ibu dan bayi (kebaikan). Dalam kondisi ini, bidan harus mengevaluasi dengan sangat hati-hati dan secara klinis mempertimbangkan apakah manfaat yang diperoleh dari tindakan tersebut secara jelas melebihi potensi risiko atau kerugiannya. Dilema ini menuntut bidan untuk secara profesional menimbang bukti ilmiah terbaik, serta memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi agar pasien memahami sepenuhnya alasan tindakan yang diambil beserta risikonya.

3. Keadilan vs Preferensi Individu

Dalam kondisi sumber daya kesehatan yang terbatas, prinsip keadilan sering kali menghadapi konflik dengan preferensi individu pasien. Prinsip keadilan menekankan perlunya distribusi sumber daya secara merata, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap semua pasien. Sebaliknya, preferensi individu pasien mungkin menghendaki perhatian khusus, perlakuan berbeda, atau alokasi sumber daya yang lebih tinggi dibandingkan pasien lain karena situasi khusus mereka. Sebagai contoh, seorang pasien yang meminta layanan khusus yang memakan lebih banyak waktu, perhatian, dan sumber daya dibandingkan pasien lain, sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan layanan yang sama bagi pasien lain. Bidan dalam kondisi ini perlu bijak dalam mengambil keputusan yang seimbang, dengan memastikan bahwa kebutuhan unik pasien tetap diperhatikan tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Solusi dilema ini biasanya melibatkan negosiasi secara terbuka dengan pasien dan keluarga serta kebijakan lembaga kesehatan yang jelas dalam mengelola sumber daya yang terbatas secara efektif dan adil.

Secara keseluruhan, dilema etik dalam praktik kebidanan mencerminkan realitas kompleks dari praktik klinis yang melibatkan kehidupan, nilai-nilai pribadi, dan berbagai keterbatasan yang nyata dalam sistem pelayanan kesehatan. Mengelola dilema etik secara efektif membutuhkan kompetensi klinis yang tinggi, sensitivitas moral, keterampilan komunikasi, serta keberanian moral untuk mengambil keputusan yang sulit dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang relevan demi mencapai hasil terbaik bagi pasien dan keluarganya.

D. Strategi Menghadapi Dilema Etik dalam Kebidanan

Dalam praktik kebidanan, dilema etik adalah tantangan kompleks yang sering dihadapi bidan. Hal ini terjadi ketika terdapat konflik antara dua atau lebih prinsip etika yang sama-sama penting untuk diterapkan. Bidan dituntut mampu mengelola dilema ini dengan bijaksana dan profesional, karena keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi moral,

emosional, sosial, budaya, serta spiritual dari pasien. Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, terdapat beberapa strategi penting yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan oleh bidan secara berkelanjutan.

Pertama, strategi komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka adalah kunci penting dalam menyelesaikan dilema etik yang muncul dalam kebidanan. Komunikasi terbuka artinya berdialog secara aktif, transparan, dan empatik dengan pasien, keluarga pasien, serta tim kesehatan lainnya. Melalui komunikasi terbuka, seorang bidan dapat secara jelas menjelaskan situasi klinis yang sedang dihadapi, potensi manfaat dan risiko dari berbagai opsi tindakan, serta mendengar secara aktif aspirasi, kekhawatiran, maupun nilai-nilai pribadi pasien. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif juga berarti bahwa bidan mampu menyampaikan informasi medis secara jelas, tanpa bias atau tekanan, sehingga pasien dapat mengambil keputusan yang terinformasi dengan baik (*informed consent*). Selain itu, komunikasi terbuka dengan tim kesehatan juga penting untuk memastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang sama terkait situasi pasien, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama yang secara moral, etis, dan profesional dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, konsultasi etik. Dalam situasi di mana dilema etik sangat kompleks dan sulit dipecahkan secara langsung, konsultasi etik merupakan strategi yang sangat berguna dan efektif. Konsultasi etik biasanya melibatkan komite etik rumah sakit atau pakar etik profesional yang memiliki keahlian khusus dalam bidang etika kesehatan. Melalui konsultasi etik, seorang bidan mendapatkan perspektif tambahan dan objektif mengenai dilema yang dihadapi, yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya. Komite etik dapat memberikan masukan atau rekomendasi yang bersifat netral berdasarkan prinsip-prinsip moral dan profesional yang berlaku secara universal. Proses konsultasi ini juga membantu bidan untuk mendapatkan dukungan moral dan mengurangi beban psikologis dari keputusan sulit yang harus diambil. Pada akhirnya, konsultasi etik memungkinkan bidan untuk membuat keputusan klinis yang lebih etis, terinformasi, dan mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang secara lebih menyeluruh.

Ketiga, pengembangan kompetensi etik. Untuk mengelola dilema etik secara efektif dalam jangka panjang, sangat penting bagi bidan untuk terus menerus meningkatkan kompetensi etiknya melalui pelatihan rutin dan pendidikan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi etik berarti membekali bidan dengan keterampilan khusus dalam menganalisis situasi moral yang kompleks, mengevaluasi konflik antara prinsip etika yang saling bertentangan, dan mengambil keputusan yang bijaksana serta tepat secara etis. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai aspek seperti simulasi kasus etik, diskusi studi kasus, serta workshop

tentang pengambilan keputusan etik yang melibatkan multidisiplin ilmu. Dengan mengikuti pelatihan ini secara rutin, bidan tidak hanya meningkatkan keterampilan praktisnya dalam menyelesaikan dilema etik, tetapi juga memperkuat kesadaran moral, sensitivitas terhadap nilai-nilai pasien, serta meningkatkan rasa percaya diri saat menghadapi situasi klinis yang menantang secara moral dan etis.

Secara keseluruhan, penerapan strategi komunikasi terbuka, konsultasi etik, dan pengembangan kompetensi etik akan membantu bidan untuk lebih siap dalam menghadapi dilema etik dalam praktik kebidanan. Strategi-strategi ini secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis, memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dengan pasien dan keluarga, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara menyeluruh. Hal ini juga secara tidak langsung memperkuat reputasi profesionalisme dan kredibilitas seorang bidan sebagai tenaga kesehatan yang mampu menghadapi tantangan moral yang kompleks secara bijaksana dan bertanggung jawab.

E. Latihan Soal

Soal 1

Seorang bidan menghadapi pasien primigravida yang meminta persalinan normal tanpa intervensi medis. Namun, hasil pemeriksaan klinis menunjukkan kondisi yang memerlukan tindakan operasi caesar segera demi keselamatan ibu dan janin. Apa langkah paling tepat yang seharusnya dilakukan bidan sesuai prinsip kepakaran klinis dalam EBMP?

- A. Menghormati keinginan pasien dan tetap melakukan persalinan normal.
- B. Menjelaskan secara detail risiko dan manfaat dari setiap pilihan tindakan kepada pasien.
- C. Langsung merujuk pasien tanpa menjelaskan secara detail.
- D. Tetap melakukan tindakan caesar meskipun pasien menolak secara tegas.
- E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada keluarga pasien tanpa diskusi.

Kunci: B

Rasional:

Dalam kepakaran klinis EBMP, bidan perlu melakukan komunikasi terbuka dan menjelaskan secara rinci manfaat serta risiko setiap opsi tindakan kepada pasien. Langkah ini memungkinkan pasien membuat keputusan yang terinformasi sambil tetap menghormati otonomi pasien, meskipun dalam kondisi darurat.

Soal 2

Seorang ibu dari latar belakang budaya tertentu meyakini bahwa bayi baru lahir harus diberi ramuan tradisional sebelum pemberian ASI pertama kali. Bidan

mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi praktik kebidanan berbasis bukti. Apa tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh bidan?

- A. Melarang secara tegas tanpa memberi penjelasan mendalam kepada ibu.
- B. Mengikuti keinginan keluarga agar ibu merasa nyaman dan diterima.
- C. Memberikan edukasi secara empatik dan terbuka mengenai risiko dan manfaat pemberian ramuan tradisional.
- D. Merujuk ibu ke rumah sakit untuk mendapatkan intervensi medis lebih lanjut.
- E. Mengabaikan tindakan tersebut karena dianggap bukan wewenang bidan.

Kunci: C

Rasional:

Menghormati nilai individu pasien dalam EBMP berarti memahami secara mendalam nilai budaya pasien. Dalam kasus ini, pendekatan terbaik adalah dengan komunikasi empatik, edukasi yang jelas dan informatif mengenai risiko pemberian ramuan tradisional, serta menawarkan alternatif yang aman secara medis.

Soal 3

Seorang bidan menghadapi dilema etik ketika pasien menolak tindakan episiotomi yang menurut hasil evaluasi klinis sangat diperlukan untuk mencegah ruptur perineum derajat tinggi. Prinsip etika apa yang sedang bertentangan dalam kasus ini?

- A. Non-maleficence vs Keadilan
- B. Otonomi vs Beneficence
- C. Non-maleficence vs Otonomi
- D. Beneficence vs Keadilan
- E. Keadilan vs Preferensi Individu

Kunci: B

Rasional:

Kasus ini jelas menggambarkan dilema etik antara menghormati hak pasien (otonomi) untuk menolak tindakan medis tertentu dan kewajiban bidan untuk melakukan tindakan terbaik demi kebaikan pasien (beneficence), agar pasien terhindar dari cedera serius.

Soal 4

Seorang bidan mengalami dilema etik karena di fasilitas kesehatannya terdapat keterbatasan alat dan sumber daya medis. Ia harus memutuskan apakah akan memberikan layanan khusus yang sangat diinginkan seorang pasien, tetapi hal itu berarti pasien lain mungkin kehilangan akses terhadap layanan dasar. Apa pendekatan terbaik dalam situasi ini?

- A. Memberikan layanan khusus tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasien lain.
- B. Menolak langsung permintaan pasien demi prinsip keadilan.
- C. Mengadakan diskusi terbuka dengan pasien mengenai keterbatasan sumber daya serta menawarkan solusi alternatif yang adil.
- D. Meminta pasien membayar lebih agar layanan bisa diprioritaskan.
- E. Menyerahkan keputusan tersebut kepada pihak manajemen tanpa diskusi lanjutan.

Kunci: C

Rasional:

Dalam dilema keadilan vs preferensi individu, pendekatan terbaik adalah diskusi terbuka mengenai kondisi keterbatasan yang ada, disertai alternatif solusi yang adil untuk semua pasien, sehingga prinsip keadilan tetap dipertahankan tanpa mengabaikan kebutuhan khusus pasien.

Soal 5

Seorang bidan menghadapi dilema etik yang kompleks, di mana pasien membutuhkan transfusi darah mendesak tetapi pasien tersebut menolak karena alasan agama yang dianutnya. Setelah berdiskusi secara intensif, pasien tetap menolak. Apa langkah paling tepat yang dapat dilakukan bidan berikutnya dalam menangani dilema ini?

- A. Tetap memberikan transfusi darah tanpa persetujuan pasien demi menyelamatkan nyawanya.
- B. Menghentikan asuhan sepenuhnya karena pasien tidak kooperatif.
- C. Melakukan konsultasi dengan komite etik atau pakar etik untuk mendapatkan rekomendasi solusi yang tepat.
- D. Merujuk pasien ke rumah sakit lain tanpa informasi lebih lanjut kepada pasien.
- E. Mengikuti sepenuhnya keinginan pasien tanpa tindakan alternatif.

Kunci: C

Rasional:

Dalam situasi dilema etis yang kompleks, strategi terbaik adalah konsultasi dengan komite etik rumah sakit atau pakar etik profesional yang dapat memberikan pandangan netral berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika yang berlaku secara universal, sehingga didapat solusi yang terbaik secara etis dan profesional.

F. Rangkuman Materi

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) menekankan pentingnya integrasi antara kepakaran klinis bidan, penghormatan terhadap nilai individu pasien, serta kemampuan menghadapi

dilema etik secara profesional. Kepakaran klinis dalam EBMP tidak hanya mencakup penguasaan teori dan keterampilan klinis, tetapi juga berpikir kritis, reflektif, serta kepekaan terhadap kondisi pasien secara holistik. Menghormati nilai individu pasien merupakan dasar dalam memberikan asuhan yang sensitif secara emosional, sosial, budaya, dan spiritual, dengan melibatkan pasien secara aktif dalam proses pengambilan keputusan klinis. Sementara itu, dilema etik yang sering muncul dalam kebidanan—seperti konflik antara otonomi dengan beneficence, non-maleficence dengan beneficence, serta keadilan dengan preferensi individu—menuntut bidan mampu mengambil keputusan yang bijaksana melalui komunikasi terbuka, konsultasi etik, serta pengembangan kompetensi etik secara berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip dan strategi ini secara konsisten, bidan dapat memberikan asuhan optimal, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan, serta memperkuat hubungan terapeutik yang efektif dan profesional dengan pasien dan keluarga.

G. Glosarium

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Praktik kebidanan yang didasarkan pada integrasi bukti ilmiah terbaik, kepakaran klinis, dan nilai atau preferensi pasien, guna memberikan asuhan kebidanan optimal.

Kepakaran Klinis (Clinical Expertise)

Kemampuan profesional seorang bidan yang mencakup pengetahuan mendalam, keterampilan klinis terasah, dan pengalaman profesional luas untuk mengambil keputusan klinis secara akurat dan tepat.

Berpikir Kritis

Proses analitis yang mendalam oleh bidan dalam mengevaluasi informasi klinis, mempertimbangkan implikasi tindakan, serta menilai validitas dan reliabilitas bukti ilmiah.

Kemampuan Reflektif

Kapasitas bidan dalam mengevaluasi secara rutin tindakan klinis yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun hambatan, sehingga kompetensi klinisnya terus berkembang.

Kepekaan Holistik

Kemampuan bidan dalam memahami dan memperhatikan dimensi emosional, sosial, budaya, psikologis, serta spiritual pasien secara keseluruhan, bukan hanya gejala fisik semata.

Nilai Individu Pasien

Prinsip dalam EBMP yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap preferensi, budaya, agama, dan keyakinan unik setiap pasien dalam pemberian asuhan kebidanan.

Otonomi Pasien

Hak pasien untuk membuat keputusan secara bebas mengenai tindakan medis yang akan diterima, berdasarkan pemahaman lengkap terhadap manfaat dan risiko yang ada.

Beneficence (Berbuat Baik)

Kewajiban moral tenaga kesehatan (bidan) untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat optimal bagi pasien.

Non-maleficence (Tidak Merugikan)

Prinsip etik yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk tidak menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap pasien.

Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan

Prinsip etik yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya kesehatan secara merata, adil, dan tanpa diskriminasi kepada semua pasien.

Dilema Etik

Situasi di mana terjadi konflik antara dua atau lebih prinsip etika yang sama-sama penting, sehingga memerlukan kebijaksanaan dan pertimbangan yang hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Komunikasi Terbuka

Strategi berdialog secara aktif, transparan, dan empatik dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan guna menyelesaikan dilema etik secara efektif dan menghasilkan keputusan yang terinformasi.

Konsultasi Etik

Proses melibatkan komite etik atau pakar etika profesional untuk memperoleh pandangan objektif serta rekomendasi dalam menghadapi dilema etika yang kompleks dalam praktik klinis.

Kompetensi Etik

Keterampilan profesional bidan dalam menganalisis situasi moral yang kompleks, mengevaluasi konflik etika, serta mengambil keputusan etis yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Hubungan Terapeutik

Hubungan profesional antara bidan dengan pasien yang didasarkan pada rasa percaya, empati, serta komunikasi yang efektif, guna mendukung hasil pelayanan kesehatan yang optimal.

H. Daftar Pustaka

- American College of Nurse-Midwives. (2021). Core competencies for basic midwifery practice. ACNM. <https://www.midwife.org/Core-Competencies>
- Black, B. P. (2019). Professional nursing: Concepts & challenges (9th ed.). Elsevier.
- Butts, J. B., & Rich, K. L. (2019). Nursing ethics: Across the curriculum and into practice (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Fahy, K., Parratt, J., Foureur, M., & Hastie, C. (2019). Birth territory and midwifery guardianship: Theory for practice, education, and research (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). Essential competencies for midwifery practice: 2019 Update. ICM. <https://www.internationalmidwives.org>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2018). Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice (4th ed.). Wolters Kluwer.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., ... & Declercq, E. (2019). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129-1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2018). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>
- Schwartz, L., Preece, P. E., & Hendry, R. A. (2018). Clinical ethics: A practical approach to ethical decisions in clinical medicine (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>

BAB 10

EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: DATA COLLECTION AND ANALYSIS METHODS, QUALITY APPRAISAL OF RESEARCH

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan metode pengumpulan dan analisis data serta menilai kualitas penelitian secara kritis dalam praktik kebidanan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menerapkan berbagai metode pengumpulan data, menganalisis data hasil penelitian dengan tepat, serta mengevaluasi kualitas bukti ilmiah untuk meningkatkan praktik kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan metode pengumpulan data dalam penelitian kebidanan berbasis bukti.
- Melakukan analisis data penelitian dengan metode statistik dan interpretatif yang relevan.
- Mengaplikasikan teknik penilaian kualitas (quality appraisal) penelitian kebidanan untuk memastikan kevalidan hasil penelitian.
- Mengintegrasikan hasil analisis data dan kualitas bukti dalam praktik klinis kebidanan.

Pendahuluan

Dalam praktik kebidanan, pengambilan keputusan klinis harus didasarkan pada bukti ilmiah terkini untuk menjamin kualitas pelayanan yang optimal. Untuk mencapai hal ini, bidan harus mampu mengumpulkan data dengan metode yang tepat, melakukan analisis secara akurat, serta menilai kualitas penelitian secara kritis (quality appraisal). Data yang valid dan analisis yang cermat menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based practice) yang meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi.

A. Metode Pengumpulan Data dalam Praktik Kebidanan

Metode pengumpulan data dalam praktik kebidanan merupakan tahapan penting yang digunakan bidan atau tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi akurat mengenai kondisi pasien atau populasi yang ditangani. Terdapat dua kategori utama dalam pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau responden yang memiliki keterkaitan langsung dengan kasus yang diteliti. Salah satu metode pengumpulan data primer yang sering digunakan dalam praktik kebidanan adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara terstruktur ataupun semi-terstruktur secara langsung kepada pasien, keluarga pasien, atau tenaga kesehatan lainnya. Wawancara mendalam biasanya bertujuan menggali informasi yang sifatnya pribadi, kompleks, atau sensitif, seperti pengalaman emosional pasien dalam menjalani persalinan, persepsi mengenai layanan kebidanan, atau bagaimana pasien memandang keputusan klinis yang diambil oleh tenaga kesehatan. Kelebihan wawancara mendalam terletak pada kemampuannya menggali informasi secara mendalam dan kaya makna yang sering kali tidak mungkin didapatkan melalui metode lain. Akan tetapi, metode ini membutuhkan waktu yang cukup lama, keahlian dalam teknik wawancara, serta sensitivitas dan empati dalam berkomunikasi agar responden merasa nyaman dan terbuka untuk berbagi informasi.

Metode lain dari pengumpulan data primer adalah observasi langsung. Observasi langsung melibatkan pengamatan secara langsung terhadap kondisi pasien, interaksi antara pasien dengan bidan, atau lingkungan tempat layanan kebidanan berlangsung. Observasi ini penting untuk mengevaluasi aspek-aspek praktik kebidanan yang nyata, seperti keterampilan klinis bidan, proses interaksi dan komunikasi, serta bagaimana lingkungan layanan kesehatan mendukung keselamatan dan kenyamanan pasien. Keuntungan dari observasi langsung adalah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perilaku atau tindakan nyata tanpa dipengaruhi oleh bias atau laporan subjektif responden. Namun, metode ini membutuhkan perhatian yang intensif, objektivitas yang tinggi dari observer, serta pemahaman yang mendalam tentang konteks situasi yang diamati.

Metode pengumpulan data primer berikutnya yang umum digunakan adalah survei dan kuesioner. Metode ini melibatkan penggunaan instrumen berupa daftar pertanyaan tertutup atau terbuka yang disusun secara sistematis dan disebarikan kepada sejumlah besar responden. Survei atau kuesioner sering digunakan dalam

praktik kebidanan untuk mendapatkan informasi mengenai kepuasan pasien terhadap layanan kebidanan, perilaku kesehatan ibu hamil atau menyusui, atau untuk memetakan masalah kesehatan di komunitas tertentu. Keuntungan utama dari survei dan kuesioner adalah efisiensi dalam mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu singkat serta kemudahan dalam analisis kuantitatif. Namun, survei dan kuesioner juga memiliki tantangan tersendiri, seperti risiko responden memberikan jawaban yang kurang jujur atau mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang disampaikan.

Di sisi lain, data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumentasi yang sudah dibuat atau tersedia dalam catatan resmi, laporan, atau publikasi penelitian. Salah satu bentuk metode pengumpulan data sekunder adalah studi literatur dan kajian dokumen. Dalam praktik kebidanan, metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang kuat, menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu, serta untuk mengidentifikasi temuan-temuan penting yang relevan dengan praktik kebidanan berbasis bukti. Kajian dokumen dapat berupa analisis laporan kesehatan dari rumah sakit, laporan tahunan dari fasilitas kesehatan, atau catatan rekam medis pasien yang dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tren kesehatan atau efektivitas intervensi tertentu. Keuntungan dari metode ini adalah tersedianya data yang cukup lengkap serta hemat waktu, tetapi kelemahannya terletak pada kemungkinan data yang kurang up-to-date atau kurang spesifik terhadap kebutuhan penelitian.

Selain itu, penggunaan database kesehatan juga merupakan bentuk penting dari pengumpulan data sekunder dalam praktik kebidanan. Database kesehatan seperti Sistem Informasi Kesehatan (SIK), catatan elektronik pasien, atau registrasi nasional tentang kelahiran, kematian ibu, maupun status imunisasi anak sering kali digunakan untuk mengevaluasi pola penyakit, hasil perawatan, atau efektivitas berbagai intervensi kesehatan secara luas. Penggunaan database kesehatan sangat bermanfaat untuk analisis statistik yang mendalam serta evaluasi dampak kebijakan kesehatan di bidang kebidanan. Namun, tantangan dalam menggunakan database kesehatan ini adalah terkadang terdapat keterbatasan akses, kerahasiaan data, serta kualitas pencatatan yang tidak merata antar fasilitas kesehatan.

Secara keseluruhan, baik metode pengumpulan data primer maupun sekunder memiliki peran penting dalam mendukung praktik kebidanan berbasis bukti. Kombinasi dari berbagai metode ini memungkinkan bidan atau tenaga kesehatan memperoleh informasi yang valid, akurat, serta relevan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat, dan mendorong praktik reflektif dalam pelayanan kesehatan maternal.

B. Metode Analisis Data dalam Penelitian Kebidanan

Metode analisis data dalam penelitian kebidanan bertujuan untuk menginterpretasikan, menyederhanakan, serta memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang akurat. Dalam penelitian kebidanan, analisis data mencakup berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, tujuan penelitian, serta desain studi yang digunakan.

Salah satu bentuk analisis data yang paling sering digunakan dalam penelitian kebidanan adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan atau meringkas data yang telah dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi atau prediksi terhadap populasi yang lebih luas. Metode analisis ini mencakup beberapa ukuran sentral dan variasi. Mean (rerata) adalah nilai rata-rata dari seluruh data yang diperoleh, yang sangat bermanfaat dalam menunjukkan kecenderungan umum data seperti rata-rata usia ibu hamil, rerata durasi persalinan, atau rata-rata berat badan bayi lahir. Median merupakan nilai tengah dalam suatu rangkaian data yang telah diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, sering kali digunakan dalam penelitian kebidanan yang melibatkan data tidak terdistribusi normal atau data dengan nilai ekstrem yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata, misalnya median usia ibu yang melahirkan atau median skor nyeri yang dilaporkan ibu selama proses persalinan. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satu set data dan berguna untuk menunjukkan pola atau frekuensi yang paling umum, misalnya modus dari metode persalinan yang paling banyak dipilih oleh ibu hamil dalam komunitas tertentu. Sementara itu, simpangan baku adalah ukuran statistik yang menggambarkan variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Dalam penelitian kebidanan, simpangan baku membantu menentukan seberapa konsisten atau bervariasi data yang diperoleh, misalnya variasi dalam usia kehamilan atau variasi durasi rawat inap ibu pasca-persalinan.

Selain analisis statistik deskriptif, penelitian kebidanan juga sering menggunakan analisis statistik inferensial. Berbeda dengan statistik deskriptif, statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari data sampel penelitian terhadap populasi yang lebih luas. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji-t, yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata antara dua kelompok data independen atau terkait, misalnya membandingkan efektivitas dua metode intervensi dalam mengurangi nyeri persalinan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisis varians atau ANOVA (Analysis of Variance) digunakan jika penelitian melibatkan lebih dari dua kelompok untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok tersebut, contohnya dalam penelitian tentang perbedaan outcome persalinan antara ibu yang menggunakan

berbagai metode persalinan nonfarmakologis. Sementara itu, analisis korelasi digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara dua variabel kuantitatif, misalnya hubungan antara berat badan ibu sebelum hamil dengan risiko komplikasi persalinan. Analisis regresi, baik regresi linear maupun regresi logistik, digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat antar variabel serta memprediksi dampak perubahan pada variabel independen terhadap variabel dependen, contohnya memprediksi risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan berdasarkan usia ibu dan indeks massa tubuh.

Metode analisis data lain yang sangat relevan dalam penelitian kebidanan adalah analisis kualitatif, terutama digunakan pada penelitian yang bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif subjektif responden. Salah satu metode analisis kualitatif yang populer adalah analisis tematik. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola tertentu (tema) yang muncul dalam data kualitatif, seperti transkrip wawancara mendalam dengan ibu tentang pengalaman emosionalnya selama kehamilan atau persalinan. Proses analisis tematik mencakup pengkodean data, identifikasi tema-tema sentral, serta interpretasi mendalam terhadap makna di balik tema-tema tersebut. Melalui analisis ini, peneliti dapat memahami berbagai aspek emosional, sosial, dan budaya dalam praktik kebidanan yang sering tidak terlihat dari pendekatan kuantitatif.

Selain analisis tematik, analisis konten juga sering digunakan dalam penelitian kebidanan. Analisis konten adalah metode analisis data yang fokus pada isi atau pesan yang terkandung dalam dokumen tertulis, rekaman audio, atau rekaman video yang terkait dengan praktik kebidanan. Misalnya, analisis konten dapat digunakan untuk mengkaji isi materi edukasi yang diberikan kepada ibu hamil, menganalisis isi kampanye kesehatan publik tentang pentingnya perawatan antenatal, atau mengevaluasi dokumentasi rekam medis pasien untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan kebidanan. Dalam analisis konten, proses utamanya melibatkan klasifikasi, kategorisasi, dan evaluasi data untuk menemukan makna yang lebih luas dan implikasi yang berguna dalam praktik klinis maupun kebijakan kebidanan.

Secara keseluruhan, pemilihan metode analisis data dalam penelitian kebidanan sangat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang dikumpulkan, serta desain studi yang digunakan. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat dan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif, hasil penelitian kebidanan akan memiliki kualitas yang tinggi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta mampu mendukung praktik klinis yang efektif dan berbasis bukti dalam kebidanan.

C. Quality Appraisal of Research (Penilaian Kualitas Penelitian)

Quality appraisal of research atau penilaian kualitas penelitian adalah proses evaluasi kritis terhadap penelitian ilmiah untuk menentukan sejauh mana temuan atau hasil penelitian tersebut dapat dipercaya, diaplikasikan, dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Dalam praktik kebidanan, proses ini sangat penting guna memastikan bahwa tindakan klinis yang dilakukan benar-benar berdasarkan pada hasil penelitian yang valid dan berkualitas tinggi.

Dalam proses penilaian kualitas penelitian, terdapat beberapa kriteria dasar yang umum digunakan untuk menilai kualitas studi, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalisasi. Validitas merupakan kriteria penting pertama yang menunjukkan sejauh mana suatu penelitian secara tepat mengukur atau mengkaji hal yang ingin diteliti. Penelitian yang valid berarti mampu memberikan hasil yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi nyata yang ingin dipahami atau diintervensi dalam praktik kebidanan. Misalnya, validitas dalam penelitian kebidanan dapat melibatkan apakah instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur tingkat kepuasan pasien atau efektivitas metode persalinan tertentu secara akurat.

Reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi atau kestabilan hasil penelitian ketika diulang dalam kondisi serupa. Sebuah penelitian yang memiliki reliabilitas tinggi akan menunjukkan hasil yang sama atau konsisten jika diulangi oleh peneliti lain dalam kondisi atau setting yang sama. Dalam kebidanan, reliabilitas penting terutama dalam pengukuran klinis, seperti pemeriksaan fisik ibu hamil atau interpretasi hasil rekam jantung janin, di mana konsistensi pengukuran sangat penting untuk memastikan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh.

Objektivitas dalam penelitian kebidanan menekankan pada tingkat netralitas penelitian atau sejauh mana penelitian tersebut bebas dari bias atau pengaruh subjektif peneliti. Objektivitas penting karena hasil penelitian yang terlalu dipengaruhi opini pribadi atau persepsi peneliti dapat menyebabkan distorsi hasil, sehingga kurang dipercaya dan sulit untuk diaplikasikan secara umum. Sebuah penelitian yang objektif akan memperlihatkan bahwa data dan temuan penelitian benar-benar mencerminkan situasi sebenarnya, bukan interpretasi yang dipengaruhi oleh asumsi pribadi peneliti.

Kriteria dasar selanjutnya adalah generalisasi, yang berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas dari sampel yang diteliti. Dalam penelitian kebidanan, generalisasi penting

untuk menentukan apakah temuan penelitian yang diperoleh dari kelompok sampel tertentu dapat berlaku secara luas pada kelompok ibu hamil atau pasien kebidanan yang lebih besar dan beragam. Penelitian dengan generalisasi yang baik biasanya melibatkan pemilihan sampel yang representatif serta desain studi yang baik, yang memungkinkan hasilnya dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas.

Dalam proses penilaian kualitas penelitian, para peneliti atau praktisi kebidanan sering kali menggunakan berbagai alat bantu atau instrumen khusus yang membantu mengevaluasi secara sistematis kualitas suatu studi. Salah satu alat bantu yang banyak digunakan adalah Checklist Critical Appraisal Skills Programme (CASP). CASP adalah sebuah instrumen checklist yang dirancang untuk menilai kualitas berbagai jenis penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Instrumen ini membantu penilai dalam menentukan apakah tujuan penelitian jelas, apakah desain penelitiannya tepat, apakah metode penelitian sudah diterapkan dengan benar, apakah data dianalisis secara tepat, dan apakah kesimpulan penelitian didukung oleh bukti yang kuat. CASP sangat berguna bagi praktisi kebidanan untuk dengan cepat menentukan apakah suatu penelitian cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar praktik klinis atau kebijakan kebidanan.

Alat bantu lain yang umum digunakan adalah Jadad Scale, yang secara khusus digunakan untuk menilai kualitas uji klinis acak terkontrol (Randomized Controlled Trials – RCT). Skala Jadad menilai kualitas studi berdasarkan beberapa aspek penting, seperti proses randomisasi atau pengacakan, proses pembutaan (blinding), serta tingkat kejelasan dalam melaporkan penarikan atau dropout subjek penelitian. Setiap item diberikan skor, sehingga menghasilkan skor total yang menunjukkan tingkat kualitas penelitian. Jadad Scale sering dipakai dalam penelitian kebidanan untuk menilai apakah sebuah uji klinis mengenai metode persalinan tertentu atau intervensi kesehatan maternal tertentu memiliki kualitas metodologi yang memadai, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan dijadikan dasar praktik klinis.

Secara keseluruhan, quality appraisal of research sangat penting dalam memastikan bahwa praktik kebidanan berbasis bukti benar-benar menggunakan hasil penelitian yang valid, reliabel, objektif, serta mampu digeneralisasikan. Dengan menggunakan alat bantu seperti checklist CASP atau Jadad Scale, praktisi kebidanan dapat secara sistematis dan objektif mengevaluasi kualitas penelitian sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan temuan penelitian tersebut dalam praktik sehari-hari, sehingga meningkatkan kualitas layanan kebidanan serta keamanan pasien secara keseluruhan.

D. Integrasi Data dan Analisis dalam Praktik Klinis Kebidanan

Integrasi data dan analisis dalam praktik klinis kebidanan merupakan suatu pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan klinis yang dibuat oleh bidan didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat serta hasil analisis yang valid dan relevan. Hal ini sangat penting dalam mencapai praktik kebidanan yang berbasis bukti (evidence-based midwifery practice), di mana keputusan klinis tidak hanya bergantung pada pengalaman pribadi tetapi juga didukung oleh hasil penelitian yang kredibel dan berkualitas tinggi.

Proses pengambilan keputusan klinis berdasarkan hasil analisis melibatkan langkah-langkah sistematis yang dimulai dari mengidentifikasi permasalahan klinis yang dihadapi oleh pasien atau kelompok pasien tertentu. Setelah itu, bidan mencari informasi atau data yang relevan melalui berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif, inferensial, atau analisis kualitatif, tergantung pada kebutuhan klinis dan tujuan penelitian. Hasil analisis inilah yang akan dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis, seperti menentukan intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah yang dialami pasien. Misalnya, jika hasil analisis statistik menunjukkan bahwa metode persalinan alami tertentu terbukti efektif dalam mengurangi risiko komplikasi dibandingkan metode lainnya, maka metode tersebut bisa dijadikan pilihan prioritas dalam asuhan kebidanan kepada pasien.

Setelah hasil analisis diperoleh, langkah berikutnya adalah menentukan relevansi bukti dalam konteks klinis spesifik. Menentukan relevansi bukti berarti mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian tersebut sesuai dengan kondisi unik pasien atau lingkungan klinis di mana praktik kebidanan dilakukan. Dalam hal ini, bidan harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti kondisi pasien secara individu, preferensi pasien, serta sumber daya dan kondisi fasilitas kesehatan tempat layanan kebidanan berlangsung. Misalnya, meskipun sebuah intervensi terbukti efektif secara ilmiah, intervensi tersebut mungkin tidak relevan apabila pasien memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membatasi penerapan intervensi tersebut atau bila fasilitas kesehatan tidak memiliki sumber daya memadai untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, integrasi hasil analisis dengan kondisi nyata pasien sangat penting dalam memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil benar-benar realistis, praktis, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi pasien dan keluarganya.

Selain aspek teknis tersebut, bagian penting lainnya dalam integrasi data dan analisis adalah refleksi praktik berdasarkan hasil penelitian. Refleksi praktik

merupakan proses di mana bidan mengevaluasi kembali tindakannya dalam pelayanan kebidanan yang telah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian atau bukti terbaru yang diperoleh. Melalui refleksi ini, bidan dapat menilai efektivitas praktiknya, menemukan potensi area perbaikan, dan melakukan penyesuaian dalam praktik selanjutnya. Refleksi praktik bisa dilakukan melalui diskusi kelompok bersama rekan kerja, jurnal refleksi pribadi, ataupun dalam forum evaluasi layanan kesehatan rutin di fasilitas pelayanan kebidanan.

Sebagai contoh, jika hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa strategi edukasi kesehatan yang selama ini digunakan kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman ibu hamil tentang persiapan persalinan, maka bidan perlu merefleksikan mengapa hal ini terjadi. Apakah metode edukasi yang digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan ibu, atau ada kendala teknis dalam pelaksanaan edukasi tersebut? Berdasarkan hasil refleksi ini, bidan dapat mengadopsi pendekatan baru atau modifikasi metode edukasi yang lebih efektif sesuai rekomendasi hasil penelitian terbaru. Proses refleksi ini sangat penting karena tidak hanya membantu memperbaiki kualitas praktik kebidanan tetapi juga mendukung pengembangan profesionalisme bidan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi data dan analisis dalam praktik klinis kebidanan tidak hanya berhenti pada pengumpulan dan interpretasi hasil analisis, tetapi juga mencakup evaluasi kritis tentang bagaimana hasil tersebut dapat secara nyata diterapkan dalam praktik sehari-hari. Integrasi yang efektif akan menghasilkan praktik kebidanan yang lebih akurat, efektif, aman, serta responsif terhadap kebutuhan pasien dan komunitas. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan, menurunkan risiko komplikasi, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperkuat profesionalisme bidan dalam menghadapi tantangan praktik kebidanan modern yang semakin kompleks.

E. Daftar Pustaka

Soal Kasus 1:

Seorang bidan sedang merencanakan penelitian untuk mengeksplorasi pengalaman emosional ibu hamil selama persalinan normal. Ia ingin menggali secara mendalam tentang perasaan dan persepsi ibu terkait pelayanan kebidanan yang diterimanya. Metode pengumpulan data primer yang paling tepat digunakan dalam kasus ini adalah:

- A. Survei menggunakan kuesioner tertutup
- B. Observasi langsung saat proses persalinan

- C. Studi literatur dari penelitian sebelumnya
- D. Wawancara mendalam (in-depth interview)
- E. Analisis data sekunder dari database kesehatan

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Wawancara mendalam adalah metode paling tepat untuk mengeksplorasi pengalaman emosional secara mendalam, kompleks, dan sensitif karena memungkinkan responden mengungkapkan perasaan dan pemikiran secara terbuka dan detail.

Soal Kasus 2:

Seorang bidan ingin mengevaluasi keterampilan komunikasi dan interaksi antar bidan dengan pasien dalam proses konsultasi antenatal. Ia membutuhkan metode yang memberikan gambaran jelas tentang perilaku nyata, tanpa dipengaruhi bias subjektif pasien atau tenaga kesehatan. Metode pengumpulan data primer yang paling sesuai adalah:

- A. Studi dokumentasi catatan medis pasien
- B. Observasi langsung terhadap interaksi bidan dan pasien
- C. Survei kepuasan pasien menggunakan kuesioner
- D. Wawancara mendalam kepada pasien setelah konsultasi
- E. Analisis konten dari rekaman audio edukasi antenatal

Kunci Jawaban: B

Rasional:

Observasi langsung memungkinkan penilaian objektif dan akurat terhadap perilaku nyata tanpa dipengaruhi persepsi atau laporan subjektif, sehingga paling tepat untuk mengevaluasi keterampilan interaksi dan komunikasi secara langsung.

Soal Kasus 3:

Seorang peneliti kebidanan melakukan analisis untuk menentukan apakah ada hubungan antara usia ibu hamil dengan risiko terjadinya preeklampsia. Ia memiliki data numerik dari sejumlah besar pasien. Metode analisis statistik inferensial yang paling tepat untuk digunakan adalah:

- A. Mean, median, modus
- B. Analisis konten
- C. Analisis tematik
- D. Uji korelasi
- E. Studi literatur

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Uji korelasi adalah metode analisis inferensial yang tepat untuk menentukan hubungan atau asosiasi antara dua variabel numerik, dalam hal ini usia ibu dan risiko preeklampsia.

Soal Kasus 4:

Seorang bidan menemukan sebuah penelitian tentang efektivitas metode hypnobirthing dalam mengurangi nyeri persalinan. Sebelum menerapkan hasil penelitian ini dalam praktiknya, ia ingin memastikan apakah hasil penelitian tersebut dapat diterapkan secara luas di tempat praktiknya yang memiliki karakteristik populasi yang beragam. Kriteria kualitas penelitian yang paling penting dipertimbangkan dalam situasi ini adalah:

- A. Reliabilitas
- B. Objektivitas
- C. Validitas
- D. Generalisasi
- E. Relevansi teoritis

Kunci Jawaban: D**Rasional:**

Generalisasi penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas dan beragam di luar sampel penelitian, sehingga relevan dengan konteks klinis di tempat praktik bidan tersebut.

Soal Kasus 5:

Seorang bidan menemukan dua penelitian dengan hasil yang bertolak belakang tentang efektivitas penggunaan bola persalinan dalam memperpendek durasi persalinan kala I. Untuk menentukan penelitian mana yang memiliki kualitas metodologi yang lebih tinggi, alat bantu yang paling tepat digunakan adalah:

- A. Analisis tematik
- B. Studi literatur sistematis
- C. Jadad Scale
- D. Analisis konten
- E. Observasi langsung

Kunci Jawaban: C**Rasional:**

Jadad Scale adalah alat bantu khusus untuk menilai kualitas uji klinis acak terkontrol (RCT), menilai aspek randomisasi, blinding, dan dropout, sehingga efektif digunakan untuk menentukan kualitas metodologi dari dua penelitian tersebut.

F. Rangkuman Materi

Dalam praktik kebidanan berbasis bukti, metode pengumpulan data memainkan peran kunci dalam menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan bermakna. Metode pengumpulan data primer seperti wawancara mendalam, observasi langsung, serta survei dan kuesioner digunakan secara luas oleh tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi langsung dari pasien atau situasi klinis. Metode-metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai aspek emosional, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kebidanan. Di sisi lain, data sekunder melalui kajian literatur dan dokumen serta pemanfaatan database kesehatan memberikan fondasi teoritis, informasi historis, dan pemahaman yang lebih luas tentang tren dan efektivitas berbagai intervensi di bidang kebidanan.

Setelah pengumpulan data, tahap analisis data menjadi langkah penting berikutnya untuk memahami dan menyederhanakan informasi yang diperoleh agar dapat diaplikasikan secara efektif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data dasar seperti rata-rata, median, modus, dan simpangan baku. Sedangkan analisis statistik inferensial seperti uji-t, ANOVA, korelasi, dan regresi berguna untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel kepada populasi yang lebih luas. Di samping itu, analisis kualitatif melalui analisis tematik dan analisis konten memberikan interpretasi mendalam terhadap fenomena kompleks dalam praktik kebidanan yang tidak terjangkau oleh analisis kuantitatif.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan diaplikasikan, penilaian kualitas penelitian atau quality appraisal harus dilakukan dengan seksama. Kriteria dasar seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalisasi digunakan untuk menentukan kualitas sebuah penelitian. Alat bantu seperti checklist CASP dan Jadad Scale juga membantu praktisi kebidanan dalam mengevaluasi secara sistematis kualitas metodologi dari penelitian, sehingga keputusan klinis yang diambil benar-benar berdasarkan bukti yang valid dan berkualitas tinggi.

Terakhir, integrasi hasil analisis data dalam praktik klinis kebidanan memerlukan langkah-langkah sistematis yang melibatkan proses pengambilan keputusan klinis, penentuan relevansi hasil penelitian dalam konteks klinis spesifik, serta refleksi praktik secara berkelanjutan. Melalui integrasi ini, bidan mampu meningkatkan efektivitas layanan, mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan kepuasan pasien, serta mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan praktik kebidanan yang semakin kompleks. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis bukti ini memperkuat kualitas pelayanan

kebidanan, memberikan manfaat maksimal kepada pasien, keluarga, dan komunitas, serta meningkatkan kepercayaan terhadap profesi kebidanan itu sendiri.

G. Glosarium

Analisis Konten

Metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menginterpretasikan pesan atau isi yang terkandung dalam dokumen tertulis, rekaman audio, atau video melalui klasifikasi, kategorisasi, dan evaluasi secara sistematis.

Analisis Statistik Deskriptif

Metode statistik untuk menggambarkan atau meringkas data tanpa melakukan generalisasi ke populasi lebih luas, menggunakan ukuran sentral seperti mean, median, modus, serta ukuran variabilitas seperti simpangan baku.

Analisis Statistik Inferensial

Metode statistik yang bertujuan menarik kesimpulan atau generalisasi tentang populasi yang lebih luas berdasarkan data dari sampel, termasuk uji-t, ANOVA, korelasi, dan regresi.

Analisis Tematik

Metode analisis kualitatif yang melibatkan proses pengkodean, identifikasi, dan interpretasi pola-pola tertentu atau tema-tema sentral dari data kualitatif seperti hasil wawancara mendalam.

CASP (Critical Appraisal Skills Programme)

Instrumen berbentuk checklist untuk mengevaluasi kualitas berbagai jenis penelitian secara sistematis, memastikan apakah desain penelitian tepat, data dianalisis secara benar, serta kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat.

Data Primer

Informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau responden yang terlibat langsung dengan kasus atau fenomena yang diteliti melalui wawancara, observasi langsung, atau survei.

Data Sekunder

Informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya seperti laporan penelitian, catatan rekam medis, database kesehatan, dan publikasi ilmiah.

Database Kesehatan

Basis data elektronik yang menyimpan informasi kesehatan pasien, populasi, atau intervensi medis secara terorganisasi, seperti Sistem Informasi Kesehatan (SIK) atau catatan elektronik pasien.

Generalisasi

Kemampuan suatu hasil penelitian untuk diterapkan secara luas pada populasi yang lebih besar di luar sampel penelitian, tergantung pada representativitas sampel dan desain penelitian.

Integrasi Data dan Analisis

Proses menyeluruh dalam menghubungkan hasil analisis data penelitian dengan pengambilan keputusan klinis dalam praktik kebidanan, yang mencakup identifikasi relevansi bukti, serta refleksi terhadap praktik klinis yang sedang berjalan.

Jadad Scale

Alat penilaian kualitas khusus untuk uji klinis acak terkontrol (Randomized Controlled Trials - RCT) yang mengevaluasi aspek randomisasi, blinding, serta laporan penarikan atau dropout subjek penelitian.

Objektivitas

Tingkat netralitas penelitian, menunjukkan sejauh mana hasil penelitian bebas dari bias atau pengaruh subjektif peneliti, sehingga mencerminkan realitas objektif.

Observasi Langsung

Metode pengumpulan data primer dengan mengamati secara langsung perilaku, interaksi, atau kondisi lingkungan dalam konteks klinis tanpa dipengaruhi laporan subjektif responden.

Quality Appraisal (Penilaian Kualitas Penelitian)

Proses evaluasi kritis terhadap penelitian ilmiah untuk menentukan validitas, reliabilitas, objektivitas, dan generalisasi hasil penelitian sebelum digunakan sebagai dasar praktik berbasis bukti.

Refleksi Praktik

Proses evaluasi dan introspeksi terhadap tindakan klinis yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan, menggunakan hasil penelitian terbaru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik klinis.

H. Daftar Pustaka

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Greenhalgh, T. (2019). *How to read a paper: The basics of evidence-based medicine and healthcare* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Gray, J. R., Grove, S. K., & Sutherland, S. (2017). *Burns and Grove's the practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Holloway, I., & Galvin, K. (2016). *Qualitative research in nursing and healthcare* (4th ed.). Wiley-Blackwell.

- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Richards, D. A., & Hallberg, I. R. (Eds.). (2015). *Complex interventions in health: An overview of research methods*. Routledge.
- Streiner, D. L., Norman, G. R., & Cairney, J. (2015). *Health measurement scales: A practical guide to their development and use* (5th ed.). Oxford University Press.
- Thorne, S. (2016). *Interpretive description: Qualitative research for applied practice* (2nd ed.). Routledge.
- Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>
- Whiting, P., Savović, J., Higgins, J. P., Caldwell, D. M., Reeves, B. C., Shea, B., ... & Churchill, R. (2016). ROBIS: A new tool to assess risk of bias in systematic reviews. *Journal of Clinical Epidemiology*, 69, 225–234. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.06.005>
- Young, J. M., & Solomon, M. J. (2009). How to critically appraise an article. *Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology*, 6(2), 82–91. <https://doi.org/10.1038/ncpgasthep1331>

BAB 11

EVIDENCE-BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: THE APPLICATION OF KNOWLEDGE TO MIDWIFERY PRACTICE, EVIDENCE FOR HOSPITAL-BASED CARE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan kebidanan berbasis bukti secara efektif dalam memberikan pelayanan kebidanan berkualitas tinggi di lingkungan rumah sakit.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan bukti ilmiah terbaik dalam praktik kebidanan rumah sakit, serta mampu melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat dan aman.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar evidence-based midwifery practice dan relevansinya dalam pelayanan kebidanan di rumah sakit.
- Mengidentifikasi sumber-sumber bukti ilmiah yang valid dan relevan untuk praktik kebidanan.
- Melakukan penilaian kritis terhadap penelitian ilmiah untuk menentukan kualitas dan aplikabilitasnya dalam konteks klinis.
- Mengaplikasikan hasil penelitian terbaru dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan kebidanan di lingkungan rumah sakit.
- Mengkomunikasikan bukti ilmiah secara efektif kepada pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Pendahuluan

Praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice - EBMP) merupakan pendekatan dalam pemberian asuhan kebidanan yang menggabungkan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis praktisi kebidanan, dan nilai-nilai serta preferensi pasien. Dalam konteks rumah sakit, penerapan EBMP menjadi esensial untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir benar-benar aman, efektif, dan mampu menghasilkan luaran kesehatan yang optimal. Pemanfaatan EBMP dalam lingkungan rumah sakit membutuhkan pengetahuan terkini, pemahaman tentang bukti-bukti klinis, serta keterampilan dalam menerapkan rekomendasi berbasis bukti secara efektif dalam praktik kebidanan sehari-hari.

A. Konsep Dasar EBMP dalam Praktik Kebidanan Rumah Sakit

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) merupakan pendekatan sistematis dalam memberikan asuhan kebidanan yang menggabungkan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis dari bidan, serta mempertimbangkan preferensi pasien dalam setiap pengambilan keputusan klinis. Di lingkungan rumah sakit, penerapan EBMP menjadi sangat penting karena rumah sakit merupakan pusat pelayanan kesehatan yang menangani berbagai kondisi klinis, mulai dari kondisi normal hingga komplikasi yang kompleks. Penerapan EBMP dalam lingkungan ini membantu memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien adalah yang paling efektif dan aman berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Dalam konteks praktik kebidanan di rumah sakit, implementasi EBMP berfokus pada integrasi yang harmonis antara tiga komponen penting, yaitu hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis yang terasah dari tenaga kebidanan, serta preferensi pasien dan keluarganya. Komponen hasil penelitian ilmiah terbaru ini mencakup berbagai jenis bukti yang kuat, seperti hasil uji klinis terkontrol acak (Randomized Controlled Trials atau RCTs), meta-analisis, systematic review, dan studi kohort. Penelitian-penelitian ini menyediakan data yang akurat dan valid yang memungkinkan bidan untuk menentukan tindakan klinis yang paling efektif dan memiliki risiko komplikasi minimal.

Selanjutnya, keahlian klinis bidan di rumah sakit sangat penting untuk interpretasi dan aplikasi hasil penelitian ke dalam praktik nyata. Keahlian klinis mencakup pengalaman profesional, pengetahuan mendalam mengenai anatomi, fisiologi, proses persalinan, serta kemampuan menilai kondisi pasien secara komprehensif. Bidan yang memiliki keahlian klinis tinggi mampu mengenali tanda-tanda awal komplikasi, melakukan tindakan yang tepat secara cepat, serta memilih intervensi yang berbasis bukti secara optimal. Di sisi lain, kemampuan klinis ini juga memungkinkan bidan melakukan penyesuaian terhadap rekomendasi penelitian ilmiah sesuai konteks spesifik pasien, sehingga intervensi yang diberikan bersifat individual dan holistik.

Preferensi pasien dan keluarganya merupakan komponen ketiga yang tidak kalah penting dalam EBMP. Rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan sering kali menghadapi berbagai karakteristik pasien yang berbeda, termasuk nilai, kepercayaan, latar belakang budaya, dan keinginan individu dalam proses perawatan. Dalam pendekatan EBMP, preferensi pasien ini dihormati dan

diperhitungkan secara serius. Oleh karena itu, bidan perlu memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik untuk mendengarkan, memahami, dan merespons kebutuhan pasien secara empati. Komunikasi yang efektif memungkinkan bidan memberikan edukasi yang tepat dan membantu pasien mengambil keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi mereka.

Penerapan EBMP secara konsisten dalam praktik kebidanan di rumah sakit memberikan sejumlah manfaat nyata. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, karena setiap tindakan kebidanan didasarkan pada bukti ilmiah yang sah dan relevan. Ini berarti pasien menerima perawatan yang telah terbukti efektif, aman, dan sesuai dengan kondisi klinis terkini. Manfaat berikutnya adalah penurunan risiko komplikasi. Dengan menerapkan intervensi berbasis bukti, kemungkinan terjadinya kesalahan, komplikasi medis, dan tindakan-tindakan yang tidak perlu dapat dikurangi secara signifikan. Akibatnya, angka mortalitas dan morbiditas ibu serta bayi dapat diminimalkan.

Selain itu, EBMP juga berdampak positif terhadap kepuasan pasien dan keluarganya. Ketika pasien merasa bahwa keputusan klinis yang diambil memperhatikan bukti ilmiah terbaik dan juga mempertimbangkan nilai serta preferensi mereka, rasa percaya dan rasa aman terhadap pelayanan yang diberikan akan meningkat. Kepuasan ini tidak hanya menciptakan pengalaman positif pasien di rumah sakit, tetapi juga membantu membangun kepercayaan jangka panjang antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Dengan demikian, konsep dasar Evidence-Based Midwifery Practice dalam lingkungan rumah sakit bukan hanya sebagai suatu metode pelayanan kesehatan, melainkan sebagai paradigma yang berorientasi pada kualitas tinggi, keselamatan pasien, serta penghargaan terhadap preferensi pasien dan keluarganya dalam konteks kebidanan. Penerapannya secara komprehensif di rumah sakit menjamin bahwa setiap pasien mendapat pelayanan kebidanan terbaik sesuai bukti ilmiah terkini, disertai penghargaan tinggi terhadap nilai-nilai individu.

B. Identifikasi Sumber-Sumber Bukti Ilmiah

Dalam Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP), identifikasi dan pemilihan sumber-sumber bukti ilmiah yang valid dan terpercaya menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan klinis yang efektif, aman, dan tepat guna dalam praktik kebidanan. Untuk itu, bidan perlu memahami secara mendalam tentang berbagai sumber bukti ilmiah yang ada dan mampu mengevaluasi kualitas bukti-bukti tersebut. Sumber-sumber bukti ilmiah utama dalam kebidanan meliputi:

1. Randomized Controlled Trials (RCT)

Randomized Controlled Trials (RCT) merupakan jenis penelitian eksperimental yang dianggap sebagai standar emas (gold standard) dalam menentukan efektivitas suatu intervensi dalam bidang kesehatan, termasuk kebidanan. RCT memiliki keunggulan karena kemampuannya dalam meminimalisasi bias penelitian melalui proses acak (randomisasi), yang artinya subjek penelitian ditempatkan secara acak ke dalam kelompok kontrol atau kelompok intervensi.

Dalam konteks kebidanan, RCT sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tindakan medis maupun intervensi keperawatan tertentu, seperti efektivitas teknik persalinan tertentu, pemberian obat-obatan tertentu selama kehamilan atau persalinan, serta pengaruh edukasi kebidanan terhadap hasil kehamilan dan persalinan. Keunggulan utama dari RCT adalah memberikan tingkat bukti yang kuat mengenai hubungan sebab-akibat antara intervensi dan hasil klinis. Namun, penting bagi bidan untuk mengevaluasi dengan cermat metodologi RCT agar hasilnya dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik sehari-hari.

2. Systematic Reviews dan Meta-analysis

Systematic reviews dan meta-analysis merupakan sintesis penelitian tingkat lanjut yang bertujuan untuk merangkum bukti dari berbagai penelitian individu yang relevan terhadap suatu topik atau pertanyaan klinis tertentu. Systematic review menggunakan metode yang terstruktur dan transparan untuk mencari, mengevaluasi, dan mensintesis hasil dari beberapa penelitian yang relevan.

Dalam systematic review, meta-analysis sering dilakukan, yaitu analisis statistik yang menggabungkan data kuantitatif dari berbagai penelitian serupa untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat dan akurat dibandingkan penelitian individual. Meta-analysis mampu memperbesar kekuatan statistik dan meningkatkan validitas kesimpulan yang diambil, karena mengumpulkan data dari banyak subjek penelitian.

Dalam praktik kebidanan, systematic reviews dan meta-analysis banyak dimanfaatkan untuk menentukan rekomendasi klinis terbaik dalam hal asuhan

antenatal, metode persalinan, intervensi postpartum, hingga pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian, systematic reviews dan meta-analysis sangat membantu bidan dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan kumpulan bukti terbaik yang tersedia.

3. Guidelines atau pedoman praktik klinis dari organisasi kesehatan terpercaya

Guidelines atau pedoman praktik klinis yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan terpercaya seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan sumber penting dalam praktik kebidanan berbasis bukti. Pedoman-pedoman ini dibuat berdasarkan sintesis bukti ilmiah yang kuat dan relevan serta hasil konsensus para ahli klinis dan akademisi di bidang kebidanan dan kesehatan ibu-anak.

Pedoman praktik klinis biasanya berisi rekomendasi praktis dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melakukan tindakan klinis tertentu. Pedoman ini mencakup standar pelayanan antenatal, persalinan aman, penatalaksanaan komplikasi kehamilan dan persalinan, tata laksana bayi baru lahir, imunisasi, serta tata cara konseling ibu hamil dan menyusui.

Sebagai contoh, pedoman WHO tentang manajemen aktif kala tiga persalinan atau pedoman Kementerian Kesehatan RI tentang pelayanan kesehatan maternal-neonatal menjadi acuan resmi yang wajib dipahami dan diterapkan oleh para bidan. Penggunaan pedoman ini memastikan bahwa praktik kebidanan yang diberikan konsisten dengan standar pelayanan nasional maupun internasional yang telah terbukti efektif.

4. Publikasi ilmiah dari jurnal bereputasi tinggi di bidang kebidanan dan kesehatan ibu dan anak

Publikasi ilmiah dalam jurnal-jurnal bereputasi tinggi merupakan sumber bukti ilmiah yang sangat relevan dan selalu terupdate dalam bidang kebidanan. Jurnal bereputasi tinggi, umumnya memiliki proses review yang ketat (peer-review), yang menjamin validitas dan kredibilitas artikel yang dipublikasikan.

Artikel-artikel dalam jurnal ilmiah mencakup berbagai jenis penelitian, mulai dari RCT, studi kohort, studi kasus-kontrol, hingga studi kualitatif yang mengeksplorasi pengalaman ibu hamil atau menyusui. Para bidan dapat mengakses hasil penelitian terbaru mengenai efektivitas intervensi, evaluasi metode persalinan baru, pengaruh intervensi kesehatan terhadap ibu dan bayi, serta berbagai isu klinis terkini yang relevan dengan praktik kebidanan.

Beberapa contoh jurnal internasional yang bereputasi di bidang kebidanan antara lain adalah Midwifery, Journal of Midwifery & Women's Health, BMC Pregnancy and Childbirth, serta Birth. Sementara jurnal nasional di Indonesia

seperti Jurnal Kebidanan Indonesia dan Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak juga menyediakan hasil penelitian yang relevan dengan konteks lokal.

Memanfaatkan publikasi jurnal ini sangat penting bagi bidan karena memungkinkan mereka untuk terus memperbarui pengetahuan berdasarkan temuan ilmiah terkini, mendukung pembaruan kompetensi klinis secara kontinu, serta memastikan asuhan kebidanan yang diberikan selaras dengan perkembangan ilmu terbaru.

C. Penilaian Kritis terhadap Bukti Ilmiah

Penilaian kritis terhadap bukti ilmiah (critical appraisal) adalah kemampuan yang penting dan harus dimiliki oleh mahasiswa kebidanan maupun praktisi profesional, karena tidak semua bukti ilmiah yang tersedia memiliki kualitas dan nilai yang sama dalam praktik klinis. Mahasiswa kebidanan perlu memahami secara mendalam bagaimana mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bukti ilmiah agar keputusan klinis yang diambil didasarkan pada informasi yang valid, terpercaya, relevan secara klinis, serta terkini.

1. Validitas (kebenaran metode penelitian)

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana metode penelitian yang digunakan benar-benar mampu mengukur atau mengevaluasi aspek yang hendak diteliti. Dalam konteks kebidanan, validitas bukti ilmiah sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi klinis yang diteliti, bukan merupakan hasil dari bias, kesalahan prosedur, atau kesalahan dalam desain penelitian.

Saat mengevaluasi validitas, mahasiswa harus mampu menilai beberapa aspek penting, seperti:

- a. Metode penelitian yang digunakan: Apakah desain penelitiannya sesuai dengan tujuan penelitian? Sebagai contoh, apakah Randomized Controlled Trials (RCT) sudah dilakukan dengan randomisasi dan blinding yang tepat?
- b. Pemilihan subjek: Apakah subjek penelitian dipilih secara representatif terhadap populasi yang ingin digeneralisasi hasilnya?
- c. Proses pengumpulan data: Apakah alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan valid dan akurat?
- d. Kontrol terhadap faktor-faktor bias: Apakah penelitian mengontrol variabel pengganggu atau bias yang mungkin memengaruhi hasil penelitian?

2. Reliabilitas (konsistensi hasil)

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi hasil penelitian apabila penelitian tersebut diulang dalam kondisi atau situasi yang sama. Dalam bidang kebidanan, hasil penelitian yang reliabel berarti bahwa hasil penelitian tersebut dapat diulang

dan menghasilkan kesimpulan yang sama atau sangat mirip setiap kali dilakukan penelitian ulang dengan metode dan kondisi yang sama.

Penilaian reliabilitas mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Konsistensi antar pengukuran (inter-rater reliability): Apakah pengukuran yang dilakukan oleh berbagai peneliti atau observer berbeda akan menghasilkan hasil yang sama atau konsisten?
- b. Konsistensi internal (internal consistency): Apakah hasil penelitian secara konsisten menunjukkan hasil yang sama sepanjang proses penelitian?
- c. Uji-uji statistik: Apakah hasil penelitian tersebut secara statistik konsisten melalui metode analisis statistik yang digunakan?

Mahasiswa kebidanan harus mampu mengevaluasi reliabilitas penelitian secara kritis, karena hasil penelitian yang tidak reliabel akan menghasilkan keputusan klinis yang tidak konsisten dan berisiko menurunkan kualitas asuhan.

3. Relevansi klinis (keterkaitan dengan masalah kebidanan)

Relevansi klinis merujuk pada sejauh mana hasil penelitian ilmiah dapat diterapkan secara praktis untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan klinis yang dihadapi dalam praktik kebidanan sehari-hari. Tidak semua hasil penelitian, meskipun valid dan reliabel, dapat langsung diterapkan dalam situasi klinis yang sebenarnya.

Dalam mengevaluasi relevansi klinis, mahasiswa perlu mempertimbangkan:

- a. Kesamaan karakteristik pasien atau populasi: Apakah populasi penelitian serupa dengan populasi pasien yang dihadapi dalam praktik nyata?
- b. Praktik kebidanan lokal: Apakah intervensi yang diuji dalam penelitian dapat dilakukan di tempat praktik kebidanan lokal?
- c. Kemungkinan penerapan hasil: Apakah hasil penelitian memberikan manfaat klinis yang nyata dan signifikan bagi pasien?

Menilai relevansi klinis memastikan bahwa intervensi atau temuan penelitian benar-benar memberikan dampak positif dalam asuhan kebidanan dan bukan sekadar hasil ilmiah tanpa aplikasi nyata.

4. Keterbaruan informasi (up-to-date evidence)

Aspek keterbaruan atau aktualitas informasi merupakan pertimbangan penting dalam menilai bukti ilmiah. Dalam dunia kebidanan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan berlangsung dengan cepat, sehingga hasil penelitian lama bisa jadi tidak relevan atau sudah tergantikan oleh temuan baru yang lebih valid dan efektif.

Dalam hal ini, mahasiswa harus menilai:

- a. Tahun publikasi: Apakah informasi yang digunakan adalah hasil publikasi terbaru, idealnya dari lima tahun terakhir?

- b. Perkembangan terbaru di bidang kebidanan: Apakah ada pedoman baru, rekomendasi terbaru dari organisasi kesehatan, atau penelitian terbaru yang mengubah standar praktik sebelumnya?
- c. Sumber informasi terbaru: Apakah sumber informasi berasal dari jurnal bereputasi tinggi yang terus diperbarui secara berkala?

Memastikan penggunaan bukti ilmiah yang terbaru berarti praktik kebidanan yang diberikan akan senantiasa mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan praktik klinis kebidanan, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan tetap tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang terkini.

D. Implementasi Bukti Ilmiah dalam Asuhan Kebidanan

Implementasi bukti ilmiah dalam asuhan kebidanan merupakan tahap penting di mana bukti-bukti yang telah dinilai secara kritis diaplikasikan secara nyata dalam praktik klinis sehari-hari di rumah sakit. Tahap ini bukan hanya sekadar pemilihan intervensi yang tepat, tetapi juga mencakup proses yang sistematis, terdokumentasi dengan jelas, serta memperhatikan keunikan kondisi setiap pasien secara individual.

1. Menyusun intervensi kebidanan berdasarkan rekomendasi berbasis bukti

Dalam menyusun intervensi kebidanan berbasis bukti, seorang bidan harus menggunakan hasil penelitian terbaik dan pedoman klinis yang telah terbukti efektif dan aman untuk pasien. Penyusunan intervensi berbasis bukti ini melibatkan proses sistematis yang terdiri dari identifikasi masalah klinis, peninjauan hasil penelitian yang relevan, serta pemilihan rekomendasi terbaik sesuai bukti ilmiah terbaru. Dalam tahap ini, bidan harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

- a. Pemilihan intervensi berdasarkan rekomendasi dari sumber-sumber terpercaya, misalnya pedoman klinis yang dikeluarkan WHO, Kementerian Kesehatan RI, atau IDAI. Intervensi yang dipilih harus terbukti efektif dalam mengatasi masalah klinis yang spesifik, misalnya dalam asuhan persalinan normal, penatalaksanaan kala tiga persalinan, atau manajemen nyeri selama persalinan.
- b. Kesesuaian rekomendasi dengan kondisi lingkungan rumah sakit, yaitu mempertimbangkan fasilitas, sumber daya manusia, serta peralatan medis yang tersedia di lingkungan rumah sakit tersebut. Hal ini penting agar intervensi yang diterapkan dapat berjalan optimal dalam realitas praktik sehari-hari.

Dengan menyusun intervensi secara sistematis berbasis bukti, tindakan kebidanan yang dilakukan tidak hanya efektif dan aman, tetapi juga mampu memberikan hasil klinis terbaik bagi ibu dan bayi.

2. Melakukan dokumentasi praktik yang mendukung transparansi dan kontinuitas pelayanan

Implementasi bukti ilmiah dalam praktik kebidanan tidak akan efektif tanpa dokumentasi yang jelas dan terstruktur. Dokumentasi klinis merupakan bagian penting dari proses implementasi bukti ilmiah yang bertujuan untuk mencatat semua intervensi yang dilakukan, hasil yang diperoleh, serta keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan bukti ilmiah. Dokumentasi ini berfungsi untuk:

- a. Menjamin transparansi praktik klinis. Dengan dokumentasi yang baik, setiap intervensi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara klinis maupun secara hukum. Catatan klinis yang jelas memungkinkan adanya evaluasi objektif terhadap tindakan yang diberikan, memastikan bahwa keputusan klinis dibuat berdasarkan bukti ilmiah terbaru.
- b. Menjaga kontinuitas pelayanan. Dokumentasi yang baik membantu komunikasi antar tenaga kesehatan, terutama ketika terjadi perpindahan tugas (handover) atau ketika pasien berpindah dari satu unit layanan ke unit lainnya. Dengan dokumentasi yang lengkap, seluruh tim kesehatan yang merawat pasien memahami alasan keputusan klinis dan tindakan kebidanan yang telah diberikan.

Dalam praktik sehari-hari, dokumentasi ini meliputi catatan mengenai diagnosis, intervensi yang dipilih beserta alasannya, respon pasien terhadap intervensi, serta evaluasi terhadap efektivitas intervensi tersebut. Dokumentasi yang rapi juga sangat berguna dalam evaluasi kualitas layanan kebidanan di rumah sakit.

3. Menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan dan kondisi spesifik pasien

Implementasi bukti ilmiah dalam kebidanan bukan berarti melakukan tindakan secara kaku tanpa memperhatikan kondisi spesifik pasien. Sebaliknya, intervensi berbasis bukti perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi individu pasien, seperti karakteristik fisik, status kesehatan, riwayat medis sebelumnya, preferensi pribadi pasien, serta aspek psikologis dan sosial.

Aspek ini melibatkan:

- a. Individualisasi perawatan kebidanan. Bidan perlu mempertimbangkan karakteristik khusus setiap pasien. Sebagai contoh, pemilihan metode pengendalian nyeri selama persalinan bisa berbeda antara satu pasien dengan pasien lain tergantung pada kondisi kesehatan ibu, riwayat medis sebelumnya, preferensi ibu, serta toleransi terhadap nyeri.
- b. Keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Pasien dan keluarga harus dilibatkan dalam diskusi terkait pilihan intervensi yang tersedia, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada bukti ilmiah semata

tetapi juga menghormati preferensi pasien. Pendekatan ini memastikan bahwa pasien merasa didengarkan, dihargai, dan lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan.

- c. Penyesuaian intervensi berdasarkan kondisi klinis pasien yang berkembang. Kondisi pasien dapat berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu bidan harus siap menyesuaikan intervensi yang telah direncanakan dengan kondisi klinis terbaru pasien, tetap dengan mengacu pada bukti ilmiah yang relevan.

Dengan menyesuaikan intervensi secara individu, maka penerapan bukti ilmiah dalam praktik kebidanan akan menjadi lebih efektif, pasien merasa lebih dihargai, dan hasil klinis yang diperoleh lebih optimal.

E. Komunikasi Efektif Mengenai Bukti Ilmiah

Komunikasi efektif mengenai bukti ilmiah adalah kemampuan vital yang wajib dimiliki oleh mahasiswa kebidanan maupun bidan profesional dalam menjalankan praktik kebidanan berbasis bukti di lingkungan rumah sakit. Komunikasi ini tidak hanya berarti penyampaian informasi klinis secara benar, tetapi juga menekankan pada penyampaian yang jelas, lugas, empatik, serta disesuaikan dengan kebutuhan pemahaman pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya. Keterampilan ini memastikan bahwa keputusan klinis berbasis bukti tidak hanya dipahami, namun juga diterima secara baik oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan.

Salah satu tujuan utama dari komunikasi efektif mengenai bukti ilmiah adalah memastikan bahwa pasien dan keluarga memiliki pemahaman yang memadai tentang intervensi kebidanan yang direncanakan. Dalam hal ini, bidan harus mampu menjelaskan alasan klinis pemilihan intervensi tersebut, apa manfaat yang diharapkan, risiko potensial, serta alternatif lain yang tersedia. Misalnya, saat bidan memutuskan untuk merekomendasikan metode tertentu dalam manajemen nyeri persalinan, bidan harus mampu menjelaskan secara jelas dan empatik mengenai kelebihan metode tersebut berdasarkan bukti penelitian terkini, potensi risiko atau efek sampingnya, serta bagaimana metode ini akan membantu pasien secara nyata. Hal ini memungkinkan pasien merasa lebih nyaman, dihargai, dan percaya dengan keputusan klinis yang diambil oleh bidan.

Selain itu, komunikasi efektif juga sangat penting dalam hubungan kerja tim medis. Dalam praktik kebidanan di rumah sakit, bidan bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai profesi kesehatan seperti dokter, perawat, ahli gizi, serta tenaga kesehatan lain yang berhubungan langsung dengan perawatan pasien. Dalam konteks ini, bidan dituntut mampu menjelaskan dengan jelas, ringkas, dan profesional mengenai keputusan klinis yang berbasis bukti kepada anggota tim

lainnya. Komunikasi yang jelas dan berbasis bukti akan memudahkan tim medis memahami rasional dari keputusan kebidanan yang diambil, menghindari kesalahpahaman, serta memperkuat kolaborasi tim dalam upaya memberikan asuhan kebidanan terbaik bagi pasien.

Salah satu tantangan dalam komunikasi mengenai bukti ilmiah adalah tingkat pemahaman yang bervariasi antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan lain. Oleh karena itu, keterampilan bidan dalam menyesuaikan gaya komunikasi menjadi sangat krusial. Untuk pasien dan keluarga, penggunaan bahasa yang sederhana, analogi yang mudah dimengerti, serta penyampaian informasi secara perlahan namun lugas menjadi kunci utama. Misalnya, menjelaskan risiko perdarahan postpartum dengan cara sederhana seperti menggunakan ilustrasi atau bahasa sehari-hari yang akrab dengan pasien akan lebih efektif dibandingkan menggunakan terminologi medis yang sulit dipahami.

Sedangkan dalam berkomunikasi dengan tim kesehatan profesional lainnya, bidan harus mampu menyajikan informasi klinis secara jelas, terstruktur, singkat namun komprehensif, termasuk mengutip hasil penelitian terbaru, pedoman klinis yang relevan, serta alasan ilmiah yang kuat yang mendukung keputusan yang diambil. Penggunaan format komunikasi yang jelas seperti format SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) sering direkomendasikan agar penyampaian informasi klinis terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh anggota tim kesehatan lainnya.

Komunikasi empatik juga menjadi aspek penting dalam penyampaian informasi berbasis bukti ilmiah kepada pasien dan keluarganya. Empati mencerminkan kemampuan bidan dalam memahami dan merasakan apa yang dialami oleh pasien, serta menunjukkan penghargaan terhadap perasaan dan kekhawatiran mereka. Saat memberikan informasi klinis, bidan perlu menunjukkan sikap empati, seperti dengan memberikan waktu yang cukup untuk pasien bertanya, mendengarkan secara aktif, mengonfirmasi pemahaman pasien, dan memberikan dukungan emosional apabila diperlukan. Ini sangat membantu dalam membangun hubungan terapeutik antara bidan, pasien, dan keluarga, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan menguasai keterampilan komunikasi efektif berbasis bukti, bidan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di rumah sakit. Pasien dan keluarga yang merasa memahami dan terlibat dalam keputusan klinis cenderung lebih puas terhadap pelayanan, lebih kooperatif terhadap intervensi yang diberikan, serta memiliki outcome klinis yang lebih baik. Di sisi lain, komunikasi yang efektif dan jelas dengan tim kesehatan lain akan memperkuat kolaborasi

antarprofesi, meningkatkan efisiensi kerja tim, serta secara keseluruhan meningkatkan keselamatan pasien.

Secara keseluruhan, penguasaan kompetensi komunikasi efektif mengenai bukti ilmiah ini bukan sekadar keahlian tambahan, tetapi menjadi inti dari praktik kebidanan yang berkualitas tinggi di lingkungan rumah sakit. Dengan komunikasi yang jelas, lugas, dan empatik, bidan mampu memastikan bahwa setiap keputusan klinis berbasis bukti tidak hanya efektif secara ilmiah tetapi juga diterima baik oleh pasien, keluarga, serta tim kesehatan, sehingga menghasilkan asuhan kebidanan yang berkualitas, aman, dan memuaskan semua pihak yang terlibat.

F. Latihan Soal

Soal Kasus 1:

Seorang ibu hamil G2P1A0 usia 30 tahun datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan rutin. Ia membawa artikel yang menyarankan persalinan secara alami tanpa intervensi medis. Sebagai bidan, langkah apa yang paling tepat dilakukan dalam pendekatan Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)?

- A. Mengabaikan artikel tersebut karena bukan dari sumber medis
- B. Menyarankan ibu untuk mengikuti protokol standar rumah sakit tanpa diskusi
- C. Berdiskusi dengan ibu tentang hasil penelitian terbaru terkait metode persalinan yang aman
- D. Menyetujui semua permintaan ibu tanpa diskusi mendalam
- E. Merujuk ibu langsung ke dokter spesialis tanpa diskusi sebelumnya

Jawaban: C

Rasional:

Dalam pendekatan EBMP, bidan harus mampu berdiskusi secara terbuka dengan pasien, mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Pilihan C menunjukkan komunikasi dan diskusi yang menghargai preferensi pasien sambil tetap mengacu pada bukti ilmiah.

Soal Kasus 2:

Bidan sedang merencanakan intervensi untuk mengurangi nyeri persalinan pada pasien primigravida usia 25 tahun. Pasien menginginkan metode yang paling efektif berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Manakah sumber informasi yang paling kuat untuk menentukan intervensi tersebut?

- A. Studi kasus tunggal yang diterbitkan di jurnal lokal
- B. Randomized Controlled Trials (RCT) terbaru
- C. Pendapat ahli dari seminar kebidanan tahunan

- D. Informasi dari media sosial kesehatan populer
- E. Pengalaman pribadi bidan dalam praktik kebidanan

Jawaban: B

Rasional:

Randomized Controlled Trials (RCT) merupakan standar emas dalam menentukan efektivitas intervensi kebidanan. RCT memberikan bukti ilmiah dengan validitas tinggi yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan klinis.

Soal Kasus 3:

Seorang ibu bersalin dengan usia kehamilan 39 minggu datang dengan pembukaan 5 cm. Bidan memutuskan menggunakan pedoman terbaru WHO dalam penatalaksanaan persalinan aktif. Apa alasan utama bidan memilih pedoman tersebut?

- A. Mudah diakses oleh pasien
- B. Dibuat berdasarkan kesepakatan para ahli saja
- C. Sudah lama digunakan secara luas
- D. Berdasarkan sintesis bukti ilmiah terbaru dan terpercaya
- E. Karena direkomendasikan oleh pimpinan rumah sakit

Jawaban: D

Rasional:

Pedoman dari organisasi seperti WHO disusun melalui sintesis bukti ilmiah terbaik dan terkini, menjadikannya dasar terpercaya untuk keputusan klinis yang efektif dan aman dalam praktik kebidanan.

Soal Kasus 4:

Saat mengevaluasi artikel ilmiah tentang efektivitas teknik persalinan dalam jurnal kebidanan, bidan menemukan bahwa hasil penelitian berbeda-beda ketika dilakukan di berbagai tempat. Apa aspek kritis yang paling perlu diperhatikan untuk menilai kualitas hasil penelitian tersebut?

- A. Popularitas jurnal tempat publikasi
- B. Ketersediaan artikel secara gratis
- C. Reliabilitas penelitian (konsistensi hasil penelitian)
- D. Panjang artikel yang diterbitkan
- E. Banyaknya peneliti yang terlibat

Jawaban: C

Rasional:

Reliabilitas merupakan ukuran penting dalam penilaian kritis bukti ilmiah, menunjukkan konsistensi hasil penelitian. Hasil penelitian yang bervariasi antar tempat perlu dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa bukti ilmiah tersebut reliabel sebelum digunakan dalam praktik.

Soal Kasus 5:

Seorang ibu postpartum mengalami kesulitan menyusui karena nyeri puting. Bidan menawarkan beberapa metode berdasarkan bukti ilmiah terbaru dan memberikan penjelasan secara empatik kepada ibu dan keluarganya. Apa manfaat utama dari komunikasi efektif ini dalam konteks EBMP?

- A. Mempercepat waktu pelayanan
- B. Mengurangi kebutuhan dokumentasi klinis
- C. Menghindari diskusi panjang dengan pasien
- D. Meningkatkan pemahaman pasien dan kepuasan terhadap pelayanan
- E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan klinis pada bidan

Jawaban: D

Rasional:

Komunikasi efektif dalam EBMP bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga benar-benar memahami intervensi yang diberikan, alasan klinis pemilihan intervensi tersebut, sehingga meningkatkan kepuasan dan kerjasama pasien dalam menjalani perawatan yang diberikan

G. Rangkuman Materi

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) adalah pendekatan sistematis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan di lingkungan rumah sakit. EBMP mengintegrasikan tiga komponen utama: hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis bidan, serta preferensi dan nilai-nilai pasien. Penggunaan sumber-sumber bukti ilmiah yang valid seperti Randomized Controlled Trials (RCT), systematic reviews, meta-analysis, pedoman praktik klinis dari organisasi terpercaya, serta publikasi ilmiah dari jurnal bereputasi tinggi, menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Kemampuan untuk melakukan penilaian kritis terhadap bukti ilmiah—meliputi validitas, reliabilitas, relevansi klinis, dan keterbaruan informasi—sangat dibutuhkan oleh tenaga kebidanan agar intervensi yang dipilih benar-benar efektif, aman, dan relevan dengan kebutuhan pasien. Implementasi bukti ilmiah secara nyata dalam praktik kebidanan di rumah sakit mencakup penyusunan intervensi berbasis bukti

secara sistematis, dokumentasi yang transparan dan lengkap, serta penyesuaian intervensi sesuai kondisi spesifik masing-masing pasien.

Selain aspek teknis dan klinis, keterampilan komunikasi efektif yang jelas, lugas, dan empatik menjadi kompetensi inti dalam EBMP. Komunikasi ini bertujuan memastikan pasien, keluarga, serta tim medis memahami dengan baik setiap keputusan klinis yang diambil, sehingga tercipta hubungan terapeutik yang kuat serta kolaborasi antarprofesi yang efektif.

Dengan penerapan EBMP secara komprehensif, praktik kebidanan di rumah sakit akan semakin berkualitas, keselamatan pasien meningkat, risiko komplikasi dapat diminimalkan, dan kepuasan pasien serta keluarganya akan tercapai. Dengan demikian, EBMP bukan sekadar metode pelayanan kesehatan, melainkan paradigma penting yang menjamin asuhan kebidanan berkualitas tinggi, aman, holistik, dan berpusat pada kebutuhan pasien.

H. Glosarium

1. Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Pendekatan sistematis dalam asuhan kebidanan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, dan preferensi pasien untuk menghasilkan keputusan klinis yang efektif, aman, dan memuaskan pasien.

2. Randomized Controlled Trials (RCT)

Jenis penelitian eksperimental yang menggunakan proses acak (randomisasi) untuk menempatkan subjek penelitian ke dalam kelompok kontrol dan kelompok intervensi, sehingga meminimalkan bias penelitian dan dianggap sebagai standar emas (gold standard) dalam menentukan efektivitas suatu intervensi kesehatan.

3. Systematic Reviews

Metode penelitian yang menggunakan pendekatan terstruktur dan transparan untuk mencari, mengevaluasi, dan menyintesis hasil dari berbagai penelitian individual yang relevan terhadap suatu topik klinis tertentu.

4. Meta-analysis

Analisis statistik lanjutan yang menggabungkan hasil kuantitatif dari berbagai penelitian individu yang relevan untuk menghasilkan bukti yang lebih kuat, valid, dan akurat mengenai efektivitas suatu intervensi atau tindakan klinis.

5. Guidelines (Pedoman Praktik Klinis)

Dokumen berisi rekomendasi praktis yang disusun oleh organisasi kesehatan terpercaya, seperti WHO atau Kementerian Kesehatan, yang berdasarkan bukti

ilmiah terbaru serta kesepakatan para ahli, digunakan sebagai acuan standar dalam praktik kebidanan.

6. Validitas

Kemampuan suatu metode penelitian dalam mengukur atau mengevaluasi apa yang seharusnya diukur secara akurat, sehingga memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi klinis yang sesungguhnya.

7. Reliabilitas

Ukuran konsistensi hasil penelitian jika penelitian diulang dalam kondisi atau situasi yang sama, memastikan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dipercaya dan konsisten antar pengukuran atau antar peneliti.

8. Relevansi Klinis

Sejauh mana hasil penelitian ilmiah dapat secara praktis diterapkan dalam situasi klinis nyata dan memberikan manfaat nyata dalam menjawab masalah klinis kebidanan.

9. Keterbaruan Informasi (Up-to-date Evidence)

Informasi ilmiah yang paling terbaru dan relevan yang digunakan dalam pengambilan keputusan klinis, idealnya hasil publikasi lima tahun terakhir.

10. Dokumentasi Klinis

Proses mencatat secara sistematis semua tindakan, keputusan klinis, intervensi yang diberikan, serta respons pasien yang digunakan untuk menjaga transparansi praktik klinis dan kontinuitas pelayanan kesehatan.

11. Individualisasi Perawatan Kebidanan

Pendekatan dalam asuhan kebidanan yang mempertimbangkan secara khusus kebutuhan, preferensi, dan kondisi spesifik pasien, sehingga intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan keadaan unik tiap pasien.

12. Komunikasi Efektif

Kemampuan menyampaikan informasi klinis secara jelas, lugas, empatik, dan disesuaikan dengan kebutuhan pemahaman pasien, keluarga, dan tim medis untuk memastikan pemahaman yang baik dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan klinis.

13. Intervensi Berbasis Bukti

Tindakan klinis atau prosedur dalam asuhan kebidanan yang dipilih berdasarkan hasil penelitian ilmiah terbaik, sehingga memiliki tingkat efektivitas tinggi serta risiko komplikasi yang minimal.

14. Komplikasi Klinis

Kondisi atau masalah yang muncul selama proses kehamilan, persalinan, atau postpartum yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan hasil penelitian ilmiah terbaru dan keahlian klinis bidan.

15. Outcome Klinis

Hasil akhir atau dampak dari intervensi atau tindakan klinis terhadap pasien, yang meliputi aspek kesehatan fisik, psikologis, maupun tingkat kepuasan pasien.

16. Paradigma Kebidanan

Kerangka pikir atau model yang mendasari praktik kebidanan, dalam hal ini mengacu pada paradigma berbasis bukti yang menekankan pentingnya kualitas tinggi, keselamatan pasien, dan penghargaan terhadap preferensi individu dalam pelayanan kebidanan.

I. Daftar Pustaka

- Bick, D., & Graham, I. D. (Eds.). (2021). Evidence-based midwifery: Applications in context. Wiley-Blackwell.
- Dahlen, H. G., & Tracy, S. (2020). Evidence-based midwifery practice and its integration in hospital settings: A systematic review. *Midwifery*, 86, 102694. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102694>
- Homer, C. S. E., Friberg, I. K., Dias, M. A. B., Ten Hoop-Bender, P., Sandall, J., Speciale, A. M., & Bartlett, L. A. (2014). The projected effect of scaling up midwifery. *The Lancet*, 384(9948), 1146–1157. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60790-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60790-X)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berbasis bukti. Kementerian Kesehatan RI.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Renfrew, M. J., McFadden, A., Bastos, M. H., Campbell, J., Channon, A. A., Cheung, N. F., Silva, D. R. A. D., Downe, S., Kennedy, H. P., Malata, A., McCormick, F., Wick, L., & Declercq, E. (2014). Midwifery and quality care: Findings from a new evidence-informed framework for maternal and newborn care. *The Lancet*, 384(9948), 1129–1145. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60789-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60789-3)
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub5>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO Press.

- World Health Organization. (2020). WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. WHO Press.
- Yanti, Y., & Claramita, M. (2020). Komunikasi efektif dalam praktik kebidanan berbasis bukti. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(1), 57–65. <https://doi.org/10.29238/kia.v14i1.418>

BAB 12

EVIDENCE BASED IN MIDWIFERY PRACTICE: KEKUATAN KELEMAHAN DALAM PENERAPAN EVIDENCE-BASED PADA PRAKTIK, BIOMEDICAL ETHICS AND THERE APPLICATION TO MIDWIFERY PRACTICE

Pendahuluan

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery (EBM) merupakan pendekatan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. Pendekatan ini mengintegrasikan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis, dan preferensi pasien untuk memastikan keputusan klinis yang tepat. Namun demikian, penerapannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan. Di samping itu, penerapan praktik kebidanan juga membutuhkan kesadaran terhadap prinsip-prinsip etika biomedis seperti otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Buku ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa kebidanan memahami penerapan evidence-based practice (EBP), mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aplikasinya, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip etika biomedis dalam praktik sehari-hari.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan konsep Evidence-Based Midwifery secara kritis dan etis dalam pengambilan keputusan klinis, dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan praktik berbasis bukti serta mengintegrasikan prinsip etika biomedis dalam pelayanan kebidanan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengimplementasikan evidence-based practice dalam praktik kebidanan serta menerapkan prinsip-prinsip biomedical ethics dalam pengambilan keputusan klinis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan konsep dasar dan pentingnya Evidence-Based Midwifery.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan Evidence-Based Midwifery dalam praktik klinis.
3. Menjelaskan prinsip-prinsip biomedical ethics: autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam praktik kebidanan.
4. Mengintegrasikan prinsip biomedical ethics dalam keputusan klinis berbasis bukti.

A. Konsep Dasar Evidence-Based Midwifery (EBM)

1. Definisi dan Ruang Lingkup Evidence-Based Midwifery

Evidence-Based Midwifery (EBM) atau kebidanan berbasis bukti merupakan pendekatan sistematis dalam praktik kebidanan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi, dan preferensi serta nilai-nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan tidak hanya didasarkan pada tradisi, kebiasaan, atau pendapat pribadi semata, tetapi harus memiliki dasar ilmiah yang kuat dan teruji melalui penelitian klinis yang relevan dan mutakhir.

Ruang lingkup EBM mencakup seluruh aspek pelayanan kebidanan, mulai dari asuhan antenatal, persalinan, pascapersalinan, hingga perawatan bayi baru lahir. Pendekatan ini menekankan pentingnya pencarian bukti terbaik melalui sumber-sumber yang kredibel seperti jurnal ilmiah terindeks, pedoman klinis (clinical guidelines), serta hasil tinjauan sistematis (systematic review) maupun meta-analisis. Praktik kebidanan berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan, memastikan keamanan ibu dan bayi, serta meminimalisir komplikasi yang mungkin terjadi selama masa kehamilan, persalinan, hingga masa nifas.

2. Sejarah Perkembangan Evidence-Based dalam Kebidanan

Konsep Evidence-Based dalam kebidanan memiliki akar sejarah yang panjang, diawali oleh perkembangan Evidence-Based Medicine (EBM) yang dicetuskan pada awal 1990-an oleh Dr. David Sackett dan koleganya. Awalnya, pendekatan ini diterapkan dalam dunia kedokteran umum dengan tujuan agar keputusan klinis tidak lagi hanya bergantung pada intuisi dan pengalaman pribadi, melainkan pada bukti empiris yang kuat.

Secara bertahap, konsep ini diadaptasi oleh berbagai profesi kesehatan, termasuk kebidanan. Sekitar tahun 1997, International Confederation of Midwives (ICM) secara resmi mendorong penerapan evidence-based dalam praktik kebidanan secara global. Gerakan ini semakin berkembang luas seiring meningkatnya publikasi hasil penelitian ilmiah yang spesifik untuk praktik kebidanan. Saat ini, praktik berbasis bukti menjadi standar emas yang diakui secara internasional dalam pelayanan kebidanan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang turut mengadopsi pendekatan ini dalam pendidikan dan praktik klinis kebidanan.

3. Komponen Utama dalam Evidence-Based Midwifery

Ada tiga komponen penting dalam praktik kebidanan berbasis bukti yang harus dipahami secara komprehensif. Pertama, komponen bukti ilmiah yang terbaik atau best evidence. Ini mencakup hasil-hasil penelitian yang relevan, terkini, dan kredibel yang diperoleh dari studi klinis yang terstruktur dan sistematis seperti randomized controlled trials (RCTs), systematic reviews, meta-analysis, serta pedoman klinis yang diterbitkan oleh lembaga kesehatan terpercaya.

Kedua, komponen pengalaman klinis praktisi. Dalam hal ini, kebijaksanaan klinis dari bidan yang diperoleh melalui pengalaman praktik di lapangan sangat penting. Praktisi yang terampil mampu menerapkan bukti ilmiah dengan bijak, mengadaptasi hasil penelitian sesuai dengan konteks klinis dan kebutuhan individual pasien.

Ketiga, komponen preferensi dan nilai pasien. Ini mengacu pada pengakuan terhadap hak dan otonomi pasien dalam membuat keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Pasien memiliki latar belakang budaya, agama, sosial, dan personal yang memengaruhi preferensi terhadap metode atau pilihan asuhan tertentu. Komponen ini menuntut adanya komunikasi yang efektif antara bidan dan pasien guna memastikan bahwa asuhan yang diberikan tidak hanya berbasis ilmiah, tetapi juga sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pasien.

4. Pentingnya Praktik Berbasis Bukti dalam Kebidanan

Penerapan praktik berbasis bukti dalam kebidanan memiliki banyak manfaat penting yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kebidanan. Dengan mengacu pada bukti ilmiah terkini, bidan dapat meningkatkan ketepatan keputusan klinis dan mengurangi risiko komplikasi atau kesalahan dalam praktiknya. Misalnya, penggunaan metode persalinan berbasis bukti dapat mengurangi angka mortalitas ibu dan bayi secara signifikan, memastikan bahwa intervensi medis hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan, serta meningkatkan efektivitas intervensi yang diberikan.

Selain itu, EBM juga membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi bidan, karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang transparan dan jelas. Pendekatan ini juga mendukung pendidikan kebidanan dengan memastikan lulusan yang dihasilkan mampu berpikir kritis, memiliki kemampuan klinis yang tinggi, serta terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Dalam jangka panjang, praktik kebidanan berbasis bukti akan membantu mencapai tujuan utama profesi kebidanan yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak secara maksimal.

B. Kekuatan dalam Penerapan Evidence-Based Midwifery

Evidence-Based Midwifery (EBM) atau praktik kebidanan berbasis bukti merupakan pendekatan yang menempatkan temuan penelitian ilmiah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan penting yang berdampak secara signifikan terhadap mutu pelayanan kebidanan.

Salah satu kekuatan utama dari penerapan Evidence-Based Midwifery adalah keakuratan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan klinis. Keputusan klinis yang diambil oleh seorang bidan yang berlandaskan bukti ilmiah yang valid dan terbaru dapat memastikan bahwa intervensi yang dipilih adalah intervensi terbaik yang telah terbukti secara empiris mampu memberikan hasil yang optimal. Dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut tidak lagi didasarkan pada intuisi atau tradisi semata, tetapi didukung oleh bukti nyata dari berbagai studi penelitian klinis. Hal ini memberikan kepercayaan diri kepada praktisi kebidanan dalam melaksanakan tugasnya karena mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan memiliki landasan kuat dalam riset ilmiah. Keputusan yang akurat dan efektif ini pada akhirnya akan membantu dalam pencapaian hasil kesehatan yang lebih baik bagi ibu dan bayi yang dilayani.

Selanjutnya, penerapan praktik kebidanan berbasis bukti juga membawa dampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan. Dengan adanya panduan yang jelas dan berlandaskan pada penelitian ilmiah, praktik kebidanan menjadi lebih terarah, terstruktur, dan konsisten. Hal ini memungkinkan para bidan untuk memberikan pelayanan yang terstandarisasi, mengurangi variabilitas dalam kualitas pelayanan, dan memastikan bahwa setiap ibu dan bayi menerima pelayanan dengan standar tertinggi yang dapat dicapai. Standarisasi ini juga mempermudah proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan dalam layanan kebidanan. Dalam jangka panjang, praktik kebidanan berbasis bukti membantu institusi kesehatan dalam mencapai tujuan strategisnya, yaitu memberikan pelayanan yang optimal, aman, dan efektif.

Selain itu, penerapan Evidence-Based Midwifery sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya kesalahan klinis. Kesalahan klinis, seperti keputusan yang tidak tepat atau penggunaan teknik intervensi yang tidak efektif, bisa memiliki dampak serius dan membahayakan keselamatan pasien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip evidence-based, para bidan memiliki alat atau referensi yang jelas dalam menentukan tindakan yang paling tepat pada setiap situasi klinis tertentu. Sebagai contoh, dalam penanganan komplikasi seperti perdarahan postpartum atau preeklamsia, bidan yang menggunakan bukti ilmiah terbaru dapat dengan cepat menentukan tindakan terbaik yang sesuai dengan pedoman klinis terkini, sehingga

meminimalisir risiko komplikasi atau dampak negatif lainnya. Pengurangan risiko ini secara nyata meningkatkan keamanan dan keselamatan ibu dan bayi selama proses perawatan.

Keunggulan lainnya yang tidak kalah penting dalam penerapan Evidence-Based Midwifery adalah peningkatan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kebidanan. Kepercayaan pasien terbentuk ketika mereka menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki dasar ilmiah yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun klinis. Dengan mengetahui bahwa asuhan yang diterima bukan hanya berdasarkan pengalaman pribadi seorang bidan, tetapi juga didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat, pasien merasa lebih yakin, nyaman, dan percaya terhadap pelayanan yang diterima. Hal ini juga berdampak positif dalam membangun hubungan terapeutik yang lebih baik antara bidan dengan pasiennya, yang pada akhirnya mampu meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kebidanan.

Dengan demikian, penerapan Evidence-Based Midwifery tidak hanya sekedar sebuah pendekatan dalam praktik kebidanan, tetapi merupakan sebuah strategi komprehensif yang memberikan banyak manfaat positif. Pendekatan ini meningkatkan keakuratan pengambilan keputusan klinis, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara menyeluruh, secara signifikan mengurangi risiko kesalahan klinis, dan secara nyata memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi kebidanan. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting untuk terus dikembangkan dan diterapkan secara luas dalam pelayanan kebidanan guna mencapai hasil klinis yang optimal serta kesejahteraan ibu dan bayi secara keseluruhan.

C. Kelemahan dan Tantangan dalam Penerapan Evidence-Based Midwifery

Meskipun penerapan Evidence-Based Midwifery (EBM) diakui secara luas sebagai standar emas dalam praktik kebidanan modern, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat berbagai kelemahan dan tantangan signifikan yang dihadapi para bidan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah keterbatasan ketersediaan bukti ilmiah yang terbaru dan relevan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan di bidang kebidanan, tidak semua kondisi atau situasi klinis mendapatkan perhatian yang sama dalam penelitian. Beberapa masalah klinis yang spesifik atau situasi unik tertentu sering kali tidak cukup diteliti atau bahkan sama sekali tidak diteliti secara memadai. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi praktisi kebidanan untuk menemukan informasi atau pedoman ilmiah yang sesuai

dan dapat diandalkan untuk kondisi-kondisi tertentu yang dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Keterbatasan ini tidak hanya mencakup kurangnya penelitian mengenai masalah khusus, tetapi juga mencakup lambatnya pembaruan informasi yang tersedia bagi praktisi kebidanan. Penelitian ilmiah biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dari mulai tahap pelaksanaan hingga publikasi, sehingga hasil yang tersedia mungkin sudah tertinggal dibandingkan perkembangan atau tantangan yang dihadapi oleh praktisi di lapangan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebutuhan akan informasi terkini dan ketersediaan informasi tersebut, sehingga praktik kebidanan kadang kala masih bergantung pada informasi yang tidak sepenuhnya mutakhir.

Tantangan lainnya adalah hambatan dalam integrasi bukti ilmiah dengan pengalaman klinis praktisi kebidanan. Dalam praktiknya, sering kali dijumpai situasi di mana hasil penelitian ilmiah tidak mudah atau bahkan sulit diterapkan dalam konteks klinis tertentu. Bukti ilmiah biasanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol dengan kondisi ideal, sementara kondisi di lapangan sering kali jauh lebih kompleks dan dinamis. Para bidan, khususnya yang sudah lama berpraktik, mungkin merasa kesulitan atau enggan untuk sepenuhnya mengadopsi rekomendasi ilmiah karena lebih nyaman dan percaya terhadap pengalaman klinis mereka sendiri. Hal ini menciptakan dilema atau resistensi dalam penerapan pendekatan berbasis bukti, yang pada akhirnya bisa menghambat penerapan optimal dari hasil penelitian terbaru dalam praktik klinis.

Selain itu, generalisasi temuan riset sering kali menjadi kelemahan tambahan dalam penerapan EBM di bidang kebidanan. Penelitian ilmiah umumnya melibatkan populasi tertentu dengan karakteristik khusus dan cenderung menghasilkan rekomendasi yang bersifat umum. Dalam praktik kebidanan, setiap ibu atau pasien memiliki latar belakang, kondisi kesehatan, budaya, preferensi pribadi, serta kebutuhan individual yang sangat beragam. Oleh karena itu, hasil penelitian yang bersifat umum tidak selalu dapat secara langsung diterapkan pada setiap kasus individual tanpa melakukan adaptasi atau modifikasi yang hati-hati. Generalisasi yang tidak tepat atau terlalu luas justru dapat menyebabkan tindakan klinis yang kurang efektif atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan khusus pasien tertentu. Tantangan ini memerlukan kehati-hatian tinggi dan kemampuan analisis yang baik dari para bidan untuk secara bijaksana menerapkan bukti ilmiah tersebut ke dalam konteks klinis yang spesifik.

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah kesulitan dalam akses terhadap informasi berbasis bukti, terutama di daerah terpencil atau minim sumber daya. Di banyak wilayah, khususnya di daerah pedesaan atau terpencil, infrastruktur

seperti jaringan internet, perpustakaan kesehatan, atau fasilitas pendidikan masih sangat terbatas. Kondisi ini menghambat para bidan dalam mengakses publikasi ilmiah terbaru, pedoman klinis mutakhir, atau hasil-hasil penelitian terkini yang sangat dibutuhkan untuk mendukung praktik klinis mereka. Akibatnya, para praktisi di daerah tersebut sering kali harus bergantung pada metode lama atau informasi yang mungkin sudah kedaluwarsa karena tidak tersedianya sarana pendukung yang memadai untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru di bidang kebidanan. Tantangan ini bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga masalah ketidakadilan akses terhadap sumber daya kesehatan yang penting, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Secara keseluruhan, meskipun Evidence-Based Midwifery menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas asuhan kebidanan, kelemahan dan tantangan yang dihadapi harus dipahami dan diatasi secara komprehensif. Diperlukan strategi yang tepat, seperti penguatan infrastruktur pendidikan dan informasi kesehatan, pelatihan berkelanjutan bagi bidan dalam penggunaan informasi berbasis bukti, serta pendekatan kolaboratif antara praktisi kebidanan, akademisi, dan pembuat kebijakan kesehatan. Dengan demikian, praktik kebidanan berbasis bukti akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di seluruh lapisan masyarakat.

D. Prinsip-Prinsip Biomedical Ethics dalam Kebidanan

Etika biomedis merupakan suatu cabang ilmu yang membahas prinsip-prinsip moral serta nilai-nilai yang berkaitan dengan praktik dalam bidang kesehatan dan medis. Dalam konteks kebidanan, etika biomedis memainkan peran penting karena setiap keputusan yang diambil seorang bidan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik pasien, tetapi juga melibatkan aspek emosional, psikologis, sosial, dan spiritual pasien. Etika biomedis memberikan panduan dan arahan dalam membantu para bidan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, bertanggung jawab, dan manusiawi.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dalam etika biomedis adalah prinsip otonomi. Dalam praktik kebidanan, prinsip otonomi merujuk pada kewajiban untuk menghargai hak pasien dalam membuat keputusan tentang kesehatan dan perawatan yang akan mereka terima. Setiap pasien, dalam hal ini ibu hamil atau ibu bersalin, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur mengenai kondisinya, berbagai pilihan intervensi atau perawatan yang tersedia, risiko dan manfaat masing-masing pilihan, serta dampak yang mungkin terjadi. Sebagai konsekuensi logis dari prinsip ini, bidan dituntut untuk memberikan informed consent atau persetujuan yang berdasarkan pemahaman penuh pasien

sebelum menjalankan prosedur apa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa pasien memiliki kendali penuh atas tubuhnya dan memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk bidan.

Selanjutnya, prinsip beneficence atau kewajiban berbuat baik, juga menjadi fondasi penting dalam praktik kebidanan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap bidan memiliki kewajiban moral untuk melakukan tindakan yang terbaik bagi pasiennya, yaitu ibu dan bayi yang dilayani. Dalam praktik nyata, ini berarti bahwa seorang bidan harus selalu mempertimbangkan dan memilih opsi perawatan yang paling memberikan manfaat maksimal kepada pasien. Prinsip ini juga mencakup kewajiban bidan untuk secara aktif mencari cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan pasien, misalnya melalui peningkatan keterampilan klinis, mengikuti perkembangan ilmu terbaru, dan selalu bersikap empati serta penuh perhatian terhadap pasien. Bidan yang memegang teguh prinsip beneficence selalu berupaya agar pasien merasakan manfaat dari pelayanan yang diberikan, baik dalam aspek fisik maupun psikologis.

Selain kewajiban untuk berbuat baik, prinsip non-maleficence atau kewajiban untuk tidak membahayakan pasien juga merupakan prinsip utama dalam etika biomedis kebidanan. Dalam konteks ini, bidan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak menyebabkan cedera, rasa sakit, atau efek negatif lainnya kepada pasien. Hal ini menuntut bidan untuk selalu melakukan evaluasi risiko secara hati-hati sebelum melaksanakan tindakan klinis apa pun, seperti prosedur invasif atau penggunaan obat-obatan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap intervensi yang dilakukan harus memperhitungkan manfaatnya yang lebih besar dibandingkan risiko atau dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan mematuhi prinsip non-maleficence ini, bidan bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko dan mencegah cedera atau komplikasi yang tidak perlu dalam proses asuhan kebidanan.

Prinsip terakhir yang sangat penting dalam etika biomedis adalah prinsip justice atau keadilan dalam pelayanan kebidanan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau ras mereka. Dalam praktik kebidanan, prinsip justice menuntut agar setiap bidan memberikan pelayanan dengan standar yang sama kepada semua pasien, memastikan bahwa sumber daya dan pelayanan kesehatan didistribusikan secara adil, serta menjamin bahwa setiap pasien mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan layanan kesehatan yang dibutuhkan. Prinsip keadilan ini juga berarti bahwa kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat institusi

atau komunitas harus memastikan tidak ada kelompok pasien tertentu yang diabaikan atau diperlakukan kurang baik dibandingkan kelompok lainnya.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip biomedical ethics—otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice—berfungsi sebagai panduan moral yang penting dalam praktik kebidanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, para bidan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan bukan hanya aman dan efektif secara klinis, tetapi juga etis, adil, dan penuh penghormatan terhadap hak dan martabat pasien. Oleh karena itu, pemahaman dan integrasi prinsip-prinsip etika biomedis ini dalam praktik kebidanan sangat penting dalam mewujudkan pelayanan yang holistik, berkualitas tinggi, serta mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan optimal bagi ibu dan bayi yang dilayani.

E. Implementasi Biomedical Ethics dalam Praktik Evidence-Based Midwifery

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery (EBM) telah menjadi standar utama dalam pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Namun, meskipun pendekatan ini menggunakan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan klinis, tetap saja dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan nilai-nilai etika biomedis secara mendalam. Integrasi etika biomedis dalam keputusan klinis berbasis bukti merupakan langkah yang sangat penting guna memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil tidak hanya memenuhi standar ilmiah tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral, hak asasi manusia, dan kesejahteraan pasien secara keseluruhan.

Integrasi ini mengharuskan bidan untuk tidak semata-mata mengikuti rekomendasi klinis secara mekanis, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan aspek-aspek etika yang relevan dalam setiap situasi klinis yang dihadapinya. Sebagai contoh, dalam suatu kasus di mana intervensi klinis tertentu secara ilmiah dianggap paling efektif, bidan tetap perlu mempertimbangkan prinsip otonomi pasien, yaitu hak pasien untuk menerima atau menolak intervensi tersebut. Dalam hal ini, bidan dituntut untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pasien sehingga pasien dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman penuh tentang risiko, manfaat, serta implikasi dari setiap pilihan yang tersedia.

Namun, dalam implementasi etika biomedis di tengah praktik berbasis bukti ini sering kali memunculkan berbagai dilema etis. Dilema ini terjadi ketika terdapat pertentangan antara prinsip-prinsip etika yang satu dengan yang lain atau antara prinsip etika dengan bukti ilmiah yang ada. Misalnya, dilema bisa muncul ketika bukti ilmiah menyarankan intervensi tertentu yang sangat efektif, tetapi intervensi tersebut bertentangan dengan preferensi atau keyakinan pasien. Dalam kasus lain, mungkin terdapat situasi di mana rekomendasi berbasis bukti memiliki implikasi

keadilan sosial, misalnya ketika suatu intervensi terbukti efektif namun sumber daya terbatas sehingga tidak semua pasien dapat menerima intervensi tersebut secara adil. Dalam menghadapi dilema seperti ini, bidan harus mampu menganalisis situasi secara cermat, menimbang berbagai nilai etika, dan mengambil keputusan yang tidak hanya berbasis bukti ilmiah tetapi juga memperhatikan nilai-nilai moral dan hak-hak pasien secara menyeluruh.

Untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana etika biomedis diterapkan dalam praktik kebidanan berbasis bukti, berbagai studi kasus bisa dijadikan sebagai referensi. Misalnya, suatu kasus di mana seorang pasien menolak prosedur medis tertentu meskipun secara ilmiah prosedur tersebut dianggap penting untuk keselamatan pasien maupun bayinya. Dalam situasi ini, prinsip otonomi pasien harus dihormati, namun di sisi lain, bidan juga memiliki kewajiban moral (prinsip beneficence) untuk melindungi keselamatan pasien. Dalam kasus seperti ini, bidan harus mampu menjelaskan secara jelas manfaat dan risiko dari setiap pilihan yang tersedia sambil menghormati keputusan akhir pasien, selama keputusan tersebut dibuat secara sadar dan terinformasi. Studi kasus semacam ini membantu para bidan memahami bagaimana menerapkan prinsip etika secara praktis, tidak hanya teori, tetapi juga dalam situasi nyata yang sering kali kompleks dan emosional.

Tidak kalah pentingnya dalam implementasi etika biomedis adalah peran komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan berbagai isu etika dalam kebidanan. Komunikasi yang efektif melibatkan kemampuan bidan untuk mendengarkan dengan empati, memberikan informasi yang jelas dan transparan, serta membangun hubungan saling percaya dengan pasien dan keluarganya. Ketika muncul dilema etika atau ketidaksepahaman mengenai keputusan klinis tertentu, komunikasi yang baik sangat penting agar pasien dan keluarga merasa didengar, dipahami, dan dihormati. Misalnya, dalam situasi konflik antara rekomendasi klinis dengan keinginan pasien, bidan harus mampu mengelola percakapan dengan empati, memberikan ruang untuk pasien mengungkapkan kekhawatiran mereka, dan mencari solusi atau kompromi yang tetap mengutamakan kesejahteraan pasien. Dengan komunikasi yang baik, banyak konflik atau dilema etika dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik, menghindari ketegangan atau perasaan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian, implementasi biomedical ethics dalam praktik kebidanan berbasis bukti bukan hanya sebuah tambahan teoritis, tetapi merupakan elemen vital yang memastikan bahwa pelayanan kebidanan berlangsung secara manusiawi, penuh penghormatan terhadap hak dan nilai-nilai pasien, serta mencerminkan standar tertinggi dalam profesionalisme. Integrasi etika ini menegaskan bahwa

praktik kebidanan berbasis bukti bukan hanya sekadar pendekatan klinis tetapi merupakan bentuk pelayanan yang utuh, mempertimbangkan pasien secara holistik baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun moral.

F. Tantangan dan Strategi Implementasi Praktik Kebidanan Berbasis Bukti

Implementasi praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery (EBM) menghadapi beragam tantangan yang muncul baik di tingkat institusional maupun komunitas. Tantangan-tantangan ini perlu dipahami secara mendalam untuk dapat merancang strategi yang tepat dan efektif, guna memastikan bahwa pendekatan berbasis bukti benar-benar diterapkan secara luas dan konsisten dalam praktik kebidanan.

Di tingkat institusional, tantangan utama yang sering kali dijumpai adalah terkait kebijakan internal, struktur organisasi, dan budaya kerja yang mungkin belum sepenuhnya mendukung penggunaan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan klinis. Banyak institusi kesehatan, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, terkadang masih memiliki kebiasaan yang kuat dalam mengandalkan tradisi dan rutinitas klinis yang sudah berlangsung lama, meskipun tidak lagi didukung oleh bukti ilmiah terbaru. Tantangan ini muncul karena resistensi terhadap perubahan di kalangan tenaga kesehatan, termasuk bidan yang merasa nyaman dengan pendekatan lama. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak manajemen untuk mengakses informasi terbaru, minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan berkelanjutan, serta keterbatasan infrastruktur teknologi dan informasi untuk mengakses dan menyebarkan hasil-hasil penelitian terbaru juga merupakan hambatan yang signifikan di tingkat institusional.

Sementara itu, di tingkat komunitas, tantangan implementasi EBM dapat berhubungan erat dengan aspek sosio-kultural, edukasi, dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya praktik berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, masih memiliki kepercayaan tradisional yang kuat dan preferensi terhadap praktik kebidanan konvensional yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini sering kali bertentangan dengan rekomendasi berbasis bukti yang lebih modern dan mungkin dianggap asing atau tidak relevan oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mendapatkan penerimaan yang luas terhadap pendekatan berbasis bukti, terutama bila rekomendasi klinis bertentangan dengan norma, nilai, atau budaya lokal yang telah lama dipegang. Selain itu, rendahnya tingkat literasi kesehatan juga menjadi tantangan besar, karena masyarakat mungkin tidak mampu memahami

atau mengapresiasi pentingnya praktik kebidanan berbasis bukti, sehingga lebih memilih mengikuti praktik tradisional yang dianggap lebih familiar.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi dan solusi yang komprehensif serta terintegrasi dengan berbagai pihak terkait. Salah satu strategi yang penting di tingkat institusional adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong penggunaan praktik kebidanan berbasis bukti secara konsisten. Hal ini bisa dimulai dengan memperkenalkan kebijakan institusional yang mewajibkan penggunaan panduan klinis berbasis bukti sebagai standar dalam setiap pengambilan keputusan klinis. Institusi juga perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pelatihan berkelanjutan, seminar, workshop, dan akses ke jurnal ilmiah atau database penelitian terbaru. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk infrastruktur teknologi informasi yang memudahkan para bidan dalam mengakses dan menerapkan bukti ilmiah terkini dalam praktik mereka sehari-hari.

Selain strategi institusional, di tingkat komunitas, pendekatan berbasis komunikasi yang intensif, edukatif, dan berbasis budaya menjadi kunci utama. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses edukasi tentang manfaat praktik berbasis bukti. Hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dirancang khusus untuk menjembatani pemahaman antara ilmu kebidanan modern dengan nilai-nilai budaya lokal yang dihormati oleh komunitas tersebut. Pemanfaatan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau pemuka adat sebagai penyampai pesan juga sangat penting, karena mereka mampu menjadi agen perubahan yang efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap praktik berbasis bukti. Strategi ini membantu menciptakan dialog terbuka di mana masyarakat bisa memahami mengapa pendekatan berbasis bukti penting untuk keselamatan ibu dan anak, sekaligus menjaga rasa hormat terhadap tradisi lokal.

Lebih lanjut, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui berbagai media, seperti pamflet, brosur, program radio lokal, atau kampanye kesehatan berbasis komunitas, merupakan solusi strategis yang efektif. Pendidikan berkelanjutan bagi masyarakat akan secara bertahap mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan penerimaan terhadap intervensi klinis yang berbasis bukti. Selain itu, institusi kesehatan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses terhadap layanan informasi dan teknologi komunikasi, sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi ilmiah terbaru tentang kesehatan ibu dan anak.

Dengan strategi-strategi ini, implementasi Evidence-Based Midwifery dapat lebih berhasil dan berkelanjutan. Institusi kesehatan dan komunitas sama-sama mendapatkan manfaatnya, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis ilmiah. Kolaborasi yang sinergis antara institusi kesehatan, praktisi kebidanan, pembuat kebijakan, dan komunitas secara keseluruhan akan memungkinkan tercapainya tujuan utama dari pendekatan berbasis bukti dalam kebidanan, yaitu meningkatkan keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup ibu dan anak di seluruh wilayah pelayanan

G. Latihan Soal

Kasus 1

Seorang bidan menghadapi seorang pasien hamil trimester akhir yang menolak pemeriksaan ultrasonografi (USG) karena alasan keyakinan pribadinya. Secara klinis, USG ini penting untuk memeriksa posisi janin. Sikap bidan yang paling tepat berdasarkan prinsip biomedical ethics adalah:

- A. Melakukan pemeriksaan tanpa persetujuan pasien demi keselamatan janin
- B. Menjelaskan pentingnya pemeriksaan dengan rinci, kemudian menghormati keputusan pasien
- C. Meminta keluarga pasien memaksa pasien agar bersedia menjalani pemeriksaan
- D. Menolak melanjutkan pelayanan kepada pasien tersebut
- E. Tetap melakukan pemeriksaan tanpa menjelaskan kepada pasien

Jawaban: B

Pembahasan:

Prinsip otonomi dalam etika biomedis menekankan pentingnya menghormati keputusan pasien. Bidan wajib memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat dan risiko pemeriksaan USG. Setelah itu, pasien memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak pemeriksaan. Melakukan tindakan tanpa persetujuan atau memaksa pasien melanggar prinsip otonomi.

Kasus 2:

Bidan Dina bekerja di daerah terpencil. Dia menemukan bahwa panduan terbaru tentang penanganan perdarahan postpartum tidak dapat diakses karena keterbatasan jaringan internet. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan Bidan Dina agar tetap menerapkan praktik berbasis bukti adalah:

- A. Menggunakan metode lama yang dia kuasai tanpa mencoba mencari referensi tambahan
- B. Menunggu instruksi dari dokter yang akan datang bulan depan
- C. Menggunakan pedoman lama tanpa melakukan evaluasi klinis
- D. Menghubungi institusi kesehatan atau kolega untuk meminta dikirimkan salinan panduan terbaru secara fisik atau offline
- E. Mengabaikan panduan dan menggunakan intuisi klinisnya saja

Jawaban: D

Pembahasan:

Praktik berbasis bukti menuntut penggunaan bukti terbaru dan relevan. Dalam situasi keterbatasan akses, langkah proaktif bidan untuk mendapatkan salinan fisik atau offline dari panduan terbaru melalui bantuan institusi atau kolega merupakan solusi terbaik. Menggunakan intuisi semata atau panduan lama tanpa evaluasi bertentangan dengan prinsip EBM.

Kasus 3:

Dalam sebuah institusi kesehatan, beberapa bidan senior menolak mengikuti protokol klinis baru yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini. Mereka merasa metode lama yang mereka gunakan selama ini sudah efektif. Strategi paling tepat untuk mengatasi tantangan ini adalah:

- A. Memberikan sanksi kepada bidan yang menolak
- B. Mengabaikan resistensi tersebut dan melaksanakan protokol secara sepihak
- C. Melaksanakan diskusi rutin dan pelatihan mengenai pentingnya praktik berbasis bukti serta manfaatnya bagi pasien
- D. Meminta pasien memilih antara metode lama atau metode baru
- E. Menghentikan layanan kebidanan sampai semua bidan bersedia mengikuti protokol baru

Jawaban: C

Pembahasan:

Strategi terbaik adalah memberikan edukasi dan pelatihan rutin agar bidan memahami pentingnya evidence-based practice. Pendekatan ini lebih efektif daripada memaksakan atau memberi sanksi, karena membangun pemahaman dan penerimaan secara sukarela serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan.

Kasus 4:

Seorang pasien mengalami komplikasi persalinan. Bukti ilmiah menyarankan dilakukannya tindakan medis tertentu yang efektif, tetapi pasien menolak karena alasan takut risiko komplikasi dari tindakan tersebut. Tindakan bidan yang paling tepat dalam situasi ini adalah:

- A. Melakukan tindakan medis tanpa persetujuan demi menyelamatkan nyawa pasien
- B. Menghormati keputusan pasien tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut
- C. Menjelaskan secara detail risiko dan manfaat tindakan medis tersebut, lalu memberikan pasien waktu mempertimbangkan kembali
- D. Meminta keluarga memutuskan tanpa melibatkan pasien
- E. Mencari alternatif lain yang belum terbukti efektif

Jawaban: C

Pembahasan:

Dalam situasi dilema etis ini, penting untuk menerapkan prinsip otonomi dan beneficence secara bersamaan. Bidan harus menjelaskan manfaat dan risiko secara mendalam, kemudian memberi pasien ruang dan waktu untuk mempertimbangkan secara matang. Tindakan tanpa persetujuan melanggar otonomi, sementara mengabaikan begitu saja bertentangan dengan prinsip beneficence.

Kasus 5:

Bidan Sari dihadapkan pada kasus di mana sebuah intervensi terbukti sangat efektif tetapi membutuhkan biaya tinggi. Hanya sebagian pasien mampu membayarnya. Prinsip etika biomedis yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan klinis ini adalah:

- A. Otonomi
- B. Beneficence
- C. Non-maleficence
- D. Justice
- E. Fidelity

Jawaban: D

Pembahasan:

Dalam situasi keterbatasan sumber daya atau biaya tinggi, prinsip keadilan (justice) sangat relevan. Prinsip ini menuntut agar bidan dan institusi kesehatan memastikan bahwa intervensi tersebut didistribusikan secara adil dan tidak diskriminatif, serta mencari solusi agar pasien dengan keterbatasan ekonomi tetap mendapatkan akses pelayanan optimal.

H. Rangkuman Materi

Evidence-Based Midwifery (EBM) merupakan pendekatan penting yang secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dengan mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh, menurunkan risiko kesalahan klinis, dan memperkuat kepercayaan pasien terhadap layanan kebidanan.

Namun demikian, penerapan EBM tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan ketersediaan bukti ilmiah yang relevan dan terbaru, hambatan dalam mengintegrasikan bukti ilmiah dengan pengalaman klinis, kesulitan dalam generalisasi hasil penelitian, serta akses terbatas terhadap informasi di daerah terpencil atau minim sumber daya. Oleh karena itu, strategi yang tepat dan komprehensif, baik di tingkat institusional maupun komunitas, sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

Selain aspek ilmiah, implementasi praktik kebidanan berbasis bukti juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika biomedis yang meliputi otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice. Integrasi etika ini menjamin bahwa pelayanan kebidanan berlangsung tidak hanya secara ilmiah tetapi juga secara etis, manusiawi, dan berkeadilan. Para bidan dituntut untuk mampu secara kritis dan bijaksana mengintegrasikan prinsip etika biomedis dalam setiap keputusan klinis berbasis bukti.

Melalui pemahaman dan penerapan yang baik terhadap Evidence-Based Midwifery dan prinsip-prinsip etika biomedis, praktik kebidanan akan menjadi lebih holistik dan profesional. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kualitas hidup ibu dan anak yang dilayani.

I. Glosarium

- **Evidence-Based Midwifery (EBM)**
Pendekatan sistematis dalam kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis praktisi, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis.
- **Clinical Decision Making (Pengambilan Keputusan Klinis)**
Proses yang sistematis dan kritis dalam menentukan tindakan terbaik untuk pasien berdasarkan bukti ilmiah, pengalaman klinis praktisi, serta preferensi dan nilai pasien.
- **Randomized Controlled Trial (RCT)**
Jenis penelitian ilmiah yang melibatkan dua kelompok (eksperimen dan kontrol) untuk menguji efektivitas suatu intervensi secara objektif dan bebas bias.
- **Systematic Review**
Tinjauan sistematis atas berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi hasil penelitian secara objektif dan kritis.
- **Meta-analisis**
Metode analisis statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian yang relevan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat mengenai suatu topik penelitian.
- **Prinsip Otonomi (Autonomy)**
Prinsip etika biomedis yang menegaskan hak pasien dalam membuat keputusan terkait kesehatannya secara mandiri, dengan didasarkan pada informasi yang lengkap dan jelas.
- **Prinsip Beneficence**
Prinsip etika yang mengharuskan praktisi kesehatan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat terbaik dan sebesar-besarnya bagi pasien.
- **Prinsip Non-maleficence**
Prinsip etika yang menegaskan kewajiban praktisi kesehatan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau menyebabkan cedera pada pasien.
- **Prinsip Justice (Keadilan)**
Prinsip etika yang menuntut perlakuan adil, setara, dan tidak diskriminatif terhadap semua pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- **Informed Consent**
Persetujuan yang diberikan pasien berdasarkan pemahaman penuh tentang manfaat, risiko, alternatif, dan implikasi dari suatu tindakan atau intervensi medis.

J. Daftar Pustaka

- Eddy, D. M. (1990, March). Evidence-based medicine: a unified approach. *JAMA*, 263(12), 1727–1730
- Eddy, D. M. (2011). The origins of evidence-based medicine: A personal perspective. *Virtual Mentor*, 13(1), 55–60. <https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2011.13.1.mhst1-1101>
- Guyatt, G. H., Sackett, D. L., Richardson, W. S., et al. (1993). Users' guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. I. Are the results of the study valid? *JAMA*, 270(21), 2598–2601.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2002). *Essential competencies for basic midwifery practice*. ICM.
- International Confederation of Midwives (ICM). (n.d.). *Global standards for midwifery education*. ICM.
- Sackett, D. L. (1997). The practice of evidence-based medicine. *Seminars in Perinatology*, 21(1), 3–5. [https://doi.org/10.1016/S0146-0005\(97\)80013-4](https://doi.org/10.1016/S0146-0005(97)80013-4)
- Sackett, D. L., Rosenberg, W. M. C., Gray, J. A. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). *Evidence based medicine: What it is and what it isn't*. *BMJ*, 312(7023), 71–72. <https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71>

BAB 13

APLIKASI PENELITIAN PADA PRAKTIK KEBIDANAN

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan hasil penelitian ilmiah terbaik dan terkini dalam memberikan asuhan kebidanan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi, serta mengatasi tantangan dalam penerapan evidence-based midwifery dan mampu memberikan informasi klinis kepada pasien berdasarkan evidence-based secara jelas dan realistis.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tantangan dalam implementasi evidence-based midwifery dalam praktik klinis nyata.
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam penerapan evidence-based midwifery.
- Mahasiswa mampu memberikan informasi yang berbasis evidence-based secara realistis, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klinis pasien.

Pendahuluan

Praktik kebidanan berbasis bukti atau Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) merupakan integrasi kritis antara penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis bidan, dan nilai serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Namun, penerapan bukti ilmiah ke dalam praktik nyata seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek klinis, administratif, maupun sosial. Lebih lanjut, komunikasi informasi berbasis bukti kepada pasien harus dilakukan secara realistis dan jelas, sesuai dengan kondisi klinis sebenarnya, agar dapat diterima dan dimanfaatkan dengan optimal oleh pasien.

A. Tantangan dalam Penerapan Evidence-Based

Implementasi Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) dalam praktik klinis kebidanan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan melalui integrasi bukti ilmiah terbaru. Namun, terdapat berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penerapannya di lapangan. Tantangan-tantangan utama tersebut adalah:

1. Keterbatasan Akses Informasi Ilmiah

Akses terhadap informasi ilmiah yang mutakhir merupakan dasar utama dalam implementasi EBMP. Namun, hal ini sering terkendala oleh berbagai faktor berikut:

- a. Kesulitan akses terhadap jurnal berbayar.
 - 1) Sebagian besar jurnal ilmiah berkualitas tinggi memiliki sistem berlangganan yang mahal, membatasi akses bidan terutama yang bekerja di fasilitas kesehatan kecil atau terpencil.
 - 2) Keterbatasan dana untuk berlangganan jurnal berbayar mengurangi kesempatan bidan dalam mendapatkan informasi penelitian terbaru.
- b. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki akses yang sama terhadap informasi terkini.
 - 1) Fasilitas kesehatan di daerah pedesaan atau terpencil sering kali memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang memadai, sehingga sulit mendapatkan informasi terbaru.
 - 2) Kurangnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan atau pusat informasi digital membuat tenaga kebidanan sulit mengikuti perkembangan bukti ilmiah terbaru.

2. Keterbatasan Waktu

Waktu adalah sumber daya yang krusial dalam penerapan EBMP. Bidan yang menghadapi beban kerja tinggi mengalami tantangan serius untuk terus memperbarui pengetahuan melalui studi mandiri.

- a. Beban kerja yang tinggi
 - 1) Jumlah pasien yang tinggi serta kewajiban administratif yang kompleks membuat bidan sulit meluangkan waktu khusus untuk membaca dan menelaah bukti ilmiah terkini.
 - 2) Adanya tanggung jawab ganda, seperti tugas klinis dan administratif, mengurangi waktu yang bisa dialokasikan untuk aktivitas pembelajaran berbasis bukti ilmiah.

3. Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Menilai Penelitian

Menilai kualitas penelitian membutuhkan keterampilan khusus, yang tidak selalu dimiliki oleh semua tenaga kebidanan.

- a. Kurangnya pelatihan khusus dalam analisis kritis penelitian ilmiah.
 - 1) Banyak bidan belum mendapatkan pelatihan formal tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengevaluasi kualitas metodologi penelitian ilmiah.
 - 2) Minimnya program pengembangan profesional berkelanjutan yang terfokus pada metodologi penelitian dan analisis kritis menyebabkan bidan kurang percaya diri dalam penerapan EBMP.
- b. Kesulitan menafsirkan hasil penelitian yang kompleks.
 - 1) Artikel ilmiah sering kali menggunakan bahasa dan terminologi statistik yang sulit dipahami tanpa latar belakang penelitian yang memadai.
 - 2) Ketidakmampuan memahami hasil analisis statistik atau interpretasi data penelitian menyebabkan rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dalam praktik klinis sehari-hari.

4. Budaya dan Kebiasaan Klinis

Budaya dan kebiasaan yang sudah mengakar kuat di lingkungan klinis sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi EBMP.

- a. Resistensi terhadap perubahan dalam praktik klinis yang telah mapan.
 - 1) Tenaga kesehatan, khususnya yang telah lama berpraktik, mungkin enggan mengubah prosedur atau teknik yang sudah terbukti nyaman dan aman bagi mereka, walaupun ada bukti terbaru yang mendukung perubahan.
 - 2) Resistensi muncul karena persepsi bahwa perubahan memerlukan usaha tambahan yang signifikan atau berpotensi meningkatkan risiko kesalahan.
- b. Pengaruh tradisi atau senioritas yang menentang bukti ilmiah terbaru.
 - 1) Praktik berbasis senioritas atau tradisi turun-temurun sering kali lebih diutamakan dibandingkan hasil penelitian ilmiah.
 - 2) Keputusan klinis yang dipengaruhi oleh senior atau tokoh berpengaruh tanpa mempertimbangkan bukti terbaru menciptakan hambatan signifikan terhadap integrasi EBMP.

5. Dukungan Institusional

Dukungan dari institusi atau organisasi kesehatan sangat penting untuk memperkuat implementasi EBMP dalam praktik kebidanan.

- a. Kurangnya dukungan administratif atau kebijakan institusional
 - 1) Tidak adanya kebijakan yang jelas dari institusi kesehatan untuk mendukung EBMP menyebabkan kurangnya prioritas implementasi praktik berbasis bukti.
 - 2) Minimnya dukungan administratif seperti penyediaan waktu khusus atau pelatihan reguler yang difasilitasi institusi menyebabkan bidan merasa kurang didukung dalam upaya penerapan EBMP.
- b. Kurangnya sistem insentif atau penghargaan
 - 1) Tidak adanya sistem insentif yang memotivasi bidan untuk menerapkan EBMP membuat praktik berbasis bukti kurang menarik secara profesional.

- 2) Dukungan berupa penghargaan atau apresiasi terhadap upaya integrasi EBMP yang dilakukan oleh tenaga kesehatan belum optimal, sehingga motivasi untuk menggunakan evidence-based practice relatif rendah.

B. Pemberian Informasi Sesuai Evidence-Based (Kenyataan)

Pemberian informasi berbasis bukti atau evidence-based dalam praktik kebidanan merupakan komponen krusial dalam asuhan kebidanan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasien menerima informasi yang tepat, relevan, dan sesuai dengan kondisi klinis mereka yang sesungguhnya. Proses ini menuntut seorang bidan untuk mampu menyampaikan informasi secara jujur, jelas, transparan, serta efektif, sehingga pasien dapat memahami kondisi yang mereka hadapi serta berbagai pilihan tindakan yang tersedia berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Komunikasi efektif menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pemberian informasi berbasis bukti. Dalam hal ini, bidan perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien, mengingat tidak semua pasien memiliki latar belakang medis yang memadai. Pemilihan kata, penyampaian kalimat sederhana, serta penjelasan yang jelas menjadi penting agar pasien tidak merasa bingung atau bahkan cemas akibat ketidakjelasan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, bidan harus secara sadar menghindari penggunaan terminologi medis yang terlalu teknis tanpa disertai penjelasan yang cukup, sebab hal ini dapat menghambat pemahaman pasien dan mempengaruhi kualitas komunikasi secara negatif.

Selain kejelasan komunikasi, transparansi informasi juga sangat penting dalam proses ini. Transparansi informasi berarti bahwa bidan wajib memberikan gambaran yang jujur dan seimbang mengenai tindakan medis atau kebidanan yang akan diberikan. Informasi tersebut mencakup bukti ilmiah yang terkait dengan manfaat, risiko, serta kemungkinan efek samping dari tindakan tersebut. Penyampaian secara jujur bukan berarti menakut-nakuti pasien, melainkan memberikan gambaran realistis agar pasien memiliki ekspektasi yang sesuai dengan kondisi nyata. Selain itu, bidan juga harus menciptakan suasana yang terbuka, sehingga pasien merasa nyaman untuk bertanya, mengklarifikasi informasi, atau berdiskusi lebih jauh mengenai pilihan tindakan maupun alternatif lain yang mungkin tersedia.

Selanjutnya, informasi yang diberikan kepada pasien harus disesuaikan dengan kondisi klinis aktual pasien, bukan sekadar penjelasan umum atau generalisasi yang tidak spesifik. Penyesuaian informasi ini membutuhkan kepekaan klinis dari bidan terhadap kondisi pasien secara individual, termasuk mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan sosial yang menyertainya. Misalnya, pasien dengan tingkat kecemasan tinggi memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih empati, lebih pelan, dan lebih menenangkan. Sebaliknya, pasien dengan kondisi medis yang

kompleks mungkin membutuhkan informasi yang lebih detail serta rinci untuk membantu mereka mengambil keputusan secara matang. Dengan memahami kondisi pasien secara komprehensif, bidan mampu memberikan informasi secara tepat, personal, dan lebih efektif dalam mendukung pasien menghadapi situasi kesehatan yang mereka alami.

Di sisi lain, bidan memiliki tanggung jawab penting dalam mendidik pasien untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Edukasi ini mencakup dorongan kepada pasien agar mereka menyadari pentingnya keterlibatan diri dalam setiap keputusan medis atau kebidanan yang menyangkut kondisi kesehatannya. Dalam proses edukasi ini, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pasien memahami cara mencari informasi tambahan dari sumber yang valid dan dapat dipercaya. Misalnya, bidan dapat merekomendasikan situs web resmi dari institusi kesehatan, jurnal yang terverifikasi, maupun sumber-sumber literatur lain yang terpercaya. Dengan demikian, pasien tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi berkembang menjadi individu yang lebih mandiri dan aktif dalam memahami kondisi kesehatannya secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, pemberian informasi berbasis bukti yang mencerminkan realita praktik klinis menuntut kombinasi berbagai keterampilan bidan yang mencakup kemampuan komunikasi interpersonal, kepekaan terhadap kondisi pasien, transparansi dalam menyampaikan fakta medis, serta keterampilan edukasi yang efektif. Hal ini bertujuan agar pasien memiliki pemahaman yang akurat, dapat mengambil keputusan yang tepat, serta secara aktif terlibat dalam perawatan kesehatannya sendiri, sehingga hasil asuhan kebidanan menjadi lebih optimal, aman, serta berorientasi pada kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

C. Latihan Soal

Soal 1:

Di sebuah Puskesmas di daerah terpencil, seorang bidan berupaya menerapkan EBMP dalam kasus penanganan preeklamsia. Namun, ia mengalami kesulitan dalam mengakses jurnal terbaru karena keterbatasan infrastruktur internet dan jurnal berbayar. Hambatan utama yang dialami bidan tersebut dalam penerapan EBMP adalah...

- A. Beban kerja administrasi yang tinggi
- B. Resistensi senior terhadap perubahan
- C. Keterbatasan akses informasi ilmiah
- D. Minimnya insentif institusional
- E. Kesulitan interpretasi hasil penelitian ilmiah

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kondisi ini menggambarkan masalah spesifik terkait kurangnya infrastruktur internet dan akses jurnal berbayar, yang merupakan bentuk nyata dari keterbatasan akses informasi ilmiah. Opsi lain tidak tepat karena tidak mencerminkan kasus secara spesifik.

Soal 2:

Seorang bidan di rumah sakit kota merasa kesulitan dalam mengikuti praktik terbaru berbasis bukti karena jadwalnya sangat padat dengan pelayanan pasien dan kegiatan administratif. Hal ini mengurangi waktu untuk membaca artikel penelitian terbaru. Tantangan utama yang dihadapi bidan ini dalam penerapan EBMP adalah...

- A. Kurangnya pelatihan analisis kritis penelitian
- B. Minimnya dukungan institusional
- C. Resistensi budaya klinis yang mapan
- D. Keterbatasan waktu
- E. Kesulitan akses jurnal berbayar

Kunci Jawaban: D

Rasional:

Fokus soal adalah beban kerja yang tinggi dan kurangnya waktu, yang secara jelas menunjukkan tantangan keterbatasan waktu. Pilihan lain kurang relevan dengan kondisi yang digambarkan dalam kasus ini.

Soal 3:

Seorang bidan yang baru bekerja di klinik swasta mengalami kendala dalam memahami hasil penelitian tentang efektivitas intervensi untuk nyeri persalinan. Ia kesulitan memahami terminologi statistik dalam jurnal ilmiah. Tantangan yang dialami oleh bidan tersebut adalah...

- A. Kurangnya waktu untuk membaca penelitian
- B. Resistensi dari senior terhadap perubahan
- C. Kurangnya keterampilan dalam menilai penelitian
- D. Minimnya insentif dari institusi
- E. Infrastruktur informasi yang tidak memadai

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kesulitan memahami terminologi statistik dan hasil penelitian secara spesifik menunjukkan keterbatasan keterampilan dalam menilai penelitian ilmiah. Pilihan lainnya tidak secara langsung mencerminkan inti masalah yang dialami.

Soal 4:

Di rumah sakit pemerintah, seorang bidan muda merasa frustrasi karena prosedur persalinan berbasis tradisi turun-temurun masih tetap digunakan, meskipun sudah ada bukti ilmiah terbaru yang menyarankan perubahan prosedur yang lebih efektif dan aman. Hambatan utama dalam situasi ini adalah...

- A. Minimnya fasilitas informasi digital
- B. Keterbatasan waktu belajar mandiri
- C. Resistensi budaya dan senioritas klinis
- D. Kesulitan memahami analisis statistik
- E. Tidak adanya insentif institusional

Kunci Jawaban: C

Rasional:

Kasus ini secara jelas menggambarkan hambatan yang muncul dari budaya klinis dan senioritas, di mana praktik lama dipertahankan tanpa mengikuti bukti ilmiah terbaru. Pilihan lain tidak tepat untuk konteks kasus ini.

Soal 5:

Seorang bidan di rumah sakit daerah memiliki minat tinggi untuk menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti terbaru. Namun, ia merasa kurang mendapatkan dukungan dari institusi tempatnya bekerja, seperti tidak adanya kebijakan yang jelas dan minimnya pelatihan rutin untuk penerapan EBMP. Tantangan yang dihadapi oleh bidan ini adalah...

- A. Keterbatasan akses terhadap jurnal ilmiah
- B. Beban administrasi yang tinggi
- C. Kurangnya keterampilan analisis kritis
- D. Resistensi budaya klinis mapan
- E. Minimnya dukungan institusional

Kunci Jawaban: E

Rasional:

Situasi ini secara eksplisit menunjukkan kurangnya kebijakan, pelatihan, dan dukungan dari institusi dalam mendorong penerapan EBMP. Pilihan lain tidak relevan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh bidan tersebut.

D. Rangkuman Materi

Implementasi Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dengan memadukan bukti ilmiah terbaru dalam praktik klinis. Namun, penerapannya sering menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi ilmiah akibat biaya jurnal yang tinggi dan infrastruktur teknologi yang terbatas, khususnya di fasilitas kesehatan pedesaan. Selain itu, beban kerja tinggi dan tugas administratif mengurangi kesempatan bidan untuk mempelajari hasil penelitian terbaru.

Tantangan lain mencakup kurangnya pengetahuan serta keterampilan khusus dalam analisis kritis penelitian ilmiah. Banyak bidan yang kesulitan memahami metode penelitian dan interpretasi statistik, sehingga sulit menerapkan bukti ilmiah ke dalam praktik. Budaya klinis yang kuat, termasuk resistensi terhadap perubahan prosedur yang sudah mapan serta dominasi senioritas atau tradisi lama, juga menjadi hambatan besar. Dukungan institusional yang minim, seperti kebijakan yang kurang jelas, pelatihan yang terbatas, serta kurangnya insentif atau apresiasi, juga mengurangi motivasi bidan dalam menerapkan EBMP secara optimal.

Di sisi lain, pemberian informasi berbasis bukti kepada pasien merupakan aspek penting dalam asuhan kebidanan yang berkualitas. Prinsip utama dalam hal ini adalah komunikasi yang efektif dengan menggunakan bahasa sederhana agar pasien mudah memahami informasi medis yang diberikan. Transparansi informasi harus diutamakan dengan menjelaskan secara jujur manfaat, risiko, serta efek samping dari setiap tindakan, tanpa menimbulkan kecemasan yang tidak perlu.

Informasi yang disampaikan perlu disesuaikan secara spesifik dengan kondisi aktual pasien, memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan sosialnya. Hal ini bertujuan agar pasien dapat memahami situasi klinis mereka secara jelas, realistis, dan relevan dengan keadaan yang sesungguhnya. Lebih lanjut, bidan harus mendorong pasien untuk aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Peran bidan tidak hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing pasien dalam menemukan informasi tambahan dari sumber yang valid dan terpercaya.

Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan EBMP dalam kebidanan memerlukan upaya kolektif yang melibatkan peningkatan akses informasi ilmiah, pengelolaan waktu yang lebih baik, pelatihan khusus dalam memahami hasil penelitian, dukungan institusional, serta perubahan budaya klinis. Di samping itu, pemberian informasi secara evidence-based harus berorientasi pada kejujuran, transparansi, komunikasi yang empati, serta edukasi pasien secara aktif agar tercapai hasil asuhan kebidanan yang optimal, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

E. Glosarium

Analisis Kritis

Proses mengevaluasi secara sistematis kualitas metodologi dan relevansi penelitian ilmiah sebelum diterapkan dalam praktik klinis.

Bukti Ilmiah (Evidence-Based)

Informasi atau hasil penelitian terbaru yang telah terbukti valid dan reliabel, digunakan untuk mendukung keputusan klinis secara ilmiah.

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Praktik kebidanan yang didasarkan pada integrasi antara bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis bidan, dan kebutuhan serta preferensi pasien.

Integrasi Bukti Ilmiah

Penggabungan bukti penelitian terbaru ke dalam praktik klinis secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Infrastruktur Teknologi

Fasilitas fisik dan teknis yang mendukung akses terhadap informasi digital seperti internet, perpustakaan daring, serta pusat data ilmiah.

Jurnal Berbayar

Publikasi ilmiah yang memerlukan biaya langganan untuk mendapatkan akses penuh terhadap konten ilmiahnya.

Keterampilan Klinis

Kemampuan praktis yang dimiliki tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan kepada pasien sesuai standar praktik profesional.

Komunikasi Efektif

Proses interaksi antara bidan dengan pasien yang menggunakan bahasa jelas, sederhana, dan mudah dipahami, serta mampu menyampaikan informasi secara transparan dan tepat.

Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Program pelatihan atau pendidikan berkelanjutan yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan.

Resistensi Budaya Klinis

Penolakan atau keengganan tenaga kesehatan terhadap perubahan praktik klinis yang baru karena adanya tradisi atau kebiasaan yang telah lama diterapkan.

Senioritas Klinis

Pengaruh dari tenaga kesehatan yang lebih senior atau berpengalaman yang cenderung mempertahankan prosedur atau metode lama dibandingkan metode berbasis bukti ilmiah terbaru.

Tanggung Jawab Ganda

Kondisi di mana seorang tenaga kesehatan menjalankan lebih dari satu jenis tugas, misalnya tugas klinis sekaligus administratif, yang berpotensi mengurangi waktu yang tersedia untuk pembelajaran mandiri.

Terminologi Statistik

Istilah atau bahasa khusus yang digunakan dalam penelitian ilmiah, khususnya dalam analisis data statistik, yang biasanya sulit dipahami tanpa latar belakang pengetahuan statistik.

Transparansi Informasi

Upaya menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap kepada pasien, mencakup manfaat, risiko, serta potensi efek samping dari tindakan medis yang diambil.

Dukungan Institusional

Kebijakan, sarana, serta dukungan administratif dan insentif yang diberikan oleh institusi kesehatan untuk mendorong penerapan praktik klinis berbasis bukti secara optimal.

Insentif Institusional

Penghargaan atau apresiasi dalam berbagai bentuk yang diberikan institusi kepada tenaga kesehatan yang secara aktif menerapkan praktik berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan.

Partisipasi Aktif Pasien

Keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya, didukung oleh edukasi dan informasi yang jelas serta berbasis bukti ilmiah.

Pendekatan Personal dalam Komunikasi

Cara komunikasi bidan yang menyesuaikan informasi sesuai kondisi individu pasien, melibatkan pertimbangan aspek psikologis, emosional, dan sosial untuk efektivitas asuhan yang lebih baik.

F. Daftar Pustaka

- Carolan, M., Smith, A., & Hall, A. (2019). Implementing evidence-based practice in midwifery: Challenges and facilitators. *Journal of Clinical Nursing*, 28(15–16), 2797–2805. <https://doi.org/10.1111/jocn.14867>
- Cleary-Holdforth, J., & Leufer, T. (2021). Essential components for integrating evidence-based practice effectively in clinical settings. *Journal of Clinical Nursing*, 30(9–10), 1203–1212. <https://doi.org/10.1111/jocn.15751>
- Dagne, A. H., Ayalew, M. M., & Gedamu, H. (2021). Barriers to implementing evidence-based practice among nurses and midwives in low-income countries: A systematic review. *BMC Nursing*, 20(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00635-7>

- Dean, S. V., Imam, A. M., Lassi, Z. S., & Bhutta, Z. A. (2019). Importance of evidence-based midwifery practice and barriers to its implementation in developing countries. *Midwifery*, 69, 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.10.005>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2018). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2018). *Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM* (5th ed.). Churchill Livingstone.
- Sinclair, S., Kondejewski, J., Jaggi, P., Dennett, L., Roze des Ordons, A. L., & Hack, T. F. (2020). What works for whom in compassion training programs offered to practicing healthcare providers: A realist review. *BMC Medical Education*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02096-0>
- WHO. (2020). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>
- Youngblut, J. M., & Brooten, D. (2018). Evidence-based nursing and midwifery practice: Challenges, opportunities, and strategies. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 15(5), 355–361. <https://doi.org/10.1111/wvn.12322>

BAB 14

TREND DAN ISSUE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran dari topik ini, lulusan mampu mengimplementasikan tren dan mengatasi isu terkini dalam praktik kebidanan secara evidence-based, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan tren dan isu terbaru dalam praktik kebidanan berbasis bukti.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan tren terbaru dalam praktik kebidanan berbasis bukti.
- Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu aktual dalam praktik kebidanan.
- Mengaplikasikan bukti ilmiah terkini untuk mengatasi isu-isu yang berkembang dalam praktik kebidanan.

Pendahuluan

Dalam era modernisasi kesehatan, praktik kebidanan mengalami berbagai perkembangan signifikan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru. Tren dan isu dalam praktik kebidanan senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang tren dan isu terkini menjadi sangat penting bagi bidan dalam memberikan pelayanan optimal, relevan, serta responsif terhadap kebutuhan pasien dan komunitas. Buku ajar ini akan menguraikan berbagai tren dan isu terkini dalam kebidanan serta bagaimana praktik berbasis bukti dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

A. Tren Terbaru dalam Praktik Kebidanan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam bidang kebidanan, menghasilkan berbagai inovasi dan perubahan praktik pelayanan kesehatan. Tren terbaru ini menekankan pada penggunaan teknologi informasi, penerapan praktik berbasis bukti, dan kolaborasi interprofesional demi mencapai kualitas pelayanan kebidanan yang lebih optimal, efisien, dan berpusat pada pasien.

1. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Praktik Kebidanan

Teknologi informasi kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik kebidanan, memberikan manfaat besar dalam pelayanan antenatal, intranatal, hingga postnatal.

- a. Telehealth dalam pelayanan antenatal dan postnatal.

Telehealth merupakan penggunaan teknologi komunikasi digital (video call, telepon, atau chat) untuk memfasilitasi pelayanan kebidanan jarak jauh. Tren ini makin meningkat terutama sejak pandemi COVID-19, yang mendorong percepatan integrasi teknologi digital dalam kesehatan.

- b. Penggunaan aplikasi mobile dan wearables untuk pemantauan kesehatan ibu hamil.

2. Metode Persalinan Berbasis Evidence-Based

Metode persalinan berbasis bukti (evidence-based) merupakan pendekatan dalam persalinan yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru, dengan tujuan meningkatkan pengalaman positif bagi ibu, mengurangi komplikasi, serta meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

- a. Praktik gentle birth dan water birth yang berbasis bukti.

Gentle birth dan water birth merupakan pendekatan persalinan yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, serta intervensi medis minimal.

- b. Teknik non-farmakologis untuk manajemen nyeri persalinan.

Teknik non-farmakologis adalah metode pengelolaan nyeri persalinan tanpa menggunakan obat-obatan kimia.

3. Pendekatan Interprofesional dalam Pelayanan Kebidanan

Pendekatan interprofesional melibatkan kolaborasi yang efektif antara berbagai profesi kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan.

- a. Kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Kolaborasi interprofesional mengintegrasikan keahlian masing-masing profesi dalam tim kesehatan untuk menghasilkan pelayanan yang lebih holistik dan efektif.

b. Implementasi model asuhan kolaboratif dalam kebidanan.

Model asuhan kolaboratif adalah penerapan praktik tim interprofesional yang terstruktur dalam pelayanan kebidanan.

B. Isu Aktual dalam Praktik Kebidanan

Dalam dunia praktik kebidanan saat ini, terdapat sejumlah isu aktual yang menjadi tantangan penting bagi praktisi kebidanan. Isu-isu tersebut mencakup kesenjangan kesehatan, kekerasan obstetri, serta stigma dan diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan. Pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu ini serta implementasi solusi berbasis bukti (evidence-based) menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan positif dalam praktik kebidanan di masyarakat.

1. Kesenjangan Kesehatan dalam Pelayanan Kebidanan

Kesenjangan kesehatan dalam pelayanan kebidanan masih merupakan masalah serius, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pedesaan. Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Di daerah-daerah terpencil, infrastruktur kesehatan sering kali kurang memadai, dengan minimnya fasilitas kesehatan yang terjangkau dan jumlah tenaga kebidanan yang terbatas. Situasi ini menyebabkan banyak ibu hamil tidak mendapatkan layanan antenatal, persalinan, maupun postnatal yang memadai. Akibatnya, angka komplikasi kehamilan dan persalinan, termasuk angka kematian ibu dan bayi, cenderung tinggi di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi berbasis bukti yang efektif. Pendekatan seperti pelayanan kebidanan bergerak (mobile midwifery services), pemberdayaan bidan desa melalui pelatihan rutin yang didukung bukti ilmiah terbaru, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti telehealth, terbukti efektif dalam meningkatkan akses layanan kebidanan. Implementasi strategi ini, berdasarkan bukti dari penelitian-penelitian terbaru, menunjukkan peningkatan signifikan dalam cakupan layanan antenatal dan postnatal, serta menurunkan angka komplikasi persalinan secara keseluruhan. Dukungan kebijakan dari pemerintah serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan upaya mengatasi kesenjangan ini.

2. Kekerasan Obstetri dan Hak-Hak Pasien

Kekerasan obstetri adalah isu sensitif yang saat ini semakin mendapat perhatian publik. Kekerasan obstetri mencakup tindakan atau perilaku dari tenaga

kesehatan yang dilakukan tanpa menghormati hak dan martabat pasien selama proses kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Bentuk kekerasan ini meliputi pelecehan verbal, tindakan medis tanpa persetujuan (seperti episiotomi tanpa informed consent), pengabaian kebutuhan emosional ibu, perlakuan kasar atau merendahkan, hingga penggunaan intervensi yang tidak perlu atau berlebihan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Isu ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak pasien dan dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam serta ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan.

Untuk mengatasi kekerasan obstetri, praktik kebidanan berbasis bukti menjadi solusi yang utama. Penerapan prinsip informed consent yang ketat dalam setiap intervensi medis menjadi dasar utama dalam pencegahan kekerasan obstetri. Selain itu, peningkatan kesadaran tenaga kesehatan melalui pelatihan khusus tentang hak pasien, komunikasi efektif, dan praktik kebidanan berbasis bukti juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi edukasi berbasis bukti bagi tenaga kebidanan berhasil menurunkan angka kekerasan obstetri secara signifikan. Evaluasi berkala dan sistem pelaporan yang transparan juga penting untuk memastikan bahwa praktik tersebut benar-benar terimplementasi secara konsisten di fasilitas kesehatan.

3. Stigma dan Diskriminasi dalam Pelayanan Kebidanan

Stigma dan diskriminasi dalam praktik kebidanan merupakan isu lain yang berdampak besar terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil. Stigma sering muncul pada kondisi kesehatan tertentu seperti HIV/AIDS, gangguan mental, atau kehamilan di luar nikah, yang menyebabkan diskriminasi dan perlakuan yang tidak setara dari tenaga kesehatan. Stigma ini berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental pasien, menyebabkan mereka enggan mencari bantuan medis, terlambat mendapatkan perawatan yang diperlukan, atau bahkan menarik diri dari layanan kesehatan sama sekali. Akibatnya, ibu dan bayi berisiko mengalami komplikasi serius yang sebenarnya dapat dicegah.

Untuk mengurangi stigma dan diskriminasi ini, intervensi berbasis bukti yang melibatkan edukasi tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting dilakukan. Edukasi dan pelatihan tentang sensitivitas budaya, empati, komunikasi terapeutik, serta pemahaman mendalam tentang kondisi medis tertentu terbukti efektif dalam mengurangi sikap diskriminatif di kalangan tenaga kesehatan. Selain itu, implementasi kebijakan fasilitas kesehatan yang tegas mengenai perlakuan setara bagi semua pasien tanpa memandang latar belakang juga menjadi langkah penting. Penelitian berbasis bukti menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang menerapkan kebijakan non-diskriminasi secara jelas berhasil

menciptakan lingkungan layanan yang lebih ramah, inklusif, dan bebas stigma, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan.

C. Implementasi Evidence-Based untuk Menghadapi Isu dan Tren

Implementasi praktik kebidanan berbasis bukti (Evidence-Based Midwifery Practice/EBMP) merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu aktual dan tren terbaru dalam kebidanan. Implementasi ini melibatkan berbagai tahapan penting mulai dari mengakses bukti ilmiah terbaru, menilai kualitasnya secara kritis, mengintegrasikannya ke dalam keputusan klinis sehari-hari, hingga melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas intervensi yang dilakukan.

1. Strategi Mengakses dan Menilai Bukti Ilmiah Terbaru

Salah satu tahapan krusial dalam implementasi praktik berbasis bukti adalah bagaimana tenaga kebidanan dapat secara efisien mengakses dan menilai kualitas bukti ilmiah terbaru yang relevan dengan praktik mereka. Pemanfaatan database jurnal ilmiah merupakan langkah awal yang penting dalam proses ini. Database seperti PubMed, ScienceDirect, Cochrane Library, ProQuest, dan Google Scholar menyediakan akses ke artikel-artikel penelitian terbaru yang dapat diakses oleh bidan secara mudah dan cepat. Melalui basis data ini, bidan bisa menemukan informasi mutakhir tentang intervensi kebidanan terbaru, evaluasi efektivitas teknologi dalam pelayanan maternitas, serta rekomendasi terkini dalam manajemen berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan.

Namun, mendapatkan bukti ilmiah saja tidak cukup. Bidan juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan critical appraisal atau penilaian kritis terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Critical appraisal adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas, reliabilitas, relevansi klinis, dan tingkat kemutakhiran sebuah penelitian ilmiah sebelum diterapkan dalam praktik klinis. Dalam critical appraisal, bidan akan menilai apakah desain penelitian sudah tepat, metode pengumpulan data sudah valid, analisis statistik yang digunakan sudah sesuai, serta kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan data yang diperoleh. Dengan keterampilan ini, bidan dapat memastikan bahwa bukti ilmiah yang digunakan benar-benar berkualitas tinggi dan relevan untuk praktik klinis mereka.

2. Integrasi Bukti Ilmiah dalam Pengambilan Keputusan Klinis

Setelah memperoleh dan menilai kualitas bukti ilmiah, tahap selanjutnya adalah integrasi bukti tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan klinis di lapangan. Integrasi ini melibatkan penyusunan kebijakan klinis berbasis bukti yang terstruktur dan jelas. Metode efektif untuk menyusun kebijakan klinis

berbasis bukti mencakup langkah-langkah seperti mengumpulkan bukti ilmiah yang valid, melakukan diskusi atau rapat klinis bersama tim kesehatan, merumuskan protokol atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas berdasarkan rekomendasi ilmiah terbaru, serta mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kebidanan.

Penerapan rekomendasi evidence-based dalam praktik sehari-hari membutuhkan teknik dan pendekatan khusus. Salah satunya adalah dengan menggunakan panduan klinis atau clinical pathway yang dirancang berbasis bukti. Clinical pathway memudahkan tenaga kebidanan dalam mengimplementasikan rekomendasi evidence-based secara konsisten dan efisien di lapangan. Selain itu, pelatihan rutin bagi bidan tentang teknik implementasi bukti ilmiah serta komunikasi efektif kepada pasien merupakan bagian penting dari integrasi bukti ini. Bidan perlu memastikan bahwa setiap keputusan klinis yang diambil tidak hanya didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat tetapi juga mempertimbangkan preferensi dan kondisi pasien secara individual, sehingga keputusan yang diambil benar-benar holistik dan berpusat pada pasien.

3. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Praktik Berbasis Bukti

Implementasi praktik berbasis bukti tidak berhenti pada penerapan rekomendasi ilmiah saja, namun perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi yang sistematis untuk menilai efektivitas dari intervensi tersebut. Monitoring ini bertujuan memastikan bahwa intervensi kebidanan berbasis bukti berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil klinis yang diinginkan. Dalam proses monitoring, alat dan metode evaluasi yang efektif seperti audit klinis, survei kepuasan pasien, serta pengukuran indikator-indikator klinis (misalnya tingkat komplikasi persalinan, angka kematian ibu-bayi, atau tingkat kepuasan pasien) dapat digunakan secara teratur.

Audit klinis merupakan salah satu metode evaluasi yang terbukti efektif dalam menilai implementasi EBMP, di mana catatan medis pasien secara acak dievaluasi berdasarkan standar praktik berbasis bukti yang telah ditentukan sebelumnya. Audit ini membantu mengidentifikasi apakah praktik klinis di fasilitas kebidanan sudah sesuai dengan rekomendasi ilmiah atau masih terdapat celah yang perlu diperbaiki.

Selain metode evaluasi, penggunaan studi kasus penerapan evidence-based yang berhasil juga penting dalam proses evaluasi ini. Studi kasus nyata dari berbagai fasilitas kesehatan yang telah berhasil menerapkan intervensi berbasis bukti dapat menjadi pembelajaran dan motivasi bagi fasilitas kesehatan lain untuk menerapkan hal yang sama. Contoh kasus sukses misalnya adalah implementasi protokol manajemen persalinan aktif berbasis bukti yang terbukti mampu

menurunkan angka perdarahan postpartum secara signifikan di beberapa rumah sakit atau puskesmas. Studi kasus ini menjadi bukti nyata bahwa implementasi praktik kebidanan berbasis bukti dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan klinis.

D. Latihan Soal

Soal 1:

Ibu R, usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 32 minggu tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Untuk mengatasi keterbatasan akses antenatal care (ANC), bidan menggunakan layanan telehealth untuk konsultasi dan edukasi kesehatan. Manfaat utama yang diperoleh dari penerapan telehealth dalam kasus tersebut adalah:

- A. Pemeriksaan fisik lengkap rutin
- B. Intervensi medis langsung
- C. Mengurangi risiko komplikasi obstetri
- D. Meningkatkan akses informasi kesehatan secara berkala
- E. Memastikan persalinan spontan di rumah

Kunci: D

Rasional:

Telehealth memfasilitasi pemberian edukasi dan informasi kesehatan secara rutin dan berkala kepada ibu hamil di daerah terpencil, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pasien terhadap tanda bahaya kehamilan dan membantu persiapan persalinan.

Soal 2:

Seorang ibu berusia 30 tahun sedang mempersiapkan persalinannya yang kedua. Ia ingin melahirkan dengan metode gentle birth yang berbasis bukti. Karakteristik utama dari metode gentle birth yang akan diterapkan oleh bidan pada ibu tersebut adalah:

- A. Melakukan episiotomi rutin untuk mempercepat persalinan
- B. Menggunakan lingkungan yang nyaman dan minim intervensi medis
- C. Menggunakan analgesik farmakologis secara rutin
- D. Menyegerakan pemotongan tali pusat
- E. Melakukan induksi persalinan agar lebih cepat selesai

Kunci: B

Rasional:

Metode gentle birth yang berbasis bukti menekankan suasana persalinan yang nyaman, rileks, dengan minimalisasi intervensi medis untuk mendukung proses persalinan alami yang optimal.

Soal 3:

Seorang ibu hamil, usia 22 tahun dengan riwayat gangguan kecemasan, merasa enggan datang ke puskesmas karena khawatir mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan (diskriminasi). Sebagai bidan, tindakan paling tepat berbasis bukti yang harus diterapkan untuk mengurangi stigma tersebut adalah:

- A. Mengabaikan riwayat medis agar tidak memicu stigma
- B. Memberikan konseling dengan pendekatan empati dan komunikasi terapeutik
- C. Meminta ibu mencari fasilitas kesehatan khusus lainnya
- D. Memberikan obat penenang tanpa konsultasi psikolog
- E. Tidak mencatat kondisi mental ibu dalam rekam medis

Kunci: B

Rasional:

Pendekatan empati, sensitivitas budaya, dan komunikasi terapeutik secara evidence-based terbukti efektif dalam mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien dengan gangguan mental dalam layanan kesehatan.

Soal 4:

Di suatu puskesmas, angka kejadian kekerasan obstetri dilaporkan cukup tinggi. Sebagai langkah pencegahan, bidan perlu menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti dengan pendekatan utama berupa:

- A. Menjalankan intervensi medis sesuai kebiasaan setempat
- B. Melakukan tindakan medis segera tanpa persetujuan pasien
- C. Menggunakan informed consent sebelum setiap tindakan
- D. Menyederhanakan informasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran pasien
- E. Menghindari komunikasi terbuka dengan pasien untuk efisiensi waktu

Kunci: C

Rasional:

Penggunaan informed consent yang jelas dan lengkap sebelum melakukan tindakan medis adalah praktik utama berbasis bukti yang terbukti efektif dalam mencegah kekerasan obstetri dan menghormati hak-hak pasien.

Soal 5:

Bidan Rika bertugas di klinik yang baru menerapkan model asuhan kolaboratif interprofesional dalam praktik kebidanan. Salah satu manfaat utama dari penerapan model tersebut yang akan diperoleh adalah:

- A. Mengurangi komunikasi antar tenaga kesehatan untuk efisiensi waktu
- B. Mengoptimalkan peran tunggal bidan dalam asuhan persalinan
- C. Menurunkan angka rujukan dengan membatasi interaksi antar profesi
- D. Meningkatkan kualitas asuhan melalui integrasi keahlian berbagai profesi
- E. Mempersempit cakupan layanan hanya pada proses persalinan saja

Kunci: D

Rasional:

Model asuhan kolaboratif interprofesional berbasis bukti terbukti meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara signifikan karena memanfaatkan integrasi keahlian dari berbagai profesi kesehatan.

E. Rangkuman Materi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktik kebidanan telah membawa dampak signifikan berupa munculnya tren terbaru yang memprioritaskan penggunaan teknologi informasi, metode persalinan berbasis bukti, serta kolaborasi interprofesional. Penerapan telehealth dan aplikasi mobile dalam pelayanan antenatal hingga postnatal membantu memperluas akses layanan dan pemantauan kesehatan ibu secara efektif. Metode gentle birth dan teknik non-farmakologis juga semakin diminati karena terbukti secara ilmiah memberikan kenyamanan dan meningkatkan keamanan proses persalinan. Selain itu, pendekatan interprofesional yang melibatkan berbagai profesi kesehatan semakin diakui mampu menghasilkan asuhan yang holistik, terintegrasi, dan optimal.

Di sisi lain, masih terdapat isu aktual seperti kesenjangan kesehatan, kekerasan obstetri, serta stigma dan diskriminasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan kebidanan. Kesenjangan layanan khususnya di daerah terpencil dapat diatasi melalui strategi berbasis bukti seperti pelayanan bergerak dan pemanfaatan teknologi digital. Kekerasan obstetri yang mencederaikan hak pasien dapat dicegah melalui peningkatan kesadaran tenaga kesehatan serta penerapan prinsip informed consent secara ketat. Sedangkan stigma dan diskriminasi terhadap kondisi kesehatan tertentu dapat dikurangi melalui edukasi sensitivitas budaya dan implementasi kebijakan non-diskriminatif yang jelas.

Implementasi praktik kebidanan berbasis bukti (EBMP) secara sistematis merupakan solusi penting dalam menghadapi berbagai isu dan tren tersebut. Proses implementasi meliputi pengaksesan dan penilaian kritis terhadap bukti ilmiah terbaru, integrasi bukti ilmiah dalam kebijakan klinis dan praktik sehari-hari, serta

monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas intervensi. Dengan demikian, EBMP mampu menjamin pelayanan kebidanan yang aman, efektif, efisien, berpusat pada pasien, serta terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru.

F. Glosarium

Audit Klinis

Metode evaluasi sistematis untuk menilai apakah pelayanan kesehatan yang diberikan sudah sesuai dengan standar praktik berbasis bukti.

Clinical Pathway

Panduan atau protokol klinis berbasis bukti yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan memberikan asuhan yang konsisten, efektif, dan efisien.

Critical Appraisal

Proses sistematis untuk menilai validitas, reliabilitas, relevansi klinis, dan tingkat kemutakhiran sebuah penelitian sebelum diterapkan dalam praktik klinis.

Evidence-Based Midwifery Practice (EBMP)

Praktik kebidanan yang menggunakan hasil penelitian ilmiah terbaru, keahlian klinis tenaga kesehatan, serta preferensi pasien dalam setiap pengambilan keputusan klinis.

Gentle Birth

Pendekatan persalinan yang berfokus pada suasana nyaman, minim intervensi medis, serta mendukung proses alami persalinan dengan memperhatikan kebutuhan emosional ibu.

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis yang diberikan pasien setelah menerima penjelasan lengkap mengenai manfaat, risiko, alternatif, dan konsekuensi tindakan yang akan dilakukan.

Interprofesional

Kolaborasi atau kerjasama lintas profesi kesehatan seperti dokter, bidan, perawat, ahli gizi, psikolog, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih holistik dan efektif.

Kekerasan Obstetri

Segala bentuk tindakan atau perilaku tenaga kesehatan yang tidak menghormati hak dan martabat pasien selama proses kehamilan, persalinan, atau masa nifas.

Kesenjangan Kesehatan

Perbedaan signifikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh populasi tertentu, terutama di wilayah terpencil atau pedesaan.

Kolaborasi Interprofesional

Integrasi keahlian masing-masing profesi dalam tim kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Mobile Midwifery Services

Pelayanan kebidanan bergerak yang ditujukan untuk menjangkau pasien di daerah terpencil guna meningkatkan akses layanan kebidanan.

Non-Farmakologis

Teknik atau metode pengelolaan nyeri yang tidak menggunakan obat-obatan kimia, seperti relaksasi, hipnosis, pijat, aromaterapi, atau teknik pernapasan.

Stigma dan Diskriminasi dalam Pelayanan Kebidanan

Sikap negatif atau perlakuan tidak adil yang diterima pasien dari tenaga kesehatan akibat kondisi tertentu seperti HIV/AIDS, gangguan mental, atau kehamilan di luar nikah.

Telehealth

Penggunaan teknologi digital seperti video call, telepon, atau aplikasi chatting untuk memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh.

Water Birth

Metode persalinan di mana proses kelahiran bayi dilakukan di dalam kolam berisi air hangat untuk mengurangi rasa nyeri dan menciptakan suasana lebih nyaman bagi ibu.

Wearables

Alat teknologi yang dapat dikenakan (misalnya smartwatch atau smartband) untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil secara real-time.

G. Daftar Pustaka

- American College of Nurse-Midwives. (2021). Telehealth and midwifery practice: Integrating technology into maternal care. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 66(3), 298–305. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13210>
- Begley, C., Sedlicka, N., & Daly, D. (2019). Respectful and disrespectful care in maternity services: Interventions to promote respectful maternity care. *Reproductive Health*, 16(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12978-019-0727-7>
- Catling, C., & Homer, C. S. (2022). Evidence-based gentle birth practices: Benefits, implementation, and challenges. *Midwifery*, 105, Article 103195. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103195>
- Dahlen, H. G., Downe, S., & Kennedy, H. P. (2022). Water birth: Current evidence and clinical guidelines. *Women and Birth*, 35(1), e1–e8. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.03.005>

- Fauziningtyas, R., & Ulfiana, E. (2022). The use of mobile health (mHealth) application in improving maternal and neonatal health outcomes: A systematic review. *Bali Medical Journal*, 11(3), 1564–1572. <https://doi.org/10.15562/bmj.v11i3.3439>
- Iida, M., & Horiuchi, S. (2021). Non-pharmacological pain management techniques during childbirth: A systematic review. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 50(4), 472–487. <https://doi.org/10.1016/j.jogn.2021.04.001>
- McRae, D. N., Muhajarine, N., & Janssen, P. A. (2022). Interprofessional collaboration in maternity care: A systematic review of models and outcomes. *Journal of Interprofessional Care*, 36(4), 503–514. <https://doi.org/10.1080/13561820.2021.1938603>
- Miller, S., & Lalonde, A. (2015). Obstetric violence: A human rights approach to respectful maternity care. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 131, S15–S18. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.02.003>
- Ramirez, M., & Elliott, K. (2023). Digital health technology and wearable devices in prenatal care: Advances and implications. *Maternal and Child Health Journal*, 27(2), 295–304. <https://doi.org/10.1007/s10995-022-03495-8>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550215>
- World Health Organization. (2021). Recommendations on digital interventions for health system strengthening. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>
- Zijlmans, L., Nijman, J., & Klomp, T. (2022). Effectiveness of collaborative maternity care models: An integrative review. *Birth*, 49(2), 183–195. <https://doi.org/10.1111/birt.12568>

PROFIL PENULIS



Dr. Bdn.Tetty Rina Aritonang S.ST., M.Keb. Lahir di Sibolga, 21 September 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan pada Program Studi Kedokteran, Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2003, melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2008, pendidikan S3 Kedokteran di Universitas Hasanuddin Makassar Lulus Tahun 2018 dengan beasiswa LPDP DIKTI dan Yayasan Medistra Indonesia. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 di RS dan Klinik bersalin. Saat ini penulis bekerja di STIKes Medistra Indonesia Bekasi dari tahun 2003 sampai sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai peneliti, penulis buku, publikasi pada jurnal Nasional terakreditasi dan Internasional terindeks scopus, seminar, pengajar mata kuliah Profesionalisme Kebidanan, Asuhan Kebidanan pada persalinan, Kegawatdaruratan Maternal, Komplikasi pada Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan BBL dan Pelayanan Kontrasepsi serta kegiatan pengabdian masyarakat. Penulis penerima Hibah penelitian PDP DIKTI tahun anggaran 2020, hibah book chapter dan penelitian fundamental tahun 2024. Penulis dapat dihubungi melalui email : tetty.rina.2109@gmail.com.

Motto: "Berilmu dengan Tulus, Berintegritas dengan Teguh."



Juanda Syafitasari, M.Keb. Lahir di Padang Lakaran, 03 Januari 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu Tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 di Akademi kebidanan Manna. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu mengampu mata kuliah Evidence Based dalam praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulisan buku, publikasi, dan seminar ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: juandaanindya@gmail.com.

Motto: "Teach with passion, learn with humility, lead with integrity."

PROFIL PENULIS



Nurlaili Ramli, merupakan dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh. Mengajar sejak tahun 2004 hingga saat ini pada beberapa mata kuliah. Ibu dosen ini mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas, Metodologi Penelitian dan Biostatistik Dasar serta *evidence based* kebidanan. Selain itu beliau juga aktif di Organisasi Aceh Peduli Asi sejak Tahun 2019 sampai sekarang, sebagai anggota Divisi Riset, serta komunitas Raharjo Institut sebagai anggota divisi Pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan Formal Sarjana dan Magister ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dosen dengan peminatan ilmu kebidanan ini merupakan anggota editor pada *Indonesian Journal For Health Sciencies*, sebagai *reviewer* di Jurnal Internasional bereputasi dan penulis beberapa artikel penelitian di Jurnal Nasional, International dan Jurnal International bereputasi. Email: nurlaili.ramli@gmail.com



Brivian Florentis Yustanta, SST., Bdn., M.Kes

Penulis lahir di Tulungagung pada tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan STIKES Karya Husada Kediri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan D3 Kebidanan di Akademi Kebidanan Griya Husada Surabaya, D4 Bidan Pendidik dan Pendidikan Profesi Bidan di STIKES Karya Husada Kediri dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki concern terhadap issue – issue terkini mengenai kesehatan bayi, balita dan anak serta kesehatan reproduksi remaja. Penulis aktif dalam kegiatan menulis artikel di majalah kebidanan maupun karya ilmiah semenjak masih di bangku perkuliahan. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini penulis juga aktif dalam organisasi IBI, sebagai penulis buku, reviewer dan editor pada beberapa jurnal ilmiah. Penulis juga aktif menghasilkan karya-karya penelitian yang telah dipublikasikan ke dalam jurnal penelitian maupun prosiding penelitian nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pembicara / narasumber dalam forum kegiatan ilmiah. Scopus ID 58947027700; Sinta ID 6121817; Orcid ID 0009-0000-2816-9033; Garuda ID 1055674; email: brivianflorentis@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb lahir di Ciamis, pada 5 September 1993. Menyelesaikan pendidikan Diploma III di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal, Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran dan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Riau.



Deny Eka Widyastuti, SST., M.Kes., M.Keb Lahir di Karanganyar, 01 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pendidikan Kedokteran Keluarga pada Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian pada Tahun 2018 penulis mengambil pendidikan Magister Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus di tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai dosen di STIKes Kusuma Husada Surakarta. Saat ini penulis bekerja di Universitas Kusuma Husada Surakarta mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Asuhan Kebidanan pada Remaja dan perimenopause dan Asuhan Kebidanan pada Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah serta Evidence Based pada Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: denka.widyastuti@ukh.ac.id

Motto:

"Kehidupan adalah rangkaian sebuah pilihan. Kita perlu memilih hal yang tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan"

PROFIL PENULIS



Yollanda Dwi Santi Violentina, S.ST., M.Keb

Ketertarikan penulis terhadap ilmu kesehatan dimulai sejak kecil karena berkeinginan menjadi tenaga kesehatan mengikuti jejak orang tua. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Padang Program Studi Kebidanan Bukittinggi tahun 2008 dan berhasil lulus tahun 2010. Penulis melanjutkan kuliah di STIKes Prima Nusantara dan berhasil menyelesaikan studi Program Studi Diploma Bidan Pendidik tahun 2013. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 Ilmu Kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.

Penulis memiliki kepakaran dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Asuhan Pelayanan Kebidanan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Penulis pernah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, STIKes Payung Negeri Pekanbaru dan Universitas Batam. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Gorontalo.

Email Penulis: yohandaeki411@gmail.com



Laily Rachmawati, S.SiT., M.KM Lahir di Sidoarjo, 29 April 1983.

Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III Karya Husada Kediri Tahun 2005, S1 pada Program Studi D-IV Kebidanan STIKES Ngudi Waluyo tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Prof Dr Hamka dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 Di RS Delta Surya sebagai Bidan Praktisi dan Menjadi Dosen Di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Pada 2008. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Di Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada mengampu mata kuliah Asuhan Komplementer Kebidanan, Inovasi Pelayanan Kebidanan Komplementer, Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan, Terapi Herbal Dalam Kebidanan, Terapi Meditasi Dan Penyembuhan Diri. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lailyrachmawati83@gmail.com
Motto: "Be the best version of your life"

PROFIL PENULIS



Bdn. Emi Br Barus, S.ST., M.Keb Merupakan Dosen Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan Sumatera Utara (INKES SUMUT). Lahir di Rumah Sumbul 13 Nopember 1987. Pendidikan yang telah di tempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Pada Program Studi Bidan Pendidik di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Kebidanan Pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar dan lulus tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di INKES SUMUT dan Lulus 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2011 sebagai Bidan Pelaksana di Praktik Bidan. Tahun 2011-2025 (sekarang) Dosen di prodi Diploma - III Kebidanan, Sarjana Kebidanan dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan INKES SUMUT. Dan Dosen Tamu di Akademi Kebidanan Nusantara 2000 Tahun TA 2017/2018. Penulis aktif dalam kegiatan tri dharma Pendidikan dan mengampu mata kuliah Evidence Based Dalam Kebidanan, Komunikasi Efektif, Asuhan Kebidanan Pada Nifas, dan Fisiologi Kehamilan, Bersalin, Nifas dan BBL. Penulis juga aktif dalam Penelitian dan memenangkan beberapa hibah penelitian dari Kemenristekdikti serta terpublikasi pada Jurnal Scopus Q3 dan Terindeks Sinta 2-6. Penulis juga aktif melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dan terpublikasi terindeks sinta. Penulis dapat di hubungi melalui e-mail : emibarus@gmail.com



Dily Ekasari, S.ST.Keb., M.K.M ; Merupakan dosen di Prodi DIII Kebidanan STIKes Bhakti Mulia Kediri. Lahir di Dili (Timor Leste), 21 Februari 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Akademi Kebidana Dharma Husada Kediri pada tahun 2010, D4 Kebidanan minat Pendidik di Universitas Kediri pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret minat Epidemiologi dan Biostatistika lulus pada tahun 2018. Pernah bekerja di RSIA Kasih Bunda Pare selama 3 tahun, dosen di Universitas Wahidiyah selama 6 bulan, menjadi erumerator proyek penelitian dari Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2017 (Riset Tenaga Kesehatan/ Risnakes), pada tahun 2018 (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas), tahun 2019 (Riset Fasilitas Kesehatan/ Rifaskes), pada tahun 2023 (Survey Kesehatan Indonesia/ SKI), dan mengikuti riset-riset dari Lembaga Masyarakat lainnya. Selain mengajar penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat telah diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun intranasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : dilyekasari89@gmail.com
Motto : Jadilah versi terbaik dari dirimu

PROFIL PENULIS



Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb. Lahir di Kab. Karo, 28 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Jenjang Diploma 4 (D4) Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan magister terapan kebidanan (S2) Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun 2019 dan melanjutkan kembali pendidikan profesi bidan di Institut Kesehatan Sumatera Utara lulus tahun 2022. Riwat Pekerjaan diawali oleh penulis tahun 2009-2010 di klinik bersalin dan tahun 2011-2014 staf pengajar di program studi kebidanan program diploma Universitas Setia Budi Mandiri dan tahun 2020-sekarang aktif sebagai dosen di program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan Institut kesehatan sumatera utara. Memiliki pengalaman sebagai sekprodi kebidanan program sarjana 2021-2024 dan sekprodi kebidanan program pendidikan profesi bidan 2024-sekarang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, seminar, bimtek, pelatihan komplementer, preceptor mentor, pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah: oral presentasi, publikasi yang diterbitkan berbagai jurnal nasional dan internasional. Selain itu penulis juga aktif dalam organisasi profesi. Penulis dapat dihubungi melalui email: desisembiringdepari@gmail.com



Bd. Dwi Retno Wati, S.Tr. Keb., M.Tr. Keb. Lahir di Madiun, 02 November 1994. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Profesi Bidan dan menjabat sebagai Wakil Ketua Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Husada Jombang untuk periode 2021–2026. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan Diploma III di STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, kemudian melanjutkan pendidikan Diploma IV (Sarjana Sains Terapan) Kebidanan di Universitas Kadiri dan melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan (M.Tr.Keb.) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Guna Bangsa Yogyakarta. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat. Penulis juga pernah mendapatkan hibah penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Kemendikbudristek, yang menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu kebidanan berbasis riset. Selain aktivitas akademik, penulis juga aktif sebagai *volunteer* di Lembaga Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Madiun sebagai Ketua Divisi Edukasi dan Pelayanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rdwi3102@gmail.com
Motto: “Mengabdikan dengan ilmu, mendidik dengan hati”

Sinopsis

Buku Ajar Evidence Based dalam Praktik Kebidanan ini disusun secara sistematis untuk menjadi acuan penting bagi mahasiswa kebidanan dan praktisi kesehatan yang berfokus pada penerapan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). Buku ini mencakup berbagai aspek fundamental seperti metode penelitian dalam kebidanan, aplikasi praktik berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan, serta kepakaran klinis dalam pengambilan keputusan yang reflektif. Dilengkapi dengan latihan soal, glosarium, dan rangkuman materi, buku ini dirancang untuk memudahkan pembelajaran aktif dan aplikatif.

Dalam setiap babnya, pembaca akan dipandu mulai dari pemahaman konsep dasar penelitian, pemilihan desain, hingga teknik pengumpulan dan analisis data yang sesuai dengan standar penelitian kebidanan terkini. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan eksplorasi mendalam tentang berbagai tantangan, manfaat, dan strategi implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM), termasuk integrasi penelitian ke dalam praktik klinis sehari-hari. Buku ini juga membahas pentingnya menghormati nilai individu pasien dan dilema etik dalam pelayanan kebidanan, guna membentuk praktisi kebidanan yang kompeten dan peka secara profesional.

Sebagai upaya menghadapi tantangan dan tren terkini dalam bidang kebidanan, buku ini menyajikan berbagai hasil penelitian terbaik yang relevan serta mengulas secara komprehensif implikasi dari implementasi EBP di lapangan. Buku ini juga menguraikan strategi praktis dalam penerapan prinsip-prinsip biomedical ethics serta pendekatan reflektif untuk meningkatkan kepakaran klinis. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa dan praktisi kebidanan dapat menjalankan praktik profesional yang berbasis bukti dengan lebih efektif, bertanggung jawab, dan bermutu tinggi.

Buku Ajar Evidence Based dalam Praktik Kebidanan ini disusun secara sistematis untuk menjadi acuan penting bagi mahasiswa kebidanan dan praktisi kesehatan yang berfokus pada penerapan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice/EBP). Buku ini mencakup berbagai aspek fundamental seperti metode penelitian dalam kebidanan, aplikasi praktik berbasis bukti dalam pelayanan kebidanan, serta kepakaran klinis dalam pengambilan keputusan yang reflektif. Dilengkapi dengan latihan soal, glosarium, dan rangkuman materi, buku ini dirancang untuk memudahkan pembelajaran aktif dan aplikatif.

Dalam setiap babnya, pembaca akan dipandu mulai dari pemahaman konsep dasar penelitian, pemilihan desain, hingga teknik pengumpulan dan analisis data yang sesuai dengan standar penelitian kebidanan terkini. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan dengan eksplorasi mendalam tentang berbagai tantangan, manfaat, dan strategi implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM), termasuk integrasi penelitian ke dalam praktik klinis sehari-hari. Buku ini juga membahas pentingnya menghormati nilai individu pasien dan dilema etik dalam pelayanan kebidanan, guna membentuk praktisi kebidanan yang kompeten dan peka secara profesional.

Sebagai upaya menghadapi tantangan dan tren terkini dalam bidang kebidanan, buku ini menyajikan berbagai hasil penelitian terbaik yang relevan serta mengulas secara komprehensif implikasi dari implementasi EBP di lapangan. Buku ini juga menguraikan strategi praktis dalam penerapan prinsip-prinsip biomedical ethics serta pendekatan reflektif untuk meningkatkan kepakaran klinis. Dengan adanya buku ini, diharapkan mahasiswa dan praktisi kebidanan dapat menjalankan praktik profesional yang berbasis bukti dengan lebih efektif, bertanggung jawab, dan bermutu tinggi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta

